

中医最新治疗经验荟萃丛书之六

神经精神科病最新中医治疗

中医古籍出版社

责任编辑 伊广谦

封面设计 于天水

图书在版编目 (CIP) 数据

神经精神科病最新中医治疗/梁冰等主编. - 北京: 中医古籍出版社, 1999. 5

ISBN 7-80013-846-1

I. 神… II. 梁… III. ①神经系统疾病-中医治疗法②精神病-中医治疗法 IV. R277.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (1999) 第 20353 号

中医古籍出版社出版发行

(北京东直门内北新仓 18 号 100700)

全国各地新华书店经销

河北省河间市曙光印刷厂印刷

787×1092 毫米 32 开 10.5 印张 224 千字

1999 年 6 月第 1 版 1999 年 6 月第 1 次印刷

印数: 0001~5000 册

ISBN 7-80013-846-1/R·842

定价: 14.00 元

目 录

血管性头痛	(1)
眩晕	(24)
痴呆	(34)
三叉神经痛	(45)
面神经麻痹	(58)
多发性神经炎	(77)
急性感染性多发性神经根神经炎	(83)
坐骨神经痛	(90)
脑梗塞	(113)
腔隙性脑梗塞	(137)
脑血栓形成	(141)
脑出血	(156)
蛛网膜下腔出血	(168)
肺性脑病	(173)
震颤麻痹	(182)
小舞蹈病	(191)
肝豆状核变性	(195)
不安腿综合征	(198)
颅内血肿	(203)
脑震荡	(207)
脑萎缩	(213)
脑动脉硬化症	(220)
椎—基底动脉供血不足	(229)
重症肌无力	(234)
发作性睡病	(239)

不寐	(246)
夜游症	(257)
神经官能症	(261)
癫痫	(270)
躁狂抑郁症	(301)
精神分裂症	(312)

血管性头痛

血管性头痛，按其分类包括偏头痛、丛集性头痛、多种原因引起颅内外动脉高度扩张所致的头痛、植物神经功能紊乱所致的血管舒缩功能障碍的头痛。本病属祖国医学“头风”、“偏头痛”、“厥头痛”等病范畴。

1 辨证论治

1.1 李泰辨证治疗血管性头痛 84 例 (1) 颅脑外伤型 20 例：颅脑损伤及手术所致者，予通窍活血汤加减，药用川芎、丹参、丹皮、赤芍、苏木、刘寄奴、鬼箭羽、郁金、元胡、五灵脂、红花、菖蒲、穿山甲、香附、土元。外伤瘀痛型，予通窍活血汤合定痛丸加减。偏肝火痰热合龙胆泻肝汤或涤痰汤加减；偏肝肾阴虚合左金丸加减；脾胃虚弱合六君子汤加减。(2) 内伤型 64 例：肝阳上亢型，用川芎、丹参、生石决、生白芍、钩藤、生龟板、刘寄奴、元胡、郁金、金铃子、元参、生地、生龙齿、红花、菖蒲、天麻。痰浊型，用川芎、丹参、丹皮、苏木、茯苓、白术、木通、郁金、菖蒲、五灵脂、元胡、红花、半夏、穿山甲、陈皮、土元。气虚型，用川芎、当归、丹皮、赤芍、丹参、白术、党参、黄芪、元胡、郁金、菖蒲、红花、升麻、麦冬、五味子、炙甘草、大枣。血虚型，用川芎、丹皮、当归、元肉、白芍、熟地、白术、淮山药、红花、元胡、郁金、党参、黄芪、阿胶珠(冲)、天麻。肾虚型，用川芎、当归、熟地、丹皮、淮山药、白芍、丹参、红花、五味子、麦冬、元胡、龟板胶、鹿角胶、升麻、天麻。均每日 1 剂，10 剂为 1 疗程。结果：痊愈 28 例，显效 26 例，好转 23 例，无效 7 例，总有

效率 91.67%^[1]。

1.2 张炳厚用川芎茶调散类方治疗偏头痛虚证 168 例 本组气血两虚型用补气养血茶调散（本方加党参、白芍等）；气阴两虚型用益气养阴茶调散（本方加党参、熟地等）；肝肾阴虚型用滋补肝肾茶调散（本方加熟地、枸杞子等）。对照组 48 例，气血两虚型用八珍汤；气阴两虚型用四君子汤合六味地黄汤；肝肾阴虚型用杞菊地黄汤。均日 1 剂水煎服，7 日为 1 疗程。治疗 3 疗程，结果：两组分别痊愈 121、9 例，好转 39、19 例，无效 8、20 例，总有效率 95.23%、58.33% ($P < 0.01$)。本组 81 例，D-木糖吸收率、血浆皮质素水平、SP、VIP 指标均有不同程度回升，其中 SP、VIP 回升明显 ($P < 0.001$)^[2]。

2 一方为主 辨证加减

2.1 全坤山等用柴葛活血汤治疗血管性头痛 本组 84 例，予柴胡、葛根、黄芩、当归各 10g，荷叶、白蒺藜各 12g，川芎、丹参、赤芍各 15g。肝阳上亢加夏枯草、珍珠母；肝肾不足加枸杞、菊花、女贞子、补骨脂、淫羊藿；痰湿阻滞加蔓荆子、白芷、苍术；气血虚加黄芪、白术、党参；寒凝气滞加炮附子、细辛、吴茱萸。日 1 剂，连服 4 剂后停药 3 日。对照组 42 例，654-2 10mg 和维生素 B₆20mg/日 3 次口服。均治疗 4 周。两组分别近期治愈 41、21 例，显效 26、14 例，好转 17、5 例，无效 0、2 例。两组显效以上者无显著性差异， $P > 0.05$ 。随访半年者本组 52 例，对照组 32 例，疗效巩固者分别为 34、11 例，偶有发作者各 11 例，复发者 7、10 例，本组疗效巩固率高于对照组 ($P < 0.01$)，而复发率低于对照组 ($P < 0.05$)。此外，观察组各型患者均有明显疗效；对照组则仅血管痉

挛型效果较好，血管扩张型无效^[3]。

2.2 朱天忠用颅痛灵治疗血管性头痛 148 例 本方含全蝎、细辛各 3g，蜈蚣 2 条，丹参 30g，川芎、赤芍各 20g，红花、白芷、甘草各 10g。血管扩张性头痛加枳壳；血管收缩性头痛加葛根。日 1 剂水煎服，7 日为 1 疗程。治疗期间禁烟、酒、辛辣，停用其他止痛药。经期停药 1 周。治疗 3~30 日，结果：治愈 71 例，显效 49 例，好转 23 例，无效 5 例，总有效率 96.6%。痊愈者 56 例，随访 >1 年，复发 2 例，仍用本方后再未复发^[4]。

2.3 高文武用复方地甲蜈蚣汤治疗偏头痛型血管性头痛 240 例 药用地龙、虻虫、青皮各 15g，刺猬皮、土鳖虫、九香虫、蝉蜕、郁金、木香、川芎各 18g，蜣螂虫、僵蚕、鸡血藤各 24g，穿山甲 21g，炙蜂房 12g，当归 30g。每日 1 剂，水煎分 4 次口服，7 日为 1 疗程，疗程间隔 3~5 日。风寒型加桂枝、细辛、附子；风热型加桑叶、黄芩、生地、栀子、黄连；痰湿型加半夏、竹茹、茯苓、苍术；肝旺型加钩藤、蜈蚣、天麻、胆草、杭菊花；兼有气血两虚者加人参养荣丸；兼有脾胃虚弱者加健脾丸或保和丸；兼有肝肾两虚者加六味地黄丸。结果：基本治愈 218 例占 90.8%，好转 12 例占 5.0%，无效 10 例占 4.2%。对治愈的 218 例进行 1~3 年随访，良好 194 例，复发 24 例^[5]。

2.4 郭士彬治疗血管性头痛 75 例 药用赤芍、桃仁、当归、生地、枳壳、牛膝各 15~20g，红花、柴胡、大黄各 10~15g，川芎 20~30g，细辛 5~10g，桔梗 15g。水煎服日 1 剂。气滞血瘀型 28 例加栀子；痰郁阻滞型 16 例加橘红、半夏；内热郁结型 17 例减细辛，加薄荷、石

青、葛根；肝木抑郁型 14 例加龙胆草、栀子；气血亏虚型 7 例减大黄，加补骨脂、黄芪。经 11~35 日治疗，显效（头痛症状基本消失，连续 1~2 年无复发）55 例，好转 16 例，无效 4 例^[6]。

2.5 蒋森等用活血搜风汤治疗偏头痛 58 例 本组用本方：川芎、白芍各 15~30g，赤芍 15~20g，红花、全蝎各 9g，蜈蚣 1~2 条，天麻 10~15g，细辛、甘草各 3~6g。风寒外袭加藜蘆、白芷、葛根；痰浊中阻加法半夏、白术、茯苓；肝火上扰加钩藤、牛膝、龙胆草；肝气郁滞加柴胡、香附；气血不足加黄芪、当归；肝肾阴虚加五味子、生地、龟板。日 1 剂水煎服。间隙期用本方 2/3 剂量，研为细末，9g/日 3 次口服。对照组 38 例，发作期用麦角胺咖啡因 1~2 片，每周不超过 8 片；安定 5~10mg/每晚，恶心呕吐酌加灭吐灵。间隙期用心得安 30mg/日 3 次，苯噻啶 0.5mg/日 1 次，均口服。疗程均 2 个月。结果：两组分别临床治愈 24、7 例，显效 17、13 例，好转 11、9 例，无效 6、9 例，总有效率 89.7%、76.3% ($P < 0.05$)。随访 1 年，复发率 31.7%、60% ($P < 0.05$)^[7]。

2.6 高正今等用消颅痛煎剂治疗偏头痛 104 例 本方含黄芪、丹参、鸡血藤、夜交藤各 30g，川芎、香附、白芷、藁本、酸枣仁、牛膝各 15g，蔓荆子 20g，当归 10g。偏热者加黄芩 12g；偏寒者加吴茱萸 10g；肝阳上亢加钩藤 12g，白芍 15g；肝郁气滞加柴胡 15g，玄胡 12g；气血虚损加党参、首乌各 30g。日 1 剂，水煎 450ml，分 3 次服。对照组 38 例，用颅痛定、谷维素、安定。均 7 日为 1 疗程，服 2~4 疗程。结果：两组分别治愈 63、13 例，好转 35、14 例，无效 6、11 例，总有效率 94%、

例^[11]。

3.2 胡志强等用芷钩汤治疗血管性头痛 42 例 本方含白芷、桑寄生、当归各 15g，钩藤、川牛膝、石决明各 30g，川芎 9g，菊花 12g，细辛 3g，甘草 6g。心悸失眠加菖蒲、远志；失眠多梦加炒枣仁、丹参；汗出恶风加白芍、黄芪；呕吐恶心加旋覆花、半夏；头晕纳差加泽泻、白术；病久不愈加全蝎、藁本；舌有瘀斑、脉涩加桃仁、红花。日 1 剂水煎服。结果：痊愈 13 例，显效 17 例，有效 9 例，无效 3 例，总有效率 92.8%^[12]。

3.3 何柏森等用散偏汤加减治疗血管性偏头痛 108 例 本方含川芎 30g，白芷、白芍各 20g，香附、柴胡、白芥子各 10g，郁李仁 6g，甘草 3g。痛剧加地龙、全蝎；痛连前额重用白芷，加防风；痛连后项加葛根、羌活；右侧痛加葛根、细辛、黄芪；左侧痛加龙胆草、红花；目胀如脱加紫贝齿、石决明。结果：痊愈 88 例，显效 14 例，无效 6 例，总有效率 94.5%^[13]。

3.4 周玉忠用血府逐瘀汤治疗血管性头痛 50 例 本组用本方：桃仁 12g，红花、当归、生地、牛膝各 9g，川芎 15g，赤芍、枳壳各 6g，桔梗 5g，柴胡、甘草各 3g。前头痛加白芷、天麻、细辛；后头痛加羌活、独活；两侧痛加蔓荆子、菊花、龙胆草；头顶痛加藁本。日 1 剂水煎服。对照组 45 例，用尼莫地平 40mg，谷维素 30mg，安定 2.5mg，日 3 次口服。均 8 周为 1 疗程。结果：两组分别痊愈 34、20 例，显效各 11 例，无效 5、14 例，总有效率 90%、68.8% ($P < 0.05$)^[14]。

3.5 王爱章等用头痛康治疗血管性头痛 48 例 本方用制附片、白芷各 12g，川芎 20g，吴茱萸 9g，全蝎 1g

各 10g, 细辛 3g。恶心呕吐加姜竹茹、半夏、砂仁、枣仁; 耳鸣、口苦加黄芩、龙胆草; 便秘加生大黄; 恶风重加防风、黄芪。共研末, 过 80~100 目筛) 10g, 水煎日 2 次口服, 10 日为 1 疗程。用 1 个疗程, 结果: 治愈 44 例, 显效 30 例, 有效 23 例, 无效 6 例, 总有效率 94.17%^[18]。

3.9 孙景兰用芎归四虫散治疗血管性头痛 36 例 本方含川芎、当归、白芷各 12g, 细辛 3g, 全蝎、虻蛭、僵蚕各 10g, 地龙 6~10g, 蜈蚣 2~3 条。失眠加酸枣仁 30g; 耳鸣、口苦加龙胆草 10g; 牙痛加石膏 30g; 大便秘结加生大黄 10g; 舌苔较厚、痰湿明显加半夏 12g, 胆南星 6~10g。结果: 痊愈 15 例, 有效 18 例, 无效 3 例, 总有效率 92%^[19]

3.10 陈玉书等用钩藤散加减治疗血管性头痛 44 例 药用钩藤、茯苓、菊花各 15g, 半夏、麦冬、防风、川芎、党参各 10g, 陈皮 12g, 石膏 20g, 甘草 5g, 生姜 3 片。舌苔黄腻去党参, 加黄芩、黄连各 10g; 舌苔白滑加天麻、羌活各 10g; 舌红少苔去党参, 加太子参 15g; 舌质紫暗有瘀点加丹参 15g; 头痛不止加地龙 10g, 全蝎 6g。日 1 剂水煎服。结果: 痊愈 29 例, 有效 12 例, 无效 3 例, 总有效率 93%^[20]。

3.11 屈振廷等用川芎天麻汤治疗偏头痛 84 例 药用川芎 30~40g, 天麻、白芷、醋玄胡、白芍各 15g, 羌活、地龙各 12g, 细辛 9g, 甘草 10g。水煎分 3 次温服。兼风寒表症者加荆芥、防风; 兼风热者加薄荷、菊花; 气血虚者加黄芪、当归、熟地; 伴眼睑下垂、偏瘫症状者加姜蚕、全蝎、蜈蚣; 恶心、呕吐加法半夏; 兼见巅顶头痛加吴茱萸、藁本。结果: 痊愈 (头痛发作控制, 伴随症状

消失；3年内无复发）28例，显效（头痛发作基本控制，偶有轻微发作，伴随症状消失）28例，有效21例，无效7例^[21]

3.12 周超凡等用芎芷细辛汤治疗偏头痛 本方含川芎、白芷、延胡索、牛蒡子、半夏各10g，细辛3g（后下）。痛甚，手发凉加丹参15g，桂枝6g；精神抑郁加香附10g，合欢皮12g；睡眠不佳加炒枣仁12g，炙远志6g；肝旺加石决明18g（先煎），钩藤12g（后下）；久病入络加蜈蚣2条，全蝎1.5g。作者介绍了组方依据及药理分析。附病例2则^[22]。

3.13 陈治水用柴胡川芎饮治疗偏头痛56例 本方含柴胡、当归、白芷、僵蚕、葛根、白芍各15g，川芎30g，细辛7.5g，吴茱萸、甘草各10g。水煎服，日1剂。夹肝火加龙胆、山栀各10g，夏枯草15g；肝阳上亢去吴茱萸、川芎，加生龙骨、生牡蛎、生石决明各20g（先煎）；夹湿者加半夏、天南星、羌活各15g；夹瘀血者加红花、桃仁各15g。结果：痊愈36例，显效15例，好转5例。服药6~30剂^[23]。

3.14 王胜利利用大剂量川芎治疗偏头痛50例 基础方：川芎30~60g，细辛5~10g，蔓荆子、葛根各10~15g。血瘀甚加丹参、延胡索、红花；气滞加柴胡、香附子；痰湿甚加升麻、苍术、竹茹；热甚加栀子、菊花、石决明、龙胆草；久病肝肾气血不足加枸杞子、枣仁、黄芪、当归。日1剂水煎服。结果：脑血流图恢复正常者44例，好转5例，无效1例^[24]。

3.15 贤述良用蠲痛汤治疗偏头痛40例 本方含川羌活、白僵蚕、荆芥穗、防风、白芷、薄荷（后下）、地

方含当归、赤芍、白蒺藜、石菖蒲、炒枣仁、白僵蚕、醋元胡各 15g, 川芎、夜交藤各 30g, 菊花 12g, 白芷 9g。面白唇淡、脉沉细加党参、熟地、黄芪; 颈痛加葛根; 舌淡红加钩藤、天竺黄; 舌质紫暗加丹参、红花; 失眠加琥珀、远志。日 1 剂水煎服。15 日为 1 疗程, 病情好转继服 20 剂。结果: 治愈 52 例, 有效 28 例, 无效 6 例, 总有效率 93.1%^[28]。

3.19 刘临兰用加减柴胡汤治疗偏头痛 36 例 本方含柴胡、法夏、菊花、竹茹、蒺藜、黄芩各 10g, 双钩、白芍各 2g, 岗梅 30g, 甘草 6g。前额头痛者加白芷、防风; 痛及后项者加葛根, 羌活; 目赤、目胀如脱者加夏枯草、石决明; 视物昏朦者加枸杞、首乌。日 1 剂水煎服, 20 剂为 1 疗程。治疗期间停服一切治疗头痛的西药, 并注意调摄饮食起居。结果: 临床治愈 7 例, 显效 18 例, 有效 9 例, 无效 2 例, 总有效率为 94.5%^[29]。

3.20 吴松年自拟定偏汤加减治疗偏头痛 本组 18 例, 用本方: 全蝎 3g, 蜈蚣 5g, 僵蚕、地龙、天麻各 10g, 川芎、葛根各 8g。偏风寒加细辛、吴茱萸、防风; 偏风热加菊花、连翘; 血虚加当归、熟地; 因情志因素诱发加白芍、柴胡; 因劳倦诱发加黄芪; 呕吐甚加姜竹茹。日 1 剂水煎服, 15 日为 1 疗程。结果: 治愈 9 例, 显效 6 例, 好转 2 例, 无效 1 例^[30]。

4 固定方治疗

4.1 莫非凡用活血行气汤治疗血管性头痛 284 例 本方含川芎、丹参、北黄芪各 40g, 当归 12g, 白芷、陈皮、木香各 10g, 细辛、甘草各 5g, 菊花 15g。每日 1 剂, 加水 1000ml 煮沸 10 分钟过滤, 再加水 500ml 煎 15 分钟过

滤，再加水 300ml 煎 20 分钟过滤，3 煎药液混匀，以白酒为引，分 3 次口服。15 日为 1 疗程。结果：治愈 96 例，显效 172 例，无效 16 例，总有效率为 94.4%。疗程 5~45 日，平均 12 日。微循环检查表明，治疗前患者多有微循环障碍，治疗后微循环血管清晰度增高，管袢开放数目增多，色泽变红，异形管袢数目明显减少，管袢渗出及出血减少或消失，血流速度增快，治疗前后比较有显著性差异 $P < 0.01$ 。提示微循环障碍是本病病变过程中的一个重要病理变化。认为舌尖及甲皱微循环检查可作为本病诊断及活血化瘀法治疗的一项较好的观察指标^[31]。

4.2 王文明用芎牛琥珀汤治疗血管性偏头痛 54 例

本方含川芎 20~30g，牛膝 30~45g，琥珀（冲服）、僵蚕各 5~10g，蔓荆子 10~15g，生石决 20~50g。水煎服日 1 剂，重者日 2 剂。待疼痛缓解后，酌情加减继服 2~5 剂以巩固疗效。结果：痊愈（头痛及伴随症状均消失，1 年内不复发者）44 例，有效（症状显著好转，头痛偶有轻微发作，1 年内发作 < 3 次）8 例，无效 2 例，总有效率为 96.3%。本组服药 3~15 剂，平均 7 剂^[32]。

4.3 于宝锋等用颅痛宁煎剂治疗血管性头痛 本品含柴胡、廬虫、白芷各 20g，香附、蔓荆子、萆薢各 25g，川芎、葛根各 50g，全蝎 10g，羌活 15g。每剂煎服 300ml，分早晚 2 次服。对照组用复方羊角冲剂（由上海青浦塘中药厂产）1 袋（8g）/日 2 次。均 7 日为 1 疗程。本组 300 例，治愈 226 例占 75.3%，好转 63 例占 21.0%，无效 11 例占 3.7%，总有效率 96.3%。对照组 50 例，治愈 28 例，好转 13 例，无效 9 例，总有效率 82.0%。两组比较有显著差异， $P < 0.01$ 。实验研究证明本品有明显的镇痛作

用^[33]。

4.4 曹洪欣等用清空汤治疗血管性头痛 本方含川芎 20~30g, 柴胡、黄芩、羌活各 15g, 黄连 5~10g, 防风、甘草各 10g, 白芍、僵蚕、郁金各 10~20g。日 1 剂水煎服。本组 32 例, 经 8~32 剂治疗, 治愈 24 例, 好转 6 例, 无效 2 例^[34]。

4.5 李维华自拟搜风止痛散治疗血管性头痛 68 例 用本品 (全蝎、蜈蚣、僵蚕、土鳖虫、川芎、川牛膝、白术、砂仁各等份, 粉碎灭菌后装胶囊, 每粒含生药 0.75g) 4 粒/日 3 次口服, 10 日为 1 疗程。不用它药, 忌食辛辣之品、劳累及郁怒。一般用 2~3 个疗程。结果: 治愈 58 例, 显效 8 例, 无效 2 例, 总有效率 97.1%^[35]

4.6 姚永年自拟颅痛饮治疗血管性头痛 21 例 药用生白芍 20g, 钩藤、川芎各 30g, 细辛 15~18g, 生石决明 50g (先煎)。每日 1 剂, 2 次分服; 重症可加服半剂, 每 8 小时服 1 次。结果: 显效 17 例, 好转 1 例, 无效 3 例^[36]。

4.7 周英豪等采用活血平肝祛痰法治疗血管性头痛 119 例 药用天麻、僵蚕各 12g, 丹参、赤芍、白芍、生南星各 15g, 红花、川芎、桃仁、菖蒲各 9g。日 1 剂水煎服, 3 个月为 1 疗程。结果: 临床控制 (3 个月未发作) 24 例占 20.2%, 显效 55 例占 46.2%, 有效 30 例占 25.2%, 无效 10 例占 8.4%, 总有效率 91.6%。71 例血浆 5-羟色胺、血栓素、前列环素及雌二醇 (女性) 浓度高、低值组均趋于正常 ($P < 0.01$)^[37]。

4.8 麦小苔等用疏痛灵冲剂治疗血管性头痛 171 例 药用当归、川芎、五灵脂、柴胡、白芷、葛根、细辛、

羌活、苍术。将上药加工成冲剂，分装成每包 10g，1 包/日 3 次开水冲服。其间避风寒和精神刺激，忌辛辣刺激物。结果：痊愈 51 例，显效 65 例，有效 45 例，无效 10 例，总有效率为 94.2%；脑血流图改善率达 94.7%^[38]。

4.9 刘继生等用芎芷二虫汤治疗偏头痛 68 例 本方含白芍、川芎、白芷、代赭石（另包，先煎）各 30g，赤芍 15g，羌活 12g，细辛、全蝎各 10g，蜈蚣 2 条。日 1 剂水煎分 3 次温服，7 日为 1 疗程，治疗最多 4 个疗程。结果：痊愈 33 例，显效 18 例，有效 10 例，无效 7 例，总有效率 89.7%。血液流变学各项指标治疗前后比较均有显著性差异， $P < 0.01 \sim 0.05$ ^[39]。

4.10 陈宝田等用痛必克汤治疗难治性偏头痛 100 例 本方含川芎、钩藤、鸡血藤、黄芪、生龙骨、生牡蛎各 30g，当归、生地、桃仁、红花、羌活、独活、防风、附子、细辛、麻黄、泽泻、茯苓各 10g，白芍 15g，白芷 12g。日 1 剂水煎服，15 日为 1 疗程。用 3~4 个疗程，结果：基本恢复 36 例，显效 58 例，有效 5 例，无效 1 例，总有效率 99%^[40]。

4.11 陈文郁等用自制头痛宁治疗偏头痛 96 例 用本品（含菊花、龙胆草、丹参、芍药、郁金、蜈蚣、全蝎、金钱蛇、山栀子、细辛、胆南星、竹茹等，每片 0.5g，吉林中药厂生产）4~6 片/日 3~5 次口服，10 日为 1 疗程。治疗 2~4 个疗程，结果：基本恢复 51 例，显效 18 例，有效 15 例，无效 12 例，总有效率 87.5%^[41]。

4.12 周冠群等用偏头痛粉治疗偏头痛 49 例 本品由党参、黄芪、赤芍、白芍、茯苓、吴萸、黄芩、制川军、炙甘草、生地、熟地、当归、川芎、威灵仙、天麻、

羌活、防风、柴胡、半夏、酸枣仁、五味子、附子、蔓荆子、黄精、枸杞子、泽泻、莪术、延胡索、全蝎、黄柏、蜈蚣各 500g，生石膏 1000g，制马钱子 340g，烘干研末备用。每日 20g 分 2~3 次服，10 日为 1 疗程，有效者连服 2~3 疗程。本组患者病程 1~20 年，服药后近期治愈（症状消失，6 个月内未复发）21 例，显效（疼痛减轻，发作次数减少一半以上）8 例，有效、无效各 10 例，总有效率为 79.6%^[42]

4.13 邢萍用消痛胶囊治疗偏头痛 214 例 本组 158 例，用本品（含全蝎、蜈蚣、元胡、天麻、川芎、蔓荆子、细辛、白芷、柴胡等，共研细末，装胶囊，每粒含生药 0.25g）5~6 粒/日 3 次口服，30 日为 1 疗程。对照组 56 例，发作前或发作时用咖啡麦角胺 1 片/日 1~3 次口服。用 2 个疗程，结果：两组分别痊愈 65、6 例，显效 49、25 例，好转 38、10 例，无效 6、15 例，总有效率 96.2%、73.2% ($P < 0.01$)。随访半年，两组分别复发 13 (86%)、18 (43.9%) 例^[43]。

5 外用药物治疗

5.1 赖福生等用温经散寒中药额颞部外敷治疗偏头痛 本组 20 例，用艾叶、生姜各 6g，葱白 4g，小麦 5g，捣碎混合成糊状，每晚 9 时加热至 50℃ 左右，置布带上，使药覆盖额颞部，次晨取下，头痛发作时连续用药 3 夜。对照 1 组 19 例，小麦捣碎加水制成糊状，余同上法；对照 2 组 21 例，用西比灵 5~10mg，每晚口服。均用 3 个月，头痛重用镇痛药。结果：3 组分别基本控制 3、0、0 例，显效 10、2、7 例，好转 6、5、9 例，无效 1、12、5 例。本组疗效优于两对照组 (P 均 < 0.01)^[44]。

5.2 鄂声浩用三生散外敷治疗偏头痛 43 例 本品含生草乌、天南星、生白附子各 30g，葱白 7 根，生姜 40g。用法：诸药研末调匀，用一层纱布包好，放入锅内隔水蒸热，敷痛处，但勿敷眼部。结果：治后 24 小时内痛止者 40 例，2~3 日痛止者 3 例，随访 2 年内无复发者 31 例^[45]。

6 内外并治

宋宪源等治疗偏头痛 600 例 本组患者中，典型偏头痛 311 例，普通型 165 例，丛集性 74 例，眼肌麻痹型 4 例，基底动脉型 27 例。1. 头痛灵方 1：麝香 0.1g（或洋金花 2g），白芷、樟脑各 10g，细辛、红花各 5g，血竭 3g，冰片 1g。研末，用 60 度白酒 200ml 浸泡 3 日，过滤。治疗时用药棉蘸药液少许缓慢涂抹头痛处约 3 分钟，日 3~6 次。每剂药用 2 周。2. 头痛灵方 2：川芎 30g，白芷、香附各 15g，毛冬青 90g，柴胡 6g，白芍 20g，生甘草 5g。随症加减，病情轻者隔日 1 剂，病情较重者每日 1 剂，水煎 2 次分服。经 2~8 周治疗结果：近期治愈 405 例，显效 163 例，无效 32 例，总有效率 94.7%^[46]。

7 中西医结合

高石麟中西医结合治疗偏头痛 120 例 本组用散偏汤：天麻、钩藤各 15g，山栀子、当归、白芷各 10g，石决明、生龙骨（均先煎）、川芎各 30g，益母草 20g。两侧痛加柴胡、黄芩；巅顶痛加藁本、防风；前额连眉棱骨痛重用白芷；后脑连颈项痛加葛根、羌活；痛连齿龈加蝉蜕、细辛、生石膏；呕吐痰涎加半夏、陈皮、吴茱萸；神情抑郁加百合、合欢皮；失眠加枣仁。日 1 剂水煎服，1 个月后改 2 日 1 剂。与对照组 40 例，急性发作时均用咖

日1次，10次为1疗程。头痛重或针刺>6次无效者，取太阳、阿是穴，加用梅花针重叩出血，2日1次。结果：治愈65例，显效21例，好转13例，无效6例，总有效率94.3%^[50]。

8.4 崔述贵针刺治疗偏头痛 130例 主穴：风池、百会；风池、太阳透率谷。刺风池穴针尖向对侧眼眶，使针感扩散到枕部；刺百会针感扩散到顶部；用3~4寸毫针沿皮刺太阳透率谷1.5~3寸，捻转进针，使针感扩散到整个颞部。两组交替使用。配穴：列缺、合谷、太溪、太冲、照海、绝骨。留针20~30分钟，隔10分钟行针1次。隔日针1次。结果：痊愈28例占22.1%，显效30例占23.5%，有效64例占48.6%，无效8例占5.8%，总有效率94.2%^[51]。

8.5 董自斌深刺风池穴治疗血管性偏头痛 240例 用28号2.5寸毫针，针尖平耳垂水平，取患侧穴，向对侧眼窝方向直刺，当针尖刺至2寸（儿童1.5寸）深时，针下如刺橡皮样物（黄韧带），再轻轻进针2~3分，针下有落空感，患者出现触电样感觉传至前额一侧，头痛立即消失，即退针（切勿捻转提插）。对照组100例，取太阳、头维、风池、太冲、合谷，按常规操作法，留针30分钟，日1次。结果：两组分别痊愈216例占90%、62例占62%，显效18例占7.5%、20例占20%，好转6例占2.5%、15例占15%，无效0例、3例占3%。两组疗效比较有非常显著性差异， $P<0.01$ 。本组疗程较对照组（ $P<0.01$ ）^[52]

8.6 贺舜岐采用巨刺法治疗血管性头痛 26例 主穴取头痛对侧足临泣，配穴取阿是穴、昆仑、中渚、太冲

30~40 分钟后，加柴胡 15g、细辛 4g 以小火煮 10 分钟。每日 1 剂，每次服 100~150ml，日 2 次。大便干燥加生大黄 5g（后煎）；头晕眼花而干涩加杭菊花 15g；血瘀重加血竭 5g；气虚加黄芪、党参各 15g；易感风寒者加防风 10g、黄芪 15g；合并前额痛者加生石膏 20g、白芷 15g；合并巅顶痛者加藁本 15g。儿童用量酌减。（2）针灸主穴取列缺、阳陵泉、头维、太阳、合谷，用泻法。配穴：面部烘热者加身柱、天柱；头痛与月经有关加气海、三阴交；与情志有关加内关、内庭；易感风寒者加风池、大椎；气虚加足三里、关元。配穴均用平补平泻手法。颞浅动脉怒张或跳动增强者于太阳穴放血。每次取 2 主穴、1 配穴，得气后留针 15~20 分钟，每日 1 次。结果：全部获愈，随访多年未见复发^[56]。

10 穴位注射疗法

10.1 马慧平采用穴位注射治疗偏头痛 204 例 治法：取风池穴直上 0.5 寸处，指压该处时多数患者感到疼痛难忍并向同侧目眶或前额传导，将维生素 B₁₂0.25 微克注入该穴，3 日 1 次，3 次为 1 疗程。结果：痊愈（症状完全消失，经 2 年以上随访未复发）160 例，显效（症状基本消失，偶有轻微发作）24 例，好转 16 例，无效 4 例，总有效率 98.1%^[57]。

10.2 胡芝兰等采用人迎穴注射治疗偏头痛 32 例 本组患者病程 2 月~12 年。采用维生素 B₁₂注射液于人迎穴注入 0.5mg，每日或隔日 1 次，5 次为 1 疗程。经治 3~10 天，痊愈 22 例，显效 8 例，好转 2 例。操作时，将颈动脉推向外侧，垂直快速刺入皮肤后，缓慢进针深约 1.2 厘米，病人有明显酸胀感后，抽无回血方可将药液徐徐注

人。人迎穴周围有丰富的血管，故不能针刺过深；该穴稍上方相当于甲状软骨上缘颈动脉搏动处系颈动脉窦之所在，操作时应避免压迫局部，以免引起血压下降、心率减慢甚至心脏停搏等意外^[58]。

参考文献

- 1 李 泰 . 河北中医 . 1988; 10 (5): 1
- 2 张炳厚, 等 . 北京中医药大学学报, 1994; 17 (4): 36
- 3 全坤山, 等 . 福建中医药 . 1991; 22 (1): 2
- 4 朱天忠 . 浙江中医杂志 . 1994; 29 (12): 535
- 5 高文武 . 中西医结合杂志 . 1988; 8 (11): 653
- 6 郭士彬 . 内蒙古中医药 . 1987; 6 (3): 12
- 7 蒋 森, 等 . 新中医 . 1995; 27 (2): 27
- 8 高正今, 等 . 湖南中医杂志 . 1992; 8 (2): 8
- 9 李熙和 . 甘肃中医学院学报 . 1990; 7 (2): 46
- 10 白俊峰 . 北京中医 . 1993; (3): 25
- 11 柳振涛 . 福建中医药 . 1991; 22 (1): 11
- 12 胡志强, 等 . 山东中医学院学报 . 1994; 18 (3): 163
- 13 何柏森, 等 . 湖南中医学院学报 . 1994; 14 (4): 27
- 14 周玉中 . 中国中西医结合杂志 . 1995; 15 (7): 438
- 15 王爱章, 等 . 河南中医 . 1994; 14 (3): 164
- 16 顾为琰, 等 . 浙江中医杂志 . 1991; 26 (6): 248
- 17 王润生, 等 . 黑龙江中医药 . 1989; (2): 18
- 18 钟 磊, 等 . 中国中医科技 . 1997; 4 (1): 63
- 19 孙景兰 . 浙江中医药 . 1993; 28 (10): 449
- 20 陈玉书, 等 . 国医论坛 . 1993; 8 (5): 35
- 21 屈振廷, 等 . 河南中医 . 1990; 10 (3): 21
- 22 周超凡, 等 . 中药通报 . 1987; 12 (12): 51

- 23 陈治水 . 四川中医 .1988; 6 (5): 31
- 24 王胜利 . 中医函授通讯 .1993; 12 (4): 44
- 25 贤述良 . 北京中医 .1994; (5): 26
- 26 戴金梁, 等 . 江苏中医 .1997; 18 (6): 9
- 27 王福林 . 中国乡村医生 .1997; 13 (6): 16
- 28 周继武, 等 . 四川中医 .1993; 11 (5): 30
- 29 刘临兰 . 湖南中医杂志 .1990; 6 (1): 9
- 30 吴松年 . 江苏中医 .1994; 15 (8): 17
- 31 莫非凡 . 广州中医学院学报 .1990; 7 (2): 69
- 32 王文明 . 吉林中医药 .1988; (3): 11
- 33 于宝锋, 等 . 中西医结合杂志 .1989; 9 (5): 278
- 34 曹洪欣, 等 . 云南中医学院学报 .1990; 13 (2): 31
- 35 李维华 . 广西中医药 .1996; 19 (1): 11
- 36 姚永年 . 上海中医药杂志 .1986; (2): 36
- 37 周英豪, 等 . 北京中医药大学学报 .1996; 19 (4): 53
- 38 麦小苔, 等 . 河南中医 .1992; 12 (2): 80
- 39 刘继生, 等 . 山西中医 .1996; 12 (3): 16
- 40 陈宝田, 等 . 山东中医杂志 .1996; 15 (4): 156
- 41 陈文郁, 等 . 实用中医内科杂志 .1996; 10 (1): 12
- 42 周冠群, 等 . 上海中医药杂志 .1988; (8): 13
- 43 邢 萍 . 河北中医 .1996; 18 (5): 10
- 44 赖福生, 等 . 中国中西医结合杂志 .1995.15 (9): 562
- 45 鄢声浩 . 四川中医 .1988; 6 (3): 32
- 46 宋宪源, 等 . 河北中医 .1991; 13 (3): 13
- 47 高石麟 . 福建中医药 .1997; 28 (1): 37
- 48 曹利民 . 上海针灸杂志 .1993; 12 (4): 157
- 49 许海书, 等 . 中医药研究 .1994; (1): 52
- 50 刘改玲, 等 . 山西中医 .1995; 11 (6): 34
- 51 崔述贵 . 中医函授通讯 .1993; 12 (6): 30
- 52 董自斌 . 针灸临床杂志 .1993; 9 (1): 18

期以上用心痛定 10 毫克/日 3 次口服。中型以上糖尿病用消渴丸 10 粒/日 3 次口服。结果：治愈 7 例，显效 14 例，好转 4 例^[2]。

2 一方为主 辨证加减

2.1 白峻峰等分步辨治眩晕证 200 例 治以升清降浊法，用净荷叶 10g，灵磁石 30g，车前子、生白术各 18g，泽泻 30~60g，生姜 20~30g。肝阳上亢加钩藤、夏枯草；肾精不足加龟板、山萸肉；痰湿中阻加半夏、茯苓；气血亏虚加首乌、菊花；瘀血内阻加川芎、泽兰。服 2~5 剂眩晕症状减轻后，再辨证分型治疗，肝阳上亢用天麻钩藤饮、龙胆泻肝汤；阳亢化风用地黄饮子；气血亏虚用十全大补汤、补中益气汤；肾精不足用河车大造丸、左归丸、金匱肾气丸；瘀血阻络用通窍活血汤、血府逐瘀汤、清魂散；痰湿中阻用升清降浊汤、苓桂术甘汤、香砂六君子汤。对照组 60 例，用西药对症治疗。结果：两组分别显效（症状完全消失，随访 > 1 年未复发）125、28 例，有效 72、19 例，无效 3、13 例，总有效率 98.5%、78.3% ($P < 0.001$)^[3]。

2.2 朱承胜等治疗老年椎 - 基底动脉供血不足型眩晕 30 例 用益气化瘀基本方：黄芪 30~75g，川芎、赤芍、当归、桃仁、红花、天麻各 10g，葛根 15g。气血亏虚加党参、白术、白芍、酸枣仁等；肾阳虚加菟丝子、鹿角胶、杜仲、苁蓉等；肾阴虚加龟板、枸杞子、熟地、山药等；肝肾阴亏酌加生地、白芍、牡蛎、鳖甲、龟板等；痰浊中阻加白术、泽泻、二陈汤等；痰郁化火加黄连、竹茹、胆南星、竹沥、半夏。日 1 剂水煎服。治疗 1~3 个月。结果：临床治愈 21 例（70%），好转 6 例，无效 3

例，总有效率 90%^[4]。

3 一方为主 随症加减

3.1 李爱华用止眩汤治疗眩晕 60 例 本方含柴胡、白术、白芍、法半夏、竹茹各 10g，陈皮 6g，茯苓、枳实、黄芪各 15g，桂枝 5g，泽泻 20g，生牡蛎 25g（包），甘草 3g。肝热加黄芩；肝阳亢加天麻、钩藤；中气虚加大黄芪量，或加党参；呕甚加生姜。日 1 剂水煎服，5 剂为 1 疗程。治疗 4 个疗程，结果：痊愈 44 例，显效 10 例，有效 6 例，总有效率为 100%。^[5]

3.2 刘为照等用苓桂术甘汤治疗水饮内停性眩晕 86 例 本组均为耳性眩晕。用本方：茯苓 15g，桂枝、炙甘草各 3g，炒白术、姜半夏、陈皮各 10g，泽泻 30g，生姜 3 片。眩晕甚加生龙骨、生牡蛎；呕吐甚加旋覆花、赭石、炒枳壳；耳鸣或耳聋加菖蒲；血压偏高加怀牛膝、地龙；头痛加川芎、白芷。日 1 剂水煎服，3 日为 1 疗程。用 2 个疗程，结果：显效 54 例，有效 29 例，无效 3 例，总有效率 96.5%^[6]。

3.3 桂克文用活血消眩汤治疗内耳眩晕 46 例 本方含丹参、泽泻各 30g，车前子 20g，白术 15g，川芎、半夏、天麻各 10g。眩晕甚加生龙骨、生牡蛎、珍珠母；耳鸣甚加砂仁、灵磁石；呕吐甚加代赭石、旋覆花；血压高加牛膝、钩藤、菊花、夏枯草。治疗 7~30 日，痊愈 41 例，好转 5 例^[7]。

3.4 何光明等自拟活血除眩汤治疗瘀血眩晕 30 例 本组包括脑外伤后综合征、美尼尔氏综合征、前庭神经炎、脑动脉硬化、椎基底动脉供血不足、颈椎病、高血压等病患者。药用葛根、丹参各 30g，当归 15g，红花、天

麻各 10g。气虚血瘀加黄芪；阴虚血瘀加生地、熟地；痰瘀互结加制半夏、云苓、白术；高血压病加菊花、怀牛膝、石决明；耳鸣加磁石。日 1 剂水煎服。结果：临床痊愈 15 例，显效 9 例，有效 5 例，无效 1 例，总有效率为 96.7%。治疗前后全血粘度、红细胞压积、全血还原粘度、红细胞电泳比较均有显著性差异， $P < 0.05 \sim 0.001^{[8]}$ 。

3.5 关建国用小柴胡汤加味治疗颈性眩晕 66 例 用小柴胡汤，肾精不足加菟丝子、枸杞子、杜仲各 15g，山茱萸 12g；气血不足加黄芪 30g，当归 12g；脾虚不运加黄芪、薏苡仁各 30g，白术 12g，升麻 10g；颈项不舒加葛根 30g；湿郁化热加黄连 6g，佩兰 15g。日 1 剂水煎服。进食不足及呕吐者适当补液。结果：临床治愈 40 例，好转 22 例，无效 4 例^[9]。

3.6 郑宪华等用通窍活血汤治疗中枢性眩晕 38 例 本方含赤芍、当归各 15g，川芎、桃仁、红花、葛根、菖蒲各 12g，麝香 0.3g，天麻 9g，老葱 3 根，红枣 7 枚。血压高加石决明、钩藤；气虚加黄芪、党参；阴虚加枸杞子、首乌、生地；兼痰浊加半夏、瓜蒌、薤白。日 1 剂水煎服。结果：显效（5~7 日内症状消失）15 例，有效 18 例，无效 5 例^[10]。

3.7 赵国民用补阳还五汤加减治疗老年性眩晕 40 例 本方含黄芪、丹参各 50g，赤芍、当归各 25g，桃仁 20g，川芎、地龙、红花、天麻、制半夏各 15g。恶心呕吐及舌体胖大、舌苔白腻者加竹茹 10g、藜芦子 15g；气虚者黄芪加至 75g；阳虚者加附子 15g；气滞者加柴胡、木香各 15g；血压低、舌质红或少苔者加党参、麦冬、五味

子各 15g；舌质暗有瘀斑者加益母草 15g，鸡血藤 25g。日 1 剂水煎服，10 日为 1 疗程。部分患者少量服用驱脂西药；血压 $> 20.0/13.3\text{Kpa}$ 者加服复方降压片 1 片/日 2 次。结果：显效（眩晕发作停止，随访 3 月无复发，头部 CT 示梗塞灶大部分吸收，全血粘度及还原血粘度均有改善）5 例，有效（眩晕发作停止，1 月内无复发，全血粘度或还原血粘度有改善）20 例，好转（眩晕发作次数明显减少，全血粘度及还原血粘度无变化）13 例，无效 2 例^[11]

3.8 王承训等用益气化痰法治疗眩晕 132 例 本组病例中高血压并动脉硬化 42 例，动脉硬化 33 例，颈椎病 34 例，其他 23 例。方用黄芪 30 ~ 50g，丹参 30 ~ 60g，葛根、鸡血藤各 30 ~ 40g，赤芍 20 ~ 30g，山楂 10 ~ 15g，川芎、当归、红花、广地龙各 10g，桃仁、生甘草各 9g。随症加减。水煎服，日 1 剂。结果：痊愈 87 例占 65.9%，显效 28 例占 21.21%，好转 12 例占 9.09%，无效 5 例占 3.8%。总有效率 96.2%^[12]。

4 固定方治疗

4.1 李树标用加味小柴胡汤治疗急性发作性眩晕 20 例 用柴胡 12g，法半夏、黄芩、党参、藿香、竹茹、白芍各 15g，防风、陈皮各 10g，大枣 20g，茯苓 25g，生姜 3 片。日 1 ~ 2 剂水煎顿服。结果：痊愈 14 例，显效 4 例，好转 2 例。停药后复发 2 例，用本方仍有效^[13]。

4.2 陈平用清眩宁治疗老年血循环障碍性眩晕 45 例 本方含天麻、陈皮各 10g，钩藤、菊花、远志、泽泻、白术、茯苓各 12g，丹参、磁石各 30g，山梔、甘草各 6g。日 1 剂，水煎分 3 次服。6 日为 1 疗程。忌服辛辣肥甘油腻之物。服 2 疗程后，治愈 13 例，显效 21 例，有效 9 例，

无效 2 例，总有效率为 95.5%^[14]。

4.3 李书义等用抗眩冲剂治疗中枢性眩晕 98 例 本品含灵磁石、川芎、丹参、葛根、钩藤、夏枯草、牛膝、制半夏等药，每包含生药 70g，1 包/日 2~3 次服，10 日 为 1 疗程，连用 2~3 疗程。合并高血压者配合降压药，低血压者用中药升压片，颈性眩晕者配合局部理疗。临床治愈 54 例，显效 27 例，有效 10 例，无效 7 例，总有效率为 92.85%^[15]。

4.4 沈宗国治疗良性阵发性位置性眩晕 39 例 药用熟地、党参各 24g、白芍、白术、当归、茯苓、川芎、陈皮、制半夏各 9g，巴戟天、肉苁蓉各 12g，甘草 3g，日 1 剂水煎服，6 剂为 1 疗程。服药 3~6 剂后，痊愈 30 例，显效 5 例，好转、无效各 2 例，总有效率为 94.87%^[16]。

4.5 睦勋华用仙鹤草治疗眩晕症 58 例 本组包括植物神经功能失调、低血压、脑动脉硬化症、内耳眩晕症。用仙鹤草 30g，鸡蛋 2 枚，日 1 剂水煮服，3 周为 1 疗程，停用其它药。结果：治愈 37 例，显效 12 例，有效 8 例，无效 1 例，总有效率 98.3%。未见不良反应^[17]。

5 中西医结合治疗

5.1 殷秋菊中西医结合治疗眩晕证 27 例 肝阳上亢用天麻钩藤饮加减；气血亏虚用归脾汤加减；肾精不足偏阴虚用左归丸加减，偏阳虚用右归丸加减；痰浊中阻用半夏白术天麻汤加减。日 1 剂水煎服。并用利多卡因 40~60mg，加 50% 葡萄糖液 40~60ml，静推（5 分钟内注毕）。结果：显效（药后 24 小时内症状消失）16 例，有效 9 例，无效 2 例^[18]。

5.2 许慧等中西医结合治疗颈椎病椎动脉型眩晕病

本组 119 例，用黄芪 15~20g，丹参 20~30g，当归、川芎、红花、赤芍、羌活各 10g。随症加减，日 1 剂水煎服，15 日为 1 疗程。与对照组 108 例，均用低分子右旋糖酐 500ml，加丹参注射液 16~20ml；10% 葡萄糖液 500ml，加胞二磷胆碱 0.5g，维生素 B₆200μg；静滴。并对症处理。结果：两组分别显效（症状基本消失）50、39 例，有效 61、31 例，无效 8、18 例，总有效率 93.2%、83.7%（ $P < 0.01$ ）^[19]。

5.3 张益进中西医结合治疗内耳眩晕病 观察组 100 例，病程 <1~9 年。辨证分型：1. 痰湿中阻型，眩晕欲倒，头重如蒙，舌淡白，苔白腻，脉沉滑，用温胆汤合半夏白术天麻汤加减。2. 肝郁痰结型，眩晕，情志抑郁，舌淡红，苔白腻，脉弦滑，用逍遥散合温胆汤加减。3. 脾虚痰聚型，眩晕无力，呕吐频繁，舌淡白，苔白腻，脉濡，用香砂六君合温胆汤加减。4. 肝肾阴虚型，眩晕耳鸣，耳聋，心悸不寐，舌红少苔，脉细数，用杞菊地黄汤加味。5. 心脾两虚型，眩晕，神疲纳减，舌淡苔薄白，脉虚，用归脾汤加减。6. 瘀血肉阻型，眩晕，头如针刺，痛处不移，舌淡紫，舌边有瘀点，苔薄白，脉细涩，用通窍活血汤加减。各型均配用西药：1. 口服谷维素片、维生素 B₁、B₆ 各 2 片/日 3 次；2. 50% 葡萄糖 60ml 加 10% 葡萄糖酸钙 10ml，维生素 B₆100mg，静注/日，连用 3~4 日；3. 烟酸片 100mg/日 3 次，安定 2.5mg/日 3 次。严重病例用阿托品 0.5mg 或 654-2 10mg 肌注，6 小时 1 次，共 2~3 次。对照组 34 例，单纯用西药治疗。结果：观察组与对照组分别为治愈 76 例、25 例，好转 20 例、5 例，无效各 4 例，治愈率 76%、73.53%，1 年后复发率为 10%、

33.3%。两组比较，对控制急性发作无明显差异 ($P > 0.05$)；复发率有显著差异 ($P < 0.05$)^[20]。

6 针灸治疗

6.1 赵义祥等针刺治疗眩晕证 58 例 取穴：定晕（耳尖上方 1cm 处）、舒肝（剑突右侧肋缘下 1.5 寸）。均快速进针。定晕穴用 2.5~3 寸 28 号毫针刺入 0.5cm，持续捻转 150~200 次/分钟，或提针向上、下、左、右斜刺 1.5cm，同速捻转 3~4 分钟，共 3 次，每次间隔 3~6 分钟，留针约 25 分钟。舒肝徐缓稍轻捻进皮下，猛刺一下约 2 寸深，不捻转迅速出针，剧痛为得气，日 1 次。15 日为 1 疗程，疗程间隔 2~3 日。用 1~3 个疗程，结果：治愈 45 例，显效 7 例，好转 5 例，未愈 1 例，总有效率 98.25%^[21]。

6.2 孙秀琴等针刺四神聪治疗眩晕 128 例 取穴四神聪，局部常规消毒，用 28 号 1 寸毫针快速刺入 5 分，得气后强刺激，留针 10 分钟，出针时开大针孔，使之出血更好。3 日针刺 1 次，5 次为 1 疗程。属肝阳上亢者加太冲、合谷；痰浊内阻者加丰隆、内关；气血亏虚肾精不足者加百会、足三里、三阴交；头痛者加太阳针刺放血。治疗 1~2 疗程，眩晕消失 77 例，明显改善 22 例，减轻 21 例，无改善或较前加重 8 例，总有效率为 93.75%。本组中内耳眩晕者 82 例经本法治疗后全部获效^[22]。

6.3 符文彬等在百会压灸治疗痰浊中阻型眩晕 63 例 本组包括颈椎病、低血压、美尼尔氏综合征、脑动脉硬化等 9 个病症。取百会穴，涂万花油，上置麦粒大艾炷并点燃，待局部有灼热感时，医者用拇指将艾火压灭并停留片刻，使热力向内传。每次压灸 3~5 壮，3~5 日 1 次。

治疗后，注意保持灸疱清洁。结果：痊愈 20 例，显效 19 例，有效 15 例，无效 9 例^[23]。

6.4 严愉芬用隔姜灸治疗眩晕症 50 例 痰湿中阻型取百会、足三里、风池、中脘；兼有外感风寒加大椎、合谷。气血两虚型取百会、风池、脾俞、隔俞。肾精亏虚型取肾俞、百会、绝骨、足三里。肝阳上亢型取太溪、三阴交、足三里、绝骨穴。每穴灸 5~7 壮，病重及体虚者可酌情加大壮数，艾炷以绿豆大小为宜，日 1 次，5 日为 1 疗程。结果：治愈 16 例，显效 29 例，好转 5 例，总有效率为 100%^[24]。

7 针药并用

林凌采用针刺配合中药治疗颈性眩晕 80 例 针刺：1 组取风池、风府。分别针 0.8~1.2 寸、1.5~1 寸，轻刺激，得气后留针 20 分钟，每隔 5 分钟捻转 1 次，出针揉按孔穴。2 组取椎间（位于增生椎体与上下椎体之间）。快速进针法，少捻转，多提插，中度刺激，针深 0.5~0.8 寸，得气后接脉冲治疗机，20 分钟出针。两组轮流，每日 1 次。并用葛根 20g，白芍 15~30g，鸡血藤 15g，川芎、首乌各 9g，丹参 12g，全蝎 8g。随症加减，后期重用补肾药。1~2 日 1 剂水煎服。结果：痊愈 28 例，显效 33 例，进步 14 例，无效 5 例，总有效率 93.8%^[25]。

参 考 文 献

- 1 崔永顺，等．黑龙江中医药．1989；（3）：15
- 2 王静怡，等．陕西中医学院学报．1990；13（2）：13
- 3 白峻峰，等．光明中医．1995；（2）：42

- 4 朱承胜, 等. 江苏中医 .1994; 15 (6): 8
- 5 李爱华, 新中医 .1995; 27 (6): 28
- 6 刘为熙, 等. 湖北中医杂志 .1996; 18 (6): 33
- 7 杨克文, 天津中医 .1993; (1): 38
- 8 何光明, 等. 河南中医 .1992; 12 (5): 231
- 9 关建国. 河南中医 .1995; 15 (3): 145
- 10 郑宪华, 等. 河南中医药学刊 .1997; 12 (2): 38
- 11 赵国民. 黑龙江中医药 .1991; (1): 20
- 12 王承训, 等. 北京中医 .1986; (5): 24
- 13 李树标. 实用中西医结合杂志 .1996; 9 (5): 294
- 14 陈 平. 山东中医杂志 .1992; 11 (6): 16
- 15 李书义, 等. 实用中西医结合杂志 .1990; 3 (3): 177
- 16 沈宗国. 中医杂志 .1991; 32 (11): 63
- 17 桂勋华. 吉林中医药 .1996; (5): 33
- 18 殷秋菊. 新疆中医药 .1996; 32 (11): 63
- 19 许 慧, 等. 实用中西医结合杂志, 1995; 8 (9): 522
- 20 张益进. 湖北中医杂志 .1988; (1): 34
- 21 赵义祥, 等. 针灸临床杂志 .1997; 13 (2): 7
- 22 孙秀琴, 等. 上海针灸杂志 .1991; 10 (3): 9
- 23 符文彬, 等. 成都中医药大学学报 .1995; 18 (4): 25
- 24 严愉芬. 针灸学报 .1991; 7 (1): 20
- 25 林 凌. 贵阳中医学院学报 .1993; 15 (3): 37

(李桂英)

痴 呆

痴呆是指所获得的大脑皮质高级功能的全面损害，包括记忆力、感觉及运动机能、日常生活能力、发挥社会职能、语言、交往及情感反应的控制，但不存在意识障碍。发病率约占老年人口的 2% ~ 4%。本病祖国医学亦称“痴呆”或“呆证”。

1 辨证论治

1.1 林长兴等以调心补肾方治疗老年性痴呆 80 例

心气不足型用调心方：党参、茯苓、甘草、石菖蒲、远志等；肾阴虚衰型用补肾方：天冬、麦冬、生地、熟地、山茱萸等。痰火加胆南星、天竺黄；肝火加夏枯草、旱莲草；血瘀加桃仁、红花；心火加黄连、木通。3 个月为 1 疗程。治疗 1 个疗程，结果：两组分别基本正常（智力分数提高 > 10 分，总分 > 20.5 分）11 例，显效 23 例，有效 25 例，无变化 18 例，无效 3 例^[11]。

1.2 徐仕珍治疗老年性痴呆 24 例

肝肾阴虚用补肾益脑汤加减：生地、首乌、山萸肉、枸杞子、菟丝子、丹参、白蒺藜、石菖蒲、郁金、黄精等；脾肾阳虚用右归丸加减：鹿角胶、菟丝子、肉桂、山萸肉、仙茅、枸杞子、熟地、砂仁等；痰浊壅塞用二陈汤加减：陈皮、半夏、茯苓、苍术、石菖蒲、白芥子、南星等；瘀血内阻用复方活血汤加减：柴胡、瓜蒌仁、当归、红花、穿山甲、大黄、桃仁、川黄连、南星等。日 1 剂水煎服，2 个月为 1 疗程。结果：显效（积分增加 > 10 分）12 例，有效 8 例，无效 4 例^[2]。

2 一方为主 辨证加减

2.1 张士云等用当归芍药散治疗老年性痴呆 21 例

用本方（当归、川芎、茯苓、泽泻、白术），气郁型加香附、郁金、合欢皮；痰阻型加菖蒲、郁金、远志、半夏；夹瘀血加丹参、桃仁、红花、地龙、蜈蚣。日 1 剂水煎服，30 日为 1 疗程。结果：痊愈 11 例，有效 6 例，无效 4 例，总有效率 81%^[3]。

2.2 王明文等用脑必复汤治疗老年痴呆 32 例 本方

含山萸肉 20g，紫河车 15g，五味子 6g，石菖蒲、远志肉、炙僵蚕、川芎各 10g。阴虚火旺加盐知母、盐黄柏；阳虚明显加肉苁蓉、炮附片；痰浊偏盛加半夏、茯苓、白术、郁金；脾肾两虚加山药、白术、补骨脂、党参；心肝火盛加黄芩、山梔、黄连、龙胆草；气滞血瘀加桃仁、红花、当归、赤芍；失眠加炒枣仁、夜交藤。日 1 剂水煎服。1 个月为 1 疗程，疗程间隔 1 周。治疗期间停用西药，配合语言及功能训练。结果：显效 9 例，有效 17 例，无效 6 例，总有效率 84.4%^[4]。

2.3 陈桂铭用补肾益脑汤治疗老年性痴呆 25 例 本

方含黄芪、党参、何首乌、枸杞子、桂圆肉、淮山药、当归各 15g，石菖蒲、远志、益智仁、巴戟天、山萸肉、菟丝子、天麻各 10g，熟地 20g，珍珠母 30g。肝肾亏虚加生地、龟板、女贞子、桑椹子；脾肾两虚加白术、茯苓、藿香、佩兰，黄芪、党参剂量加至 30~40g；心肝火盛合用黄连解毒汤；气滞血瘀加丹参、赤芍、川芎。以上均可加兔脑、猪脊髓等。日 1 剂水煎服。服药 30 日以上，结果：显效（主症基本消失，神志清醒，定向健全，生活自理等）8 例，有效（主症减轻或部分消失，生活基本自理，

但反应迟钝，智力与人格仍有部分障碍）7例，无效10例^[5]。

2.4 冯金海等用益灵汤治疗老年性早期痴呆症 50例

药用黄芪 90g，天麻、龙眼肉各 9g，山萸肉、泽泻各 15g，杜仲 10g，远志、水蛭各 6g，菖蒲 12g，山药 30g。肾阴虚加女贞子、旱莲草；肾阳虚加紫河车、肉桂；痰湿阻窍加半夏、胆南星。日 1 剂水煎服。1 月为 1 疗程。治疗 1~5 疗程，痊愈 37 例，有效 7 例，无效 6 例^[6]。

2.5 孙继铭用益肾髓痰汤治疗早老性痴呆 12 例

本方含熟地、肉苁蓉、炙龟板各 24g，山茱萸、黄精、郁金各 15g，白蒺藜、僵蚕、天麻各 12g，黄芪、石菖蒲、制南星、红花各 10g。肾阳虚加淫羊藿 10~15g，菟丝子 12g；阴虚有热去制南星，加黄柏、黄连各 5~10g，知母 12g；痰湿征象明显去肉苁蓉，加半夏、陈皮各 10g，佩兰 5~10g。日 1 剂水煎服。服药 1~4 个月后，显效 3 例，有效 8 例，无效 1 例^[7]。

2.6 王昌俊以益智灵为主治疗老年性痴呆 51 例

本品含太子参 30g，制胆星、天冬各 10g，熟地 20g，川芎、炙远志各 6g。制成口服液，含生药 2g/ml。30ml/日 2 次服。兼痰火扰心加礞石滚痰丸；肝肾阴虚甚加杞菊地黄丸；气郁不舒加四制香附丸；血瘀阻络明显加丹参注射液静滴；心肾不交加磁朱丸。配合脑力训练。1 个月为 1 疗程。治疗 1~4 个疗程，基本恢复 18 例，显效 13 例，有效 16 例，无效 4 例，总有效率为 92.2%。CCSE 平均增加 7.58 分，FAQ 平均降低 9.13 分，自身前后对比， $P < 0.01$ ；精神意识能力和社会功能活动能力明显增强^[8]。

3 一方为主 随症加减

3.1 韩颖萍等用益智醒脑汤治疗老年期痴呆 35 例

用本方：益智仁、骨碎补、补骨脂、天竺黄、石菖蒲、广郁金、川芎各 10g，何首乌 18g，枸杞子、丹参各 30g。气虚加人参、党参、白术；血虚加鸡血藤；血瘀加益母草、水蛭；阳虚加附子、肉桂、肉苁蓉；口角流涎加白术；口眼歪斜加白附子、全蝎；步履蹒跚加蜈蚣、钩藤；上肢痿软加桂枝，下肢加桑枝；心神不安、失眠多梦加茯神、枣仁、龙齿。日 1 剂水煎服，7 日为 1 疗程。结果：显效（智力评分增加 2 个等级或基本正常，社会活动功能基本正常）2 例，有效 8 例，改善 14 例，无效 11 例^[9]。

3.2 杜曦用涤痰化痰汤治疗老年痴呆 38 例 本组包括脑血管性痴呆、阿尔采默性痴呆，用本方：半夏、茯苓、枳实、石菖蒲、郁金、竹茹、僵蚕各 10g，胆星、天麻各 12g，丹参 30g，陈皮、甘草各 6g。舌苔白腻加苍术、白术；头痛加钩藤、菊花；肢体震颤加全蝎、蜈蚣；偏瘫加桃仁、地龙；失眠心悸加辰砂、龙齿；急躁易怒加川黄连、山栀；便秘腹胀加大黄、川朴；神疲气短加党参、黄芪。日 1 剂水煎服，1 个月为 1 疗程。治疗 3 个疗程，结果：显效（痴呆面容消失，反应较为灵敏，记忆力明显增强，语言清晰，口角不流痰涎，步履变稳，生活能自理）11 例，好转 13 例，无效 14 例^[10]。

3.3 善才人用补肾活血汤治疗老年性痴呆 32 例 本方含黑附子（从 5~10g 开始，渐增，最大量 30~60g；先煎 2 小时）、桂枝、川芎、白芍各 12g，干姜 5g，炙黄芪 30g，潞党参、熟地各 20g，白术、菟丝子、炒杜仲、菖蒲各 15g，淫羊藿 10g，甘草 6g。口角流涎、小便清长加益

消失，神识清醒，反应灵敏，生活自理）74例占40.22%，有效90例占48.91%，无效20例占10.87%，总有效率89.13%。血管性优于老年性及混合性痴呆（ $P < 0.001$ ）。血清T-ch、LDL-ch，红细胞SOD活性、血浆LPO治疗前后比较均有显著性差异， $P < 0.01$ 或 $0.05^{[18]}$ 。

5 中西医结合治疗

5.1 楼晓佳等中西医结合治疗脑血管性痴呆 12例

用解语丹加味：天麻12g，牛膝、甘草各5g，全蝎、白附子各10g，石菖蒲、胆南星各20g，远志15g，羌活6g，丹参30g。气虚加黄芪；心神不宁加酸枣仁；肾气阳虚痰瘀加淫羊藿、鹿角霜；肾气阴虚痰瘀加玉竹、石斛；肢体偏瘫疼痛加鸡血藤、路路通。日1剂水煎服。西药用维脑路通0.4g，加5~10%葡萄糖液250ml，静滴，日1次。哑门穴（对下颌骨方向缓慢刺入1~1.5寸，以不刺进脊膜为度）注射脑活素1ml；风池（双，略斜向下或向双侧眼眶内下缘方向进针1~1.5寸）各0.5ml；日1次，两穴交替使用，穴注后观察5分钟。结果：显效（临床症状明显改善，MMSE评分提高10~15分）4例，好转6例，无效2例。有效者随访0.5~2年，加重2例^[19]。

5.2 段从存等中西医结合治疗老年性痴呆症 30例

本方含生地、熟地各20g，巴戟天、山萸肉各10g，菟丝子、枸杞子、远志各12g，制首乌、太子参、黄芪各15g，炒酸枣仁30g，纳差加麦芽、山楂、鸡内金，阳虚加肉苁蓉；阴虚加女贞子、麦冬；伴动脉粥样硬化性心脏病加丹参、当归、川芎。日1剂水煎服。妄想为主症用舒必利0.6~1.0g/日，其余用奋乃静40~60mg/日，分2~3次口

服。症状改善或消失后，渐减或停用；继用本方2周。治疗1~3个月，结果：显效（内省力恢复，生活自理，记忆力部分恢复）21例，好转8例，无效1例^[20]。

6 针灸疗法

6.1 赖新生针刺治疗老年性血管性痴呆 两组各30例。本组主穴取四神针（百会左右前后各旁开1.5寸）、智三针（本神、神庭）、水沟；配穴：神门、后溪、足三里、太溪。前两穴均用平刺法，进针0.8~1寸，得气后接G6805-1型电针仪，连续波。45次/分钟，电流强度以患者耐受为度。留针45分钟，15分钟行针1次，施提插捻转手法。日1次，12次为1疗程，疗程间隔3日。对照组用阿尼西坦0.2g/日3次口服。均用42日，结果：两组分别痊愈6、3例，有效20、16例，无效4、11例，总有效率86.7%、63.3%（ $P < 0.05$ ）^[21]。

6.2 沈卫东等针灸治疗老年痴呆40例 取穴：合谷、神门、间使、足三里、三阴交、太冲（均双）、神庭（沿督脉向上沿皮刺，行捻转法）。烦躁升火加风池、太溪；流涎不止加地仓、颊车；言语蹇涩加廉泉；胸闷心悸加内关；小便不利加关元、中极；偏瘫取外关、曲池、环跳、阳陵泉、昆仑等。直刺0.5~1寸，提插捻转法，得气后，留针30分钟。同侧足三里与三阴交加电针，用G6805-II型治疗仪，频率2Hz，方波连续刺激30分钟。再取穴：百会，隔药饼（含附子、麻黄、肉桂等，研粉，加水、蜂蜜，制成圆饼，厚1cm）艾炷灸3壮，约1小时。隔日1次，30次为1疗程。结果：显效10例，有效24例，无效6例。多数症状明显改善（ $P < 0.001 \sim 0.05$ ）^[22]。

6.3 杨湘潭报道针灸醒脑开窍法为主治疗老年性痴呆 26 例 取水沟（向上斜刺 0.5 寸）、内关透外关（进针 1 寸许），得气后，提插强刺激半分钟；太溪（直刺，进针 0.5~1 寸）、悬钟（直刺，进针 1~1.5 寸），得气后，行捻转补法，上穴均每次取 1 侧，两侧交替使用，留针 30 分钟。取风池（双），斜刺，平补平泻法，留针 20 分钟。取百会（沿皮刺）、大椎（向上斜捻转进针 1.5~2 寸），行补法半分钟，起针后，均艾灸 3~5 分钟。均用 28 号毫针，日 1 次，10 次为 1 疗程，疗程间隔 2 日，10 次后酌情隔日 1 次。结果：治愈 9 例，显效 11 例，有效 4 例，无效 2 例^[20]。

7 综合疗法

7.1 罗玉凤等采用针药并治老年痴呆 30 例 (1) 头针：取双侧语言二区或晕听区，快速进针并捻转 3~5 分钟，不留针，日 1 次，30 日为 1 疗程。(2) 体针：主穴取百会、风池、哑门、大椎、神门、大陵。心脾虚配心俞、脾俞、足三里；肝肾虚配肝俞、肾俞、志室、太溪、复溜、行间；痰郁血瘀配内关、膈俞、丰隆。除任督二脉穴外均双侧，每次选主穴 3~4 个，配穴 2~3 个，进针得气后用补法（行间为泻法），提插捻转，留针 15 分钟，背俞穴可不留针。隔日 1 次，15 次为 1 疗程，疗程间隔 3~5 日。(3) 穴注：多发梗塞性痴呆取双肾俞、足三里，用当归注射液 4ml，每穴注射 1ml，日 1 次；脑萎缩取哑门、双风池、双肾俞，用乙酰谷酰胺注射液 5ml，每穴注射 1ml，隔日 1 次；均 20 次为 1 疗程。(4) 取穴：心、脑、皮质下、肾、内分泌、神门、肝等，用王不留行籽贴压，各穴交替使用，1 个月为 1 疗程。并按辨证分型用中药。

治疗 3~6 个月, 结果: 痊愈 10 例, 有效 18 例, 无效 2 例, 总有效率为 93%^[24]。

7.2 张怀法采用中药按摩并治老年期痴呆 40 例 本组均为多发性脑梗塞所致血管性痴呆。髓海不足型用左归饮加减; 肝肾亏虚型用知柏地黄汤加减; 心肝火盛型用黄连解毒汤加减; 脾肾两虚型用归脾汤和金匱肾气汤; 痰浊阻窍型用二陈汤加减; 气滞血瘀型用血府逐瘀汤加减。日 1 剂水煎服。取穴: 太阳、风池、内关、合谷、足三里、三阴交 (均双)、百会、哑门。强刺激, 快速重按, 得气后, 留针 2~3 分钟, 日 1~2 次, 20 日为 1 疗程。并用丹参注射液、脉络宁交替静滴, 15 日为 1 疗程。治疗 3 个疗程, 结果: 痊愈 22 例, 有效 16 例, 无效 2 例, 总有效率 95%^[25]。

参 考 文 献

- 1 林长兴, 等. 上海中医药杂志 .1995; (9): 8
- 2 徐仕珍. 上海中医药杂志 .1995; (5): 5
- 3 张士云, 等. 安徽中医学院学报 .1996; 15 (6): 20
- 4 王明文, 等. 山西中医 .1994; 10 (3): 28
- 5 陈桂铭. 中医函授通讯 .1992; 11 (1): 15
- 6 冯金海, 等. 河北中医 .1993; 15 (2): 14
- 7 孙继铭. 新中医 .1992; 24 (11): 56
- 8 王昌俊. 中国医药学报 .1993; 8 (1): 33
- 9 韩颖萍, 等. 中医研究 .1995; 8 (2): 37
- 10 杜 曦. 浙江中医学院学报 .1995; 19 (1): 25
- 11 善才人. 云南中医中药杂志 .1997; 18 (2): 5
- 12 刘积庆. 陕西中医 .1996; 17 (3): 112

- 13 蔡春华 . 江苏中医 .1994; 15 (11): 9
- 14 廖方正, 等 . 成都中医药大学学报 .1996; 19 (1): 20
- 15 郑向黎, 等 . 光明中医 .1997; (1): 43
- 16 邱秉新, 等 . 中药药理与临床 .1993; 9 (3): 4
- 17 侯光明, 等 . 湖南中医学院学报 .1992; 12 (4): 27
- 18 尚炽昌, 等 . 中国医药学报 .1996; 11 (5): 36
- 19 楼晓佳, 等 . 实用医学杂志 .1996; 12 (1): 51
- 20 段从存, 等 . 安徽中医学院学报 .1994; 13 (3): 28
- 21 赖新生 . 中国针灸 .1997; 17 (4): 201
- 22 沈卫东, 等 . 上海针灸杂志 .1996; 15 (5): 5
- 23 杨湘潭 . 中国针灸, 1996; 16 (11): 3
- 24 罗玉凤, 等 . 针灸临床杂志 .1995; 11 (1): 15
- 25 张怀法 . 光明中医 .1996; 11 (4): 41

(彭文杰)

三叉神经痛

三叉神经痛，是三叉神经分支范围内反复发作的阵发性短暂剧烈疼痛的一种病症。多见于中老年人，女性略多于男性。由于疼痛的部位多着重于面部，故祖国医学称为“面痛”。

1 一方为主，随症加减

1.1 谢玉坤用面痛化解汤治疗三叉神经痛 73 例 本方含丹参 15g，川芎、当归、赤芍、秦艽、钩藤各 12g，红花 9g，珍珠母 30g，僵蚕、白芷各 10g，甘草 5g。风寒袭络加细辛 3g，防风 6g，羌活 9g；风热入络加菊花 12g，黄芩 10g，生石膏 30g；阴虚阳亢加黄柏 10g，龟板 20g，生地 10g；血瘀阻络加桃仁 9g，王不留行 15g。日 1~2 剂水煎服，6 日为 1 疗程。结果：显效 45 例，有效 22 例，无效 6 例，有效率为 91.7%^[1]。

1.2 魏承昌等用患痛汤治疗三叉神经痛 42 例 本方含白芷、蝉蜕、穿山甲、僵蚕、全蝎、甘草各 10g，细辛 9g，白蒺藜 12g，川芎、当归、枸杞子各 1g，白芍、生地、炒枣仁各 18g，蜈蚣 2 条（研冲），制马钱子 15g（冲）。肝胆火盛加羚羊角粉、丹皮、栀子、龙胆草；肝肾阴虚加元参、女贞子、旱莲草、牛膝；痰浊瘀阻加白附子、胆南星、郁金、半夏；腑实加大黄、枳实、青黛；血瘀加制乳香、制没药、丹参；虚寒加天麻、桂枝、干姜。日 1 剂水煎服。忌食冷、热、酸、辣食物。停用止痛剂。用 1~3 个疗程，结果：痊愈 30 例，显效 8 例，有效 4 例^[2]。

1.3 阎国章用患痛饮治疗三叉神经痛 168 例 方用

李仁、天麻、全蝎粉（吞）各 6g，白芷子 10g，黑木耳 15g。痛甚加柴胡、没药；烦热加生石膏、荆芥；面、颌肿加金银花；血压高兼目痛加夏枯草、白蒺藜；偏寒加细辛、制川乌；痛久加黄芪、红花。用药 2~12 剂，结果：均痊愈^[6]。

1.7 朱久育等用镇痛汤治疗特发性三叉神经痛 13 例

本组中第 2 支发病者 4 例，第 3 支 7 例，2、3 支同时发病者 2 例；8 例曾服去痛片或酰胺咪嗪不效，3 例拔除 7 颗牙、开髓治疗两颗牙无效。本方含细辛、白芷、僵蚕各 12~18g，制半夏、知母各 9~12g，蝉蜕 6g。血瘀加鸡血藤、当归、赤芍、蜈蚣；气滞加延胡索、川芎、柴胡、青木香；痰盛加陈皮、苍术、天麻；肝阳上亢加磁石、生龙骨、生牡蛎。服药 9~57 剂，结果：缓解 4 例，显效 5 例，有效 3 例，无效 1 例，总有效率为 92.3%^[7]。

1.8 蒋吉林用牵正散加味治疗原发性三叉神经痛 27 例 基本方：全蝎、僵蚕、白附子各 10g。苔黄热重者加龙胆草；外风诱发者加白芷；病程长、抽掣痛剧烈者加蜈蚣。诸药共研细末，分为 10 包。1 包/日 1~2 次，饭后以黄酒吞服，10 日为 1 疗程。经治 1~3 疗程后均获愈；1 年后随访仅 1 例复发，再服本品 1 疗程面愈^[8]。

1.9 戚清权等用祛风活血方治疗三叉神经痛 41 例

本方含天麻、钩藤、地龙、僵蚕、白附子、全蝎、甘草各 10g；羚羊角粉 0.6g，蜈蚣 2 条，丹参、川芎各 30g，赤芍 15g。阳亢热盛加生石膏、知母、生大黄；寒凝经脉加制川乌、制草乌、白芷、细辛；气血虚弱加党参、黄芪、当归。日 1 剂水煎服。结果：显效 14 例，有效 21 例，无效 6 例，总有效率 85.4%。血液的流速、流量治疗前与正常

人比较及与治疗后再比较均有显著性差异， P 均 $< 0.05^{[9]}$ 。

1.10 杨进茹等用通络止痛饮治疗三叉神经痛 96 例

本方含川芎、羌活、荆芥、僵蚕、青皮、防风、秦艽各 10g，细辛 5g，鸡血藤 30g，菊花 15g，石膏 20g，蜈蚣 2 条，全蝎、甘草各 6g。面部潮红、灼热感重，加龙胆草。日 1 剂水煎服。结果：治愈 85 例，有效 10 例，无效 1 例，总有效率 98.6%^[10]。

2 外用药物治疗

2.1 李志文用龙蝎饼治疗三叉神经痛 45 例 取地龙 5 条，全蝎 20 个，路路通 10g，生南星、生半夏、白附子各 50g，细辛 5g，共为细末，加一半面粉，用酒调成饼并摊贴于太阳穴，敷料固定，每日换药 1 次。结果：治愈 42 例，好转 3 例，疗程最长 6 日，最短 2 日^[11]。

2.2 杨金文等用止痛膏穴位敷贴治疗原发性三叉神经痛 65 例 药用樟脑、细辛各 10g，薄荷 12g，五加皮 15g，全蝎、龟板胶、当归、白芷、寻骨风各 30g，蒲公英、紫花地丁、川芎各 45g。除樟脑、龟板胶外，均经炮制、干燥粉碎，取香油 500 ~ 750g 在锅中烧至滴水成珠时，加入上药，充分搅拌均匀，文火至沸，冷凉即成膏状。3g 为 1 丸。用时略加温后压成圆饼状，敷贴患侧，据受累神经不同，选择不同的穴位，3 日换 1 次。结果：治愈 62 例，显效、好转、无效各 1 例，总有效率为 98.46%^[12]。

2.3 李澎涛等用克面痛散搐鼻治疗三叉神经痛 62 例

本组用本品：萆薢（漂洗烘干）、木鳖子（去壳）、藿香（漂洗烘干）、冰片按 5:5:1 的比例，四药混合精研 1 小时，过 180 目筛，贮瓶备用。搐鼻时将火柴大小体积的药

粉（约0.05g）置纸折中，利用痛侧鼻孔吸气的力量将药粉吸入。首次应在痛时吸入，隔10分钟再吸，以后隔3小时1次，每日4次。对照组42例用双料喉风散。两组均用药4日。结果：两组分别完全缓解44、1例，显效8、4例，有效5、6例，无效5、31例，总有效率91.9%和26.2%。两组疗效比较有显著性差异， $P < 0.01$ 。随访3~8年者38例，复发3例（7.9%）。在疼痛缓解的同时，三叉神经分布区域皮肤痛阈也相应提高。本品对三叉神经2、3支的疗效最好^[13]。

3 中西医结合治疗

3.1 孔荣中西医结合治疗原发性三叉神经痛 50 例

本组均用三叉神经痛汤：当归、夏枯草各12g，白芷10g，细辛3g，钩藤15g，升麻6g。日1剂水煎服，10日为1疗程，疗程间隔1~2日。合并高血压重用夏枯草、钩藤；失眠者钩藤加倍，症状减轻后用上方加黄芪、党参，继续巩固2~3疗程。同时口服维生素B₁20mg/日3次；维生素B₁₂500~10000μg肌注，共用1~2周。结果：优（疼痛消失）32例，良（疼痛明显减轻）17例，差1例^[14]。

3.2 王绍武等中西医结合治疗原发性三叉神经痛 37 例

本组用自拟痛宁汤：川芎20g，生石膏、生地、白芍各30g，知母、黄连、天麻、甘草各10g，生大黄6~10g（后下），麦冬15g，蜈蚣2条。日1剂水煎服，7日为1疗程。维生素B₁₂500μg/日1次肌注，2周为1疗程。疼痛甚、病程长者予卡马西平0.1~0.2g/日3次口服，3~5日停用。结果：治愈26例，显效4例，有效5例，无效2例，总有效率94.6%^[15]。

3.3 张立民等中西医结合治疗三叉神经痛 86 例 本

组用白芍 30~60g, 全蝎 6~10g, 蜈蚣 3 条, 川芎 30g, 炙甘草 15g。肝胃热加生石膏、龙胆草; 遇风痛重加白芷、荆芥、细辛; 病久痛甚加制马钱子粉 (0.3g); 瘀血阻络加红花、丹参、元胡等。日 1 剂水煎服, 用 10 日。与对照组 83 例, 均用经皮穿刺麦克氏囊注药法: 术前 30 分钟用安定 10mg, 肌注。患者仰卧, 标记: 患侧外耳孔前 3cm, 正视之瞳孔中央下方眼睑, 无菌下用 9 号腰穿针在患侧口角外 3cm 处作穿刺点, 针头指向内后上方, 针尖到达卵圆孔后再进针 1cm, 即到麦克氏囊, 拔出针芯, 有脑脊液溢出, 注入 1% 利多卡因 0.2ml, 1 分钟后痛觉消失, 注入消痛液 (含甘油、维生素 B₁₂、利多卡因等) 0.5ml, 患者取头低位 30 分钟。仍痛者 5 日后再次注射, 1~2 次为 1 疗程。结果: 两组分别治愈 82、66 例, 好转 2、3 例, 无效 2、14 例, 总有效率 97.7%、83% ($P < 0.01$)。随访 1 年, 复发 4、12 例^[16]。

4 针刺疗法

4.1 袁永珍针刺止痛灵穴为主治疗原发性三叉神经痛 28 例 主穴: 健侧止痛灵穴 (屈肘成 90°角, 曲池前、下各 1 寸, 距手三里 2 寸处); 1 支痛加太阳; 2 支痛加下关; 3 支痛加颊车。针法: 本穴刺入 1.3 寸, 得气后行龙虎交战手法, 使针感放散至肩峰为佳。取太阳呈 30°角向下关方向刺 1 寸余, 以针下酸胀感为度。取下关针尖以 85°角向后下方, 朝对侧乳突方向刺 1 寸, 使酸胀感扩散至耳区。取颊车沿皮刺透地仓, 以局部酸胀或向周围扩散为宜。留针 20~30 分钟, 5 分钟行针 1 次, 行补泻兼施手法。日 1 次, 10 次为 1 疗程。结果: 治愈 20 例, 显效 3 例, 进步 4 例, 无效 1 例, 总有效率为 96.4%^[17]。

4.2 吴奇方针刺三孔穴治疗三叉神经痛 49 例 主穴：第 1 支取眶上孔鱼腰穴，第 2 支取眶下孔四白穴，第 3 支取颊孔夹承浆穴。均取患侧穴。外感风邪、风袭经络者加外关；肝阳上亢、肝胃郁热者加太冲、内庭；气血不足、阴虚火旺者加太溪。鱼腰直刺 2 分，四白针尖向下刺 8 分，夹承浆斜刺 1 寸，要求毫针必须刺入神经孔中，使面部出现强烈针感或触电感。配穴用常规刺法。留针 30 ~ 40 分钟，日 1 次。对照组 30 例，用西药治疗。10 日为 1 疗程，治疗 3 疗程。结果：两组分别痊愈 30、10 例，好转 13、8 例，无效 6、12 例，总有效率 87.7%、60%。两组疗效比较有显著性差异， $P < 0.025^{[18]}$ 。

4.3 朱桂等针刺治疗三叉神经痛 150 例 1. 1 支痛取眶上孔，用 30 号 1 寸毫针，在攒竹、鱼腰两穴联线的中点眶上切迹处刺入，向内上方进针 0.5 ~ 0.8 寸，待有触电样感传至前额时，捻转提插约 1 分钟。2. 2 支痛取颧下凹，用 28 号 2 寸针在颧弓下缘水平线与髁突前缘垂直线之交叉点呈垂直方向刺入 1.2 ~ 1.6 寸；针眶下孔，在鼻翼外侧 0.5cm 处向外上方与鼻中隔呈小于 45° 方向刺入 0.8 ~ 1.0 寸，有电击感时大幅度提插捻转约 1 分钟。3. 3 支痛取颧下凹（方法同上）；取颊孔，用 28 号 2 寸毫针在一、二双尖齿牙槽突缘与下颌下缘间中点向前下方刺入，有电击感时捻转提插约 1 分钟。以上均间歇运针，留针 30 ~ 60 分钟；1 ~ 2 日 1 次。结果：治愈 67 例，显效 57 例，好转 24 例，无效 2 例^[19]。

4.4 周继荣采用深刺下关穴为主治疗原发性三叉神经痛 32 例 主穴取患侧下关，辅穴取健侧合谷。第 1 分支痛加阳白、攒竹、鱼腰；第 2 分支痛加四白、迎香、禾

膠；第3分支痛加承漿、頰車、翳風。用瀉法。針刺下關穴用30號2.5寸毫針，針尖以85度角向后下方朝對側乳突方向深刺2寸左右，用緊提慢按手法，使針感向下頷方向或四周擴散并持續20~30秒。留針30~60分鐘，其間每10~15分鐘提插行針1次，出針前再提插行針約30秒。每日1次，10次為1療程，療程間隔1周。結果：近愈15例，好轉16例，無效1例^[20]。

4.5 石信箴用鋒針點刺太陽穴治療三叉神經痛80例

主穴取太陽。1支痛配陽白透魚腰；2支痛配四白；3支痛配下關、夾承漿；感受風寒配風池、合谷；肝胃火盛配內庭、陽陵泉；陰虛火旺配照海、三陰交、太沖、太溪。以消毒鋒針點刺主穴，進針約0.2~0.3cm，起針后立即拔火罐，使出血2~3ml。配穴用毫針刺，補虛瀉實，寒証加灸法。2日1次，3次為1療程，療程間隔3~5日。結果：痊愈（疼痛完全消失，1年內未復發）56例，明顯好轉（疼痛明顯減輕，發作減少）15例，好轉3例，無效（治療9次無變化者）6例，總有效率為92.5%^[21]。

4.6 張和平採用群針密刺治療三叉神經痛 沿疼痛的三叉神經根干尋找最痛點，用0.5~1.5寸毫針緩緩向下直刺，得氣後在該痛點之前後左右相距0.5~1厘米處依法各刺1針，留針90分鐘，每20分鐘捻轉1次，平補平瀉。每日1次，10次為1療程，療程間隔4~5日。一般2~5療程痊愈。針刺時必須使針感達到痛處，並要有適當深度。留針期間，要让病人集中思想，意念配合，閉目體會針感。治療48例，效果滿意^[22]。

4.7 袁明澤等採用一穴多針治療原发性三叉神經痛85例 主穴：听宮（患側，用30號毫針，閉口取穴，快

上。治疗 1~3 疗程。结果：三组显效率分别为 82.0%、40.0%、52.0%；总有效果分别为 96.0%、77.8%、78.0%。本组疗效优于两对照组 ($P < 0.01$)，对控制病例中的 60 例随访 18 个月，复发率为 16.7%，再经本法治疗又获愈^[27]。

6.2 戚耀等采用穴位封闭治疗原发性三叉神经痛 62 例 主穴：下关、阿是穴（扳机点）。配穴：1 支痛取鱼腰、阳关；2 支痛取颧髁、四白；3 支痛取大迎、夹承浆。每次取主穴 2 个，配穴 1 个，均患侧。取注射用地塞米松 5mg，注射用水 1ml，用 5 号半或 6 号针头刺入穴位有针感、无回血时缓慢注入药液，每穴 0.5~1ml，出针后稍压片刻，日 1~2 次，10 日为 1 疗程，疗程间隔 5~7 日。结果：痊愈 32 例，显效 14 例，有效 11 例，无效 5 例，总有效率 91.9%^[28]。

6.3 刘士杰采用全息疗法治疗三叉神经痛 86 例 本组患者均取双手第二掌骨桡侧近指掌关节处（本全息胚的全息相关头穴），用 5ml 注射器 6 号针头略斜刺入，探测到强针感后，各注入威海制药厂生产之当归寄生注射液 2ml，3 日重复 1 次。痛惊宁对照组 44 例按常规服药。1% 普鲁卡因封闭对照组 12 例，于双侧中渚穴各注入该药 2ml，3 日重复 1 次。治疗 15 日后，本组痊愈（诸症消失，2 月无复发）46 例，好转（发作次数及疼痛程度明显减轻）36 例，无效 4 例，总有效率为 95.3%。痛惊宁组和普鲁卡因组分别为好转 32 例和 7 例，无效 12 例和 5 例，均无痊愈者；总有效率分别为 72.7% 和 58.3%。治疗组疗效明显优于对照组 ($P < 0.005$)^[29]。

参 考 文 献

- 1 谢玉坤. 福建中医药 .1993; 24 (6): 26
- 2 魏承昌, 等. 山东中医杂志 .1996; 15 (12): 541
- 3 阎国章. 天津中医 .1992; (5): 9
- 4 阙淑华. 甘肃中医学院学报 .1991; 8 (3): 53
- 5 田林忠, 等. 中级医刊 .1994; 29 (10): 57
- 6 张普照, 等. 内蒙古中医药 .1995; (4): 16
- 7 朱久育, 等. 四川中医 .1988; 6 (8): 31
- 8 蒋吉林. 浙江中医学院学报 .1989; 13 (3): 17
- 9 戚清权, 等. 上海中医药杂志 .1994; (6): 44
- 10 杨进茹, 等. 安徽中医学院学报 .1995; 14 (4): 15
- 11 李志文. 陕西中医 .1989; 10 (5): 223
- 12 杨金文, 等. 时珍国药研究 .1993; 4 (1): 11
- 13 李澎涛, 等. 中医杂志 .1994; 35 (1): 35
- 14 孔 荣. 新中医 .1987; (3): 35
- 15 王绍武, 等. 北京中医 .1993; (2): 25
- 16 张立民, 等. 中国中西医结合杂志 .1995; 15 (10): 630
- 17 袁永珍. 山西中医 .1991; 7 (3): 37
- 18 吴奇方. 陕西中医 .1993; 13 (4): 179
- 19 朱 桂, 等. 上海针灸杂志 .1991; 10 (4): 15
- 20 周继荣. 江苏中医 .1989; 10 (2): 18
- 21 石信箴. 山西中医 .1991; 7 (5): 32
- 22 张和平. 河北中医 .1989; 11 (2): 30
- 23 袁明泽, 等. 中国针灸 .1996; 16 (4): 41
- 24 刘桂良. 安徽中医学院学报 .1987; 6 (2): 38
- 25 王文远. 针灸临床杂志 .1993; 9 (4): 28
- 26 胡佐芳, 等. 四川中医 .1987; 5 (11): 47

- 27 袁三衡, 等. 中华理疗杂志 .1992; 15 (2): 83
- 28 戚 耀, 等. 陕西中医学院学报 .1993; 16 (1): 43
- 29 刘上杰. 山东中医杂志 .1989; 8 (5): 20

(杨淑莲)

面神经麻痹

面神经麻痹指颞骨内面神经管内段的面神经发生急性非化脓性炎症面引起的周围性面瘫。常见于中、青年，多因受寒着凉、循环障碍、病毒或非特异性感染造成面神经肿胀，受相对狭窄的面神经管压迫，髓鞘、轴突变性而致。表现为一侧面颊部表情肌瘫痪，额纹消失，鼻唇沟变浅，口角下垂，眼裂不能闭合。祖国医学称本病为“口眼喎斜”，认为由脉络空虚，风寒乘虚侵袭所致。

1 一方为主 辨证加减

1.1 王广智用苍耳子散辨证加味治疗面神经炎 87 例

用本方（苍耳子 6~12g，辛夷 9~12g，白芷 9~15g，薄荷 3~15g）加味：风寒外袭型酌加荆芥、防风、羌活、细辛、川芎；风热上感型酌加桑叶、菊花、浮萍、蝉蜕、桔梗、川芎、葛根；肝经风热型酌加天麻、钩藤、黄芩、龙胆草、栀子、柴胡、地龙；风痰阻络型酌加天南星、白附子、清半夏、天花粉、天麻、川芎、苍术等；风邪久羁型酌加当归、川芎、红花、威灵仙、防风、细辛、皂刺，另用三虫散（全蝎 100g，蜈蚣 10 条，金钱蛇 1 条，焙干，研细末）2~3g/日 2~3 次冲服，配合针灸、理疗。均日 1 剂水煎服。结果：痊愈 80 例，显效 5 例，有效 2 例，有效率 100%^[1]。

1.2 夏时金用龙胆泻肝汤治疗急性周围性面瘫 31 例

用龙胆草、木通、泽泻、柴胡、车前仁、当归、栀子各 10g，生地 12g，黄芩 15g，甘草 6g。兼风热表证加银花藤、钩藤、菊花；兼风寒表证加防风、白芷；半月未愈加白术、薏苡仁。日 1 剂水服分 3 次服。3 例配合针灸治疗。

经治 15 ~ 30 日，治愈 26 例，好转 5 例^[2]。

1.3 申屠小良用白附芎麻汤治疗周围性面神经麻痹

本方含白附子 6 ~ 10g，川芎、天麻各 10 ~ 12g，蜈蚣 2 ~ 3 条，全蝎 5 ~ 10g，防风、白芷、僵蚕、葛根各 10g。风热外感加金银花、菊花、蝉蜕；风寒外感加麻黄、桂枝；头晕加钩藤、水杨梅；气血亏虚加黄芪、当归。结果：痊愈 20 例占 57.1%，显效 12 例占 34.3%，好转 3 例占 8.6%^[3]。

2 一方为主 随症加减

2.1 陈立富用葛根牵正汤治疗周围性面瘫 86 例 本方含葛根 15 ~ 50g，麻黄 15 ~ 20g，桂枝、白附子、川芎各 10 ~ 30g，羌活、防风、僵蚕各 10 ~ 15g，全蝎 5 ~ 10g（研粉冲服），甘草 6g。湿盛腮肿或眼睑浮肿加茯苓、苍术；发热加柴胡、黄芩。日 1 剂水煎服，儿童酌减。服 3 ~ 5 剂汗出后，减麻黄、桂枝、葛根、羌活用量，加红花、当归、黄芪。恢复期用十全大补汤。结果：痊愈 79 例，好转 5 例，无效 2 例，总有效率 97.67%^[4]。

2.2 王胜用祛风通络饮治疗周围性面瘫 100 例 本方含羌活、防风、川芎、当归、僵蚕、桃仁、红花各 10g，蜈蚣 1 条，全蝎、桂枝尖、生甘草各 6g。风热加蝉蜕、大青叶；表虚自汗加黄芪、党参；肝阳上亢加石决明、钩藤、天麻；痰湿加天南星、白附子；面麻日久不愈蜈蚣加倍，加稀莩草、地龙。日 1 剂水煎服，10 日为 1 疗程，治疗期间停用它法。结果：痊愈 51 例，显效 20 例，好转 17 例，无效 12 例。年龄 < 40 岁、> 40 岁，病程 < 半个月、> 半个月总有效率分别为 96.4%、76.7% ($P < 0.05$)，97.9%、78.8% ($P < 0.01$)^[5]。

3 固定方治疗

3.1 姜成才用顺风匀气散治高病程面神经麻痹 100 例 本组病程 3~36 个月。均用本品（白术 20g、人参、天麻各 10g，炙甘草、沉香、青皮、紫苏叶、白芷、木瓜各 5g，乌药 15g，为细末）40~80g/日，加水 200ml，纱布包煎 10 分钟，日 2 次口服，10 日为 1 疗程。治疗 1~4 疗程后，痊愈 76 例，显效 7 例，进步 8 例，无效 9 例，总有效率 91%。平均用药 33.4 日^[6]。

3.2 徐福明等用黄芪桂枝五物汤加味合牵正散治疗面神经麻痹 68 例 用黄芪 30g，桂枝、赤芍、白芍、当归、威灵仙各 15g，生姜、大枣、甘草各 10g，白芷、防风、秦艽各 12g，细辛 3g。日 1 剂水煎服，10 日为 1 疗程。用牵正散（全蝎、白僵蚕、白附子各 20g，共为细末）3g/日 2 次温热水或温黄酒冲服。儿童剂量酌减。结果：痊愈 62 例，好转 6 例^[7]。

3.3 方基虎用补中益气汤加味治疗产后面瘫 26 例 用炙黄芪、当归各 15g，党参、白芍各 12g，炒白术、陈皮各 10g，炙甘草、桂枝各 6g，柴胡、升麻各 3g。日 1 剂水煎服。用 10~20 剂，结果：治愈 20 例，显效、好转各 3 例。随访 1 年无复发^[8]。

3.4 周复峻治疗面神经炎 35 例 用制南星、防风各 40g，日 1 剂，晚睡前武火煎煮取液，1 次服，服后盖被取汗。结果：治愈 34 例，好转 1 例，均未复发^[9]。

4 外用药物治疗

4.1 李三贵用面瘫散治面瘫 本品含川乌、草乌、白附子各 0.5g，白芥子 7 粒，巴豆仁 1 粒（去油），斑蝥 1 只（去头足），麝香 0.2g。共研极细末，密封备用。将医

用胶布剪成 1.5~2cm 直径圆形，内敷 2 层 0.5cm² 消毒纱布，撒药末，贴于患侧太阳、迎香、颊车和地仓穴，5~7 天自行脱落，无痛苦，不留瘢痕。贴敷 1~2 次可愈。附病案 1 则，患本病 3 月余，经贴本品 1 次而愈^[10]。

4.2 邵胜前等用乳没散外敷治疗面瘫 107 例 用药棉蘸少许松节油涂擦患处，再用本品（乳香、没药、白及、蝉蜕各等份，共研末）适量，调鸡蛋清外敷，厚 2~3mm，覆盖塑料薄膜，胶布固定，2~3 日 1 次。结果：痊愈 103 例（96.3%），好转 3 例，无效 1 例^[11]。

4.3 唐寿延自拟正容散穴位敷贴治疗面瘫 123 例 本品含白芷、番木鳖等份，配 1/10 的冰片，研细末，取药末 1~2 分撒于直径约 2cm 的胶布或伤湿解痛膏上，贴于患侧下关穴，4~6 日换 1 次。治疗 3~4 次后，痊愈 112 例，好转 9 例，无效 2 例^[12]。

4.4 张运和用巴豆斑蝥生姜膏治疗面瘫 50 例 本组病程 1 天~6 月。取大巴豆 3 枚去壳，大斑蝥 3 只去足翅，鲜生姜 6g 去皮，捣为泥状，均匀摊在 4cm×5cm 的 6~8 层纱布上，药膏面积 2.5cm²，以患侧下关穴为中心外敷，用胶布固定 3~4 小时后取掉。此时可出现水泡，当按无菌操作方法沿水泡下缘抽出液体。观察 2~3 周，若不愈，可重复治疗 1~2 次。结果：痊愈 45 例，显效 2 例，好转 1 例，无效 2 例。疗程 10~45 天^[13]。

4.5 孙裕民等用附子桂枝膏治疗面神经麻痹 50 例 用白附子 20g，肉桂 15g，研末，加陈醋 200g，煎至约 50g，加阿胶 15g（烱化），摊白布上敷患侧。并饮姜糖水 1 杯。结果：痊愈 45 例，有效 4 例，无效 1 例，总有效率 98%^[14]。

4.6 张庆瑞用皂角膏治疗面神经炎 38 例 取大皂角 6g, 去皮与籽研末, 过 500 目筛, 入铜锅或铜勺 (忌铁器), 用微火炒至焦黄色, 再入醋 30g 收匀成膏。把药膏平摊于敷料上厚约 3mm, 贴于口角处, 左歪贴右, 右歪贴左, 贴药时稍向患侧牵拉固定。每日 1 次, 2 日后改为间日 1 次至病愈。敷药 1~18 次后, 全部获愈, 随访 1~5 年无复发^[15]。

4.7 陈安辉用面麻膏药治疗面神经麻痹 本组 100 例均属周围性面神经麻痹患者, 病程 2~180 天。每张膏药含马钱子粉 1g, 樟脑粉 0.3g, 膏药脂 4g, 经加热调匀后涂于 7cm×7cm 的膏药布上。用时将膏药烘软并贴在患侧耳垂前面神经干区域, 4 天换药 1 次。用本膏药 1~8 张, 经过 4~32 天的治疗后, 痊愈 98 例, 好转 2 例, 对 57 例随访 1~4 年未见复发^[16]。

4.8 朱新武等用马钱子外敷治疗特发性面神经麻痹 52 例 本组发病时间 6 日~3 个月。取市售马钱子适量, 置清水中浸泡 24 小时后捞出, 沿纵轴切成厚约 1mm 薄片, 将其间隔 0.5cm 排列粘附于橡皮膏上, 然后贴于患侧面颊。7 日换 1 次。结果: 全部治愈, 其中用药 1 次痊愈者 42 例, 2 次 8 例, 3 次 2 例^[17]。

4.9 张丽丽等采用劳宫穴巴豆液蒸汽熏喷治疗周围性面神经炎 取巴豆 5g 捣碎并装入小口瓶中, 加优质白酒 250 毫升浸泡 1 日后, 连瓶置于器皿中加热, 沸后离火, 将掌心置瓶口上, 以能耐受为度, 左侧发病熏右手, 右侧发病熏左手, 至无热感为止, 每日熏 1 次, 共观察 47 例, 熏治 15~25 次后, 痊愈 44 例, 好转 3 例^[18]。

4.10 高德清等用巴椒栓熏鼻治疗面瘫 56 例 将巴

豆 10 粒去皮后烧焦，用多层吸油纸包裹微烘成巴豆霜；大枣 8 枚去核；加胡椒 15 粒、葱心 1 个共捣。根据鼻孔大小制成栓剂，睡前放入患侧鼻孔内，微汗后清晨取出，每晚 1 次。治疗 2~4 次，痊愈 54 例，好转 2 例，治愈 96.43%^[19]。

5 内外并治

张万能用川芎茶调散治疗周围性面神经麻痹 54 例

本组患者均用本方，偏风热加柴胡、桑叶、菊花、忍冬藤、连翘；肝阳偏亢加夏枯草、钩藤、白蒺藜、地龙、丝瓜络；夹风痰加白附子、僵蚕、全蝎；气血不足加当归、黄芪。日 1 剂水煎服。另取川芎、荆芥各 120g，防风 45g，白芷、羌活、甘草各 60g，细辛 30g，薄荷油 5g，研成细末（为 5~7 日用量）。用时加适量茶水调敷于患侧面颊地仓、颊车、巨髃、牵正、听宫、瞳子髎等穴位约 1~1.5cm 厚，每日换药 1 次，5 日为 1 疗程，疗程间隔 1 日。结果：痊愈 50 例，显效 3 例，有效 1 例。治疗 5~36 日，平均 18.5 日^[20]。

6 中西医结合

6.1 朱连才中西医结合治疗面神经麻痹 36 例

用搜风活络汤：羌活、僵蚕各 10g，防风、赤芍各 12g，蜈蚣 1 条（研冲），全蝎（研冲）、甘草各 3g，桑枝 20g，丹参 15g。因风热致加板蓝根、蚤休、忍冬藤；气虚加黄芪；阴虚加黄精；头晕加天麻；局部僵木加白附子；脉数弦加地龙；肌痉挛加葛根、蝉蜕；高血压加罗布麻；日久加当归、肉苁蓉、草乌。日 1 剂水煎服。西药用维生素 B₁、芦丁片各 40mg，地巴唑、谷维素各 20mg，均日 3 次口服。治疗 2~24 日，结果：均获愈。随访 3 月，无复发^[21]。

6.2 何允宏等用西咪替丁和新加率正散治疗西神经炎 47 例 用本方：银花、蝉蜕各 30g，连翘 15g，白附子、僵蚕、全蝎各 10g，丹参 20g。便秘加大黄；心火上炎，舌边溃疡加黄连、山栀子；气虚汗出加黄芪。日 1 剂水煎服。并用西咪替丁 0.2g/日 4 次口服。对照组 42 例，用泼尼松 10mg，维生素 B₁20mg，均日 3 次口服；聚肌胞 2mg，维生素 B₁₂0.5mg，均日 1 次肌注。治疗 10 日，结果：两组分别痊愈 29、15 例，显效 10、12 例，有效 7、8 例，无效 1、7 例，总有效率 97.9%、83.3% ($P < 0.05$)^[22]。

6.3 杨树云中西医结合治疗面神经麻痹 6500 例

(1) 挑刺：以患侧内颊膜咬合线上相当于第 2 磨牙处为 1 点，距该点前、后 0.4cm 处各取 1 点，在咬合线上、下约 0.4 厘米的平行线上各取相应的 3 点，共 9 个挑刺点。每点用三棱针以雀啄式由浅而深约挑刺 20 次，至出血为度。然后清洁口腔。2. 芥敷：用温水调白芥子末 10~20g 为糊状后，摊在消毒纱布上（芥糊面积约 4cm²、厚 0.5cm（小儿酌减），敷于患侧颊部（相当于地仓、下关、颊车穴之间）24 小时，去敷药后可见红肿或少许水泡，按烫伤换药 2~3 次即可。3. 西药：B 族维生素、地巴唑、加兰他敏，有的加特定电磁波（TDP）治疗。计挑刺芥敷组 2047 例、挑刺芥敷加西药组 4191 例、挑刺芥敷加 TDP 组 262 例，结果 3 组总有效率分别为 96.2%、98.3%、99.6%，后两组的疗效均优于单纯挑刺芥敷组 ($P < 0.01$)^[23]。

6.4 吴宾容治疗周围性面神经炎、面神经麻痹 100 例

1. 急性炎症期：西药消炎为主，用肾上腺皮质激素，成人 10 毫克/日 3 次口服，1 周后减量；用抗生素及维生素 B₁、B₁₂、C。针灸以取手足阳明经穴为主，平补平泻，

运动点（鱼腰与丝竹空连线中点上 2 分处，透刺阳白），口轮匝肌运动点（口角上下各 3 分处，透刺人口），眼轮匝肌运动点（外眼角直下 3 分处，透刺承泣），鼻肌运动点（攒竹穴直下与四白穴水平线交点处，自下点向上点透刺）。得气后，小幅度快速捻转约 10 秒钟，留针 30 分钟，10 分钟行针 1 次；日 1 次，10 次为 1 疗程，疗程间隔 2~3 日。用 10~40 日，结果：治愈 57 例，显效 4 例，进步 6 例，无效 5 例，总有效率 93.1%^[27]。

7.4 孟庆良等采用滞针法治疗周围性面瘫 150 例

本组主穴：颊车透地仓，地仓透承浆，四白透迎香，阳白透鱼腰，太阳透下关，颧髎透人中（均患侧）；配穴：曲池（双）。常规消毒后，用 1.5~2.5 寸毫针，先针曲池，用泻法，得气后，留针 30 分钟；再以 15°角透刺主穴，提插捻转有针感后，向同一方向捻针，至医者手下出现沉紧感，将针滞紧，双手捏针柄，由进针方向倒退将面肌持续牵拉 10 秒钟，间隔 10 秒钟，重复上述手法 2 次；休息 10 分钟，再重复上述手法 2 遍出针。对照组 145 例，主穴同上，配穴：合谷。主穴进针得气后，用平补平泻法，合谷用泻法，留针 30 分钟，10 分钟行针 1 次，出针后按压针孔。均日 1 次，7 日为 1 疗程，疗程间隔 2 日。结果：两组分别痊愈 136（90.7%）、98（67.6%）例（ $P < 0.05$ ），好转 12（8.0%）、42（28.9%）例，无效 2（1.3%）、5（3.5%）例。两组病程 1 周内痊愈率分别为 96.9%、77.7%（ $P < 0.05$ ），病程短者疗效佳（ $P < 0.05$ ）^[28]。

7.5 程旺毅采用络刺法治疗周围性面瘫 120 例

主穴：阳白、四白、迎香、地仓、大迎、颊车；配穴：下关、上关、攒竹、瞳子髎、合谷。除合谷取双侧外，均取

患侧穴，常规消毒，用13~25mm长毫针，速进速出，针刺深度5~10mm，令出血，风寒阻滞型和风热阻滞每穴连刺3~4针，出血4~5滴（约0.1ml）；风痰瘀血阻滞型每穴连刺5~6针，出血5~8滴（约0.15ml）。日1次，10日为1疗程。结果：痊愈104例占87%，显效12例占10%，无效4例占3%^[29]。

7.6 李又刚点刺内颊车治疗面瘫50例 治法：取穴内颊车（面颊部口腔内，正对颊车穴处），用三棱针常规消毒后，点刺患侧本穴，深2~3mm，而后挤压出血，温开水漱口，隔2日1次。结果：治愈36例，好转8例，无效6例，总有效率为88%。病程短者疗程短疗效佳，病程长者疗效较差，病程3~7日31例，治疗10次，全部治愈；半年以上者5例，治疗30次，好转2例，无效3例^[30]。

7.7 施土生采用五透法治疗面瘫512例 （1）面部五透法：太阳透颊车，地仓透颊车，四白透地仓，攒竹透鱼尾，阳白透鱼腰、鱼尾、攒竹。（2）配穴：承浆透颊车，挟水沟透颊车，颧髎透颊车；酌情选听宫、翳风、水沟、合谷穴等。急性期，发病<7~10日，每日针1次，15日为1疗程，以后隔日1次。后遗症，隔日1次，15次为1疗程。病程在3~6个月以上者，可采用综合措施，如穴位注射、灸法、按摩、梅花针及埋线疗法等。结果：急性398例，痊愈388例占97.4%，显效8例占2.01%，有效2例占0.5%，总有效率100%；慢性104例，显效90例占86.54%，有效9例占28.65%，无效5例占4.81%，总有效率95.19%；后遗症10例，有效8例，无效2例^[31]。

7.8 王民集等报道邵经明教授沿皮透刺治疗面瘫 216

例 主穴：阳白、攒竹、丝竹空、四白、下关、地仓、颊车、合谷。耳后乳突部疼痛配翳风、完骨；枕后疼痛配风池；耳廓热痛配耳尖放血；头晕、耳鸣配中渚、太冲；头痛配太阳；面颊板滞不适配颧髎；病久体弱配足三里。针刺患侧地仓、颊车沿皮相互透刺；阳白、攒竹、丝竹空沿皮透刺至鱼腰；四白穴针尖与表皮呈 15° 角沿皮透刺至地仓；合谷穴（两侧交替）针尖稍上向斜刺；提插捻转运气，使针感向上传导至面颊。泻法。留针 30 分钟，行针 2 次，初病日针 1 次，10 次为 1 疗程。不愈者改 2 日针灸 1 次，用补法，地仓、颊车、足三里穴加灸。结果：痊愈 173 例，显效 23 例，有效 17 例，无效 3 例，总有效率为 98.61%^[32]。

7.9 杨金安等采用指针加隔姜灸治疗顽固性面瘫 122

例 主穴：太阳、四白、地仓、颊车。配穴：合谷、太冲。取患侧主穴施揉扣混合术。揉法：以拇指或中指指端行环形按揉，使皮肤及皮下组织一起做圆形转动，平揉 1 小圆周为 1 次，每穴 40~60 次。扣法：用指力按压皮肤及皮下组织深部，得气后逐渐减轻指力，每穴 2 分钟。配穴施点捏法：用指尖对准穴位往下直捏，用力均匀，平补平泻手法，不马上抬手，两侧穴位交替，每穴 1~2 分钟，患侧手法宜重，治疗次数多于健侧。然后施隔姜灸，将 0.2~0.3cm 厚鲜姜片中央穿数孔置于穴位上，将蚕豆大艾炷置于姜片上点燃，连灸 4~6 壮。日 1 次，10 次为 1 疗程，疗程间隔 2~4 日，治疗 2 个疗程。结果：基本痊愈 72 例占 59.02%，显效 31 例占 25.41%，好转 13 例占 10.66%，无效 6 例占 4.91%^[33]。

竹空，反复 5~8 次；向内上推挤翳风穴 1~2 分钟，手法可重至有胀感；并用揉、拿法施术于合谷、风池穴，各 0.5~1 分钟。对照 1 组 47 例，单用针灸；对照 2 组 46 例，单用推拿。治疗 6~60 日，结果：三组分别治愈 46 (97.9%)、40 (85.1%)、39 (84.8%) 例，显效 1、7、6 例，好转 0、0、1 例。本组疗效优于两对照组 ($P < 0.05$)^[35]。

8.2 李圣平采用电针配合穴位敷贴治疗面神经炎 88 例 本组取穴：患侧翳风、下关、颊车、地仓、太阳，健侧合谷。针刺得气后，以三对导线分别按翳风-颊车，下关-地仓、太阳-合谷组连接 DG-1 电针治疗仪，断续波频率 26 ± 6 次/分钟，强度以病人耐受为度，通电 30 分钟，日 1 次，10 日为 1 疗程，疗程间隔 1 日。电针结束后取翳风、下关、太阳穴，局部消毒后，用消毒的刀片在穴处皮肤各划一带血痕的小 $\times$ ，然后将少许药粉（冰片、乳香各 10g，丁香、肉桂各 6g，维生素 B₁ 20 片，共研细末）粘在 3 块 $1.2\text{cm} \times 1.2\text{cm}$ 麝香止痛膏胶布中心，分别贴于上 3 穴，日 1 次。对照组 57 例单用电针治疗。结果：分别痊愈 80、44 例，有效 6、4 例，无效 2、9 例，两组比较有显著性差异， $P < 0.01$ 。本组疗程较对照组短^[36]。

8.3 王光鼎以针刺配合外敷中药治疗面瘫 226 例 风寒闭阻经络型：针刺取合谷、地仓、承浆、颊车、人中、迎香为主穴；配合睛明、攒竹、风池、百会、太阳。药用生草乌、白及、炙南星、僵蚕、洋白附子各 30g，全蝎 15g，麝香少许，研末，分 6 份，加新鲜鳝鱼血适量调成糊状，针后立即外敷患侧，日 1 次。风热闭阻经络型：针刺取外关、翳风、颊车、承浆、人中、迎香为主穴；配

合谷、下关、攒竹。肝肾阴虚，风痰阻络型：针刺取地仓、颊车、人中、合谷、太冲为主穴；配合风池、百会、太溪、三阴交、足三里、曲池、丰隆、阳陵泉。配合局部外敷中药。以上均灸患侧地仓、颊车每穴 10 分钟。先针健侧，后针患侧。健侧施泻法。留针 20 分钟，日 1 次。治疗 2 个月后治愈 219 例，好转 7 例^[37]。

8.4 张正广以挑刺加芥末外敷治疗周围性面神经麻痹 (1) 挑刺法：先用 3% 硼酸水漱口，术者 1 手持长柄三棱针，1 手将病人患侧唇颊部外翻以充分暴露内颊粘膜，并以相当于地仓穴的对应点“内地仓穴”为第 1 挑刺点。由此点沿咬合线向后挑 2 个点，每点间隔 0.5cm，然后在咬合线的上下各 0.5cm 处的平行线上，于上述第 1~2 挑刺点和第 2~3 挑刺点之间各挑刺 1 点，共挑 7 点，均用三棱针行雀啄式挑刺，由浅而深，深度约 1~2mm，范围约 0.3cm。每点挑刺 20 次左右，以使其出血并略有痛感为宜。若在患侧粘膜见有怒张的小静脉血管，可点刺放血。(2) 芥末外敷法：黄或白芥子 5~10g 研为细末，调成糊状，敷于患侧颊部相当于地仓、下关、颊车 3 穴之间约 2.5cm² 大小，用胶布固定。也可根据病情增加外敷部位，如眼不能闭合加敷太阳或承泣穴约 1cm² 大小等等。一般外敷 3~12 小时取下，不宜超过 24 小时。本组患者年龄 2 月~84 岁，病程 1 日~24 年。经 1~8 次以上治疗的 915 例，痊愈 725 例 (79.2%)，明显好转 169 例 (18.5%)，无效 21 例 (2.3%)^[38]。

8.5 郑国东采用刺络拔罐法治面瘫 取穴：病在阳明经取阳白、颊车、迎香；病在太阳经取颧髻、太阳、地仓；病在少阳经取丝竹空、下关、牵正。用三棱针点刺 3

~5次或用梅花针扣刺皮肤至血色斑点，后拔火罐10分钟。急性期以患侧为主，每日1次，恢复期双侧交替使用，隔日1次；疗程间隔3~5日。附验案1则^[39]。

9 其它疗法

9.1 于雷以推拿治疗周围性面瘫 本组患者取仰卧位，医者先后点揉双侧攒竹、太阳、阳白、鱼腰、四白、迎香、下关、颊车、地仓、人迎、翳风，以及承浆穴，频率120~160次/分，约6分钟；两拇指从眉弓抹至发际，再从眼眶抹至下颌，约3分钟；重复上述手法2~3遍。用一掌心轻揉患侧眼球1分钟，再用震颤法2分钟；一手提患侧耳垂，固定面部，另一手在患侧面部用擦法约20次，以透热为度；最后点揉风池、合谷穴各1分钟；每次20分钟。对照组用五官超短波治疗机（北京医用设备厂生产），将两电极分置于患侧茎乳突孔处及耳前区，微热剂量，每次15分钟。均7次为1疗程，治疗3个疗程。两组各39例，分别痊愈29、3例，显效6、7例，有效4、20例，无效0、9例，总有效率100%、79.8%。本组疗效优于对照组（ $P<0.05$ ）^[40]。

9.2 陶学成以单纯手法治愈面瘫42例 手法均于患侧：（1）用整个拇指罗纹面由睛明穴沿眉经鱼腰穴、丝竹空、瞳子髎至太阳穴推抹1~2分钟。（2）用中指指端罗纹面重按并加以节律性刺激，鱼腰、牵正、承浆、水沟、翳风各穴1~2分钟。（3）用拇指尖端按地仓穴上，食指尖端按在颊车穴上，两指同时对捏1~2分钟。（4）用大鱼际或掌根推擦眼轮匝肌、额肌、皱眉肌、咬肌、颊肌等有关表情肌部分，反复推擦，直至整个患部发热、发红，深达皮下肌层。可适用润滑剂如按摩乳、酒精姜汁等。5.

- 11 邵胜前, 等. 江苏中医 .1996; 17 (11): 20
- 12 唐寿延. 江苏中医 .1990; 11 (7): 26
- 13 张运和. 山东中医杂志 .1986; (5): 28
- 14 孙裕民, 等. 中国乡村医生 .1996; 12 (12): 38
- 15 张庆瑞. 浙江中医杂志 .1989; 24 (6): 257
- 16 陈安辉. 江苏中医 .1988; 9 (6): 31
- 17 朱新武, 等. 中级医刊 .1989; 24 (1): 45
- 18 张丽丽, 等. 中华理疗杂志 .1990; 13 (3): 172
- 19 高德清, 等. 吉林中医药 .1993; (4): 26
- 20 张万能. 浙江中医杂志 .1989; 24 (6): 255
- 21 朱连才. 江苏中医 .1994; 15 (10): 6
- 22 何允宏, 等. 中西医结合实用临床急救 .1996; 3 (7): 297
- 23 杨树云. 中级医刊 .1991; 26 (4): 63
- 24 吴宾容. 黑龙江中医药 .1988; (5): 17
- 25 薛 浩. 新疆中医药 .1990; (1): 37
- 26 刘洪奎. 黑龙江中医药 .1989; (1): 32
- 27 李建波. 针灸临床杂志 .1996; 12 (12): 10
- 28 孟庆良, 等. 针灸临床杂志 .1995; 11 (7): 36
- 29 程旺毅. 上海针灸杂志 .1995; 14 (5): 217
- 30 李又刚. 内蒙古中医药 .1989; (3): 12
- 31 施土生, 等. 中医药研究 .1989; (6): 13
- 32 王民集, 等. 针灸临床杂志 .1993; 9 (4): 4
- 33 杨金安, 等. 中国针灸 .1992; 12 (4): 5
- 34 张 俊, 等. 上海针灸杂志 .1997; 16 (2): 22
- 35 朱必伟. 针灸临床杂志 .1996; 12 (2): 23
- 36 李圣平. 上海针灸杂志 .1992; 11 (1): 6
- 37 王光鼎. 云南中医杂志 .1991; 12 (1): 38
- 38 张正广. 山东中医杂志 .1986; (5): 25
- 39 郑国东. 中医药研究 .1990; (6): 40
- 40 于 雷. 按摩与导引 .1994; (1): 4

- 41 陶学成 . 按摩与导引 .1987; (5): 7
- 42 王俊德 . 中国乡村医生 .1994; (6): 27
- 43 陈冬秀 . 中国针灸 .1988; 8 (5): 5
- 44 陈建新, 等 . 中医药研究 .1993; (1): 42
- 45 薄 庆 . 四川中医 .1994; 12 (2): 29
- 46 杨桂荣, 等 . 针灸临床杂志 .1994; 10 (5): 19

(张仲全)

本组患者病程 1 ~ > 30 天。基本方含桂枝、当归、白芍各 15g, 通草 5g, 细辛、甘草各 3g, 大枣 5 枚。病发于上肢者加羌活、防风、荆芥各 10g; 病发于下肢者加川牛膝、苍术各 10g, 木瓜、薏苡仁各 15g; 四肢同病者上药合用。若外邪已解, 则用基本方加黄芪 20g。结果: 痊愈 8 例, 好转 2 例。附 1 病例上下肢同病 2 日, 住院后按上法服药 12 剂痊愈, 随访 1 年无复发^[3]。

1.4 李广振用黄芪桂枝五物汤加味治疗末梢神经炎 51 例 本方含黄芪 45g, 白芍 15g, 桂枝、当归各 10g, 桑寄生、鸡血藤各 30g, 生姜 6g, 大枣 4 枚。伴疼痛加制没药; 伴肿胀加薏苡; 皮色紫暗加桃仁; 上肢偏重加片姜黄; 下肢偏重加怀牛膝; 肌萎缩加服人参养荣丸或十全大补丸; 糖尿病患者配合降糖药物。结果: 治愈 (症状消失, 局部肿胀消除, 皮色恢复正常) 36 例, 好转 (症状减轻, 肿胀消除, 皮色改善) 11 例, 无效 4 例, 总有效率为 92.2%^[4]。

2 固定方治疗

2.1 徐应坤等用马钱子酒治疗多发性神经炎 6 例

取制马钱子、当归、川牛膝、红花、乌梢蛇、蚕砂各 60g, 蜈蚣 60 条, 白花蛇 2 条。共为粗末, 水煎 3 次, 合并滤液, 浓缩至 1500ml, 兑入白酒 1500ml, 装瓶备用。服用量从小量开始逐渐加大, 常用量为 10ml/日 3 次。根据患者体质、年龄、病情, 用量可以增减, 但日用量不得超过 60ml。用药后出现局部肌肉跳动感、患肢微僵直感是最佳治疗量的标志, 认为用本品治疗 1 个月左右要服 1 次接近中毒的剂量, 但要防止严重过量中毒。因此, 掌握用量是治疗本病成败的关键。为便于观察毒性反应, 以住院

治疗为宜。经本法治疗均取得显著效果。心脏病、高血压、严重的肝肾疾病患者慎用，＜12岁忌用^[5]。

2.2 杨云志用马钱子治疗糖尿病并发末梢神经炎性疼痛 15例 用本品（取马钱子成熟种子，于麻油中炸至膨胀焦黄，滤油，冷研细末，过80目筛，装胶囊，每粒200mg）1粒/日3次口服，连用3日，无效者停药。治疗3~9日，结果：显效（疼痛消失）10例，有效4例，无效1例^[6]。

2.3 王家琳等采用益气活血法治疗糖尿病合并多发性神经炎 8例 基本方：黄芪30g，党参12g，当归、赤芍、川芎、地龙、桃仁、红花、苏术、僵蚕、生地、熟地各10g，丹参15g，枳实6g。日1剂，水煎分3次服，30日为1疗程。并每日用达美康及消渴丸适量。治疗1~3个疗程，结果：临床治愈、显效各3例，有效2例^[7]。

3 外用药物治疗

张进华等用云南白药酒治疗末梢神经炎 20例 用50°~60°白酒1斤，加入云南白药粉40g，放置1昼夜后，将患肢浸入药酒内，并反复揉搓，以肌肤发热为度。每次30分钟，日2次，于午时和子时治疗，15日为1疗程。期间禁食油腻，冷酸之品，禁涉冷水、过劳。经治2~5个月，能参加正常劳动，随访1年以上未复发者7例；明显减轻者13例^[8]。

4 内外并治

4.1 陈超等用黄芪桂枝五物汤加味治疗多发性神经炎 35例 本组用本方为基本方，感觉障碍为甚加当归、川芎；运动障碍为甚加附片、白术；营养机能障碍为甚加熟地、红花。日1剂水煎服。另加生姜酒浸1周后外擦。

对照组 27 例，用强的松、地巴唑口服，维生素 B₁₂、加兰他敏肌注。两组均连续用药 14 日为 1 疗程，疗程间隔 3 日。结果：两组分别治愈 6、2 例，显效 10、6 例，有效 16、10 例，无效 3、9 例，总有效率 91.43%、66.67%。两组疗效比较有明显差异， $P < 0.01$ ^[9]。

4.2 赵新爱等用归芪通络汤治疗多发性神经炎 18 例

本方含当归、桂枝、党参各 10g，生白芍 20g，川牛膝、川木瓜、炒白术各 15g，黄芪、鸡血藤、桑枝各 30g，细辛 3g。水煎服日 1 剂，药渣再加水煎取 1500ml，兑入白酒或黄酒 50g 熏洗患肢。病在上肢重用桑枝；病在下肢重用川牛膝；疼痛加川草乌，四肢末梢发凉甚者加炮附子；肢体困重加薏苡。经 2 疗程治疗后，痊愈（症状消失，能从事一般体力劳动，随访 1 年无复发）10 例，好转 8 例^[10]。

5 中西医结合

王庆余等中西医结合治疗糖尿病性周围神经炎 33 例

本组用补气活血祛湿汤：黄芪 60g，桂枝 10g，白芍、鸡血藤各 20g，丹参 30g，当归、稀莪草、威灵仙、党参各 12g，大枣 3 枚。本组与对照组 21 例，均控制血糖，用维生素 B₁20mg/日 3 次口服，维生素 B₁₂500μg/日 1 次肌注。结果：两组分别痊愈 10、1 例，有效 22、14 例，无效 1、6 例，有效率 96.9%、71.4% ($P < 0.01$)^[1]。

6 中药配合捏脊疗法

石晓军采用中药配合捏脊治疗多发性神经炎 9 例 本组患者病变均未波及颅神经及躯干肌、肋间肌和横膈肌。予扶正治痿汤：莲子肉、龟板各 15g，芡实、麦冬、甘草、板蓝根、木瓜、山药各 10g，黄芪 25g，当归、连翘各 20g，牛膝 7.5g。肺热津伤加沙参、天冬；湿热浸淫加

- 10 赵新爱, 等. 浙江中医杂志 .1989; 24 (3): 106
- 11 王庆余, 等. 中级医刊 .1994; 29 (10): 56
- 12 石晓军. 吉林中医药 .1990; (6): 21
- 13 金 镜, 等. 辽宁中医杂志 .1996; 23 (4): 184
(谷克义)

急性感染性多发性神经根神经炎

急性感染性多发性神经根神经炎，又称急性炎症性脱髓鞘性神经病，俗称格林-巴利综合征。主要损害多数脊神经根和周围神经，也常累及颅神经，是多发性神经炎中最常见的一种类型。本病属于祖国医学“痿证”范畴。

1 辨证论治

1.1 陈连起辨证治疗急性感染性多发性神经根炎 27

例 本组患者均有不同程度肢体麻痹，其中伴呼吸肌麻痹 15 例，颅神经麻痹 11 例。(1) 湿热浸淫型（急性期），治以清热燥湿、解毒通络，用苍术、薏苡、虎杖各 15g，黄柏 9g，川牛膝 10g，忍冬藤、板蓝根、鸡血藤各 30g。吞咽困难用旋覆代赭汤，呼吸困难用六君子汤或独参汤，肺部感染用千金苇茎汤加味。(2) 脾气虚损，瘀阻筋脉型（恢复期），治以益气健脾、化瘀通络，用生黄芪 30~60g，赤芍 15g，川芎、地龙、桃仁、红花各 9g，当归 10g，鸡血藤、桑枝各 30g。(3) 肝肾亏虚，筋脉失养型（恢复期），治以滋补肝肾，壮筋通脉，用熟地黄、怀牛膝、白芍各 15g，知母、黄柏各 9g，当归、仙灵脾各 12g，木瓜、干姜各 10g，巴戟天 12g，桑枝 30g。同时针刺颈部及四肢肿大淋巴腺或加电刺激，并配合西药对症治疗。结果痊愈 8 例，基本痊愈 7 例，好转 9 例，死亡 3 例^[1]。

1.2 张秋才等辨证治疗急性感染性多发性神经根炎

20 例 肺热型用养阴清肺汤加减。湿热型用加味四妙汤加减。寒湿型用羌活胜湿汤加减；初期用麻黄加术汤加川乌、草乌（先煎）；中焦寒湿改用附子理中汤。脾虚型用清暑益气汤加减。肾虚型用痿证方加味（熟地、寄生、山

黄肉、玄参、石斛、川断、沙参、麦冬、五味子)，随症加减。均日1剂水煎服，15剂为1疗程，一般3个疗程。结果：痊愈9例，显效6例，有效4例，无效1例^[2]。

2 分期论治

冯福海等治疗格林-巴利综合征9例 (1) 急性期：黄芪60g，黄精、银花、大青叶、枸杞子、桑寄生各30g，葛根、伸筋草各20g，红花、全蝎各10g，淫羊藿15g，油制马钱子0.3~3g，甘草3~30g，蜈蚣3条。伴呛咳、咽干、声嘶、言语无力者，黄芪增至120g，加玄参、牛蒡子、木蝴蝶各15g；伴口眼歪斜加制白附子10g，僵蚕15g；手足麻木加鸡血藤、豨莶草各30g。(2) 缓解期：黄芪60~150g，川续断、杜仲、桑寄生、枸杞子、鸡血藤、黄精各30g，怀牛膝、伸筋草、山药各15g，当归、淫羊藿各12g，全蝎10g，蜈蚣3条，油制马钱子0.3~3g，甘草6~30g。伴头晕耳鸣，加阿胶（烔化）10g，龟板30g；手足拘挛不伸，加木瓜、活络草各15g。治疗24~74日后，痊愈3例，好转（主要症状消失，肌力恢复3~4级）6例^[3]。

3 一方为主 随症加减

3.1 朱倩等用加减补阳还五汤治疗感染性多发性神经根炎35例 本方含黄芪15g，赤芍9g，丹参12g，当归、地龙、桃仁、桂枝各6g。上肢麻痹重加桑枝；下肢麻痹重加牛膝；发热、灼痛、心烦加黄柏；身重肢沉加萆薢、苍术；潮热盗汗、舌干苔少加龟板、麦冬。日1剂水煎服，2周为1疗程。结果：痊愈27例，好转8例^[4]。

3.2 张兆湘用三妙丸加减为主治疗感染性多发性神经根炎69例 本组包括脊神经型27例，脊神经和颅神经

型 42 例；出现呼吸肌麻痹者 28 例。均予苍术、怀牛膝、茯苓、车前子各 10g，黄柏、法半夏各 5g，薏苡、藿香各 30g，银花、泽泻各 15g。肢体疼痛加海风藤、延胡索；呼吸困难，咳嗽吐痰加杏仁、桔梗、川贝；大便干燥加大黄；后期舌红少苔口渴加玄参、麦冬。吞咽困难者鼻饲给药，必要时补液和补充维生素 B₁、B₁₂、C 等。部分病人加用加兰他敏、三磷酸腺苷、辅酶 A 等，危重者应用激素 3~7 天。呼吸肌麻痹严重者行气管切开。结果全部治愈，无后遗症。服药 13~57 剂，平均 25 剂^[5]。

4 固定方治疗

钟宇明等用马钱子散治疗格林-巴利综合征 16 例 马钱子（麻油酥制）10g，地龙（焙干）40g，甘草（焙干）50g，研细末，混匀。日服 2g，连服 5 日；然后年龄小于 18 岁者日服 4g，大于 18 岁者口服 6~8g。均分 2 次于早晚饭后 1 小时冲服，10 日为 1 疗程，疗程间隔 3~5 日。结果：经治 2~5 疗程，全部获愈^[6]。

5 中西医结合

周玉林等中西医结合治疗格林-巴利综合征 100 例 本组用复方甘草汤：甘草（<5 岁 10~15g）、板蓝根、公英各 20g，连翘 15g，黄连 5~10g。日 1 剂水煎，口服或鼻饲。疗程 2~3 周，佐以补钾。对照组 99 例，用氢化可的松 100~200mg/日，静滴，或溶于高渗糖中与甘露醇交替静注；或用泼尼松常规量口服。两组均用神经营养剂及常规抗感染。严重呼吸肌-球麻痹、紫绀及缺氧严重，宜气管切开、人口呼吸及其它抢救措施。结果：呼吸肌-球麻痹型两组分别 60、56 例，气管切开 13、26 例，死亡 3、14 例（P 均 < 0.01）。普通型分别 40、43 例，显著进步

(四肢肌力恢复升级 $> \text{II}^\circ$ 、 III°) 18、10 例, 进步 11、10 例, 维持 10、17 例, 发展 1、6 例, 总有效率 72.5%、46.5% ($P < 0.05$)^[7]。

6 针刺疗法

6.1 王子康等针刺治疗格林-巴利综合征 46 例 取穴以华佗夹脊穴(上肢瘫痪取 $T_1 \sim T_3$, 下肢瘫痪取 $L_1 \sim S_1$; 针尖向脊, 呈 75° 角进针 0.5 ~ 2.5 寸)与阳明经穴(中脘、合谷、手三里、曲池、臂臑、肩髃、髀关、伏兔、犊鼻、足三里、丰隆、解溪、内庭、三阴交)为主, 隔疗程交替针刺。呼吸困难加身柱、素髎; 言语困难、吞咽不利加天柱、廉泉; 属肺热配尺泽、肺俞; 湿热配阴陵泉、商丘、脾俞; 肝肾阴亏配肝俞、肾俞、太冲、太溪、绝骨。日针 1 次, 留针 30 分钟, 10 次为 1 疗程, 疗程间隔 3 ~ 5 日。进针得气后, 加用 G6805 电针仪, 选断续波。结果: 痊愈 38 例, 显著好转 5 例, 好转 2 例, 无效 1 例, 总有效率 97.8%^[8]。

6.2 刘桂英针刺治疗格林-巴利综合征 30 例 治法: 用红外线适温照射患肢 25 分钟。上肢不能高举者选用肩井、肩贞、肩髃、臂臑、曲池、手三里、合谷、八邪穴; 不能坐立者取臂俞、肾俞、华佗夹脊穴; 下肢不能抬高、迈步困难者取环跳、白环俞、次髎、殷门、风市、阳陵泉; 踝关节不能活动者取昆仑、解溪、丘墟; 身体虚弱、消化不良者加足三里。视病情交替选用, 得气后通电用连续波、疏密波各 10 分钟, 并用 698 点送机治疗。日 1 次, 15 次为 1 疗程。结果: 痊愈 18 例, 显效(功能大部分恢复正常) 8 例, 好转(转治疗前功能进步) 4 例^[9]。

6.3 张大强等采用电针治疗急性感染性多发性神经

根炎 26 例 取穴：大椎、命门、腰阳关、腰俞、手三里、足三里、三阴交、髀关。常规消毒后，用 28 号 1.5 寸毫针针刺，泻法，得气后，接 DW701 - IIA 型电麻仪（2 台），间断波，频率 100 次/分，电流强度以患者能耐受为度，留针 20 分钟，日 1 次，10 次为 1 疗程，疗程间隔 2 日。治疗 3~5 个疗程，结果：痊愈 19 例，显效 5 例，有效 2 例^[10]。

6.4 徐惠梅等针刺治愈 1 例颅神经型格林-巴利综合征 男，48 岁。2 周前患上呼吸道感染，3 日前夜间受凉，次日晨起闭目、闭口不全，面部麻木，饮水呛，讲话困难，不能吞咽，下午出现复视。经检查诊为本病。入院后即予激素、抗菌素、辐射血等疗法，未见明显效果。2 周后开始针刺治疗。取穴：内关、风池、风府、地仓、颊车。平补平泻手法，留针 30 分钟。次日闭口较前好转，能伸部分舌，其余症状如前。针刺穴位加太阳、攒竹、鱼腰、丝竹空穴。第 3 日症状明显改善。共针 15 日，拔除鼻饲管，能正常进食，眼球、下颌运动接近正常，双软腭抬举正常，咽反射存在，构音清晰，仅右侧外展稍差。病情好转出院，回当地医院继续针治，2 个月后完全康复^[11]。

7 针药并用

刘国良报道针药并用治疗格林-巴利综合征 19 例 取穴：大椎、阳陵泉、手三里、足三里、曲池（均用泻法）、阴陵泉、外关、合谷（平补平泻法）、三阴交。留针 20 分钟，日 1 次。并用苍术、黄柏、羌活各 20g，白术、防己各 15g，茯苓、当归、牛膝、木瓜各 12g。日 1 剂水煎服。吞咽、呼吸困难者用青霉素 480~640 万 u，地塞米松

- 8 于子康, 等. 山西中医. 1995; 11 (3): 29
- 9 刘桂英. 陕西中医. 1989; 10 (3): 132
- 10 张大强, 等. 针灸临床杂志. 1996; 12 (3): 38
- 11 徐惠梅, 等. 针灸学报. 1991; 7 (2): 56
- 12 刘国良. 针灸临床杂志. 1996; 12 (11): 14
- 13 李公伦, 等. 云南中医杂志. 1992; 13 (4): 11

(江秀卿)

坐骨神经痛

坐骨神经痛是由多种原因引起的，以坐骨神经通路及其分布区的疼痛为主要表现的脊神经疾患。临床上有真、假性坐骨神经痛之分。属于中医学“痹证”、“腰腿痛”范畴。

1 辨证论治

鲁国良治疗坐骨神经痛 62 例 (1) 虚寒型用缓急阳和汤：桂枝 10g，麻黄 9g，木瓜、当归、牛膝、白芍、白芥子各 15g，甘草 8g，制川乌、制草乌各 6g，首乌、熟地各 30g，鹿角胶 12g。(2) 湿热型用舒筋利胆汤：黄柏、木瓜、钩藤、牛膝、白芍、虎杖、连翘各 15g，薏苡 30g，秦艽 12g，丹皮 10g，苍术 9g，甘草 8g。均随症加减。结果：治愈 32 例，显效 19 例，好转 8 例，无效 3 例^[1]。

2 一方为主，辨证加减

2.1 李建萍等用穿石通痹汤治疗坐骨神经痛 115 例

本方含穿山龙、丹参、薏苡各 30g，石钻风、延胡索各 15g，黄芪、熟地各 18g，当归、地龙、川牛膝、炙甘草各 10g，赤芍、白芍各 15 ~ 30g。寒湿偏重型去薏苡，加苍术、独活、细辛、制川乌；湿热偏重型去黄芪，加防己、黄柏、木通、栀子，炙甘草易生甘草，重用豨莶草 30 ~ 50g；气血瘀滞型加桃仁、红花、山甲珠、土鳖虫；阴虚内热型去黄芪、加生地、旱莲草、女贞子、沙参、地骨皮、知母、丹皮；气血两虚型重用黄芪，加党参、白术、阿胶、鸡血藤；顽痹久前者酌加蜈蚣、全蝎、白花蛇、麝虫等。结果：痊愈 83 例占 72.17%，显效 13 例占 11.3%，好转 11 例占 9.57%，无效 8 例占 6.96%^[2]。

2.2 刘玺珍等用皂角刺煎剂治疗坐骨神经痛 117 例

皂角刺 20~40g, 水煎取液 300ml, 分 2 次服。风寒型加防风、细辛、麻黄、独活、桂枝; 寒湿型加苍术、白术、薏苡仁、附子、肉桂、木瓜、羌活; 肝肾俱虚型加续断、杜仲、枸杞子、山萸肉、桑寄生; 脉络瘀阻型加川牛膝、王不留行、乳香、没药、鸡血藤、穿山甲; 湿热型加汉防己、黄柏、土茯苓。均与本品同煎, 日 1 剂, 服至病愈。结果: 临床痊愈 73 例占 62.4%, 基本控制 20 例占 17.1%, 好转 18 例占 15.4%, 无效 6 例占 5.1%^[3]。

3 一方为主 随症加减

3.1 陈进等用五藤逐痹汤治疗坐骨神经痛 65 例 本方含忍冬藤、鸡血藤、络石藤、海风藤、红藤、钻地风、千年健、川牛膝各 15g, 北细辛 8g, 赤芍、丹皮、广地龙各 10g, 透骨草 12g。患肢痛剧, 行走困难, 北细辛加至 10g, 加制川乌; 腰痛去赤芍、丹皮、广地龙, 加金狗脊、川续断、地鳖虫。日 1 剂水煎服。15 剂为 1 疗程, 疗程间隔 3~5 日。忌饮酒、重体力劳动。配合针灸、理疗 3 例。结果: 治愈 26 例, 显效 19 例, 好转 16 例, 无效 4 例^[4]。

3.2 汪克敏用补阳还五汤化裁治疗坐骨神经痛 43 例

本方含黄芪 30g, 地龙、当归、赤芍各 15g, 桃仁、红花、川芎各 10g。气虚甚重用黄芪, 加党参、炙甘草; 血虚去红花, 加生地、阿胶; 肢体麻木加鸡血藤、牛膝、桂枝; 肢体拘挛疼痛加全蝎、蜈蚣、海风藤、秦艽; 表证加柴胡、防风、白芷。日 1 剂水煎服, 10 日为 1 疗程。结果: 痊愈 25 例, 好转 10 例, 有效 6 例, 无效 2 例, 总有效率 95.35%^[5]。

3.3 孙桂芝用小柴胡汤治疗坐骨神经痛 60 例 本方

木瓜、透骨草，偏湿加苍术、蚕砂；风湿热痛加黄柏、生薏苡仁、桑枝、络石藤；津亏加生地、麦冬。日1剂，分次空腹温服。结果：显效（疼痛完全消失，功能恢复正常）44例，好转26例，无效2例，总有效率97.22%^[12]。

3.10 吴学文用独活寄生汤化裁治疗坐骨神经痛 93例 基本方：独活、桑寄生、杜仲、牛膝、细辛、秦艽、茯苓、肉桂心、防风、川芎、人参、甘草、当归、芍药、干地黄。肾虚加淫羊藿；痛剧、拘挛不得屈伸重用川芎、白芍，加川乌、全蝎；麻木不仁加鸡血藤；重着沉困加防己；热盛去细辛、肉桂心；寒盛加附子；体壮者减地黄、人参。日1剂水煎服，9日为1疗程，疗程间隔2~4日。结果：治愈63例，好转26例，无效4例，总有效率为96.7%^[13]。

3.11 朱世增用四物汤加味治疗坐骨神经痛 112例 本方含白芍或赤芍、熟地、山甲各15~20g，当归15~20g，川芎10~15g，蜈蚣2~3条，乌蛇10~25g。痛痹加附子10~15g，肉桂10~25g；行痹加独活、秦艽各15~20g，防风10~15g；着痹加茯苓15~25g，薏苡15~20g，苍术10~15g。水煎分2次服。结果：显效（用药2周内疼痛缓解，不复发）61例，有效（用药1月疼痛缓解）44例，无效7例，总有效率为93.8%^[14]。

3.12 贾松林等用四味芍药汤加味治疗坐骨神经痛 46例 用本方加味：白芍、生牡蛎（包，先煎）各30g，丹参25g，炙甘草、醋元胡各15g，苏木18g。偏寒加独活、制川乌、附子；偏热加虎杖、忍冬藤；痛剧加紫荆皮、丁公藤；痛久加乌梢蛇、徐长卿；骨质增生加肉苁蓉、骨碎补、鹿角霜。日1剂水煎服。停用其它药。用10~75日，

结果：痊愈 35 例，好转 9 例，无效 2 例，总有效率 95.7%^[15]。

3.13 郑跃进用四虫蠲痹汤治疗干性坐骨神经痛 124 例 本方用全蝎 3~6g，蜈蚣 2 条，土鳖虫 6g，地龙、天麻、当归、柴胡、牛膝各 10g，薏苡 45~60g，葛根 30g，鹿衔草、熟地各 15g，白芍 18g。瘀血加乳香、没药各 6g，田三七 2g；偏寒加制川乌、制草乌各 15~30g（先煎 1 小时）；湿热加忍冬藤、上茯苓各 15~30g，黄柏 10g。日 1 剂水煎服，6 日为 1 疗程。结果：痊愈 72 例占 58.1%，显效 38 例占 30.6%，有效 11 例占 8.9%，无效 3 例占 2.4%^[16]。

3.14 弭阳用四生丸治疗坐骨神经痛 88 例 白僵蚕 10g，白附子、草乌各 9g，地龙、五灵脂各 15g。腰髋部疼痛经大腿后侧、腘窝、小腿外侧放射至足趾部，遇风冷加重，苔白、脉沉迟者，加桂枝、川乌；疼痛从臂部向下肢放射，腰及双下肢酸软无力，舌红苔白、脉沉细者，加淫羊藿、巴戟天、补骨脂、金毛狗脊；腰髋部疼痛并向下肢放射，心悸气短，舌淡苔薄白、脉细弱者，加黄芪，党参、白术；下肢呈放射样疼痛，患肢沉重、行走不利，舌暗红苔白腻、脉沉滑者，加薏苡仁、黄柏、苍术；肢体灼热，舌红苔黄、脉滑数者，加知母、石膏、忍冬藤。治疗 30~120 日，痊愈 45 例，显效 35 例，无效 8 例，总有效率 90.99%^[17]。

3.15 骆洪道用坐骨宁治疗根性坐骨神经痛 87 例 本方含制川乌 6g，白芍 30g，炙甘草 8g，三棱、全蝎各 10g，白芥子、五灵脂、莪术、细辛各 12g，续断、狗脊、牛膝各 20g，徐长卿 15g，蜈蚣 3 条。灼热痛减川乌量，加

黄柏、丝棉木；舌根苔白厚加制南星、川草薢、丝瓜络；胀痛加八月札、路路通；久病或舌有瘀斑去川乌，减细辛量，加生地、山药、石斛；脾胃虚弱加炒白术、炒薏苡仁、焦楂曲；肝肾不足加熟地、枸杞子、炒杜仲；气血不足加生黄芪、党参、鸡血藤、当归；椎间盘突出加青风藤；骨质增生加威灵仙；骶骨隐裂加骨碎补。日1剂水煎服；1/3煎液热敷腰部15分钟，日2~3次；12日为1疗程。用1~2个疗程，结果：显效（疼痛基本消失，直腿抬高 $>70^{\circ}$ ，颏胸试验阴性）54例，好转27例，无效6例，总有效率为93%^[18]。

3.16 陈世彬用乌梅合剂治疗坐骨神经痛 26例 本品含乌梅、威灵仙各30g，当归、延胡、川楝子、桂枝、茯苓、白芍各9g，柴胡、甘草各6g，薏苡仁20g。每日1剂，饭后服。气血虚弱加黄芪、党参；腿冷痛喜温加附子、细辛或川乌；湿重加苍术、防己；瘀血重加丹参、虻虫、乳香、没药。结果：治愈（症状消失，随访1年无复发）4例，显效17例，好转3例，无效（服药12剂无改善）2例^[19]。

3.17 张笑玲等自拟寒痹灵治疗坐骨神经痛 120例 基本方：桂枝12g，白芍、丹参各30g，牛膝、骨碎补各15g，川木瓜、桃仁、红花、小茴香、制乳香、制没药、川楝子各10g，威灵仙18g，寄生20g。局部发热加金银花、黄柏；舌苔厚腻加茯苓、车前子、泽泻；冷痛甚加制附子、制川乌、制草乌、细辛；沉困重加大木瓜用量；麻木重加全虫；伴腰部凉痛加炒杜仲、川断、补骨脂、狗脊。日1剂水煎服。结果：痊愈31例，显效64例，有效16例，无效9例，有效率为92.5%^[20]。

3.18 靳松茂等用乌头逐痹汤治疗坐骨神经痛 48 例

本方含全蝎 5g, 蜈蚣 2 条 (均研冲), 蜜炙川乌 (先煎 1 小时)、甘草各 10g, 白芍 30g, 川牛膝、当归、独活、威灵仙各 15g, 细辛、红花各 6g, 制马钱子 0.5g (研冲)。随症加减, 日 1 剂水煎饭后服。结果: 治愈 34 例, 好转 8 例, 无效 6 例, 总有效率 88%^[21]。

3.19 张天真等用补肾舒筋汤治疗坐骨神经痛 36 例

本方含怀牛膝、川断、寄生各 30g, 桃仁、红花各 10g, 木瓜、独活各 15g, 蜈蚣、全蝎各 1g (研末冲服)。随症加味, 水煎服日 1 剂, 重症日 2 剂。结果: 临床治愈 18 例, 好转 15 例, 无效 3 例^[22]。

4 固定方治疗

4.1 姚德纯用加味独活寄生汤治疗坐骨神经痛 100 例

基本方含独活、茯苓、党参、秦艽、防风各 15g, 寄生、川芎、熟地、杜仲各 20g, 白芍、牛膝各 30g, 桂枝、当归、炙甘草各 10g, 细辛 5g。日 1 剂水煎服。结果: 临床治愈 87 例, 显效 7 例, 好转 3 例, 总有效率为 97%。疗程平均 12 日。观察认为, 方中寄生、牛膝、杜仲之用量达到 30g 时, 疗效显著^[23]。

4.2 刘远见等用痹除定痛汤治疗坐骨神经痛 236 例

本方含独活、当归、杜仲、威灵仙、防己、防风各 15g, 桑寄生、丹参、王不留行、鸡血藤、川牛膝各 30g, 土鳖虫、细辛、附子 (制) 各 10g, 甘草 6g。日 1 剂水煎服, 15 日为 1 疗程。治疗 1~3 个疗程, 结果: 治愈 127 例, 显效 71 例, 有效 29 例, 无效 9 例, 总有效率 96.2%^[24]。

4.3 刘傲霜用越痹汤治疗坐骨神经痛 本组 110 例,

用本方：川牛膝 60~100g，细辛、川断、伸筋草、木瓜、海风藤、秦艽、赤芍、桃仁各 15g，寄生、丹参各 30g，红花、制乳香、制没药各 10g，全蝎 6g。痛甚且肢温低加制川乌（10g，先煎半小时）。日 1 剂水煎服。对照组 66 例，用尪痹冲剂 1~2 包/日 3 次口服。用 2 个月，结果：两组分别治愈 98、29 例，好转 9、25 例，无效 3、12 例，总有效率 89.09%、43.94% ($P < 0.01$)^[25]。

4.4 董长才用加味芍药甘草汤治疗坐骨神经痛 50 例

白芍 60g，生甘草、独活、川芎、海桐皮各 15g，制川乌 9g，日 1 剂水煎服。2 例因疼痛剧烈用普鲁卡因合地塞米松注射液穴位封闭。结果：症状完全消失 38 例，显著好转 8 例，无效 4 例。服药 5~30 剂。复发 3 例，服本方仍有效^[26]。

4.5 邢萍用消痛Ⅱ号胶囊治疗坐骨神经痛 86 例 用本品（含全蝎、蜈蚣、牛膝、当归、地龙、元胡、地鳖虫、乳香、没药、威灵仙、丹参，研极细末，装胶囊，每粒 0.25g）5~8 粒/日 3 次口服，30 日为 1 疗程。治疗 1~2 个疗程，结果：治愈 62 例，好转 20 例，无效 4 例，总有效率 95.34%^[27]。

4.6 李志强治疗坐骨神经痛 31 例 用本品（制马钱子 4.5kg，广地龙、乳香、没药、肉桂、全蝎、细辛各 3kg，共研细末，过 60 目筛，装胶囊，每粒重 0.4g）3 粒/日 2 次口服，无不良反应，逐日加至 6 粒/次。服药期间，出现一过性肌肉僵凝感及肌肉轻度颤动者，稍减量，可用蜂蜜解毒。结果：治愈 20 例，好转 7 例，无效 4 例，总有效率 85%^[28]。

4.7 谢建斌用加味九分散治疗坐骨神经痛 38 例 本

组患者病程 20 天 ~ 12 年。本品含制马钱子 45g, 制乳香、制没药、麻黄、肉桂、全虫各 30g, 上药共研细末装入胶囊, 每粒 0.25g。口服 2 ~ 4 粒/日 2 次, 3 周为 1 疗程。结果: 痊愈 (症状完全消失, 随访 1 年以上未复发) 27 例, 显效 (症状消失, 半年以上复发后经再治好转) 9 例, 无效 2 例。马钱子必须经过炮制、去茸毛, 可用油炸或砂烫, 以颜色紫红为度; 用量须从小量开始; 一旦出现口唇麻木、舌僵等应立即停药或减半服用^[29]。

4.8 曾庆佩自拟鹿马丸治疗坐骨神经痛 54 例 取川牛膝、熟狗脊、廋虫各 40g, 制马钱子 3g, 焙干, 研极细末, 过筛, 鹿角胶 60g 烊化, 加蜂蜜适量, 以文火煎浓, 加上述药末调匀, 制丸如绿豆大。6g/日 2 ~ 3 次口服, 10 日为 1 疗程。结果: 痊愈 30 例, 基本治愈 12 例, 有效 10 例, 无效 2 例, 总有效率为 96.3%^[30]。

4.9 程运文从肝论治原发性坐骨神经痛 250 例 本组病程 2 个月 ~ 5 年, 均经多方治疗而效果不佳者。方药: 桂枝 30 ~ 60g, 生黄芪 20 ~ 30g, 山萸肉 15 ~ 30g, 川断 10 ~ 20g, 独活、当归、白芍各 10g。水煎服, 日 1 剂。如疼痛甚剧, 病情较重者, 开始可日 2 剂, 分多次服, 待痛缓解后, 再改日 1 剂。结果: 全部治愈, 其中服药 7 剂痊愈 163 例, 15 例 70 例, 25 剂 17 例^[31]。

4.10 李汉佳用鹿龙药酒治疗坐骨神经痛 321 例 本品由鹿筋、地龙、牛膝、枸杞子等药置预先配备好的蜜酒中, 按酒剂冷浸法制备。具有补肝肾、强筋骨、祛风湿、温经散寒、通络止痛之功。15 ~ 20ml/日 3 次温服, 7 日为 1 疗程。结果: 痊愈 288 例, 占 89.7%, 好转 12 例, 占 3.6%, 有效 17 例, 占 5.1%, 无效 4 例, 占 1.6%, 总有

效率为 98.4%。平均用药 21 日^[32]。

5 贴穴疗法

蔡德猷采用贴穴法治疗坐骨神经痛 1192 例 取穴：肝俞、肾俞、腰阳关、环跳、殷门、风市、委中、梁丘、阳陵泉、承山、悬钟等。配合局部压痛点，分别顺序贴蟾酥膏（含蟾酥、细辛、丁香、雪上一枝蒿等）。5~7 日换药 1 次，4 次为 1 疗程。结果：显效（症状体征完全消失，恢复工作或劳动）705 例占 59.14%，有效 439 例占 36.83%，无效 48 例占 4.03%，总有效率 95.97%^[33]。

6 内外并治

6.1 覃道勋内外结合治疗坐骨神经痛 105 例 基本方：麻黄、桂枝、独活、附片（先煎）、黄芪、防风、乳香各 10g，怀牛膝、当归、丝瓜络各 15g，三七、炙甘草各 5g，秦艽 12g。疼痛游走不定加大防风、麻黄量，加威灵仙；疼痛不移、得温则减、遇冷则剧加大附片、桂枝量，加巴戟天；重着肿胀加大苍术、丝瓜络、桂枝量，加汉防己、茯苓。日 1 剂水煎服。外用独活、续断、草乌、黄芩、伸筋草各 20g，水煎 15 分钟，熏洗患处，配合按揉，日 3 次。结果：治愈 85 例占 81%，有效 14 例占 13%，无效 6 例占 6%，总有效率 94%^[34]。

6.2 崔衍富用愈痛散与阳和汤治疗根性坐骨神经痛 81 例 用愈痛散（当归、乳香、肉桂、草乌各 30g，干姜、白芷、胆南星、赤芍、乌梢蛇、川芎、威灵仙各 60g，粉碎，过筛）100g，加 60℃ 白酒 300ml，调糊装布袋外敷患处，绷带固定，日 1 次。并用阳和汤：熟地、鹿角胶（烊化）各 30g，肉桂、白芥子各 6g，生甘草、生麻黄、炮姜各 3g；随症加减，日 1 剂水煎服。结果：治愈

42例，显效23例，进步14例，无效2例，总有效率97.5%^[35]。

6.3 王仁群用活络效灵丹加味治疗坐骨神经痛 61例

药用生乳香、生没药、当归、丹参各5g，杜仲、木瓜各15g，骨碎补、薏苡仁、牛膝各10g，威灵仙20g。风寒加独活、秦艽、防风；寒湿加独活、泽兰、伸筋草、仙茅；湿热加黄柏、知母、木防己；痛甚加马钱子0.3~0.9g（研细冲服）、徐长卿、松节、白芷，或加制川乌、草乌；足弱无力加千年健、桑寄生、狗脊、川断；阳虚加补骨脂、淫羊藿，或制川附子、肉桂、巴戟天；阴虚加知母、龟板，或合六味地黄丸；气血虚加熟地、黄芪，或八珍汤。黄酒或白酒少许为引。日1剂，水煎分3次服。药渣加透骨草50g，川椒适量水煎熏洗局部。也可用作散剂，20g/日4次，黄酒2~3ml并温开水送服。5日为1疗程，治疗1~13个疗程，痊愈43例，显效12例，有效4例，无效2例，总有效率为96.7%^[36]。

6.4 李一明应用中药离子导入配合中药内服治疗坐骨神经痛 36例 用五灵脂、制草乌、生川乌、大黄、芒硝、忍冬藤、艾叶、干姜各1份，虻虫、川山甲各0.5份。风寒湿加细辛（0.5份）、桂枝（1份）；湿热去制草乌、干姜，加石膏、公英（各2份）、连翘（1份）；血竭（1/3份）；肝肾不足加寄生、鸡血藤（各2份）。共研末，加凡士林占总药量的1/3，用纱布包叠成18cm×7cm×2cm的中药块。再用康乐KANGLE型药物渗透机（上海第七医疗器械厂生产），两个电阻板上各固定一中药块，用高温加热12分钟后，放置患处20分钟，可反复多次，1周为1疗程。风寒湿型用羌活、独活、秦艽、当归、川芎、川

乌、威灵仙各 10g, 桂枝 8g, 桑枝 20g, 海风藤 15g, 甘草 5g。湿热型用忍冬藤、络石藤各 15g, 防己 12g, 丹皮、栀子、泽泻、秦艽、豨莶草、地龙各 10g, 桑枝 20g, 甘草 5g。气滞血瘀型用桃仁、川芎、当归尾、川山甲、地龙、杜仲、寄生、乳香各 10g, 红花 8g, 全蝎 4g。肝肾不足型用独活寄生汤加减。日 1 剂水煎服。结果: 治愈 24 例, 好转 6 例, 进步、无效各 3 例^[37]。

7 针灸疗法

7.1 沈健针刺治疗坐骨神经痛 60 例 取足太阳、足少阳经穴为主; 秩边、环跳 (均刺 3 寸)、大肠俞、关元俞、腰 3~5 夹脊、委中 (点刺 0.5~1 寸)、阳陵泉、承山、绝骨等 (均患侧)。每次选 4~5 穴, 直刺, 得气后 (针感必须气至病所, 达到疼痛远端 > 3 次) 留针 20~30 分钟, 可配用温针灸或 G6805 电针仪, 隔日 1 次。结果: 治愈 38 例, 显效 12 例, 进步 8 例, 无效 2 例, 总有效率 96.67%^[38]。

7.2 崔述贵针刺治疗坐骨神经痛 250 例 本组患者中, 原发性坐骨神经痛 118 例, 继发性 132 例。主穴取秩边。疼痛沿下肢后侧放射取承山、昆仑; 疼痛沿下肢外侧放射取阳陵泉、绝骨、丘墟; 湿重加阴陵泉、丰隆; 久病体虚加足三里、肾俞; 根性型加肾俞、夹脊穴腰 2~5、大肠俞。多予中强度刺激, 秩边穴可针深 2~3.5 寸, 使针感向下肢远端放射。寒湿型予温针灸或艾条灸, 沿疼痛部位循经温熏; 风热型用泻法不留针; 瘀血型用泻法, 中强度刺激, 可提插捻转, 局部可加拨火罐; 虚弱型用补法, 宜轻刺激, 留针并 5 分钟行针 1 次。急性发作用泻法; 慢性期每日电针 1 次, 平补平泻, 10 次为 1 疗程, 疗

程期隔3日。结果：痊愈94例占37.6%；显效101例占40.4%；好转30例占12%；无效25例占10%^[39]。

7.3 刘延宝针刺上下对应点为主治疗坐骨神经痛 125例 取穴：以患侧下肢疼痛部位，选取同侧上肢对应部位。如疼痛经臀部沿大腿外侧放射至足趾，针同侧上肢肩髃、曲池、合谷、外关。并配双阳穴（直刺2.5~3寸）。常规消毒后，用37~50mm毫针快速刺入1~1.5寸，提插捻转强刺激，得气后尽量使针感上下放射，留针20分钟，5分钟行针1次。年老体弱者手法宜轻，初病重症可适当延长留针时间。日1次，10次为1疗程，疗程间隔3日。结果：痊愈81例占65%，好转40例占32%，无效4例占3%，总有效率97%^[40]。

7.4 孟庆良用锋钩针治疗原发性坐骨神经痛 198例 本组主穴取阿是穴，配穴取环跳、阳陵泉、悬钟、委中、承山。常规消毒，左手拇、食指绷紧皮肤，右手持锋钩针迅速刺入，刺时针尖与皮肤垂直，然后将针柄扭正再与皮肤垂直，进针0.5~1寸，上下提动针柄，可听到割断纤维的嚓嚓声，每穴钩割3~4次后按进针方向倒退出针，按压针孔片刻，隔日1次，3次为1疗程，疗程间隔3日。对照组126例，取穴同上，用毫针常规疗法，日1次，10次为1疗程。结果：两组分别痊愈179（90%）、81（64%）例，显效8、27全，邹转11、16例，无效0、2例。两组治愈率比较有显著性差异 $P<0.01$ ^[41]。

7.5 陈幸生用芒针治疗坐骨神经痛 114例 本组主穴：根性坐骨神经痛取腰三针（腰3、4、5华佗夹脊穴）、臀三针（秩边、环跳、新设），干性坐骨神经痛取臀三针。配穴：小腿前外侧足跖痛重者选风市向上沿胆经方向透

刺、阳陵泉透三阴交；小腿后侧至足跖痛重选承扶透髌关、承山透委中。对照组 90 例，取患侧大肠俞、关元俞、秩边、环跳、殷门、委中、承山、阳陵泉、昆仑、足三里、三阴交。臀三针用 5~6 寸芒针直刺，腰三针用 3~4 寸毫针直刺，行提插泻法。用 13~15 寸芒针从风市进针沿胆经向上横刺，用 11~13 寸芒针从阳陵泉向三阴交方向斜刺；承扶向髌关直刺 4~5 寸；用 8~10 寸芒针从承山透刺至委中，行捻转泻法。对照组均用捻转泻法。留针 20 分钟，日 1~2 次，10 次为 1 疗程，疗程间隔 3 日。结果：本组与对照组分别痊愈 80、31 例，显效（症状、体征大部分消失，活动自如，劳累后偶有酸痛）21、24 例，有效（症状、体征好转，能行走，但常有疼痛）6、7 例，无效 7、28 例，总有效率 93.9%、68.9%。两组疗效比较有非常显著差异， $P < 0.01$ 。^[42]

7.6 姜春等采用针刺放血治疗坐骨神经痛 54 例 取穴：主穴取大杼（双）；配穴取神阙、命门。常规消毒后，用三棱针点刺大杼穴，深 0.3~0.5 分。术者用拇指在患者穴位局部由上向下推按顺压被点刺穴位，并刺断少许红色的纤维组织，使之充分出血。然后用三棱针点刺配穴出血。每 3~5 日挑治 1 次，4 次为 1 疗程。结果：痊愈 37 例，显效 10 例，好转 4 例，无效 3 例，总有效率 94.4%^[43]。

7.7 敖学艳以电针外环跳治疗坐骨神经痛 60 例 取患侧外环跳（位于髂前上棘、股骨大转子高点、骶管裂孔均等距离之处）用 4~5 寸长针斜向下 45°方向，采用切指进针法进入 3~4 寸，得气后行大鹏展翅手法，使针感沿大腿后侧传导至足，再加用 GD680 电针治疗仪，用连续

波留针 30 分钟，每日 1 次，10 日为 1 疗程。结果：痊愈 38 例，显效 15 例，进步 7 例^[44]。

7.8 杨清远等采用痛点灸配点穴治疗坐骨神经痛 65 例 取阿是穴及疼痛放射终止点，压痛表浅用隔姜灸，深达骨部用温针灸 3~5 壮；痛区范围大，痛线长，用艾条沿痛线上下移动灸或痛区回旋灸；血管性痛者三棱针痛点刺血，加拔火罐。患者俯卧，沿痛线先轻后重手法各点、按、揉 5 遍，再以重手法点最痛点约 100 下；取患侧肾俞、关元俞、环跳、承扶、委中等穴，食、中、无名指交替自上而下点 5~10 遍，指端与穴位垂直，每秒 1~2 下，一点一提，点时以酸胀重痛为度。结果：痊愈 41 例，显效 15 例，好转 9 例^[45]。

8 针灸结合其他疗法

8.1 薛梅芝针刺结合穴位注射治疗坐骨神经痛 50 例 本组与对照组 50 例，均取本病显著表现所循经脉、腰夹脊、环跳、环中、昆仑；太阳经加委中；少阳经加阳陵泉。行泻法，通连续波，留针 30 分钟。取腰夹脊、环跳、痛点，两组分别用生理盐水、当归液穴位注射，每穴 1ml，日 1 次，10 次为 1 疗程。结果：两组分别痊愈 43、32 例，显效 5、6 例，有效 2、4 例，无效 0、8 例，有效率 100%、84% ($P < 0.05$)^[46]。

8.2 韩贵娥针刺加穴位注射与单纯针刺治疗坐骨神经痛 220 例 本组 160 例与对照组 60 例，均取腰部压痛点，患侧环跳、秩边、委中、阳陵泉、悬钟、昆仑。常规消毒后，虚证用补法，实证泻法；寒证烧山火，热证透天凉；不实不虚平补平泻。本组出针后，再在上穴各注射混合药液（当归注射液、麝香注射液各 2ml，维生素 B₁ 注射

动略受限) 33 例, 无效 5 例, 总有效率为 97.54^[49]。

8.5 高国权采用电针结合中药离子导入治疗根性坐骨神经痛 516 例 主穴: 大肠俞、秩边、环跳、阳陵泉; 配穴: 委中、承山、绝骨、昆仑。每次用 2~3 个, 交替使用。直刺大肠俞, 遇腰椎横突后稍退针, 针尖与背部中线呈 45°角, 越过横突, 缓慢进针 1 寸, 有放射性触电感时稍退针。得气后均接 G6805 电针仪, 连续波, 通电 20 分钟, 日 1 次, 15 次为 1 疗程。并将中药(防己、威灵仙、五加皮、赤芍、公英、泽兰、鸡血藤各等份, 共研细末, 加 95% 酒精和镇江陈醋各等份, 浸泡 >1 周) 泥状适量, 用条索状棉织品固定于患侧腰椎 4~ 骶椎 1 旁, 上置直流电导入阴极极板, 阳极置承山或委中穴(交替), 强度以患者能耐受为度。每次 20 分钟, 日 1 次, 12 次为 1 疗程。结果: 治愈 378 例占 73.26%, 显效 98 例占 18.99%, 有效 25 例占 4.85%, 无效 15 例占 2.9%^[50]。

8.6 班旭升针药并治坐骨神经痛 204 例 主穴: 秩边、委中、阳陵泉、承山、太冲; 配穴: 大肠俞、后溪、大钟。取侧卧位, 每次选 4~6 穴, 提插捻转手法交替使用, 刺激中等强度。针感要求: 秩边呈电击样反应, 向脚趾传导, 阳陵泉酸麻感下传至足背; 太冲酸胀感上传至承扶。留针 30 分钟, 每 10 分钟行针 1 次。隔日 1 次, 7 次为 1 疗程。药用桂枝、当归、桃仁、甘草各 10g, 白芍、葛根各 30g, 地龙 24g, 细辛、酒大黄各 3g, 蜈蚣 2 条。随症加减, 日 1 剂, 水煎服, 15 剂为 1 疗程。结果: 治愈(症状消失, 随访 1 年未复发) 164 例占 80.39%, 显效 29 例占 14.22%, 好转 9 例占 4.4%, 无效 2 例占 0.98%^[51]。

8.7 王凤桥等针药并用治疗坐骨神经痛 100 例 用

当归、白芍、独活、制乳香、制没药、制草乌、甘草、全蝎各 10~15g, 牛膝、川芎各 12~30g。有热象酌减草乌, 如忍冬藤、海桐皮; 气虚重用甘草, 加黄芪; 血虚重用当归, 加鸡血藤; 寒甚重用草乌, 加细辛; 风甚加防风、海风藤; 湿重加苍术、木瓜、薏苡仁; 肾虚加杜仲; 骨质增生加炮山甲。日 1 剂水煎服。取穴: 肾俞、气海俞、次髎、阿是穴、秩边、腰 3~5 夹脊; 循经配穴。进针得气后, 行提插泻法, 日 1~2 次, 10 日为 1 疗程, 疗程间隔 3 日。结果: 痊愈 74 例, 显效 19 例, 好转 4 例, 无效 3 例, 总有效率为 97%^[52]。

8.8 陈书镜等针灸结合中药治疗坐骨神经痛 86 例

取穴: 肾俞、大肠俞、秩边、环跳、承扶、委中、足三里、承山、悬钟。快速进针, 深度为 1.5~3 寸, 腰臀部穴进针后使针感下传, 但不宜多次重复。留针 30 分钟, 日 1 次, 7 日为 1 疗程。并用祛风定痛汤: 防风、路路通、红花、党参各 15g, 独活 12g, 鸡血藤、丹参、黄芪各 30g, 薏苡仁、当归各 20g, 土鳖虫 10g, 蜈蚣 3 条, 三七 (另煎)、甘草各 3g。日 1 剂水煎服, 21 日为 1 疗程。结果: 痊愈 66 例, 显效 11 例, 改善 7 例, 无效 2 例, 总有效率 97.67%^[53]。

8.9 王万袒用中药结合手针治疗坐骨神经痛 158 例

本组用自拟寻骨风汤: 寻骨风 50g, 独活、木瓜各 20g, 川牛膝、防己、川乌、草乌 (先煎 1 小时) 各 30g, 乳香、没药各 12g, 赤芍、白芍各 100g, 萆薢 15g, 川芎 25g。风寒型加桂枝 20g, 细辛 9g, 伸筋草 30g; 湿热型加秦艽 15g, 稀莪草、薏苡仁各 30g; 瘀血型加桃仁 15g, 土鳖虫 10g; 腰椎骨质增生加鹿衔草 50g, 穿山甲 15g, 蜂房 12g,

狗脊、石南藤各 30g。日 1 剂，水煎，分 3 次用蜂蜜 30g 兑服。用 28 号 1 寸毫针刺健侧坐骨穴（手背第四掌指关节尺侧缘），进针 0.5 ~ 0.8 寸，得气后留针 30 分钟，每隔 5 分钟捻针 1 次，并嘱患者弯腰伸腿。日 1 次，7 次为 1 疗程，疗程间隔 2 日。结果：治愈 108 例占 68.4%，显效 33 例占 20.9%，有效 7 例占 4.4%，无效 10 例占 6.3%^[54]。

9 综合疗法

9.1 裴克成用中药芒针药棒治疗坐骨神经痛 250 例

(1) 中药：当归、白芍、川芎、制乳香、制没药、威灵仙、独活、萆薢、鸡血藤、红花、香附子、延胡索、地龙、川牛膝、甘草。(2) 芒针取穴：腰阳关、秩边、环跳、承扶、殷门、阳陵泉、委中。膀胱经放射疼痛配承山、昆仑；胆经放射疼痛配风市、膝阳关、悬钟、丘墟；腰、骶痛甚配大肠俞、命门、白环、上髎、中髎、下髎。用 3 ~ 8 寸芒针，每次取 4 ~ 6 穴，命门、腰阳关、膝阳关用补法，痛点用泻法，余用平补平泻。留针 20 ~ 30 分钟，其间行针 1 ~ 2 次。10 次为 1 疗程。(3) 药棒疗法：取穴以痛为俞，选 1 ~ 2 个痛点进行拍打，随着药液的渗入肌肤表面呈青色突出如豆大的斑点时效果较佳。结果：痊愈 105 例，显效 73 例，有效 57 例，无效 15 例，总有效率 94%^[55]。

9.2 黎润霖等以坐骨舒为主治疗坐骨神经痛 48 例

本方含熟附片（先煎）、生姜各 15 ~ 30g，续断、鹿角霜、白芍、桑寄生、鸡血藤、木瓜、鹿衔草各 30g，肉苁蓉、锁阳、桂枝、单鞭救主各 25g，牛膝、骨碎补各 20g，甘草 15g。随症加减，日 1 ~ 2 剂水煎服，3 周为 1 疗程。病

情控制后将本方改为散（丸）剂，8~12g/日 3~4 次口服。同时局部配合振颤按摩、气功点穴、针灸等治疗。结果：基本痊愈 18 例，好转 10 例，有效 12 例，无效 8 例，总有效率为 83.4%^[56]。

9.3 刘天海用黄芪桂枝三七汤为主治疗坐骨神经痛 36 例 药用黄芪 60~90g，桂枝、三七、甘草各 6g，独活、防风各 9g，牛膝 20g，杜仲、川续断、桑枝各 15g，乌梢蛇 12g，当归、秦艽各 10g，白芍、薏苡仁各 30g。辨证属寒者加熟附子 12g，桂枝加至 12g；气虚明显加党参 20g，黄芪加至 90g；血虚加鸡血藤 30g；湿热重加黄柏 9g；疼痛剧烈加乳香、没药各 6g。每日 1 剂。病程长、痛点明显者，配合穴位注射和针灸推拿治疗。疼痛消失后，每日早晚各服吉林产人参再造丸 1 丸，连用 10~15 日，以防复发。结果：全部治愈，用药时间 8~35 日，平均 14 日^[57]。

参 考 文 献

- 1 鲁国良. 新中医. 1987; 19 (10): 36
- 2 李建萍, 等. 江苏中医. 1988; 9 (12): 47
- 3 刘玺珍, 等. 北京中医药大学学报. 1994; 17 (4): 21
- 4 陈 进. 浙江中医杂志. 1995; 30 (10): 452
- 5 汪克敏. 实用中医药杂志. 1996; 12 (1): 16
- 6 孙桂芝. 陕西中医函授. 1995; (4): 31
- 7 牛永琴, 等. 河南中医. 1994; 14 (1): 27
- 8 姜玉铃, 等. 中国骨伤. 1993; 6 (2): 29
- 9 姚尊华, 等. 黑龙江中医药. 1988; (1): 18
- 10 陈邦芝. 辽宁中医杂志. 1995; 27 (7): 318

- 11 张玉盘, 等. 甘肃中医 .1995; 8 (4): 12
- 12 黄锦龙. 安徽中医学院学报 .1995; 14 (4): 16
- 13 吴学文. 黑龙江中医药 .1994; (1): 34
- 14 朱世增. 吉林中医药 .1991; (5): 封3
- 15 贾松林, 等. 湖南中医杂志 .1997; 13 (2): 29
- 16 郑跃进. 新中医 .1990; 22 (12): 39
- 17 弭 阳. 黑龙江中医药 .1993; (2): 12
- 18 骆洪道. 甘肃中医 .1997; 10 (1): 10
- 19 陈世彬. 广西中医药 .1991; 14 (1): 15
- 20 张笑玲, 等. 中医正骨 .1993; 5 (3): 26
- 21 靳松茂, 等. 甘肃中医 .1993; 9 (5): 28
- 22 张天真, 等. 黑龙江中医药 .1988; (4): 17
- 23 姚德纯. 实用中医内科杂志 .1990; 4 (1): 17
- 24 刘远见, 等. 甘肃中医学院学报 .1995; 12 (2): 19.
- 25 刘傲霜. 河南中医 .1997; 17 (1): 41
- 26 董长才. 广西中医药 .1992; 15 (1): 8
- 27 邢 萍. 河北中医 .1996; 18 (2): 8
- 28 李志强. 实用中医内科杂志 .1996; 10 (1): 34
- 29 谢建斌. 上海中医药杂志 .1988; (7): 23
- 30 曾庆佩. 实用中医内科杂志 .1993; 7 (3): 31
- 31 程运文. 新疆中医药 .1988; (4): 29
- 32 李汉佳. 山西中医 .1990; 6 (5): 26
- 33 蔡德猷. 北京中医 .1990; (5): 20
- 34 贾道勋. 湖南中医杂志 .1995; 11 (3): 32
- 35 崔衍富, 等. 山东中医杂志 .1996; 15 (8): 352
- 36 王仁群. 四川中医 .1993; 11 (9): 23
- 37 李一明. 实用中医药杂志 .1997; 13 (2): 4
- 38 沈 健. 针灸临床杂志 .1997; 13 (1): 23
- 39 崔述贵. 辽宁中医杂志 .1988; 11 (12): 24
- 40 刘延宝. 上海针灸杂志 .1996; 15 (2): 10

- 41 孟庆良, 等. 上海针灸杂志. 1994; 13 (3): 111
 - 42 陈幸生. 山西中医. 1991; 7 (6): 37
 - 43 姜 春, 等. 黑龙江中医药. 1988; (3): 31
 - 44 敖学艳. 云南中医杂志. 1992; 13 (5): 35
 - 45 杨清远, 等. 上海针灸杂志. 1996; 15 (1): 17
 - 46 薛梅芝. 上海针灸杂志. 1996; 15 (1): 18
 - 47 韩贵娥. 针灸临床杂志. 1995; 11 (9): 21
 - 48 甘承铨. 浙江中医杂志. 1990; 25 (10): 454
 - 49 汤仁香. 新疆中医药. 1990; (3): 46
 - 50 高国权. 安徽中医临床杂志. 1996; 8 (5): 204
 - 51 班旭升. 中国医药学报. 1989; 4 (6): 37
 - 52 王凤桥, 等. 中国民间疗法. 1997; (1): 30
 - 53 陈书镜, 等. 河南中医药学刊. 1995; 10 (1): 25
 - 54 王万祖. 实用中医药杂志. 1993; 9 (3): 9
 - 55 裴克成. 中国骨伤. 1993; 6 (3): 36
 - 56 黎润霖, 等. 新中医. 1993; 25 (2): 41
 - 57 刘天海. 广西中医药. 1991; 14 (3): 103
- (岳宗海)

天麻汤合泽泻汤加减；元气虚衰型用地黄饮子加减。均用川芎嗪 100 ~ 150mg 静滴，日 1 次。结果：基本痊愈 20 例，显效 14 例，有效 6 例，无效 2 例，总有效率 95.2%^[2]。

2 一方为主 随症加减

2.1 周成钦用补阳还五汤加味治疗脑梗塞后遗症 35 例 药用北黄芪 30 ~ 120g，当归、赤芍、桃仁、川红花、地龙干各 10g，川芎 6g，丹参 30g。痰湿偏盛加法夏、陈皮；肝阳上亢加天麻、钩藤；气血亏虚加党参；大便秘结加大黄、火麻仁。日 1 剂，水煎分 2 次服，每次服药时，配服华佗再造丸或人参再造丸 1 粒。结果：治愈 18 例，显效 10 例，有效 5 例，无效 2 例，总有效率 94.3%^[3]。

2.2 金学仁等用脑复饮治疗脑梗塞后遗症 62 例 本方含虎刺、桂枝、山楂、泽泻、首乌各 12g，红叶铁树 15g，赤芍、红花、胆南星、野菊花、杜仲各 10g，黄芪 40g。肝阳上亢加钩藤、灵磁石、生龙骨；痰火上扰加天竺黄、枳壳、黄芩；气虚血瘀加党参、全当归、水蛭、龟板。日 1 剂水煎服，20 日为 1 疗程，疗程间隔 3 日。用 2 ~ 3 个疗程，结果：显效（神志清晰，肌力恢复，生活自理）48 例，有效 11 例，无效 3 例，总有效率 95%。血液流变学（全血比粘度、血浆比粘度、血沉、血球压积、纤维蛋白原）各项指标治疗前后比较均有显著性差异， $P < 0.01$ ^[4]。

2.3 周作霖用桃红四物汤加味治疗脑梗塞 32 例 药用桃仁、红花、葛根各 15g，当归、生地、赤芍各 20g，川芎 25g，水蛭 10g，黄芪 50g。随证加减。日 1 剂水煎分 3 次服。对照组 24 例，用维脑路通 0.2g/日 3 次口服。45

日为1疗程。结果：两组分别痊愈10、3例，显效11、9例，好转9、6例，无效2、6例，总有效率为93.8%、75%。本组疗效优于对照组（ $P < 0.05$ ）^[5]。

2.4 彭世桥等用加味黄连解毒汤治疗脑梗塞50例

本方含黄连、黄芩、黄柏、焦山栀、当归、川芎各12g，全蝎10g，炙甘草6g。夹风型加防风、僵蚕、白花蛇；夹痰型加菖蒲、胆南星；气虚明显加黄芪、党参；阴虚阳亢加枸杞子、生龙骨、生牡蛎、天麻、钩藤；脾虚纳呆加炒白术、炒山药、麦芽。日1剂水煎服，15日为1疗程。服药10~60剂后，痊愈（症状消失，能参加轻便劳动）32例，显效（症状基本消失，生活自理）9例，好转（症状明显减轻，但生活仍不能自理）5例，无效4例，总有效率92%^[6]。

2.5 刘洪明等用芪黄蛭蛹汤治疗脑梗塞60例 本组用本方：生黄芪60g，大黄、三七各6g，水蛭9g，当归12g，路路通15g，首乌30g。便秘加枳实、厚朴；神昏加菖蒲、远志、郁金；痰多加贝母、胆南星、瓜蒌；舌红少苔加天冬、熟地。日1剂水煎服。对照组30例，用706代血浆500ml，川芎嗪80mg，静滴，日1次，10日为1疗程，疗程间隔5日。并用肠溶阿斯匹林25mg，维生素E100mg，日1次；西比灵5mg/每晚1次；脑复康0.8g/日3次；均口服。均配合对症处理及功能锻炼。结果：两组分别基本痊愈14、4例，显效23、6例，有效20、16例，无效3、4例，总有效率95%、86.7%（ $P < 0.01$ ）^[7]。

2.6 孟庆年用大黄廕虫丸加减治疗脑梗塞34例 本方含大黄9~30g，廕虫、杏仁各12g，桃仁、赤芍、牛膝各15g，黄芩、虻虫、干漆、地龙、蛭蟥各10g，水蛭、

干生地各 20g。阴虚加石斛、玉竹、玄参；睡眠差加酸枣仁、远志、夜交藤；气血虚加黄芪、党参、当归；肝阳偏亢加天麻、钩藤、石决明。颅内压明显升高用 20% 甘露醇脱水，合并感染者加用抗生素。结果：临床治愈 25 例，显效 6 例，有效 2 例，无效 1 例，总有效率 97%^[8]。

2.7 申屠小良用芎芪丹参饮治疗脑梗塞 30 例 本方含川芎 15~30g，生黄芪 40~60g，丹参 30~50g，当归 15~20g，地龙、红花、桃仁各 10g。意识障碍加菖蒲、远志、麝香；头晕加天麻、石决明、杭白菊；痰盛加胆南星、竹沥半夏、天竺黄；口眼歪斜加白附子、僵蚕、全蝎、蜈蚣；气郁加郁金、制香附；便秘加麻仁、瓜蒌仁；头痛加白芷、白蒺藜；肌肉无力加寄生、千年健。日 1 剂水煎服，1 个月为 1 疗程。并用维生素 B 族。伴脑水肿 1 例加甘露醇。结果：基本治愈 12 例，显效 9 例，好转 7 例，无效或死亡 2 例^[9]。

2.8 吴富成采用益气活血通络法治疗急性脑梗塞 30 例 用滇三七 3g，黄芪 30g，当归、赤芍、丹参、鸡血藤各 15g，桃仁、红花、泽兰、地龙、甘草各 10g，炮山甲、川芎各 6g。头痛头胀目眩加天麻、白蒺藜；神识呆滞、言语蹇涩不利加石菖蒲、郁金、远志；口眼喎斜加白附子、天南星；肢体偏废无力加桂枝、续断、牛膝；失眠多梦、心烦加栀子、珍珠母、酸枣仁；患侧肢冷而肿加附片、茯苓、薏苡仁。日 1 剂水煎服，15 日为 1 疗程。治疗 27~109 日，结果：痊愈 19 例（63.3%），好转 9 例，无效 2 例，总有效率 93.3%^[10]。

3 固定方治疗

3.1 李桥等用醒脑活血汤治疗脑梗塞恢复期 58 例

本组用本方：丹参 30g，石菖蒲、郁金、胆南星、桂枝、红花、桃仁、水蛭、豨莶草各 10g，刘寄奴、葛根各 15g，益智仁 12g，日 1 剂水煎服。对照组 46 例，用西比灵胶囊 10mg，睡前服。并对症支持疗法。结果：两组分别基本痊愈 7、3 例，显著进步 17、11 例，进步 21、15 例，稍进步 8、9 例，无变化 5、8 例，总有效率为 91.4%、82.63% ($P < 0.05$)。本组喎僻不遂、语言障碍、健忘、血瘀舌象改善率高，对照组头痛、眩晕、情感障碍改善率高。治疗后本组全血粘度比、血浆粘度比、全血还原粘度、纤维蛋白原较治疗前明显降低 ($P < 0.05$, 0.01)，对照组仅全血粘度比、纤维蛋白原有改善 ($P < 0.05$)。治疗后两组血浆粘度比、全血还原粘度比较有显著性差异， $P < 0.05^{[11]}$ 。

3.2 徐黎明等用脑栓通汤治疗急性脑梗塞 136 例

本组用本品（黄芪 60g，赤芍、桃仁、生石膏、牡蛎、车前子、百合、丹参、瓜蒌、陈皮、白芍、党参、苏子各 30g，归尾、郁金、五味子、柴胡、黄芩各 15g，川芎、地龙、红花、水蛭、蒲黄、桂枝、川大黄、乌药、川椒、甘草各 10g，大枣 10 枚。用特制自动电高压锅加热密封提取法，1 剂提取 250ml，每瓶 500ml，高压灭菌）。80ml/日 3 次空腹服。对照组 136 例，用维脑路通 1g/日，静滴。均 15 日为 1 疗程。治疗 1 ~ 2 疗程，结果：痊愈 71 (52.2%)、36 (26.4%) 例，显效 43 (31.6%)、27 (19.9%) 例，有效 19 (14.0%)、49 (36.0%) 例，无效 3 (2.2%)、19 (14.0%) 例，对照组恶化 3 (2.2%) 例，死亡 2 (1.5%) 例。总有效率分别为 97.8%、82.3% ($P < 0.01$)。本组 CT 复查总有效率及血液流变学 11 项指标的改善均优于对照组 (P 均 < 0.01)^[12]。

中西药。结果：两组分别痊愈 142、107 例，显效 113、90 例，有效 41、65 例，无效 12、45 例，总有效率 96%、85.4% ($P < 0.01$)。本组血脂三项（胆固醇、 β 脂蛋白、甘油三酯）、血液流变学各项指标（全血比粘度、血浆比粘度、红细胞压积、血小板聚集、纤维蛋白原）治疗前后比较均有显著性差异， $P < 0.01$ 、 $0.05^{[15]}$ 。

3.6 蔡松泉等用通塞益脑液治疗急性脑梗塞 20 例

本组 20 例，用本品（由川芎、地龙等组成）50ml/日 2 次口服。对照组 20 例，用 6% 低分子右旋糖酐 500ml/日 1 次静滴，维脑路通片 0.2g/日 3 次口服。血压高者常规口服降压药，适当予葡萄糖、甘露醇。2 周为 1 疗程。结果：本组和对照组分别痊愈 4、5 例，显著进步 6、5 例，进步各 7 例，无效各 3 例，总有效率均为 85%。两组疗效相近，血液流变学指标均得到改善^[16]。

3.7 李才顺等用脑复苏治疗脑梗塞 120 例

本组用本品（水蛭、川芎、郁金、全蝎、胆南星、川牛膝、牛黄，共研细末，装 0.5 胶囊）5 粒，对照组 50 例，用维脑路通 0.2g；均日 3 次口服，2 个月为 1 疗程。结果：两组分别基本治愈 85（70.8%）、16（32%）例，进步 33（27.5%）、15（30%）例，无效（1.7%）、19（38%）例，总有效率 98.3%、62% ($P < 0.01$)^[17]。

3.8 徐木林等用脑脉通治疗脑梗塞 228 例

本组用本品（含黄芪、丹参、当归、党参等，制成冲剂，每包含生药 15g，湖北省中医药研究院研制）1 包；对照组 57 例，用大活络丸 1 丸；均日 3 次口服或鼻饲。均辅以脱水、降压、维持水电解质平衡等西药。用 30 日，结果：两组分别基本痊愈 121、17 例，显著进步 58、12 例，进步

42、18例，无效7、10例，总有效率96、93%、82.46% ($P < 0.01$)。两组气虚血瘀证占总数的47.37%，总有效率分别97.32%、73.91% ($P < 0.01$)^[18]。

3.9 陆朴莺等用芪龙膏治疗脑梗塞20例 本组用本品（含杜仲、川断、牛膝、白附子、南星、黄芪、桃仁、红花、丹参等25味，上海市第二人民医院研制）15~20mg/日3次口服；对照组28例，用丹参注射液8支，脑活素10ml，分别加补液中静滴，日1次，14日为1疗程，疗程间隔3~4日。治疗3个疗程，结果：两组分别基本痊愈8、10例，显效7、10例，有效4、6例，无效1、2例，总有效率95%、92.8% ($P > 0.05$)^[19]。

3.10 李万鹏等用穿蛭散治疗脑梗塞34例 本组用本方：穿山甲、生水蛭、黄芪各30g，制马钱子3g。共研细末，过120目筛，装胶囊，每粒0.5g，4~6粒/日3次，空腹温开水冲服。对照组33例，用维脑路通0.2g/日3次口服。均30日为1疗程，疗程间隔3日。结果：两组分别基本痊愈19、13例，显著进步9、5例，进步各3例，无效3、12例，总有效率为91.18%、63.62% ($P < 0.01$)。肌力及血液流变学（血小板最大聚集率、全血比粘度、红细胞压积）指标本组治疗前后自身及与对照组比较均有明显差异 ($P < 0.01$ 或 0.05)^[20]。

3.11 顾丽芳等用清脉791-1冲剂治疗脑梗塞50例 本组50例，用本品（含土山漆、甘草等，奚九一方）1包/日2次口服，1个月为1疗程，起效后再用2~3疗程。结果：治愈14例，显效16例，进步17例，无效3例。观察15例，PAG、PCG治疗前后比较有显著性差异， $P < 0.001 \sim 0.01$ 。动物实验结果表明，本品有抑制动脉血栓

形成和降低脑动脉阻力，改善脑循环的作用^[21]。

4 中药针剂治疗

4.1 陈大水用血塞通治疗脑梗塞 120 例 用本品注射液（三七总皂甙制剂）400mg，加 5% 葡萄糖液 350 ~ 500ml（糖尿病用生理盐水），静滴，日 1 次，15 日为 1 疗程。结果：治愈 59 例，显效 45 例，无效 16 例。全血比粘度、全血还原粘度、血浆比粘度、血沉方程 K 值、红细胞压积及纤维蛋白原治疗前后比较均有显著性差异， $P < 0.01$ ^[22]。

4.2 方铎悟用云南灯盏花注射液治疗急性脑梗塞 106 例 本组用本品（每 ml 含总黄酮 4.5mg）16 ~ 20ml；对照组 103 例，用维脑路通注射液 0.4 ~ 0.6g；均加 5% 葡萄糖液或葡萄糖盐水 250ml，静滴，日 1 次，15 日为 1 疗程。酌情用抗生素、维生素、脱水剂，不用其它血管活性药。结果：两组分别基本痊愈 23、11 例，显效 48、12 例，有效 30、50 例，无效 5、29 例，恶化 0、1 例。本组红细胞压积、血小板计数、纤维蛋白原、胆固醇及甘油三酯均显著下降（ $P < 0.01$ 或 0.05 ）^[23]。

4.3 陈达仁等用川芎注射液治疗急性脑梗塞 134 例 本组患者 134 例，用 10% 川芎注射液（上海第二军医大学附属长海医院产，每 10ml 相当生药材 1g）30ml 加 5% 葡萄糖盐水 500ml；对照组 86 例用低分子右旋糖酐 500ml；均日 1 次静滴，疗程 2 周。高血压者口服降压药，颅内高压者加用脱水剂。结果：两组分别痊愈 51、15 例，显著进步 35、9 例，进步各 30 例，无效 18、32 例，总有效率为 86.6% 和 62.8%，本组疗效显著高于对照组（ $P < 0.01$ ）。CT 检查示本组病灶消失及缩小率高于对照组，但

无统计学差异^[24]。

4.4 傅仁杰用通络熄风注射液治疗急性脑梗塞 135 例 本组 135 例用本品（从黄芪、丹参、赤芍等药中提取有效成分制成，北京益民制药厂生产，每支 10ml 含生药 10g）20ml 加 5% 葡萄糖液 500ml 静滴；对照组 51 例用低分子右旋糖酐 500ml 静滴。均日 1 次，15～30 日为 1 疗程。治疗期间配用维生素 B、维生素 C 等与治疗中风无直接影响的药物，合并其他疾病时投以相应的药物治疗。结果：两组分别基本治愈 70、16 例，显著进步 5、2 例，进步 41、13 例，无效 19、20 例，总有效率 85.93%、60.78%。两组疗效比较有非常显著性差异， $P < 0.01$ ^[25]。

4.5 戴维葆等用清开灵脉络宁并化痰通脑汤治急性脑梗塞 275 例 本组用清开灵 60～80ml，加 5% 葡萄糖液或 0.9% 生理盐水 500ml；脉络宁 20～30ml，加 706 代血浆或低分子右旋糖酐 500ml；均静滴，日 1 次。用本方：大黄、枳实、竹茹、菖蒲、厚朴各 10g，郁金、怀牛膝、地龙、川芎各 15g，生地、麦芽各 30g，甘草 6g。日 1 剂水煎服或鼻饲或灌肠。对照组用维脑路通 0.6g，加低分子右旋糖酐 500ml，静滴，日 1 次；藻酸双酯钠 0.2g，脑复新 0.1g，均日 3 次口服。两组病危时均予支持疗法，纠正水电解质、酸碱平衡；颅内压增高予脱水剂及对症处理。结果：两组分别基本痊愈 194、83 例，显效 42、21 例，有效 23、22 例，无效 7、29 例，恶化 9、8 例。本组疗效优于对照组（ $P < 0.05$ ）^[26]。

4.6 宁华英等用黄芪注射液配合清栓酶治疗脑梗塞 42 例 本组用黄芪注射液（上海福达制药有限公司生产，每 ml 相当于生药 2g）4～10ml；与对照组 35 例，均用清

14 日为 1 疗程。恢复期：气虚血瘀型用补阳还五汤加减；肝阳上亢型用天麻钩藤饮加减；余型辨证施治；可配合血塞通、丹参注射液静滴或针灸等。均配用西药治疗。结果：治愈 20 例，显效 18 例，好转 5 例，无效 2 例，总有效率 95.6%^[29]。

5.2 沈力等中西医结合治疗脑梗塞 64 例 本组用涤痰通络方：鸡血藤、桑枝各 30g，象贝、川牛膝各 12g，姜半夏、胆南星、地龙、石菖蒲各 10g，白附子 3g。痰瘀互阻型加川芎、丹参等；阳亢痰扰型加石决明、天麻、白芍等；痰热腑实型加生大黄、栀子等；气虚痰浊型加黄芪；阴虚风动型加生地、女贞子、龟板（或鳖甲）等。随症加减，日 1 剂水煎服或鼻饲。与对照组 50 例，均用低分子右旋糖酐 500ml，静滴，日 1 次；尼莫地平 40mg/日 3 次口服；用 30 日。结果：两组分别痊愈 23、11 例，显著进步 20、10 例，进步 16、23 例，无变化 5、6 例，总有效率 92.2%、88% ($P > 0.05$)。本组治愈加显著进步率优于对照组 ($P < 0.05$)^[30]。

5.3 薛恩彬中西医结合治疗脑梗塞 66 例 瘀血内阻型用当归、赤芍、桃仁、红花、菊花、全蝎各 10g，生地 15g，丹参 30g，蜈蚣 3 条。并取穴：百会、人中、外关、环跳、阳陵泉、太冲等；深刺泻法。痰湿上扰型用茯苓、半夏各 15g，化红、枳壳、竹茹各 12g，陈皮、菊花、全蝎各 10g，丹参 30g，蜈蚣 3 条。并取穴：百会、人中、外关、环跳、丰隆、足三里等，针刺用泻法。气虚血瘀型用黄芪 60g，当归、桃仁、红花、川芎各 10g，赤芍、地龙各 12g。并取穴：人中、外关、足三里、阳陵泉、委中、太溪等，针刺用补法。均日 1 剂水煎服。与对照组 38 例，

均用脉通 500ml, 维脑路通 400mg, 静滴, 日 1 次, 14 日为 1 疗程, 疗程间隔 1 周。用 1~3 个疗程, 结果: 两组分别治愈 18、8 例, 进步 40、18 例, 无效 8、12 例, 本组疗效优于对组 ($P < 0.05$)^[31]。

5.4 姚兰中西医结合治疗脑梗塞 103 例 经脉空虚, 风邪入中: 用大秦芎汤加味; 肝肾阴虚, 风阳上扰: 用镇肝熄风汤或天麻钩藤饮加减; 痰热腑实, 风痰上扰: 用导痰汤或温胆汤, 昏迷者配用安宫牛黄丸或至宝丹; 气滞血瘀型: 用补阳还五汤加味。配以脉络宁 10~20ml/日 1 次静滴, 10 日为 1 疗程, 用 2~3 疗程。口服维脑路通, 恢复期配针灸治疗。结果: 基本痊愈 31 例, 显著进步 62 例, 进步 8 例, 无效 2 例, 总有效率 90%^[32]。

5.5 葛朝晖中西医结合治疗脑梗塞 16 例 基本方: 天麻、钩藤、干地龙、豨薟草、白芍、赤芍、牛膝、桑寄生各 15g, 石决明 30g, 竹沥半夏 12g, 胆南星、远志各 6g, 石菖蒲 9g, 丹参 20g, 头痛, 目赤面红, 烦躁易怒, 口苦苔黄去豨薟草, 加龙胆草、丹皮、夏枯草; 心悸不寐加炒枣仁、柏子仁; 手足麻木无力加黄芪、当归。并用蝮蛇抗栓酶、复方丹参注射液静滴, 脑水肿用甘露醇; 抗栓丸、维脑路通等口服。结果: 痊愈 11 例, 好转 4 例, 无效 1 例^[33]。

5.6 李兆秋等中西医结合治疗脑梗塞恢复期 82 例 本组用活血通脉汤加减: 黄芪 30~60g, 当归 20g, 丹参 20g, 葛根 15g, 地龙 12g, 赤芍、川芎、石菖蒲各 10g。血压高加夏枯草、钩藤、石决明; 口眼歪斜, 语言障碍加僵蚕、白附子; 偏瘫, 下肢重加牛膝, 上肢重加桂枝。日 1 剂水煎服。腰椎穿刺, 从穿刺针内向椎管缓推入地塞米松

5mg, 神经生长因子 (NGF) 2000Bu (皮试阴性), 每周 1 次, 4 次为 1 疗程。与对照组均用维脑路通 1.0g, 加 5% 葡萄糖盐 250ml (糖尿病者用盐水), 静滴, 日 1 次, 12 日为 1 疗程, 疗程间隔 3~5 日。治疗 30 日, 结果: 两组分别治愈 37、7 例, 明显进步 22、11 例; 进步各 15 例, 无效 8、13 例, 总有效率 90.24%、71.74% ($P < 0.05$)。神经系统损伤进步分数分别为 10.93 ± 0.84 、 6.18 ± 1.22 ($P < 0.05$)。血液流变学指标及血脂本组治疗前后自身及组间比较均有显著性差异, $P < 0.05^{[34]}$ 。

5.7 黄文柱中西医结合治疗脑梗塞 42 例 本组用涤痰活血汤: 制胆星、橘红、细枳实各 6g, 制半夏、红花、鸡血藤各 10g, 茯苓、丹参各 15g, 全瓜蒌 30g, 生大黄 3g, 随症加减。日 1 剂水煎服。并用脉络宁注射液 20ml, 加 5% 葡萄糖液 500ml, 静滴, 日 1 次。对照组 20 例, 用复方丹参注射液 20ml, 加低分子右旋糖酐 500ml, 静滴, 日 1 次。均常规用 20% 甘露醇降颅内压及对症处理, 20 日为 1 疗程。结果: 两组分别临床治愈 24、6 例, 好转 16、8 例, 无效 2、6 例。两组治愈率及总有效率比较均有显著性差异, $P < 0.05$ 、 $0.01^{[35]}$ 。

5.8 王淑云等中西医结合治疗脑梗塞 103 例 本组用黄芪 50g, 丹参、川芎、赤芍各 20g。血瘀重加桃仁、红花、鸡血藤、没药、香附; 痰浊重加天麻、半夏、陈皮、茯苓、白术。与对照组 35 例, 均用维脑路通 400mg, 低分子右旋糖酐 500ml, 蝮蛇抗栓酶 III 号 1u, 选 1~2 种, 静滴, 日 1 次, 3 周为 1 疗程, 疗程间隔 5 日。合并脑水肿、高血压、冠心病、肺内感染等对症治疗。结果: 两组分别基本痊愈 24 (23.3%)、4 (11.4%) 例, 显效 40

(38.8%)、7 (20%) 例，有效 35 (34%)、19 (54.3%) 例，无效 4 (3.9%)、5 (14.3%) 例，本组基本痊愈率、显效率及总有效率均高于对照组， $P < 0.01$)^[36]。

5.9 刘兆元等中西医结合治疗脑梗塞 80 例 本组用血府逐瘀汤：生地、当归、牛膝、红花、桃仁、赤芍各 15g，川芎 9g，柴胡、桔梗、枳壳各 6g，甘草 3g。随症加减，日 1 剂水煎服；与对照组 60 例，均用胞二磷胆碱 0.5g，加 5% 葡萄糖液 500ml，静滴，日 1 次；并用阿斯匹林、尼莫地平、维生素 E、脑脉康等。14 日为 1 疗程，疗程间隔 4 日。结果：两组分别痊愈 21、12 例，显效 40、24 例，有效 15、14 例，无效 4、14 例，总有效率 95.1%、83.3%^[37]。

5.10 张学安中西医结合治疗脑梗塞 178 例 I 组 34 例，用维脑路通 1000mg 加入 10% 葡萄糖 500ml 静滴。II 组 68 例，用复方丹参液 20ml 加入低分子右旋糖酐 500ml 静滴。III 组 76 例，用江浙蝮蛇抗栓酶 0.5u 加入生理盐水 250ml 静滴（先作皮试，阳性者禁用）；配服补阳还五汤加味：黄芪 30~240g，当归、红花各 15g，赤芍 12g，川芎 9~15g，桃仁 10g，丹参、鸡血藤、川牛膝各 30g，地龙 20g，甘草 3g。三组静滴药均日 1 次。均以 21 日为 1 疗程，一般用 1~2 疗程。三组均辅助应用脑复康、脑益嗉、维生素 B₁，对高血压、颅内高压及其他合并症均作相应处理。结果：I、II、III 组分别治愈 12、28、36 例，显效（瘫痪肢体肌力恢复 IV 级以上或上下肢肌力和 $\geq$ VII 级，症状体征明显改善，生活可部分自理）10、21、28 例，进步（肌力恢复 I~II 级，症状体征改善）5、11、9 例，无效 7、8、3 例，总有效率 79.42%、88.24%、95.41%。

治愈率及总有效率三组之间有明显差异，Ⅲ组明显高于Ⅰ、Ⅱ组 ($P < 0.005$)^[38]。

5.11 吴重玲等中西医结合治疗脑梗塞 141 例 本组 141 例，用 20% 甘露醇 500 ~ 1000ml 静滴，日 1 次；水蛭 15 ~ 30g/日水煎服。与对照组 70 例，均用维脑路通 0.6 ~ 0.8g，低分子右旋糖酐或 706 代血浆 500ml，静滴，日 1 次。均疗程 14 ~ 21 日。结果：两组分别基本痊愈 31、5 例，显著进步 72、15 例，进步各 28 例，无变化 9、18 例，恶化 1、4 例，死亡 0、1 例，总有效率 92.9%、68.5% ($P < 0.01$)。本组纤维蛋白原、血浆粘度、全血粘度、血细胞压积治疗前后比较有显著性差异 ($P < 0.001$ 或 0.05)，对照组无显著性差异 ($P > 0.05$)^[39]。

5.12 胡金明用补肾化痰益气方药联合光量子血治疗脑梗塞 161 例 用六味地黄汤合补阳还五汤：熟地 25g，淮山药、山茱萸、茯苓、川芎、当归、地龙各 15g，丹皮、泽泻、赤芍、桃仁各 12g，黄芪 60g，红花 10g。语言不利加菖蒲、远志；口眼歪斜加全蝎、蜈蚣；肝阳上亢加天麻、钩藤。日 1 剂水煎服，20 剂为 1 疗程。并用丹参注射液 20ml，加 5% 葡萄糖液 250ml，静滴，日 1 次，2 周为 1 疗程。均用 2 ~ 3 个疗程。配合西医、针刺、理疗法。用 DLX₂-254 电脑冷光光量子血疗仪进行血疗（患者静脉血 200ml，注入装有抗凝液贮血袋内混匀，无菌条件下，将血液注入透紫外线血疗袋，充氧，紫外线照射 10 分钟，再充氧 2 分钟后，将血液转入贮血袋中，静脉回输给患者），每周 3 次，6 次为 1 疗程，疗程间隔 2 周。结果：治愈 122 例 (75.77%)，显效 33 例，有效 6 例。随访 1 年，复发 11 例^[40]。

6 针灸疗法

6.1 郁云亚以针灸治疗脑梗塞 120 例 (1) 头针组 60 例, 肢体运动障碍、感觉障碍取顶中线由前顶穴向百会透刺 25mm, 顶颞前、后斜线(对侧)上 1/3、中 1/3 处, 用 3 根 25mm 毫针分 3 段接力刺, 快速进针, 徐徐推进 25mm, 拇、食指紧捏针柄, 用爆发力将针向外抽提 3~5 次, 留针, 隔 10 分钟行针 1 次, 共 3 次, 行针时配合患肢活动。语言障碍配额中线、颞前和颞后线。(2) 头针配合穴注组 60 例, 头针同上。穴注取穴: 肝胆火旺、余热未净型取肝俞、胆俞、阳陵泉、行间、天枢、中渚透少府、合谷透劳宫; 痰浊内蕴、脾胃虚弱型取脾俞、胃俞、中脘、阳陵泉、丰隆、曲池、内关; 肝肾阴亏、风阳未潜型取肝俞、肾俞、关元、太溪、太冲、曲泽、神门透阴郄; 气血两虚、心脾亏损型取心俞、膈俞、脾俞、足三里、三阴交、曲池、神门。药用维脑路通 200mg, 丹参注射液 4ml, 乙酰谷酰胺 100mg, 维生素 B₁₂200μg, 三磷酸腺苷钠 20mg, 混合摇匀, 每穴注射 1~2ml, 1~2 日 1 次, 10 日为 1 疗程。结果: 两组分别痊愈 10、20 例, 显效 15、30 例, 有效 29、9 例, 无效 6、1 例。头针配穴注组疗效优于头针组, 各证型疗效无显著差异^[41]。

6.2 郁朝印等报道用中风神灸药条治疗脑梗塞 本品含端阳艾、硫磺、雄黄、全蝎、白花蛇、白芷、乳香、没药、麝香、川乌、草乌等。19 味中药制成 20cm×1.8cm 之药条, 外用棉纸封糊。药条灸组 52 例: 风中厥阴阳明型灸百会、天窗、风池、肩髃、曲池、足三里、太冲、合谷; 风中太阳阳明型灸风府、曲池、至阴、跗阳、太溪、环跳、阳陵泉、足三里、下巨虚; 风中太阳少阳型灸风

府、肩井、曲池、支沟、至阴、环跳、阳陵泉、足三里、丘墟、阳辅、昆仑。凡局部下陷、虚软者用温灸，局部痛硬、外形微隆或寒凉者用烧灼灸法，顽痹久瘫或有明显挛缩现象，直接隔布灸熨穴处，以局部发热或肢体柔软舒适为度。每日1~2次，14次为1疗程。针刺组36例选穴同上，日1次，10次为1疗程。药物组17例予西药常规治疗，15日为1疗程。结果3组总有效率分别为82.69%、80.56%和70.58%^[42]。

6.3 邹循昌等针刺阳经六穴治疗脑梗塞32例 针刺组32例主穴取患侧肩髃、曲池、合谷、环跳、阳陵泉、光明。辅穴：口眼歪斜取患侧下关、翳风；舌强语蹇或失语取上廉泉、双增音（均点刺）。根据辨证配穴。用提插手手法，根据虚实用补泻手法。留针30分钟，日1次，2周为1疗程，治疗3个疗程。卡兰片组31例用本品（日本武田药品工业株式会社提供）1片（含阿朴长春胺酸乙酯5毫克）/日3次口服，疗程同上。结果：两组分别基本治愈20、8例，显效4、5例，有效6、13例，无效2、5例，总有效率93.75%、83.87%。针刺组疗效显著优于卡兰片组（ $P < 0.05$ ）。治疗前两组多数患者血液流变学指标均高于对照组（同龄健康人），经针刺或药物治疗后，血小板最大聚集率、血液粘度和红细胞比积明显下降，治疗前后比较均有显著差异（ $P < 0.05 \sim 0.001$ ）。提示针刺可能通过改善血液流变性以疏通经络、活血化瘀，促进肢体运动功能的恢复^[43]。

6.4 王建新等报道体针加刺络治疗脑梗塞临床及血液流变学观察 本组30例，在体针基础上加刺络法。（1）体针：上肢取肩髃、曲泽、外关、合谷；下肢取环跳、风

市、委中、阳陵泉、足三里、悬钟；面瘫取颊车、地仓、太阳、翳风；失语取哑门、廉泉。用2~5寸毫针，施平补平泻法，留针20~30分钟，日1次，6日为1疗程，疗程间隔1日。（2）络刺法：用小号不锈钢三棱针点刺曲泽、委中穴，出血50~100ml，出血不畅者加火罐，10日1次。对照组30例，单用上述体针。均治疗2个月。结果：本组与对照组分别治愈22、16例，显效6、5例，好转2、9例，总显效率93.33%、70%。两组显效率比较有显著差异， $P < 0.05$ 。两组急性期疗效均优于非急性期。本组治疗前后血液流变学指标除红细胞压积的变化无显著差异外，全血粘度、红细胞聚集指数、纤维蛋白原、循环内血小板聚集率、血小板粘附率均有非常显著差异， $P < 0.01$ 和 $P < 0.001$ ；对照组除循环血小板聚集率、血小板粘附率显著降低有非常显著差异（ $P < 0.01$ ）外，其它指标均无显著差异， $P > 0.05$ 。提示络刺法对血液流变学影响大于体针组^[44]。

6.5 于学平等采用针刺配合功能训练治疗脑梗塞后痴呆 主穴：百会、神庭、人中。配穴：神门、间使（均双）。肾精不足配肾俞、绝骨；肝阳偏亢配太冲、太溪；痰火闭窍加丰隆、劳宫；气滞血瘀加气海、膈俞。针刺得气后，行捻转或提插补泻法（肾精不足用补法，气虚血瘀用平补平泻法，余型用泻法），留针20分钟，日1次。并进行功能训练。用1个月，结果：基本恢复（智力复常等）8例，显效12例，有效19例，无效7例，总有效率85%^[45]。

6.6 崔玉莹等以针刺治疗多发性脑梗塞性强哭强笑症20例 本组用1寸毫针刺双侧大陵、神门穴，强笑用

泻法，强哭用补法；取头部情感区，用2寸毫针平刺，快速捻针200次/分钟。得气后均留针30分钟，10分钟行针1次，日针1次。对照组16例，用胞二磷胆碱500mg加入5%葡萄糖500ml静滴，日1次。治疗1个月。结果：本组与对照组分别痊愈18、6例，显效2、8例，无效0、2例。本组治愈率优于对照组， $P < 0.01$)[46]。

6.7 房丽等采用头穴久留针治疗急性脑梗塞 两组取穴：前神聪透悬厘、百会透曲鬓（均取头部病灶侧）。常规消毒，沿上述穴区分3段用毫针与皮肤呈 150° 角进针至帽状腱膜下，深1.5寸，每根针捻1分钟，每分钟200次，留针5分钟，重复2次，共15分钟。本组32例，留针12小时，于6小时及出针前再各行针1次。对照组30例，操作后出针。日1次，10次为1疗程。结果：两组分别显著进步7、0例，进步21、23例，无变化4、7例，有效率88%、77%（ $P < 0.01$ ）。神经功能缺损程度改善两组治疗前后自身及治疗后两组比较均有显著性差异， $P < 0.001 \sim 0.05$)[47]。

6.8 张学鉴采用头针疗法治疗脑塞40例 本组取头皮部患侧运动区、感觉区。常规消毒后，用2根32号1.5寸不锈钢毫针，与头皮呈 $15^\circ \sim 30^\circ$ 角，沿刺激区不同方向快速刺入皮下，达到所需深度时接通电针治疗仪，连续频率240~260次/分，每次30分钟。对照组用脑活素10ml，加生理盐水200ml；胞二磷胆碱0.5g，加5%葡萄糖盐水500ml，静滴。均日1次，10日为1疗程，疗程间隔3日。两组各40例，治疗2个疗程，结果：两组分别治愈23（57.5%）、11（27.5%）例，显著进步16、20例，进步1、9例，显效率97.5%、77.5%（ $P < 0.05$)[48]。

6.9 温瑞书等用眼针治疗脑梗塞偏瘫 62 例 取穴：双上焦区、双下焦区穴。阴虚阳亢型配患侧肝区、肾区穴；痰湿中阻型配患侧脾区、中焦区穴；气虚血瘀型配患侧心区、肺区穴。常规消毒后，用左手指压住眼球，使眼眶皮肤绷紧，右手持 32 号 5 分不锈钢针，在眼眶缘周区 2 分许沿皮刺入，不施手法，留针 5 ~ 15 分钟，缓慢出针，日 1 次，10 次为 1 疗程。治疗 1 ~ 3 疗程，结果：治愈 41 例，显效 8 例，有效 12 例，无效 1 例，总有效率 98.38%^[49]。

7 针药并用

7.1 朱永志等采用针药结合治疗脑梗塞 769 例 头针：取患肢对侧百会与曲鬓连线，用 28 号 2 寸毫针 2 支，从上至下分 3 段依次刺入头皮下，快速捻转 3 分钟，隔 5 分钟再捻转 1 次，伴失语者加刺焦氏语言一区或二、三区，日 1 次，连针 20 日改体针。体针取穴：肩髃、曲池、外关、合谷、环跳、足三里、解溪、太冲，面瘫取颊车透地仓、地仓透迎香，均取患侧穴；失语取哑门、廉泉。平补平泻，日 1 次，连针 20 日。急性期患者配合川芎嗪、维生素静滴。中药：风痰瘀阻型用涤痰汤加桃仁、赤芍、丹参；肝阳偏亢型用镇肝熄风汤加桃仁、红花、丹参；气虚血瘀用补阳还五汤。结果：基本治愈 446 例，显效 223 例，有效 85 例，无效 15 例^[50]。

7.2 胡从富报道针刺药物治疗脑梗塞 320 例 本组 215 例，主穴：颈三夹脊；四肢穴：肩髃、曲池、手三里、臂中、外关、合谷、八邪、环跳、髀关、风市、迈步、阳陵泉、悬钟、解溪、八风、委中。口眼歪斜加地仓、合谷；语言不利加廉泉、哑门；头痛加百会、风池；

痰湿盛加内关、丰隆；肝阳上亢加太冲、肝俞；肝肾不足加肾俞、复溜；心脾两虚加三阴交、脾俞。每次必取主穴，其余穴选4~8个。急性期取健侧，泻法；恢复期、后遗症期取患侧，平补平泻法。留针30分钟，日1次，15日为1疗程，疗程间隔3日，治疗5个疗程。与单纯药物组105例，均用补阳还五汤加味：黄芪30~120g，当归、川芎、赤芍、桃仁、红花、地龙各10g，丹参、山楂、鸡血藤各30g，水蛭15g。随症加减。日1剂水煎服。用蝮蛇抗栓酶（沈阳第一制药厂产），皮试阴性者，第1周0.25u、第2周0.5u，加生理盐水250ml，静滴，日1次，21日为1疗程，疗程间隔1周，用2~3疗程。辅以脑活素、胞二磷胆碱、脑复康、细胞色素C、尼莫地平、维生素E、B₆。兼症对症处理。结果：两组分别基本痊愈162（75%）、57（54%）例，显著进步40、32例，进步11、8例，无效2、8例。两组基本痊愈率比较有显著性差异， $P < 0.01^{[51]}$ 。

参 考 文 献

- 1 刘 华. 浙江中医杂志. 1992; 27 (4): 154
- 2 赵钦波. 新中医. 1994; 26 (7): 40
- 3 周成钦. 广东医学. 1992; 13 (1): 39
- 4 金学仁, 等. 中医药学报. 1996; (5): 13
- 5 周作霜. 中医函授通讯. 1992; 11 (3): 44
- 6 彭世桥, 等. 浙江中医杂志. 1991; 26 (12): 540
- 7 刘洪明, 等. 吉林中医药. 1997; 17 (2): 7
- 8 孟庆年. 云南中医杂志. 1993; 14 (6): 6
- 9 申屠小良. 浙江中医杂志. 1996; 31 (5): 205

- 10 吴富成. 浙江中医杂志. 1994; 29 (5): 203
- 11 李 桥, 等. 中医药研究. 1995; (5): 17
- 12 徐黎明, 等. 中医药研究. 1995; (1): 16
- 13 易振佳, 等. 湖南中医杂志. 1992; 8 (1): 3
- 14 魏保国, 等. 天津中医. 1995; 12 (4): 17
- 15 王松龄, 等. 河南中医药学刊. 1996; 11 (6): 30
- 16 蔡松泉, 等. 江苏中医. 1991; 12 (11): 10
- 17 李才顺, 等. 河北中医. 1996; 18 (3): 9
- 18 徐木林, 等. 天津中医. 1996; 13 (6): 12
- 19 陆朴菴, 等. 中成药. 1995; 17 (10): 25
- 20 李万鹏, 等. 中医杂志. 1995; 36 (5): 294
- 21 顾丽芳, 等. 上海中医药杂志. 1995; (2): 44
- 22 陈大水. 中西医结合实用临床急救. 1996; 3 (7): 313
- 23 方铎悟. 浙江中医杂志. 1996; 31 (8): 381
- 24 陈达仁, 等. 中国中西医结合杂志. 1992; 12 (2): 71
- 25 傅仁杰. 中国医药学报. 1993; 8 (2): 24
- 26 戴维葆, 等. 辽宁中医杂志. 1996; 23 (2): 64
- 27 宁华英, 等. 贵阳中医学院学报. 1996; 18 (3): 23
- 28 谢智慧, 等. 北京中医. 1997; (1): 14
- 29 杨秀兰. 长春中医学院学报. 1996; 12 (2): 14
- 30 沈 力, 等. 中西医结合实用临床急救. 1995; 2 (5): 198
- 31 薛恩彬, 等. 天津中医. 1997; 14 (1): 6
- 32 姚 兰. 黑龙江中医药. 1993; (1): 9
- 33 葛朝晖. 江苏中医. 1996; 17 (1): 15
- 34 李兆秋, 等. 辽宁中医杂志. 1996; 23 (2): 75
- 35 黄文柱. 辽宁中医杂志. 1995; 22 (10): 466
- 36 王淑云, 等. 中医杂志. 1996; 37 (8): 481
- 37 刘兆元, 等. 实用中医药杂志. 1996; 12 (5): 25
- 38 张学安. 实用医学杂志. 1991; 7 (5): 261
- 39 吴重玲, 等. 中西医结合实用临床急救. 1995; 2 (6): 242

- 40 胡金明 . 实用医学杂志 .1996; 12 (7): 476
- 41 郁云亚 . 上海针灸杂志 .1993; 12 (2): 54
- 42 郭朝印, 等 . 陕西中医 .1989; 10 (11): 516
- 43 邹循昌, 等 . 中西医结合杂志 .1990; 10 (4): 199
- 44 王建新, 等 . 中国针灸 .1991; 11 (3): 1
- 45 于学平, 等 . 针灸临床杂志 .1997; 13 (2): 13
- 46 崔玉莹, 等 . 针灸学报 .1992; 8 (1): 19
- 47 房 丽, 等 . 上海针灸杂志 .1996; 15 (5): 7
- 48 张学鉴 . 中国康复医学杂志 .1995; 10 (2): 85
- 49 温瑞书, 等 . 山东中医学院学报 .1995; 19 (2): 119
- 50 朱永志, 等 . 黑龙江中医药 .1992; (3): 38
- 51 胡从富 . 浙江中医杂志 .1994; 29 (8): 352

(梁 冰)

96.97%。两组疗效比较无显著差异， $P > 0.05^{[5]}$ 。

5 中药针剂治疗

5.1 蓝恭洲用血塞通注射液治疗腔隙性脑梗塞 20 例

本组均用本品（系三七皂甙制剂）400mg 加入 10% 葡萄糖 500ml/日 1 次静滴，15 日为 1 疗程。对照组 20 例用维脑路通 400mg 加入脉通 500ml/日 1 次静滴，14 日为 1 疗程。疗程间隔均 7 日。均采用常规吸氧、降颅压、维持适当血压、使用激素、纠正水电解质平衡等治疗。结果：两组分别基本痊愈 6、4 例，显效 10、4 例，好转 3、5 例，无效 1、7 例。本组疗效显著优于对照组（ $P < 0.05$ ）^[6]。

5.2 黄玉春采用自血光量子加蝮蛇抗栓酶治疗腔隙性脑梗塞 A 组 48 例，用自血光量子法：取患者静脉血 200ml，缓慢流入含 25% 枸橼酸钠袋内，再倒入无菌石英玻璃瓶内经紫外线照射和充氧 8~10 分钟，立即回输，2 日 1 次，6 次为 1 疗程。并用蝮蛇抗栓酶 0.5~0.75u，加生理盐水 500ml，静滴，日 1 次，14~21 日为 1 疗程。B 组 18 例，C 组 30 例，分别用上两法。结果：三组分别治愈 44、15、23 例，显效 3、2、4 例，有效 1、1、2 例，无效 0、0、1 例^[7]。

6 眼针疗法

郑毓英采用眼针治疗腔隙性脑梗塞 75 例 纯运动性卒中取双眼的上焦穴、下焦穴。构音困难——手笨拙综合征配心区、肝胆区；高血压或纯感觉障碍配肝胆区；二便失禁配肾区、膀胱区。用左手压住眼球，并使眼皮绷紧，右手持 30 或 32 号 5 分针，在距眶缘周穴区 2 分许沿皮刺，顺经穴分布进针，用补法，不提插捻转，留针 15~20 分钟，日 1 次，10 次为 1 疗程。疗程间隔 3~5 日，病重者

加用体针。结果：基本治愈 39 例，显效 24 例，有效 11 例，无效 2 例，总有效率 97.3%^[8]。

参 考 文 献

- 1 刘冬立. 中国医药学报 .1994; 9 (4): 29
- 2 徐京玉, 等. 中医药学报 .1990; (5): 32
- 3 李 磊, 等. 吉林中医药 .1993; (5): 11
- 4 陆智慧, 等. 安徽中医临床杂志 .1996; 8 (2): 57
- 5 王训国, 等. 湖北中医杂志 .1993; 15 (5): 5
- 6 蓝恭洲. 上海中医药杂志 .1992; (4): 6
- 7 黄玉春. 实用中医药杂志 .1997; 13 (2): 35
- 8 郑毓英. 山西中医 .1995; 11 (6): 35

(邱 莉)

脑血栓形成

脑血栓形成亦称动脉粥样硬化性血栓形成性脑梗塞，简称动脉硬化性脑梗塞。是指颈动脉、椎—基底动脉系统，由于动脉管壁病变，或（和）血液有形成分凝聚，使管腔狭窄或闭塞，以致相应部位脑组织缺血或坏死。多属于中医学“中风”之范畴。

1 辨证论治

1.1 雷衍光辨证治疗脑血栓形成 53 例 风痰中腑致瘀，药用秦艽、羌活、桃仁、红花、赤芍、当归、大黄、枳实、瓜蒌皮、胆南星、僵蚕、石菖蒲、远志。急煎 1 次温服，大便通畅为度。治疗 1~3 日。继用瓜蒌皮、胆南星、法夏、陈皮、当归、赤芍、川芎、蜈蚣、僵蚕、川牛膝、桃仁、红花、桑枝、羌活。疗程 15~45 日。气虚痰浊致瘀，药用黄芪、当归、川芎、赤芍、桃仁、红花、瓜蒌皮、胆南星、法夏、僵蚕、蜈蚣、远志、石菖蒲、桑枝、炙甘草。疗程 20~55 日。阴虚风动致瘀，药用生地、熟地、玄参、川牛膝、当归、赤芍、川芎、桃仁、红花、龟板、珍珠母、僵蚕、蜈蚣、桑枝、知母、石菖蒲、炙远志、炙甘草。均日 1 剂水煎服。疗程 70~80 日。少数有严重并发症者加用部分西药对症处理。结果：基本治愈 28 例，显效 16 例，好转 7 例，无效 2 例，总有效率 96.2%^[1]。

1.2 张海顺等应用中风康复丸治疗脑血栓形成 85 例 肝阳上亢，风痰阻络型，用本品 I 号：羚羊角 10g，鳖甲、穿山甲、威灵仙、龟板、钩藤各 20g，桑寄生 100g，石决明、代赭石、当归、土鳖虫、龙胆草、地龙、丹参各

舌紫斑，脉滞涩等；方中每用虫类药；血压过高者，黄芪用量不宜过大^[4]。

2 一方为主 辨证加减

傅辉用四虫活血汤为主辨证加减治疗脑血栓形成 26 例 本方含水蛭、山药各 15g，蜈蚣 3 条，僵虫 12g，全蝎 6g，丹参 24g，川芎、甘草各 10g。气滞血瘀型加红花、地龙、郁金；气虚血瘀型加生黄芪、当归、鸡血藤；风痰阻络型加胆星、竹沥、远志、菖蒲；阴虚阳亢型加龟板、女贞子、磁石、钩藤；脑水肿明显者加大黄、牛膝。日 1 剂水煎服，10 剂为 1 疗程。治疗 30~120 日后，临床治愈 16 例，显效（症状明显好转，瘫痪侧肌力提高Ⅲ级以上，生活能自理）5 例，进步（肌力提高Ⅱ~Ⅲ级，生活部分自理）4 例，无效 1 例^[5]。

3 一方为主 随症加减

3.1 伍世林等用通栓汤治疗脑血栓形成 68 例 本组用本方：黄芪 45g，丹参 15g，水蛭（研末吞服）、三七（研末冲服）各 3g，地龙、赤芍各 10g。喉间痰多加制南星、川贝母；便秘加川大黄。日 1 剂水煎服。对照组 68 例，用维脑路通 0.4g，加 10% 葡萄糖液 500ml，静滴，日 1 次；潘生丁 50mg/日 3 次口服。有合并症对症处理。疗程均 30 日。结果：两组分别治愈 19、15 例，显效 33、25 例，有效 13、14 例，无效 3、14 例，总有效率 95.56%、79.34% ($P < 0.05$)^[6]。

3.2 杨玉坤等用健步通栓汤为主治疗脑血栓形成 150 例 本方含黄芪、丹参各 30g，川芎 12g，水蛭粉 4g（冲服），全蝎、当归、川牛膝各 10g，地龙、桑枝各 15g，益母草 20g。气虚血瘀重用黄芪；肝肾阴虚或阴虚阳亢减黄

芪量，加山萸肉、枸杞子、生龙骨、生牡蛎；痰湿阻滞加半夏、陈皮、薏苡仁；兼热加黄连；失语加白附子、石菖蒲、胆南星；肌张力低重用黄芪，加杜仲；肌张力高加木瓜、伸筋草。日1剂水煎服，1个月为1疗程。颈动脉加压滴注复方脑栓通针剂，隔日1次，15次为1疗程，同时每日静滴脉络宁或低分子右旋糖酐。急性期视病情予甘露醇及脑细胞活化剂。对照组80例，静滴脉络宁或低分子右旋糖酐加丹参针，日1次，15日为1疗程。结果：两组分别痊愈107（71.33%）、46（57.5%）例，显效31（20.67%）、13（16.25%）例，好转9（6%）、12（15%）例，无效3（2%）、9（11.25%）例，总有效率为98%、88.75%（ $P < 0.05$ ）^[7]。

3.3 俞大毛用消栓汤治疗脑血栓形成68例 本方含丹参20g，川牛膝15g，大黄6g，川芎、葛根、桃仁、红花、赤芍、僵蚕、地龙、天竺黄、制胆星各10g。大便干燥或秘结加玄明粉；瓜萎实、炒莱菔子；痰多失语，舌苔厚腻加菖蒲、郁金、鲜竹沥；意识障碍加羚羊片、安宫牛黄丸；血压偏高加钩藤、石决明。日1~2剂。治疗20日后，基本痊愈29例，显著好转（神经系统症状部分消失，偏瘫明显好转，肌力达3~4级，能扶杖步行，生活基本能自理）16例，好转12例。无效11例，总有效率83.8%^[8]。

3.4 杨承岐用消栓振废汤治脑血栓形成35例 本组患者均经脉通，维脑路通等药治疗1周以上症状无明显改善。本方组成：川芎、桂枝、鸡血藤各30g，葛根、羌活、当归各15g，黄芪60~120g，地龙、炒三棱、炒莪术、石菖蒲、乌梢蛇各10g，甘草6g。头晕肢麻、血压高加天

麻、石决明；上肢瘫痪严重加桑枝、姜黄；下肢瘫痪严重加川牛膝、杜仲；口眼歪斜严重加白附子、僵蚕；语蹇流涎严重加胆南星、远志；舌红无（少）苔者加白芍、知母。服药 20 ~ 100 日后，痊愈 14 例，显效（语言基本流畅，步履稳健，上肢功能基本正常但不灵活，能参加一般体力劳动）13 例，好转（语言及肢体功能有所恢复，生活基本自理，留有明显后遗症）7 例，无效 1 例^[9]。

3.5 李学文等用通络溶栓汤治疗脑血栓 86 例 本方含黄芪 60 ~ 120g，当归、川芎、桃仁、红花各 10 ~ 15g，蜜虫 4 ~ 6g，桂枝 6 ~ 12g，丹参 20 ~ 30g，赤芍、地龙、葛根各 15 ~ 20g，炮穿山甲 6 ~ 10g，甘草 6g。阴虚去桂枝加生地、玄参各 15g；失语加菖蒲、郁金各 12g；口眼歪斜加白附子 10g，全蝎 4g；肢体麻木加鸡血藤 30g；痰多有内热去桂枝加胆南星 10g，鲜竹沥（兑服）30g；气虚痰湿瘀阻加苍术、茯苓各 12g，陈皮 6g；高血压加石决明 40g；血压低者加太子参 20g；血脂高加何首乌 25g，山楂 50g。日 1 剂，水煎服。10 日为 1 疗程，疗程间隔 1 ~ 3 日。经治 2 ~ 3 个疗程，治愈 60 例，显效 23 例，好转 2 例，无效 1 例，总有效率 99%^[10]。

3.6 刘万森用导痰通络汤治疗脑血栓 本组 37 例，用本方：清半夏、橘红、泽泻、菖蒲各 12g，枳实、红花、黄连、大黄、僵蚕各 10g，茯苓、丹参各 20g，甘草 6g。血压偏高加菊花、夏枯草、生石决明；言语蹇涩加远志、全蝎；高血脂加何首乌、山楂。日 1 剂水煎服，15 日为 1 疗程。结果：治愈 28 例，显效 6 例，有效 2 例，无效 1 例^[11]。

3.7 陈昌和用起瘫汤治疗脑血栓 24 例 本组用本

方：黄芪 50g，草决明 20g，当归、川芎、地龙各 10g，白附子 6g。咽间多痰加制南星、川贝母；便秘去草决明，加白术、淮山药；腹胀便秘去白附子，加枳实。日 1 剂水煎分 2 次，各送服药末（含田三七、西洋参各 3g，水蛭 2g，研末拌匀，等分 2 包）1 包。对照组 24 例，用脑复新 0.2g，潘生丁 25mg/日 3 次口服；西比灵 5mg，睡前服。高血压加用复方降压片 1 片/日 3 次口服。疗程 30 日。结果：两组分别基本痊愈 13、5 例，显效各 6 例，有效 4、6 例，无效 1、7 例，总有效率 95.8%、70.8% ($P < 0.05$)^[12]。

3.8 杨昌祖用丹芪汤治疗脑血栓形成 37 例 本方含黄芪 20 ~ 40g，丹参 15 ~ 30g，桃仁、红花、地龙常规用量。随症加减。除 3 例治疗 > 60 日外，其余治疗 15 ~ 60 日。结果：显效（瘫痪肢体活动恢复，患侧肌力与健侧相近，生活能自理）21 例，好转（症状好转肢体活动较健侧为差，生活不能完全自理）14 例，无效（经治疗 60 日后，好转不明显）2 例指出黄芪、丹参两药大剂量同用，可相互辅佐，提高疗效^[13]。

3.9 王明侠从痰瘀论治脑血栓 60 例 本组患者病程 3 ~ 7 日，均口服涤痰汤，用胆南星 6 ~ 9g，白术、白芍、竹茹、半夏、枳实、黄芩、石菖蒲各 9g，橘红 6g，甘草 3g。阴虚加生地、麦冬、玄参；阳亢加羚羊角粉、石决明、钩藤；痰多加天竺黄、川贝、郁金；呃逆加旋覆花、代赭石、刀豆子；抽搐加鳖甲、龟板、牡蛎；发热加薄荷、青蒿、黄芩；气虚加黄芪；便秘加生川军；昏迷嗜睡者加至宝丹。每日以复方丹参注射液 8ml 加 5% 葡萄糖 250ml 静滴。均 14 日为 1 疗程。颅内压增高明显者予 20%

甘露醇 250ml, 2~3 次/日, 连用 3~5 日, 严重者适当加激素; 合并感染者加抗生素。治疗 1~2 疗程后, 痊愈 31 例, 显效 14 例, 好转 10 例, 无效 5 例^[14]。

3.10 宋涌文等以益气活血、祛瘀通络为主治疗脑血栓形成 58 例 药用生黄芪 30~120g, 当归、川芎各 15g, 香附、赤芍、桃仁各 10g, 红花 6g, 丹参 30g, 地龙 12g。随症加减, 日 1 剂水煎服。三虫散 (全蝎、蜈蚣各 1 份, 土鳖虫 2 份, 为末) 3g/日 2 次, 白开水或米酒送服。20 日为 1 疗程。结果: 临床治愈 35 例, 显效 14 例, 好转 8 例, 无效 1 例^[15]。

4 固定方治疗

4.1 赵力等用稀莖通栓丸治疗脑血栓 本组 70 例用本品 (含稀莖草 200g, 水蛭 100g, 三七、当归、桃仁、红花各 60g, 川芎、天南星各 40g, 麝香、冰片各 5g, 粉碎, 炼蜜制成 250 丸, 每丸含生药 2.15g。吉林抚松制药厂生产) 1 丸/日 3 次口服。对照 A 组 60 例用维脑路通 500mg 加低分子右旋糖酐 500ml 静滴, 日 1 次。对照 B 组 36 例用环扁桃酯胶囊 (每粒含生药 0.1g) 3 粒/日 3 次口服。均 2~3 周为 1 疗程。用 1~2 个疗程后, 3 组分别治愈 22、15、8 例, 显效 36、22、14 例, 好转 10、12、8 例, 无效 2、11、6 例, 总有效率 97.1%、81.7%、83.3%。本组疗效优于两对照组 ($P < 0.01$)。1 个疗程后复查 CT, 3 组分别显效 31、16、9 例, 有效 30、25、17 例^[16]。

4.2 南征等用麝香抗栓丸治疗脑血栓形成 442 例 本品含水蛭、麝香、三七、天麻、乌梢蛇、大黄、黄芪、赤芍、当归尾等药。本组用本品 1 丸/日 3 次口服。对照组 100 例用补阳还五汤原方水煎服。均 2 周为 1 疗程。治

疗2周后两组分别治愈97、18例，显效207、32例，好转103、39例，无效35、11例，总有效率为92.1%、89%。病程在1月以内者疗效最好，1年以上者疗效差。分型以气滞血瘀型疗效最好^[17]。

4.3 周里用血栓解治疗脑血栓形成 243例 方药：水蛭、郁金、川芎。按1.5:2:3的比例破碎、混合制成片剂，每片重0.3g。6片/日3次口服，7日为1疗程，疗程间隔2日，共服8个疗程。在用本品期间，停用其它药物；对伴有高血压、冠心病者，停用或延用原来药物；对神志欠清，服片剂困难者，可将药研碎，用水缓缓送服。结果：基本痊愈99例（其中完全性瘫痪者11例，不完全性瘫痪者88例），显效73例，进步35例，无效36例，总有效率85%^[18]。

4.4 赵力等用血栓心脉宁治疗脑血栓 治疗组158例，用本品（取麝香、冰片、蟾酥各5g，牛黄50g，川芎、丹参各2000g，槐花米、毛冬青各1000g，水蛭500g。）2~4粒/日2次口服，3~4周为1疗程。对照组117例，用低分子右旋糖酐加维脑路通。结果：治愈加显效分别为98例，占62.1%、45例，占38.5%，总有效率为96.3%、86.3%。两组比较有显著差异 $P < 0.01$ 。血脂及血液流变性测定结果证明，本品具有改善脑、心缺血作用，可增加脑血流量，降低血脂、血粘度、红细胞压积和血小板聚集率（ $P < 0.01$ ）。药理实验亦证实本品对实验家兔和大鼠具有上述作用。本品无毒副作用^[19]。

4.5 苏文弟等以桃红四物汤治疗脑血栓形成 本组用本方加减：桃仁、红花、当归、川芎各10g，赤芍、益母草各15g，丹参30g，水蛭粉6g（冲）。日1剂水煎服。

对照组用 20% 低分子右旋糖酐 500ml，静滴，日 1 次，用 15 日停 5 日，再用 15 日。输液间隔期用脉通 1 粒，维脑路通 200mg，均日 3 次口服。两组各 26 例，治疗 2 个月，结果分别痊愈 19、16 例，好转 5、2 例，无效 1、7 例，死亡各 1 例。本组疗效优于对照组 ($P < 0.05$)^[20]。

4.6 支楠用苏心通脑灵治疗脑血栓形成 120 例 本组用本品 I 号（含川芎、丹参各 15g，桃仁、山楂各 10g，郁金、青皮各 20g，制成液体，浓度 80%）50ml，II 号（含三七、细辛、川椒、沉香各 3g，琥珀 5g，熊胆粉 1g，西洋参 20g。研细粉。均为北京同仁医院研制）1g，日 2 次冲服。对照组 80 例，用补阳还五汤，日 1 剂水煎服。均 30 日为 1 疗程，用 3 个疗程。结果：两组分别治愈 35、10 例，明显进步 54、24 例，进步 18、16 例，恶化 13、30 例，总有效率 89.2%、62.5% ($P < 0.001$)。血液流变学 3 项（全血粘度、血浆粘度、血小板粘附率）指标本组治疗前后比较均有显著性差异， $P < 0.01$ 、0.05^[21]。

4.7 周端求用康圣灯盏花素片治疗脑血栓形成 84 例 本组用本品（每片 20mg，湖南湘潭制药三厂生产）40mg；对照组 72 例，维脑路通片（每片 0.1g，河南商丘制药厂生产）0、2g；均日 3 次口服，20 日为 1 疗程。用 1~2 个疗程，结果：两组分别基本治愈 40、34 例，显著进步 28、12 例，进步各 12 例，无效 4、14 例，总有效率 95%、80.5% ($P < 0.05$)。本组个别患者见皮肤瘙痒，停药后消失^[22]。

5 中药针剂治疗

5.1 刘莘辨证应用中成药静脉点滴治疗脑血栓 116 例 本组肝阳上亢、阳化风动型和痰热壅盛、风痰上扰型

16kPa，意识障碍或精神症状明显者停用。术者要集中精力，匀速推注；患者尽量避免咳嗽、讲话、吞咽动作等。日1次，5次为1疗程。对照组472例，用本品20ml，加低分子右旋糖酐500ml，静滴，日1次，7次为1疗程。均疗程间隔2日。治疗1~3个疗程，结果：两组分别痊愈326（43.5%）、138（29.2%）例（ $P < 0.05$ ），显效232（30.9%）、206（43.6%）例，好转177（23.6%）、114（24.2%）例，无效15（2.0%）、14（3.0%）例。病程<3个月、不完全性偏瘫痊愈率分别为46.6%、31.6%，50.6%、33.9%（ P 均 < 0.05 ）^[25]。

5.4 顾选文以复方丹参为主治疗脑血栓形成200例

本组均为急性脑血栓形成患者，病程<2~>5日。用上海第九制药厂生产的复方丹参注射液16ml加入5%葡萄糖500ml中静滴，每日1次，14次为1疗程，疗程间隔7日。第1疗程期间口服小续命汤；第2疗程用补阳还五汤加生白术。均每日煎服1剂。经2~3疗程治疗后，痊愈（肢体活动自如，语言清晰，肌力恢复至IV~V度，能参加适当劳动）118例，显效56例，有效17例，无效9例，总有效率为95.5%。对50例患者进行了体外血栓形成测定，结果治后各指标均明显下降（ $P < 0.001$ ）；对30例患者下肢主要肌群的肌力测定结果，表明治后均提高3~4倍^[26]。

5.5 赵洪斌以刺五加为主治疗脑血栓20例 本组病程<2个月~4年，均经脑CT检查确诊。主要治疗用刺五加注射液40ml加入1%的葡萄糖300ml中静滴，日1次，必要时日2次，14日为1疗程；辅助药用黄芪、桂枝、牛膝、赤芍、白芍、当归、天麻、半夏、鸡血藤、地龙、白

术、川芎、白附子、桃仁、防己。水煎服，日1剂。有些患者加服回天再造丸、消栓再造丸、醒脑再造丸。2例治疗4个疗程，余均3个疗程。结果：治愈12例，显效（肌力提高2级以上，生活基本自理）6例，无效2例^[27]。

5.6 林勉生等用川芎嗪、复方丹参治疗脑血栓形成53例 川芎嗪组31例，予脉通注射液500ml加川芎嗪80mg；复方丹参组22例，予脉通注射液500ml加复方丹参8ml。静滴，每日1次，15日后，川芎嗪组有效率为93.55%（显效14例，有效15例，无效2例），复方丹参组有效率为68.18%（显效5例，有效10例，无效7例），两组有显著性差异， $P < 0.05$ 。血液流变学指标检测表明，川芎嗪组红细胞压积、全血粘度和纤维蛋白原的平均水平均较治前显著降低（ $P < 0.05 \sim 0.001$ ），血浆粘度和红细胞电泳时间则与治前无显著差异（ $P > 0.05$ ）；复方丹参组治疗前后血液流变学指标虽有所改善，但均无统计学意义（ $P > 0.05$ ）。说明川芎嗪在改善血液流变学方面优于复方丹参。本研究结果提示复方丹参治疗缺血性脑血管病可能主要不是通过改善血液流变学这一途径而起作用^[28]。

6 中西医结合

6.1 何友作等用维脑路通加补阳还五汤治疗脑血栓形成 104例患者随机分为治疗组53例和对照组51例，均肌注太原第二制药厂生产的维脑路通注射液200mg/日2次。注意纠正水电解质紊乱，控制感染，有脑水肿时用甘露醇。治疗组同时口服汤剂，药用黄芪40g，当归尾、赤芍、地龙、桃仁、红花各9g，川芎6g，兼口眼歪斜者加僵蚕（炙）5g，白附子10g，全蝎3g，每日1剂。两组均用药20天。结果：治疗组基本治愈32例，显著进步14

例，进步 5 例，无效 2 例；对照组分别为 17 例、10 例、14 例和 6 例，另有恶化及死亡各 2 例。有效率分别为 96.2% 和 80.4%。治疗组疗效明显高于对照组， $P < 0.01^{[29]}$ 。

6.2 张振东等中西医结合治疗脑血栓形成 102 例

用当归芍药散加味：当归、赤芍、茯苓、白术、泽泻、甘草各 10 ~ 20g，川芎，全蝎各 15 ~ 30g，蜈蚣 10 ~ 20 条，水蛭 10 ~ 30g。便秘加生大黄；痰多加胆星；气虚加黄芪；血瘀明显水蛭用至 30 ~ 50g。日 1 剂水煎服。低分子右旋糖酐 500ml 加维脑路通 8ml/日 1 次静滴。结果：痊愈 54 例，显效 40 例，好转 7 例，无效 1 例，总有效率 99%^[30]。

6.3 罗家盛中西医结合治疗脑血栓形成

对照 A 组 30 例用黄芪 50 ~ 100g，归尾 20 ~ 40g，川芎、桃仁、红花各 10 ~ 20g，地龙 20 ~ 50g，豨莶草 10 ~ 15g，丹参 20 ~ 30g。重症早晚各 1 剂水煎服，恢复期日 1 剂。对照 B 组 30 例，常规西药治疗：脑活素、低分子右旋糖酐、维脑路通等静滴，配合降压、对症治疗。本组 60 例，同时用上述两种治法。均 2 ~ 3 周为 1 疗程。治疗 1 ~ 2 个疗程。结果：本组与对照 A、B 组分别治愈 50、19、19 例，显效 5、5、4 例，好转 4、2、3 例，无效 1、4、4 例，总有效率为 98.3%、86.7%、86.7%，本组疗效优于两对照组 (P 均 < 0.01)^[31]。

6.4 肖云平等中西医结合治疗脑血栓形成 60 例

用偏瘫行气通栓汤：木香 25g，槟榔片、厚朴各 30g，枳壳、丹参各 20g，当归、川芎、桃仁各 15g，红花、伸筋草各 10g。随症加减。日 1 剂水煎服，7 日为 1 疗程，疗程间隔

3日。并予精制蝮蛇抗栓酶0.5~1u,胞二磷胆碱注射液0.5g,加生理盐水(或10%葡萄糖)250ml,静滴,日1次,6次为1疗程,疗程间隔2日。配合针刺疗法。对照组60例,用不同于本组的扩张血管药。结果:两组分别治愈24(40%)、10(16.7%)例,显著好转18、20例,好转16、18例,未愈2、12例,总有效率96.7%、80%($P<0.05$)^[32]。

参 考 文 献

- 1 雷衍光.湖南中医杂志.1992; 8(1): 9
- 2 张海顺,等.陕西中医.1994; 15(3): 107
- 3 宋伯良,等.中医研究.1995; 8(6): 41
- 4 张恩麟.湖南中医杂志.1988; 4(3): 4
- 5 傅辉.湖北中医杂志.1991; 13(6): 14
- 6 伍世林,等.北京中医.1995; (5): 42
- 7 杨玉坤,等.国医论坛.1995; (3): 24
- 8 俞大毛.浙江中医杂志.1987; 22(10): 441
- 9 杨承岐.新中医.1991; 23(1): 32
- 10 李学文,等.安徽中医学院学报.1993; 12(2): 22
- 11 刘万森.四川中医.1994; 12(7): 23
- 12 陈昌和.新中医.1994; 27(1): 38
- 13 杨昌祖.湖北中医杂志.1991; 13(3): 7
- 14 王明侠.上海中医药杂志.1989; (11): 17
- 15 宋诵文,等.新中医.1989; 21(7): 21
- 16 赵力,等.中国中西医结合杂志.1994; 14(2): 71
- 17 南征,等.中医杂志.1992; 33(1): 33
- 18 周里.北京中医.1987; (6): 24
- 19 赵力,等.中西医结合杂志.1991; 11(6): 327

- 20 苏文弟, 等. 天津中医学院学报 1995; 14 (4): 25
 - 21 支楠. 中国中西医结合杂志 .1997; 17 (2): 101
 - 22 周端求. 中国中医急症 1996; 5 (5): 207
 - 23 刘芊. 中级医刊 .1994; 29 (12): 44
 - 24 焦桐范, 等. 陕西中医学院学报 .1993; 16 (2): 31
 - 25 孟庆良, 等. 中西医结合实用临床急救 .1996; 3 (2): 49
 - 26 顾选文. 上海中医药杂志 .1989; (7): 5
 - 27 赵洪斌. 甘肃中医学院学报 1988; (1): 27
 - 28 林勉生, 等. 河北中医 .1990; 12 (5): 3
 - 29 何友作, 等. 中级医刊 .1988; 23 (10): 52
 - 30 张振东, 等. 实用中西医结合杂志 .1993; 6 (7): 420
 - 31 罗家盛. 中西医结合实用临床急救 .1996; 3 (3): 101
 - 32 肖云平, 等. 实用中西医结合杂志 1996; 9 (3): 145
- (邱莉)

■

脑出血

脑出血又称出血性脑卒中或脑溢血，是指脑实质内出血。此病绝大多数是高血压动脉硬化，脑内小动脉破裂所致，属于中医学“中风”、“偏枯”范畴。

1 辨证论治

1.1 孙怡等辨证治疗脑出血 84 例 痰热蒙蔽清窍型 25 例，药用羚羊角粉（冲）、天麻、钩藤、栀子、益母草、天冬、生石决明（先煎）、黄芩、生大黄（后下）、白芍、元参、竹沥，合用安宫牛黄丸，疗程 5~74 日，平均 49 日。痰热阻络型 21 例，药用陈皮、半夏、竹茹、茯苓、枳实、远志、菖蒲、黄芩、水蛭、生大黄（后下），疗程 15~122 日，平均 56 日。脉络空虚、风邪入络型 21 例，药用秦艽、羌活、川芎、桂枝、黄芩、生地、当归、牛膝、赤芍、水蛭，疗程 30~50 日，平均 38 日。气虚血瘀型 12 例，药用黄芪、川芎、地龙、红花、桂枝、赤芍、当归、桃仁、牛膝、生大黄，疗程 18~82 日，平均 48 日。阴虚风动型 5 例，药用生地、麦冬、牛膝、石斛、知母、当归、山萸肉、枸杞子、水蛭、菖蒲，疗程 40~108 日，平均 72 日。有合并症者予西药对症治疗。结果：基本治愈 40 例（以脉络空虚、风邪入络型最高），显效 16 例，有效 17 例，死亡 11 例^[1]。

1.2 张伯勋报道用大黄、葶苈子加辨证治疗急性脑出血 中经络肝阳暴亢者用夏枯草、龙骨、牡蛎、白芍、牛膝、钩藤、黄芩、泽泻、元参；风痰瘀阻者用胆南星、半夏、竹茹、全瓜蒌、菊花、当归、丹参、川芎；阴虚风

各 10g, 女贞子 15g, 怀牛膝、当归、地龙各 12g, 黄芪、丹参各 30g, 鸡血藤、葛根各 20g。均日 1 剂水煎服。早期加用安宫牛黄丸 1 丸, 清开灵注射液 20ml (北京中医学院生产) 加液体静滴; 昏迷者用鼻饲或灌肠给药。颅压高等症对症治疗。结果: 基本治愈 14 例, 显著进步 21 例, 进步 2 例, 稍进步 3 例, 无效 5 例, 总有效率 82.2%^[4]。

2 一方为主 随症加减

2.1 赵玉茶用熄风汤为主治疗脑出血急性期 两期病例均经颅脑 CT 检查证实。本组 44 例, 用天麻、钩藤、生地、夏枯草各 20g, 羚羊角 2g, 黄芩、栀子、泽泻、车前子、益母草各 15g, 全蝎 5g, 石决明 25g。日 1 剂水煎服。痰多加胆南星、竹茹、石菖蒲各 15g; 大便燥结加番泻叶 5~10g/日泡水饮; 头痛呕吐频繁 (10 例) 加 20% 甘露醇 250ml, 6~12 小时次静滴, 连用 3~5 日; 神志不清安宫牛黄丸 1 丸/日 2 次鼻饲。对照组 40 例, 用 20% 甘露醇 250~500ml 静滴, 6~8 小时 1 次, 连用 5~7 日; 部分病例加用速尿、地塞米松静滴及降压药、抗感染药; 个别病例用氨乙酸、止血芳酸等, 并对症治疗。结果: 两组分别治愈 29、15 例, 好转 12、14 例, 无效 1、6 例, 死亡 2、5 例。本组疗效优于对照组 ($P<0.01$)^[5]。

2.2 潘洋采用活血化瘀、清热化痰法治疗高血压性脑出血 34 例 用大黄、珍珠母各 10g, 鸡血藤、血竭、菖蒲、胆南星各 15g, 水蛭 5g, 水牛角 30g, 赭石 25g, 牛膝 20g。随症加减, 日 1 剂水煎服或鼻饲; 15 日为 1 疗程。用 1 个疗程, 结果: 好转 25 例, 无变化 1 例, 恶化 3 例, 死亡 5 例, 总有效率 73.5%^[6]。

2.3 何华用脑衄汤治疗脑出血急性期 80 例 本方含

羚羊角粉 3~6g (冲服), 钩藤 30g, 水牛角 10~30g, 生地、白芍各 15~30g, 丹皮、竹茹各 15g, 栀子、陈皮各 12g, 三七粉 3g (冲服), 甘草 6~10g。神志不清加菖蒲、远志; 血压高加石决明、夏枯草、生龙骨、生牡蛎; 喉中痰鸣, 烦躁, 苔黄厚加胆南星、天竺黄; 腹胀便秘加大黄; 头痛, 呕吐甚加半夏、茯苓、益母草; 呕血或便血, 配服大黄粉、白及粉、云南白药。日 1 剂水煎分 3 次口服或鼻饲。合并症用脱水、降压、抗感染、吸氧、营养支持疗法等。结果: 基本治愈 32 例, 显效 28 例, 有效 12 例, 无效、恶化各 4 例, 总有效率 90%。未见毒副反应。神经功能积分及 CT (53 例) 值治疗前后比较均有显著性差异, $P < 0.001^{[7]}$ 。

3 中西医结合

3.1 郑安等报道中西医结合治疗脑出血的临床和 CT 观察 本组前 2 周用中风 I 号口服液 (黄芩、黄连、天竺黄、天麻、钩藤、夏枯草、白芍、木通、桑白皮、丹皮、生地、九节菖蒲等), 后 2 周用中风 II 号口服液 (党参、钩藤、地龙、赤芍、桃仁、红花、当归、黄芪、丹参、珍珠母、川芎、徐长卿、葛根等)。同时用降低颅压、抗脑水肿、降血压、神经营养等药物, 以及维持水、电解质平衡、支持疗法等。对照组用西医治疗, 均 4 周为 1 疗程, 均在起病 1~3 日治疗。两组各 24 例, 分别痊愈 7、5 例, 好转 16、11 例, 无效 1、8 例。有效率 95.83%、66.67%, 两组疗效和血肿全部吸收率比较均有显著性差异, $P < 0.01$ 和 $0.05^{[8]}$ 。

3.2 刘茂才中西医结合治疗脑出血 66 例 本组轻型 15 例, 中型 41 例, 重型 10 例; 发病 24 小时~14 日。治

法：甲组 58 例病情相对较缓，用毛冬青甲素 20~40mg 或盐酸川芎嗪 80~160mg，加 10% 葡萄糖液 500ml 静滴，日 1 次；丹参注射液 4ml/日 2 次肌注；口服剂川芎嗪片、毛冬青甲素胶囊、华佗再造丸、西黄丸等，随症选用 1~2 种。不用任何止血剂。乙组 8 例，病情相对较急，运用止血剂，抗血纤溶芳酸 0.2~0.4g 加 10% 葡萄糖液 500ml 静滴，日 1 次，一般用 7~10 日；安络血 10~20mg 日 2 次肌注。均对症治疗。治疗 1 个月，甲、乙组分别为治愈 15 例、0 例，显效 22 例、2 例，有效 16 例、2 例，无效 2 例、0 例，死亡 3 例、4 例，总有效率 91.38%、50%。接受治疗时间愈早，疗效愈高^[9]。

3.3 张文学中西医结合治疗急性脑出血 53 例 用羚羊角粉 3g（冲服），钩藤 20g，菊花、白芍、玄参各 15g，菖蒲、黄芩、竹茹各 12g，川贝 9g，甘草 6g。痰盛加胆南星、天竺黄；便干加大黄（后下）。日 1 剂水煎服或胃管灌入。并用大黄（后下）、芒硝、川贝各 9g，厚朴、枳实、黄芩各 12g，双钩藤 15g，水煎 150ml，保留灌肠 30 分钟，日 1 次，用 5~10 日。西药脱水、降颅压、降压、抗感染、抗休克等对症处理。治疗 1~3 个月，结果：临床痊愈 27 例，显效 16 例，有效 8 例，无效 2 例，总有效率为 96.2%^[10]。

3.4 陆朴堯等治疗重度脑出血 25 例 本组急性期：用安宫牛黄丸 1~2 丸/日分 2~3 次水化鼻饲，用 7 日。地塞米松 5mg，加 20% 甘露醇 250ml，静滴，日 1~3 次；血清白蛋白或干糖浆 20ml，加 5% 葡萄糖液 250ml，静滴，日 1 次，用 3~5 日。注意调整血压（心痛定 10mg/日 3 次口服或舌下含）、止血（止血芳酸 0.4~0.6g，加 5% 葡萄

糖液 500ml，静滴，日 1 次，用 7 日）、预防感染（青霉素 400 万 u，加 5% 葡萄糖液 500ml，静滴，日 1 次；用 0.5% 甲硝唑 100ml，静滴，日 2 次，用 7 日）。稳定恢复期：用补阳还五汤加减：黄芪 30g，当归尾、红花、桃仁泥、石菖蒲、炒赤芍、天竺黄各 9g，干地龙 12g，炙远志 5g，全瓜蒌 24g（打），川黄连 3g，生大黄 4.5g（后下），丹参 15g。语蹇炙远志加至 9g，石菖蒲减至 6g；便秘倍生大黄，加枳壳、火麻仁；偏瘫甚加水蛭、地鳖虫；高血压加石决明、珍珠母、生牡蛎，均先入。日 1 剂水煎服，于中风后 1 周开始服。西药用脑活素 10~20mg，静注，10~20 日为 1 疗程。西药对照组 25 例。结果：两组分别痊愈 10、6 例，好转 15、12 例，无效 0、7 例，有效率 100%、72% ($P < 0.01$)^[11]。

3.5 杨林用脑衄化痰汤为主治疗脑出血 33 例 药用生黄芪 50g，海藻、仙鹤草、生地各 30g，地龙，泽泻各 20g，赤芍、当归、川芎各 10g，地鳖虫、参三七、甘草各 5g。血压高加决明子、生龙骨、生牡蛎；神昏窍闭加石菖蒲、天竺黄；舌强言蹇加胆南星；舌红少苔或无苔者加枸杞、山萸肉；舌紫甚加桃仁、红花；腑实加大黄、舌苔厚腻加莱菔。颅压高、烦躁头痛或昏迷、呕吐抽搐项强者，用 20% 甘露醇 200~250ml、50% 葡萄糖 60ml，快速静脉交替点滴，日 2~3 次。适当用抗生素、补液、维持水电解质平衡，血压高加利血平 1mg 肌注。结果：显效 18 例，好转 11 例，无效 3 例，死亡 1 例，总有效率为 87.9%^[12]。

3.6 陆志强用脑血宁为主治疗高血压性脑出血 22 例 本组均有意识障碍，病程 2.5~52 小时。用本品（含水蛭 3g，生大黄、怀牛膝各 8g，胆星 6g，水牛角、泽泻各

15g, 鸡血藤、代赭石、石菖蒲各 10g、青黛 5g。水煎浓缩, 每 100ml 含生药 63.5g) 100ml/日 2 次口服, 意识障碍者鼻饲。西医对症处理: 适当降低血压, 控制脑水肿, 防止出血, 改善脑缺氧, 维持水、电解质平衡等。对照组 20 例, 用上述西医疗法, 治疗 14 日。结果: 两组分别进步 16、6 例, 无变化 3、6 例, 恶化 1、3 例, 死亡 2、5 例。两组比较有显著性差异 $P < 0.05$ 。本品有改善微循环、控制和防止脱水等导致血液高粘滞综合征的作用^[13]。

3.7 林亚明治疗急性丘脑出血 本组 12 例予清开灵注射液 (北京中医学院实验药厂产) 40 ~ 60ml 加 5% ~ 10% 葡萄糖或 0.9% 生理盐水 400 ~ 500ml 静滴, 日 2 次, 连用 2 周, 1 周后改为日 1 次; 安宫牛黄丸、至宝丹或苏合香丸 1 丸/日 1 ~ 4 次口服、鼻饲或灌肠; 自拟解毒化痰涤痰汤: 酒大黄、白薇、木芙蓉叶、大青叶、竹叶、芦根、鱼腥草、炒水蛭、桃仁、红花、胆南星、石菖蒲等。水煎服, 鼻饲或低位灌肠。本组和对照组 (9 例) 均予西医控制血压、脑水肿、肺部感染、盐水平衡治疗, 并止血、对症治疗, 予能量合剂等。结果: 两组分别基本治愈 5、2 例, 显著进步 2、0 例, 进步 2、3 例, 无变化 1、0 例, 死亡 2、4 例, 总有效率 75%、55.56%。两组疗效比较有显著性差异, $P < 0.05$ ^[14]。

3.8 李相忠等用清开灵合通腑祛瘀散为主治疗脑出血急性期 50 例 本组用清开灵 50ml, 加 5% 葡萄糖液 250ml (糖尿病可加胰岛素 4u, 或用生理盐水), 缓慢静滴, 日 2 次。并用本散 (生大黄、地龙各 6g, 芒硝 3g, 共为细末) 15g, 加沸水 100ml, 溶解后, 口服或鼻饲或灌肠, 日 1 次, 根据大便情况加减药量。与对照组 50 例,

3.11 阎莉等中西医结合治疗脑出血急性期 251 例

(1) 神志清楚及嗜睡患者，取穴：内关、水沟、三阴交、极泉、委中、尺泽。吞咽障碍加风池、翳风、完骨；语言不利加金津、玉液刺络放血；烦躁者针刺百会、四神聪、神门或用西药镇静药。西医配合支持疗法。(2) 伴有意识障碍及颅压高的患者，取穴：印堂、上星透百会、风池、完骨、天柱。中枢性呼吸衰竭针刺气舍穴。配合清开灵静脉滴注；西医予脱水、冰袋、营养支持、抗感染、吸痰等对症治疗。结果：治愈 87 例，好转 58 例，无变化 32 例，死亡 74 例，总有效率 57.76%，总存活率 70.9%^[18]。

4 针灸疗法

4.1 陈守龙报道早期针刺治疗脑出血偏瘫 30 例 本组病程 0.5 小时 ~ 2 日。住院后全部经中西药物常规治疗，意识状态恢复后，于发病后 2 ~ 3 日最长不 > 10 日开始针刺治疗。治法：头针取运动区，左瘫取右侧，右瘫取左侧，快速捻转 200 次/分以上，连续 3 分钟，休息 5 分钟，反复 3 次，同时嘱患者主动运动患肢。体针取瘫侧腧穴，上肢取十二井穴（放血）、合谷、后溪、外关、内关、手三里、曲池、肩三针等；下肢取环跳、伏兔、髀关、足三里、阳陵泉、丰隆、绝骨、丘墟、解溪。血压高加太冲、太溪；失语加廉泉；便秘加支沟。平补平泻，留针 30 分钟，均日 1 次，12 次为 1 疗程。疗程间隔 2 ~ 3 日。头、体针同时进行。结果：1 疗程后功能基本恢复，肌力均在 4 级以上者 22 例；2 疗程后功能恢复正常者 8 例，接近正常人水平者 22 例^[19]。

4.2 李金亭等用针灸治疗脑出血 30 例 先直刺双侧内关 0.5 ~ 1 寸，用捻转提插泻法 1 分钟；继斜刺人中 0.5

寸，用重雀啄手法至流泪或眼球湿润为度；经胫骨后缘斜刺三阴交 1~1.5 寸，用提插补法，使患者下肢抽动 3 次；直刺极泉、尺泽 1~1.5 寸，提插泻法，使患者上肢抽动 3 次；仰卧，直腿抬高刺委中 1 寸，用提插泻法，使下肢抽动 3 次。吞咽障碍加风池、翳风、完骨，针向喉结 2~2.5 寸，小幅度、高频率捻转补法，每穴均 1 分钟；手指握固加合谷，针向三间穴，用提插泻法，使食指抽动；语言蹇涩取金津、玉液放血。结果：30~50 岁组、51~70 岁组各 15 例，血肿完全或大部吸收各 13、8 例，周边吸收各 2、7 例，30~50 岁组的疗效明显优于后者 ($P < 0.05$)^[20]。

4.3 许武定等采用微波针灸治疗脑出血 100 例 用 28 号或 30 号针刺曲池、手三里、阴市、中三里穴，得气后，将 DBJ—1 型微波针灸仪接到针柄上，调整好输出功率，以患者无刺痛为度。隔日治疗 1 次，每次 15~20 分钟，10 次为 1 疗程。结果：治愈（语言清楚，上肢能抬举握物，下肢可以行走，肌力在Ⅳ级以上，生活能自理）37 例，显效 33 例，进步 27 例，无效 3 例，总有效率 97%^[21]。

4.4 东贵荣等运用头针治疗急性脑出血 48 例 本组患者均以头穴透针方法治疗为主，选择性加用脱水剂。用 28 号 2 寸毫针，自百会至曲鬓穴分段沿皮刺 4 针，留针 30 分钟，每隔 5 分钟以 200 转/分的速度连续捻转 5 分钟。每日治疗 1 次，40 日为 1 疗程，同时配合康复功能锻炼。结果：显效 37 例，进步 8 例，有效 2 例，无效 1 例，总有效率 97.9%；治疗前后患者职业功能、生活功能、自理功能的康复率有显著性差异， $P < 0.01$ ^[22]。

5 针药并用

崔金才等治疗脑出血 52 例 中脏腑闭证，用丹参 15g，郁金、菖蒲各 10g，苏合香、安息香、三七粉（冲）各 3g，针刺人中、内关、太冲。脱证，用党参、熟附子各 30g，麦冬、五味子各 15g，苏合香、安息香各 3g 冲服；针刺百会、足三里、内关，灸神阙。颅压增高加 20% 甘露醇 250ml 静滴，日 2~4 次；连用 3~5 日。中经络，用当归、丹参、鸡血藤各 15g，三七粉（冲）3g；针刺风池、肩髃、曲池、外关、环跳、阳陵泉。均 2 个月为 1 疗程。基本痊愈 9 例，显效 15 例，进步 18 例，无效 3 例，死亡 7 例。总有效率为 80.77%^[23]。

参 考 文 献

- 1 孙 怡，等．中医杂志．1991；32（2）：30
- 2 张伯勋，等．中医杂志．1993；34（3）：159
- 3 孙西庆．江苏中医．1995；16（8）：5
- 4 潘 龙，等．陕西中医学院学报．1993；16（4）：7
- 5 赵玉茶．中国中西医结合杂志．1993；13（11）：679
- 6 潘 洋．中医药学报．1997；25（1）：14
- 7 何 华．中医研究．1996；9（6）：27
- 8 郑 安，等．福建中医药．1993；24（6）：16
- 9 刘茂才．广东医学．1989；10（4）：34
- 10 张文学．中医研究．1995；8（5）：29
- 11 陆朴莺，等．上海中医药杂志．1994；（10）：12
- 12 杨 林．浙江中医杂志．1992；27（5）：200
- 13 陆志强．中国中西医结合杂志．1993；13（7）：405
- 14 林亚明．云南中医学院学报．1992；15（4）：37

- 15 李相中, 等. 中西医结合实用临床急救. 1995; 3 (1): 4
- 16 沈卫平, 等. 南京中医药大学学报. 1997; 13 (1): 15
- 17 申彩文, 等. 天津中医学院学报. 1995; 14 (3): 19
- 18 阎 莉, 等. 中国中医急症. 1993; 2 (3): 108
- 19 陈守龙, 等. 新中医. 1990; 22 (1): 27
- 20 李金亭, 等. 天津中医. 1993; (6): 25
- 21 许武定, 等. 陕西中医. 1988; 9 (5): 199
- 22 东贵荣, 等. 中国针灸. 1990; 10 (1): 19
- 23 崔金才, 等. 天津中医. 1992; (6): 10

(刘玉琢)

蛛网膜下腔出血

蛛网膜下腔出血系指脑底部或脑表面的血管破裂、血液直接进入蛛网膜下腔而言。最常见的病因是脑底动脉瘤、脑血管畸形和脑动脉粥样硬化。根据本病临床表现，大凡归属于中医学的“中风”、“类中风”、“瘫痪”、“头痛”、“卒中”、“眩晕”等范畴。

1 一方为主 辨证加减

卢桂梅用清热祛瘀为主辨证治疗蛛网膜下腔出血 本方含钩藤（后下）30g，田三七（冲）2g，大黄10g，葛根60g，菖蒲12g。痰浊型加半夏10g，茯苓15g，橘红、甘草各6g。肝阳上亢型加黄芩12g，石决明（先煎）、牡蛎（先煎）各30g，白芍、菊花各15g。肝肾阴虚型去大黄，加黄柏12g，知母、丹皮各10g，生地15g，龟板18g。瘀血者加丹皮、赤芍、牛膝各10g。中脏腑，肝阳暴亢型加羚羊角（先煎）3g，黄芩12g，生地15g，并冲服至宝丹1瓶，每日两次。痰迷心窍者加天竺黄、胆星各10g，并冲服安宫牛黄丸1丸，每日两次。上面几型如呕甚加竹茹12g；头痛甚加蔓荆子、刺蒺藜各12g，藁本10g；肝热甚加山栀子12g，龙胆草10g。治疗10数例，疗效较好，症状改善快，能缩短疗程，减少死亡率及后遗症的发生。附验案2则^[1]。

2 验案报道

2.1 王子耀采用釜底抽薪法治愈蛛网膜下腔出血2例 例1：女，65岁。平素阴虚火炽，因酒后赶路，烈日曝晒，突然昏倒，剧烈头痛，伴恶心呕吐，烦躁不安，颈项强硬而入院；不久又转入昏迷，脑脊液压力增高，呈血

珍珠母 40g, 黄菊花、赤芍各 18g, 桃仁 12g, 生军 5g, 黄芩、丹皮、决明子、元胡粉（冲服）各 18g, 甘草 2g。药后 6 小时解下大量臭秽便，次日神志稍清，头痛减轻，血压正常。予前方去生大黄、元明粉，加羚羊角 5g, 麻仁 18g。2 剂后神志清楚，肝阳得降，头痛已瘥，颈项转动自如，惟时有头晕，大便 2 日未行，舌苔黄厚。随证加减再进 3 剂病愈^[3]。

3 中西医结合

3.1 韩树芬等中西医结合治疗蛛网膜下腔出血 6 例

本组病人病程 20 小时 ~ 9 天。中药予当归、赤芍、桃仁、红花各 9g, 益母草、钩藤、白蒺藜、生龙骨、生牡蛎、珍珠母各 12g, 丹参、白芍各 10g, 炙甘草 6g。意识障碍者加石菖蒲 10g。水煎服日 1 剂，共服 16 ~ 44 剂不等。西药：静滴 20% 甘露醇 250ml/日 1 ~ 2 次，共用 7 ~ 15 次不等；6-氨基己酸 6 ~ 10g/日 1 次。结果：全部治愈，计用药后 9 ~ 40 天；8 ~ 40 天脑膜刺激征消失；1 例伴右侧肢体轻瘫者 8 天完全恢复正常；1 例伴意识障碍者 12 天恢复正常^[4]。

3.2 寇玉铮中西医结合治疗蛛网膜下腔出血 100 例

治疗组和对照组各 100 例均有典型的蛛网膜下腔出血“三联症”，均用西药降颅内压、止血，无禁忌症者加激素及对症治疗。治疗组加用中药，予陈皮、茯苓、合欢、佩兰、菖蒲各 15g, 半夏、竹茹各 10g, 葶苈子 30g, 天竺黄（研面冲服）、甘草各 5g。头痛重者葶苈子逐渐加量至 50 ~ 60g, 但应注意腹泻的发生；痰盛加川贝母 15g; 痰血均重加龙胆草 7.5g, 大黄、枳实各 15g; 伤津加天花粉 25g; 风重加生石决明 50g。水煎服或鼻饲。结果：治疗组和对

珍珠母 40g, 黄菊花、赤白芍各 18g, 桃仁 12g, 生军 5g, 黄芩、丹皮、决明子、元胡粉（冲服）各 18g, 甘草 2g。药后 6 小时解下大量臭秽便，次日神志稍清，头痛减轻，血压正常。予前方去生大黄、元明粉，加羚羊角 5g, 麻仁 18g。2 剂后神志清楚，肝阳得降，头痛已瘥，颈项转动自如，惟时有头晕，大便 2 日未行，舌苔黄厚。随证加减再进 3 剂病愈^[3]。

3 中西医结合

3.1 韩树芬等中西医结合治疗蛛网膜下腔出血 6 例

本组病人病程 20 小时 ~ 9 天。中药予当归、赤芍、桃仁、红花各 9g, 益母草、钩藤、白蒺藜、生龙骨、生牡蛎、珍珠母各 12g, 丹参、白芍各 10g, 炙甘草 6g。意识障碍者加石菖蒲 10g。水煎服日 1 剂，共服 16 ~ 44 剂不等。西药：静滴 20% 甘露醇 250ml/日 1 ~ 2 次，共用 7 ~ 15 次不等；6-氨基己酸 6 ~ 10g/日 1 次。结果：全部治愈，计用药后 9 ~ 40 天；8 ~ 40 天脑膜刺激征消失；1 例伴右侧肢体轻瘫者 8 天完全恢复正常；1 例伴意识障碍者 12 天恢复正常^[4]。

3.2 寇玉铮中西医结合治疗蛛网膜下腔出血 100 例

治疗组和对照组各 100 例均有典型的蛛网膜下腔出血“三联症”，均用西药降颅内压、止血，无禁忌症者加激素及对症治疗。治疗组加用中药，予陈皮、茯苓、合欢、佩兰、菖蒲各 15g, 半夏、竹茹各 10g, 葶苈子 30g, 天竺黄（研面冲服）、甘草各 5g。头痛重者葶苈子逐渐加量至 50 ~ 60g, 但应注意腹泻的发生；痰盛加川贝母 15g; 痰血均重加龙胆草 7.5g, 大黄、枳实各 15g; 伤津加天花粉 25g; 风重加生石决明 50g。水煎服或鼻饲。结果：治疗组和对

照组 3 周内症状消失率分别为 76% 和 48%，脑膜刺激症消失率为 70% 和 41%；4 周内死亡率分别为 5% 和 24%，住院期间病死率为 6% 和 30%。治疗组疗效明显优于对照组 ($P < 0.01$)^[5]。

3.3 杨玉珍等中西医结合治疗蛛网膜下腔出血 16 例

本组患者年龄 16 ~ 63 岁。急性期昏迷者选用安宫牛黄散、紫雪散，清醒后用犀角地黄汤、清营汤、白虎汤加减；同时予西医镇静、止血、脱水、脑细胞激活剂、抗菌素及对症疗法。结果：痊愈（患者神清，症状体征全部消失，脑脊液恢复正常）10 例，好转（神清，头痛减轻，体征减少或不明显，能坐起或下地稍事活动）6 例。对照组 18 例单纯用西药治疗，结果：痊愈 5 例，好转 8 例，无效 2 例，死亡 3 例。治疗组疗效明显优于对照组， $P < 0.01$ ^[6]。

3.4 刘沛然中西医结合治疗蛛网膜下腔出血 11 例

本组除常规降颅压、止血、镇静、止痛及预防感染外，均予栀子金花汤：焦栀子、黄芩各 6 ~ 12g，黄连 1 ~ 6g，黄柏 3 ~ 10g，大黄 1 ~ 12g。初期火热炽盛，症见头痛、神昏或二便失禁，加金银花炭 40 ~ 60g，菊花炭 12 ~ 30g，生地炭 30 ~ 60g；头晕呕吐加竹茹 12g 并重用焦栀子；大便秘结，小便失禁，手足麻木或偏废，加牛膝炭、蚕砂各 12 ~ 30g，金银花 20 ~ 30g；烦躁、语言不清，加地骨皮 30g，丹皮 10 ~ 15g，生地 15 ~ 20g。本组 11 例经治 9 ~ 31 天全部获愈^[7]。

3.5 张存志等中西医结合治疗蛛网膜下腔出血 24 例

本组患者共 48 例，病程 2 小时 ~ 8 日。治疗组 24 例，以丹参注射液 8 ~ 10 支（每支相当于生药 2g）加入 10% 葡

肺性脑病

肺性脑病又称肺气肿脑病、高碳酸血症、二氧化碳麻醉等，是慢性支气管炎合并肺气肿、肺源性心脏病、肺功能衰竭的常见并发症。临床表现主要有：早期可出现头痛、头昏、精神怠倦、记忆力减退、工作能力降低等症状，以后随着病情发展可出现兴奋、烦躁不安、胡言乱语、忧郁，有的病人还可以出现幻觉、妄想、抽搐，重症病人可出现嗜睡、昏沉，以致昏迷。肺性脑病属于中医的“痰浊蒙窍”、“肝风内动”以及温病的“热传心包”等证范畴。

1 辨证论治

1.1 朱亚萍等辨证论治肺性脑病 44 例 (1) 痰浊闭窍，治以豁痰开窍，用苏合香丸 1 丸/日 2~3 次；涤痰汤，药用橘红、姜半夏、茯苓、枳实、竹茹、胆南星、菖蒲、贝母等。(2) 痰火扰心，治以清心豁痰，开窍醒神，用安宫牛黄丸或至宝丹 1 丸/日 2~3 次；清营汤、黄连温胆汤，药用玄参、莲子、竹叶、犀角、麦冬、丹参、黄连、竹茹、茯苓、半夏、陈皮、天竺黄、菖蒲、大黄、郁金等。(3) 肝风内动，治以滋阴潜阳，平肝熄风，用羚羊钩藤汤、大定风珠，药用羚羊角、钩藤、菊花、生地、白芍、竹茹、贝母、生石决明等。(4) 痰瘀互结，治以化痰去瘀，醒神开窍，用至宝丹 1 丸/日 2 次；佛手二陈汤、苓桂术甘汤合桃红四物汤，药用当归、川芎、桃仁、橘红、半夏、茯苓、白术、天竺黄、胆南星、菖蒲等。(5) 痰盛气衰，治以益气养阴，涤痰开窍，用生脉散、醒神散，药用人参或西洋参、麦冬、五味子、黄芪、胆南星、

石菖蒲、天竺黄、郁金等。均水煎服。兼症随症加减。治疗2~10日后，临床治愈30例，死亡14例，治愈率为68.18%^[1]。

1.2 刘胜利辨证分型为主治疗肺性脑病20例 (1)痰迷心窍型用涤痰汤加减，送服苏合香丸。(2)痰火扰心型用清营汤、菖蒲郁金汤加减。(3)肝风内动型用羚角钩藤汤加减。(4)痰盛气衰型用参附汤或参脉饮、菖蒲郁金汤加减。后3型均送服安宫牛黄丸。各型均加活血化瘀药；腑气不通加通腑降浊药；水肿明显加活血利水药；上消化道出血加云南白药。西药酌情用呼吸兴奋剂、强心利尿剂、肾上腺皮质激素，对症及支持疗法。经治1~3日，有效17例，无效3例^[2]。

2 一方为主，随症加减

2.1 汤礼文采用活血化瘀法为主治疗肺脑综合征42例 本组患者中轻型12例，中型和重型各15例。治疗组22例，基本方为丹参20g，红花、川芎、赤芍、丹皮、菖蒲、胆星、浙贝、郁金、钩藤各10g。气阴两虚者酌加吉林参须、麦冬、五味子等；中重型病人加用丹参注射液8~10g（加入10%葡萄糖中静滴）。对照组20例，采用常规西药治疗。结果：治疗组缓解18例，死亡4例，缓解率为81.8%；对照组缓解11例，死亡9例，缓解率为55%。治疗组缓解率明显高于对照组（ $P < 0.01$ ）^[3]。

2.2 樊亚巍采用开闭固脱法为主治疗肺性脑病30例 本组药用红参、熟附子、青皮、陈皮、槟榔、生大黄、菖蒲各10g，郁金、葶苈子、卫矛、牡荆子各15g，黄芪20g。痰火甚加黄芩、天葵子；热极生风加羚羊角、钩藤；水气凌心加泽泻、益母草；湿郁化热加防己、椒目；阴液

3.2 罗本清等用豁痰化瘀开窍针剂为主治疗脑性脑病 102 例 本组寒痰与热痰闭窍两型用复方三生针（含生附子、生南星等，重庆市中医研究所研制）30ml，加 10% 葡萄糖液 100ml；复方丹参针（四川雅安制药厂生产）10 ~ 20ml，加 10% 葡萄糖液 100 ~ 200ml，均静滴，日 1 次。热痰型并用醒脑静针（无锡中药厂生产）10 ~ 20ml，加 10% 葡萄糖 100 ~ 200ml，静滴；或 2 ~ 4ml 肌注。兼风动闭窍加复方麝香注射液（吉林省吉安制药厂生产）2 ~ 4ml/日 1 ~ 3 次肌注；兼内闭外脱用参麦针（含人参、麦冬，重庆市中医研究所研制）30 ~ 100ml，加 10% 葡萄糖液 100 ~ 200ml，静滴，日 1 ~ 2 次。与对照组 34 例，均用西药治疗。结果：两组分别显效（无意识障碍、精神症状及神经系统异常体征；低氧血症和高碳酸血症明显好转）18（26.47%）、2（5.88%）例，有效 30（44.12%）、10（29.41%）例，无效 20（29.41%）、22（64.71%）例，总有效率 70.59%、35.29%（ $P < 0.01$ ）。治疗后神志恢复正常时间、氧分压（ PaO_2 ）及氧饱和度（ SaO_2 ）本组均优于对照组（ P 均 < 0.05 ），二氧化碳分压（ PaCO_2 ）两组均有下降（ $P < 0.05$ ）；本组 SaO_2 、 PaO_2 、 PaCO_2 治疗前后比较均有显著性差异， P 均 < 0.05 或 $0.01^{[7]}$ 。

4 中西医结合

4.1 倪克中以中西医结合治疗肺性脑病 12 例 中药用皮尾参 15g，麦冬、胆南星、郁金各 10g，远志 6g，石菖蒲 12g，鹿衔草、蒲公英各 30g。日 1 剂。安宫牛黄丸 1 粒/日 2 次，研末送服，昏迷者鼻饲。西药均应用 2 种抗生素，持续低流量吸氧，呼吸兴奋剂，其中 5 例应用利尿剂，2 例应用西地兰，4 例应用激素。结果：有效（1 ~ 2

日神志转清，治疗后出院）11例，无效（死亡）1例。未完全进入昏迷及早应用本法，可防止病情发展^[8]。

4.2 刘振宇中西医结合治疗肺性脑病 13 例 本组患者年龄 45 ~ > 70 岁，均为肺心病所继发，其原发疾病为慢性支气管炎，病程 8 ~ 34 年。本病脾肾阳虚水泛、痰瘀蒙蔽心窍型用真武汤合涤痰汤加减；痰热夹瘀壅肺、痰火扰心风动型，用凉膈散加减；阴阳离决型用参附汤加味。同时均予西医综合治疗，即氧疗、防治感染、疏通气道、改善通气、纠正酸碱平衡和电解质紊乱、脱水剂和激素的使用，积极有效地纠治其他并发症如心功能不全、消化道出血、休克等。结果：救治成功 9 例，死亡 4 例，死亡率 30.7%。抽取同期性别、年龄、病情大体相似而单用西医综合治疗者 16 例对照，死亡 9 例，病死率 56.2%^[9]。

4.3 陶凯中西医结合治疗肺性脑病低氧血症 (1) 痰浊闭窍型（昏睡型）10 例：治以涤痰开窍、醒神，药用石菖蒲、天竺黄、川贝各 12g，郁金、胆南星各 9g。水煎两次共取 500ml 左右（下同），重者冲服羚羊角粉 3g，或安宫牛黄丸 1 丸。(2) 风痰交扰型（躁动型）5 例：治以祛痰平肝熄风，药用羚羊角粉 1 ~ 3g（冲服），石决明 30g，炒条芩、天麻、云苓各 12g，山梔、胆南星、化橘红各 9g。重者冲服紫雪丹 1g。(3) 痰瘀腑实型（腑实型）3 例：治以清肺化痰通腑，药用全瓜蒌 30g，黄芩 12g，半夏、厚朴、枳实各 9g，大黄 5 ~ 15g。伴发热加生石膏、金银花各 30g，知母 9g。(4) 痰盛气衰型（衰竭型）13 例：治以益气养阴涤痰，药用人参或西洋参 9 ~ 12g，麦冬 30g，五味子、胆南星、石菖蒲、化橘红、郁金、天竺黄各 9g，黄芪 15g。重者加醒神散（羚羊角粉 1.5g，石菖

蒲、郁金各 9g，天竺黄、黄芩、栀子、黄连各 6g，人工牛黄、冰片各 0.25g）6g 冲服。神志不清鼻饲或高位保留灌肠，每次 150ml/日 2~3 次。神志清醒后改口服，500ml 分 2~3 次/日。予氧疗和西药对症治疗。治疗 31 例，临床治愈 23 例，死亡 8 例^[10]。

4.4 雷希龄中西医结合治疗肺性脑病 本组原发病以慢性支气管炎、肺气肿为主，病程 6~30 年。(1) 中西医结合组：安宫组 18 例，用安宫牛黄丸，轻症日 1 丸，重症日 2 丸，温水调服或鼻饲管注入，连用 2~4 日。涤痰组 13 例，用涤痰汤。痰热内盛加葶苈子、天竺黄；肝风内动加钩藤、全蝎；皮肤粘膜出血、咯血、便血加生地、丹皮。日 1 剂，昏迷者鼻饲。上两组酌加抗生素、吸氧、强心、利尿等西医疗法。(2) 西药组 10 例，用西药疗法同上。结果：中西医结合组与西药组分别为：显效 16 例、2 例，有效 4 例、1 例，无效 11 例、7 例，有效率 64.52%、30%。安宫组有效率 88.89%，涤痰组 30.77%^[11]。

4.5 安知有等中西医结合治疗肺性脑病 (1) 治疗组（中西医结合）21 例。中医分型治疗：痰浊闭窍型予涤痰汤加减。阳虚水泛型予真武汤加减。热瘀伤络型，神识不清选用安宫牛黄丸或紫雪丹以参汤送服；出血用益气摄血（重用太子参、沙参、黄芪、党参），或用清热凉血（重用生地、玄参、白茅根、藕节、地榆、仙鹤草），或二者合用。元阳欲绝型用参附汤合参麦散加味。西医治疗：持续低流量吸氧，大剂量联合使用抗菌素，静注肺脑合剂，纠正水、电解质、酸碱平衡，予强心利尿剂，纠正心衰。(2) 对照组 19 例，仅用西医治疗。结果：治疗组与

对照组分别为显效 13、5 例，无效 8、14 例，其中死亡 7、13 例，有效率 61.90%、26.30%，病死率 33.33%、68.42%。两组疗效比较有显著差异， $P < 0.05^{[12]}$ 。

4.6 程祖声中西医结合治疗肺性脑病 20 例 西医疗疗重点是保持呼吸道通畅，改善肺泡通气，用祛痰剂、支气管扩张剂，控制感染。予呼吸兴奋剂，调整水、电解质及酸碱平衡，强心、利尿等对症处理。中药治以豁痰开窍，用导痰汤加味：制半夏、茯苓、郁金各 12g，陈皮、枳实各 9g，制胆星、生甘草各 6g，石菖蒲、青礞石各 30g。痰黄、发热者加黄芩 12g，石膏 30g，竹沥油 20ml。水煎 200ml，每 6 小时 50ml 口服或鼻饲。昏迷者加服苏合香丸或至宝丹日 1 粒。醒脑静注射液 4ml 静推。面浮足肿、尿少心悸者加车前子 30g，泽泻、防己各 12g。大便咖啡色加参三七粉 2g/日 2~3 次服。病情危重、四肢逆冷、脉微细欲绝、血压下降者先予参附龙牡汤，血压回升后再予前法。本组与西药组各 20 例，分别显效 5、2 例，好转 7、6 例，无效 8、12 例，总有效率 60%、40%^[13]。

4.7 刘家磊中西医结合治疗肺性脑病 53 例 中药用黄芪、蒲公英、金银花各 30g，白参、太子参、胆南星、姜半夏、郁金、石菖蒲、远志、赤芍、白桔梗各 10g。日 1 剂水煎服。安宫片黄丸或至宝丹 1 粒/日 2 次，研末冲服或鼻饲西药均用 2 种抗生素，持续低流量吸氧，呼吸兴奋剂；用利尿剂 26 例，西地兰 8 例，激素 19 例。结果：有效（治疗 1~3 日神志转清）49 例、无效 4 例^[14]。

4.8 张国梁中西医结合治疗老年肺性脑病 40 例 本组用菖蒲 15g，郁金 20g，半夏、陈皮、连翘、苏子、川芎、赤芍、桃仁、红花各 10g，玉枢丹 1 支（冲服）。便秘

加大黄；气虚欲脱加高丽参。日 1 剂水煎，口服或鼻饲。心功能不全 $\geq$ II 级者加用黄芪注射液、丹参注射液适量，加葡萄糖液静滴。5 日为 1 疗程。与对照组 30 例，均抗感染、解痉、化痰、止咳、吸氧、呼吸兴奋剂、呼吸机的机械通气、纠正呼酸、保持水电解质平衡等。结果：两组分别显效（神志和精神症状消失或肺性脑病程度改善 > 2 级）13、7 例，好转 17、8 例，无效 10、15 例，总有效率为 75%、50% ($P < 0.05$)。两组 PaCO_2 和 PaO_2 治疗前后自身及组间比较均有显著性差异， $P < 0.01$ 或 $0.05^{[15]}$ 。

5 肛滴疗法

施亥时等采用肛滴三子羚丹汤救治肺性脑病 10 例用本方（含附子、葶苈子、苏子、紫丹参、羚羊角），随症加减，日 1 剂，水煎，取液 300ml，直肠滴入，约 100 滴/分钟，每次约 40 分钟。日 2 次，3 日为 1 疗程。用 < 2 个疗程，结果：显效（神清、水肿、气喘消失，心肺功能明显改善）5 例，有效 3 例，无效 2 例^[16例]。

参 考 文 献

- 1 朱亚萍，等．中国医药学报．1991；6（5）：45
- 2 刘胜利．湖南中医杂志．1993；9（5）：22
- 3 汤礼文．浙江中医杂志．1988；23（10）：440
- 4 樊亚巍，等．实用中医药杂志．1993；9（1）：11
- 5 宋 康．中医杂志．1994；35（6）：347
- 6 王 琦，等．中医杂志．1994；35（12）：728
- 7 罗本清，等．中国中医急症．1994；3（6）：244
- 8 倪克中．上海中医药杂志．1991；（7）：8
- 9 刘振宇．江西中医药．1987；（6）：20

- 10 陶 凯 . 中西医结合杂志 .1987; 7 (10): 616
 - 11 雷希龄 . 湖南中医杂志 .1989; 5 (3): 13
 - 12 安知有, 等 . 成都中医学院学报 .1990; 13 (3) .30
 - 13 程祖声 . 中西医结合杂志 .1990; 10 (3): 172
 - 14 刘家磊 . 实用中西医结合杂志 .1993; 6 (1): 23
 - 15 张国梁 . 中国中医急症 .1995; 4 (3): 103
 - 16 施亥时, 等 . 浙江中医杂志 .1997; 32 (9): 393
- (谷克义)

震颤麻痹

震颤麻痹又名帕金森氏病，是一种比较常见的中枢神经系统变性疾病。以运动减少、肌张力强直和静止性震颤为主要症状。对未发现任何确切病因的病例称为原发性震颤麻痹。对于有确切病因发现的病例，则称为震颤麻痹综合征。它们在临床表现及病程演化上都有很多共同特征。原发性震颤麻痹好发于 50~60 岁之间，40 岁以前发病者甚少，男多于女。祖国医学根据临床表现可属“颤证”、“震掉”、“痉证”的范畴。

1 辨证论治

1.1 王坤山等报道辨治震颤麻痹 (1) 阴虚阳亢、风动振摇：用天麻、钩藤、全蝎、羚羊角、蜈蚣、生龟板、生鳖甲、生地、麦冬、阿胶、白芍、鸡子黄、生牡蛎。(2) 气血虚弱、筋脉失养：用人参、黄芪、当归、白芍、熟地、白术、桂心、茯苓、炙甘草、天麻、钩藤、全蝎、羚羊角、丹参、鸡血藤。(3) 风痰阻络、经脉失约：用半夏、天麻、天南星、威灵仙、僵蚕、枳实、茯苓、橘红、甘草、姜汁、竹沥、郁金、钩藤、蜈蚣、丹参、赤芍。(4) 脾肾阳虚、经脉失煦：用附片、鹿角片、淫羊藿、紫河车、红参、白术、茯苓、干姜、桂枝、赤芍、白芍、全蝎、羚羊角。(5) 气虚血瘀、脑络栓塞：用生黄芪、红参、当归、川芎、桃仁、红花、蜈蚣、全蝎、钩藤、赤芍、地龙。(6) 气滞血瘀，络脉梗阻：用当归、赤芍、生地、桃仁、红花、柴胡、枳壳、青皮、牛膝、丹参、羚羊角、全蝎、钩藤。(7) 营卫失调、经输不利：用桂枝、白芍、甘草、生姜、大枣、葛根、独活^[1]。

1.2 陶春祥报道辨治震颤麻痹 (1) 肝肾不足、虚风内动，用地黄、玄参、龟板、白芍、麦冬、阿胶、牡蛎、石决明、僵蚕、钩藤。(2) 痰热动风、风痰阻络，用法半夏、胆南星、枳实、陈皮、天麻、钩藤、茯苓、山栀、川牛膝、黄芩、石决明、大黄、僵蚕、竹沥。(3) 气血两亏，筋失濡养，用人参、熟地、白芍、当归、白术、茯苓、黄芪、天麻、钩藤、五味子、川芎、丹参、地龙、全蝎。(4) 心虚神弱、意识迟钝，用人参、地黄、当归、酸枣仁、柏子仁、川芎、茯神、琥珀、菖蒲、远志、甘草、麝香。各附验案 1 则^[2]。

1.3 李庚和报道辨治震颤麻痹症 50 例 (1) 肝肾阴虚型用生地、熟地、首乌、山萸肉、龟板、元参。抖动不已加羚羊角粉、钩藤、蕲蛇、潼白蒺藜、生牡蛎；大便秘结加大黄、火麻仁、郁李仁；腰膝酸痛加杜仲、桑寄生；筋脉拘紧加木瓜、鸡血藤、伸筋草。(2) 气滞血瘀型：用丹参、赤芍、红花、桃仁、川芎、牛膝、当归、地鳖虫、炮山甲等。疼痛剧加徐长卿、虎杖、姜黄；头痛加白芷、夏枯草、全蝎。(3) 气血两虚型用人参、黄芪、白术、当归、熟地、甘草、白芍、丹参、五味子、女贞子等。抖动不已加钩藤、羚羊角粉、天麻；筋脉拘紧张直加木瓜、蕲蛇、广地龙、僵蚕；目花加甘枸杞、女贞子；早莲草；头痛头晕加天麻、潼白蒺藜、菊花、净蝉衣；全身关节酸痛加虎杖、金雀根、威灵仙、徐长卿。日 1 剂水煎服。服 7~450 剂后，显效 15 例，好转 24 例，无效 11 例，总有效率 78%^[3]。

1.4 王素娥等报道辨证论治结合五虫散治疗老年性震颤麻痹 11 例 药用蝉蜕 9g，地龙、僵蚕、土鳖虫各

5g, 全蝎 3g, 共研细末, 6g/日 2 次, 以汤药送服。肝肾阴虚, 血虚风动型以大定风珠送服; 脾虚痰湿、筋脉失养型以导痰汤送服; 血瘀脉络、痹而不通型以血府逐瘀汤送服。1 月为 1 疗程, 连服 3 疗程。结果: 显效 3 例, 好转 5 例, 无效 3 例^[4]。

2 一方为主 随症加减

2.1 任光墨用熄风汤治疗帕金森氏综合征 中药组 35 例, 用熄风汤: 天麻、钩藤各 12g, 全蝎 5g, 洋金花 0.6g, 蜈蚣 2 条。日 1 剂, 重者 2 剂, 水煎服。头晕耳鸣, 腰酸膝软者加龟板、生地、熟地、山萸肉; 面色无华, 食少倦怠乏力加党参、焦白术、当归、熟地; 胸脘痞闷, 咯痰色黄, 苔黄腻加胆南星、枳实、竹茹。安坦组 38 例, 用安坦 4mg/日 3 次。结果: 中药组与安坦组分别痊愈 29 例、12 例, 显著进步 5 例、17 例, 进步 0 例、3 例, 无效 1 例、5 例, 恶化 0 例、1 例。两组痊愈率、有效率比较均有显著性差异, $P < 0.005$ 及 0.05。安坦组出现不同程度的口干 21 例, 视力模糊 7 例, 便秘 5 例; 中药组则未见不良反应^[5]。

2.2 李怀生用定振丸加减治疗震颤麻痹 11 例 药用熟地、生地、当归、川芎、白芍、钩藤、制首乌、枸杞子各 15g, 黄芪 24g, 白术、天麻、防风、威灵仙各 10g, 全蝎 6g, 蜈蚣 2 条。肝肾阴虚合六味地黄丸: 风痰窜动去熟地、首乌、枸杞子, 加竹沥、僵蚕; 伴肢体疼痛, 或恶风寒, 去首乌、枸杞子, 加秦艽、荆芥、细辛、桂枝、葛根、片姜黄。15 日为 1 疗程, 治疗 1~3 个月后, 痊愈 7 例, 好转 4 例。治愈者随访 1 年无复发^[6]。

2.3 樊蕤报道周仲瑛治疗震颤麻痹的经验 本病主

因肝肾亏虚、内风暗动、痰瘀交阻，属虚实夹杂证，治宜滋肾柔肝、平肝熄风为主，用地黄饮子加减：地黄 12~15g，石斛、续断、白蒺藜、炙鳖甲（先煎）各 15g，白芍 15~30g，肉苁蓉 10~15g，海藻 12g，僵蚕、炮山甲（先煎）各 10g，煅龙骨、煅牡蛎（均先煎）各 20g，石决明 30g（先煎）。震颤甚宜重镇熄风为主；筋僵拘挛、肌张力较高加柔肝解痉药，重用熄风通络解痉药；舌质紫暗、脉细涩、面晦滞，宜重用祛瘀药；痰浊内盛或血脂较高重用僵蚕、海藻，加胆南星、荷叶、苍术；内热偏盛加滋阴降火药；阴精亏损、体虚加枸杞子、首乌、杜仲、牛膝、寄生、楮实子、麦冬；阴损及阳或阳虚加巴戟天、淫羊藿、黄芪、锁阳；心悸失眠、紧张除用重镇药外，加养心安神药或用通阳安神法；反应迟钝、健忘宜补肾荣脑、化痰开窍^[7]。

3 固定方治疗

3.1 徐尚华等用复方养血熄风汤治疗震颤麻痹病 24 例 本方含白芍、钩藤各 16g，山萸肉 10g，全蝎、鹿角胶（烊化）各 8g，枸杞子、生地、白附子、当归各 12g，蜈蚣（焙干研末冲服）1 条，甘草 6g。隔日 1 剂水煎服。鸭蛋 5~6 枚，用 95% 酒精浸泡 48 小时后，1 枚打入水中煮熟，每早空腹吃蛋喝汤。3 个月为 1 疗程。治疗 1~3 疗程，结果：痊愈 13 例，显效 8 例，无效 3 例^[8]。

3.2 张书瑞等报道治愈 1 例帕金森氏征 女，55 岁，1990 年 2 月初诊。诉 1 月前确诊为本病，服左旋多巴有效，但停药如故。证见面色萎黄，身颤不已，嗜静懒言，口干纳差，大便燥结，舌红裂、无苔，脉弦细数。证属肝肾阴虚，筋脉失荣，治宜滋补肝肾，佐以清热安神，药用

沙参 30g, 当归、丹皮各 10g, 枸杞子、生龙骨、生牡蛎各 20g, 生地 18g, 麦冬 25g, 山萸肉 15g, 茯苓、生白芍各 12g, 生山药 24g, 鸡内金 9g, 砂仁、甘草各 6g。进 3 剂, 震颤稍轻, 精神好转, 舌苔似生。原方再进 3 剂, 仅左侧半身震颤; 原方去沙参加党参、石斛, 3 剂后颤止, 行走自如, 再进 4 剂善后。1 年后随访未复发^[9]。

4 中西医结合治疗

蔡俊中西医结合治疗帕金森氏病 60 例 气血两虚、血瘀风动用定震熄风汤 (生地、熟地、天麻、全蝎、防风、白芍、钩藤、珍珠母、黄芪、党参、细辛、秦艽、蜈蚣、羚羊角粉); 痰热风动用控涎熄风汤 (白芥子、胆南星、旋覆花、钩藤、天麻、珍珠母、赤芍、葛根、白芍、苏子霜、半夏、薏苡仁、全瓜蒌等); 肝肾阴虚、血瘀风动用育阴熄风汤 (白芍、麦门冬、知母、黄柏、玄参、巴戟天、丹参、钩藤、全蝎、蜈蚣、羚羊角粉、葛根、首乌、山萸肉等)。日 1 剂水煎服。与对照组 30 例, 均用左旋多巴 200mg/日 3 次饭后服。均 45 日为 1 疗程。结果: 两组分别痊愈 4、0 例, 显著进步 27、6 例, 好转 19、12 例, 无效 10、12 例, 总有效率 83.3%、60% ($P < 0.05$)^[10]。

5 针刺疗法

5.1 刘家瑛等针刺治疗震颤麻痹 159 例 主穴: 舞蹈震颤控制区、百会、神庭、曲池、外关、太冲、消颤穴 (少海穴下 1.5 寸)。肝肾阴虚加三阴交、复溜; 气血不足加足三里、合谷; 痰热动风加阴陵泉、丰隆。用 32 号 1 寸或 1.5 寸毫针直刺, 平补平泻。得气后留针 30 分钟, 舞蹈震颤区加电流, 频率 150 ~ 200 次/分, 强度以患者感

6 针药并治

6.1 张乃钺针药结合治疗震颤麻痹 50 例 取穴：阳陵泉、太冲、行间、曲池、合谷、足三里。留针 30 分钟，日 1 次。10 日为 1 疗程，疗程间隔 5 日，用 4 个疗程。并用震颤宁汤：鸡子黄 1 个，阿胶、地黄各 15g，枸杞子、钩藤各 30g，当归、川芎、白芍各 10g，全蝎、蜈蚣粉各 5g（均焙干研末）。日 1 剂水煎服，用 60 日。结果：显效（症状明显改善，主要体征 > 半数进步）14 例，有效 27 例，无效 9 例，总有效率 82%^[15]。

6.2 李玉生针药结合治疗震颤麻痹 52 例 取穴：风池、行间、丰隆、阳陵泉（均泻法）、内关透外关（平补平泻）、头临泣（平刺）、足三里（补法）。隔日 1 次，15 日为 1 疗程，用 3 个疗程。并用平肝熄风豁痰汤：天麻、丹参各 15g，钩藤、牛膝、黄芩各 12g，橘皮、姜半夏、茯苓、竹茹、生甘草、石菖蒲各 10g，地龙、全蝎各 9g，豨莶草 30g，鲜竹沥汁 10ml（兑服）。震颤较重加蜈蚣；纳差加炒三仙；小便黄赤加滑石。日 1 剂水煎服，用 3 个月。结果：治愈 8 例，有效 40 例，无效 4 例，总有效率 92.3%^[16]。

6.3 翼桂芳等针药结合治疗帕金森氏病 45 例 取穴：百会、哑门、颈夹脊，针刺得气后留针 30~40 分钟；舞蹈震颤抑制区，用 G6805 II 型电针仪，疏密波，刺激 30~40 分钟。隔日 1 次，10 次为 1 疗程。配合定风胶囊（含羚羊角粉、洋金花等）2 粒，水木熄风冲剂（含山萸肉、钩藤、天麻、丹参等）2 包，均日 2 次口服。治疗 3 个疗程，结果：显效（用修正的 Webster's 10 项计分法，减少 > 61%）28 例，有效 13 例，无效 4 例，总有效率为

参 考 文 献

- 1 王坤山, 等. 甘肃中医 .1993; 6 (2): 8
- 2 陶春祥. 黑龙江中医药 .1994; (1): 49
- 3 李庚和. 上海中医药杂志 .1992; (2): 12
- 4 王素娥, 等. 中级医刊 .1992; 27 (11): 59
- 5 任光星. 山东中医杂志 .1990; 9 (2): 21
- 6 李怀生. 浙江中医杂志 .1993; 28 (4): 186
- 7 樊 莹. 中医杂志 .1996; 37 (11): 663
- 8 徐尚华, 等. 浙江中医杂志 .1994; 29 (12): 534
- 9 张书瑞, 等. 吉林中医药 .1991; (2): 7
- 10 蔡 俊. 实用中西医结合杂志 .1995; 8 (9): 527
- 11 刘家瑛, 等. 针灸临床杂志 .1993; 9 (5): 10
- 12 王选伟. 陕西中医 .1994; 15 (4): 176
- 13 俞竹青. 浙江中医学院学报 .1994; 18 (6): 45
- 14 张乃钲, 等. 中国针灸 .1996; 16 (2): 5
- 15 张乃钲, 等. 中国针灸 .1996; 16 (12): 11
- 16 李玉生. 中国针灸 .1995; 15 (3): 26
- 17 奚桂芳, 等. 上海针灸杂志 .1995; 14 (6): 243
- 18 谢瑶芳, 等. 中国中西医结合杂志 .1993; 13 (8): 490
- 19 王永泉. 按摩与导引 .1994; (4): 1

(赵丽珠)

谷、阳池、八邪；腹部动作配中脘；下肢动作配环跳、阳陵泉、悬钟、丘墟、秩边、承扶、足三里、解溪、八风。风府、大椎穴留针 10~15 分钟或不留针。其他穴得气后施提插捻转手法，以针感向四周或远端传导为度。留针 60 分钟，行针 1~2 次。大部分症状控制后，配穴可轮流交替使用。日 1 次，10 次为 1 疗程，疗程间隔 3 日。结果：治愈 29 例，有效 1 例。痊愈者近期复发 3 例，经治获愈。随访 3 年，均无复发^[5]。

3.2 许心华等以针刺治疗偏侧舞蹈病 11 例 在治疗原发病同时用针，头针舞蹈震颤区、平衡区。体针：气血两虚取足三里、血海、三阴交；肝肾不足取太冲、太溪、风池。日 1 次。经针刺 5~10 日后均获愈，复发 1 例^[6]。

3.3 杨白燕以针刺治疗舞蹈病 36 例 主穴：内关（用提插捻转泻法 1 分钟）、人中（向鼻中膈斜刺 0.2~0.3 寸，用雀啄法，以眼球湿润为度）、风池（用捻转补法 1 分钟）、印堂（向下斜刺 0.3~0.5 寸，捻转补法）、四神聪（直刺 0.2 寸，留针）、合谷（捻转泻法）、后溪、申脉（捻转泻法）。肝肾不足配三阴交、太溪；气血两虚配关元、气海、足三里；痰热风动配丰隆、太冲。头针：运动区、舞蹈震颤控制区。耳针：神门、肾、脾；心、肝、胃；两组交替使用。结果：治愈 14 例，好转 20 例，无效 2 例^[7]。

参 考 文 献

- 1 邹世光. 浙江中医杂志. 1992; 27 (4): 155
- 2 陈映标. 北京中医. 1994; (5): 8

- 3 王书成 . 四川中医 .1986; 4 (9): 23
- 4 张克起 . 上海中医药杂志 .1996; (2): 24
- 5 胡银虎, 等 . 中国针灸 .1994; 14 (2): 11
- 6 许心华, 等 . 浙江中医杂志 .1992; 27 (7): 324
- 7 杨白燕 . 针灸临床杂志 .1997; 13 (9): 17

(王继亮)

各 0.5g) 9~12 片/日 3 次口服。本组 34 例, 结果: 显效 (4 周后神经系统症状及体征显著改善, 且病情改善 ≥ 2 级) 3 例, 好转 21 例, 无效 10 例, 总有效率 70.6%。治疗后 24 小时尿酮明显增加 ($P < 0.01$); 肝肾功能各项指标无明显变化 ($P > 0.01$)^[3]。

2.2 杨任民等治疗肝豆状核变性 107 例 用大黄 6g, 黄连、黄芩各 10g, 鱼腥草、半枝莲、泽泻各 20g。日 1 剂水煎服。治疗 4 周后, 显效 9 例, 好转 81 例, 无效 17 例, 总有效率 84.2%。临床症状以言语不清、流涎、四肢抖动及笨拙疗效最好。脑型、假性硬化型与精神障碍型间疗效比较无显著性差异, $P > 0.05$ 。但脑型与内脏型和脑内脏混合型比较则有显著性差异, $P < 0.001$ 。病轻者疗效优于病重者 ($P < 0.001$)。治疗前后的尿排铜量和血清铜氧化酶比较均有明显变化 (P 均 < 0.01), 但血清铜、锌含量均无明显变化 (P 均 > 0.05)^[4]。

3 中西医结合

3.1 任明山中西医结合治疗肝豆状核变性 两组各 40 例。本组用肝豆汤: 大黄 6g, 黄连、黄芩、泽泻各 10g, 鱼腥草、半枝莲、穿心莲各 20g。日 1 剂水煎服。与对照组均用二巯基丁二酸 (上海新亚制药厂生产) 25mg/kg/日 2 次口服。均用 1 个月, 结果: 两组分别显效 (症状、体征显著改善, 病情分级改善 ≥ 2 级) 10、6 例, 好转 24、19 例, 无效或恶化 6、15 例, 总有效率 85%、62.5% ($P < 0.05$)。24 小时尿铜、锌、铁、钙的排泄量两组治疗前后自身及尿锌排泄量治疗后组间比较均有显著性差异, $P < 0.01$ 。两组见副反应 7、9 例^[5]。

3.2 杨任民等中西医结合治疗肝豆状核变性 418 例

中药肝豆汤（或肝豆片）：含大黄 6～10g，黄连、黄芩各 10g，穿心莲、半枝莲、萆薢各 20g。日 1 剂，3～4 周为 1 疗程，亦可长期服用维持。巯基络合剂：二巯基丁二钠每日 2～10g，分 2～4 次静注，剂量根据个体耐受性而定；6 日为 1 疗程，按症状轻重分别注射 4～20 个疗程不等。青霉胺每日 1～2g 分 4 次于饭前半小时口服，10 日为 1 疗程。5% 硫酸锌溶液每日 10ml，或葡萄糖酸锌片 1.6g，分 3 次饭后服，3～4 周为 1 疗程。结果：显效 103 例占 26.64%，好转 286 例占 68.42%，无效 22 例占 5.26%，死亡 7 例占 1.68%，总有效率 93.06%。轻度组的显效率远高于中度及重度组（ $P < 0.001$ ）；重度组的病死率显著高于轻度组（ $P < 0.05$ ）。本病与假性硬化型的显效率显著高于腹—肝脑型，（ $P < 0.01$ ）；前两组的病死率又显著低于后者^[6]。

参 考 文 献

- 1 杜新平．辽宁中医杂志．1994；21（6）：251
- 2 冯彦臣．河南中医．1985；（1）：19
- 3 胡文彬，等．中医杂志．1997；38（7）：414
- 4 杨任民，等．中医杂志．1993；34（11）：676
- 5 任明山，等．中国中西医结合杂志．1997；17（3）：136
- 6 杨任民，等．中西医结合杂志．1990；10（3）：134

（梁 冰）

不安腿综合症

不安腿综合症是睡眠相关性障碍的一种疾病，简称(RLS)，常在两小腿深处酸麻胀痛，活动后暂时减轻。一般见于老年人伴有睡眠中周期性动作(PMS)者，有时为服用三环类抗忧郁剂或停服镇静剂所激发。本病属祖国医学“痹证”范畴。

1 一方为主 随症加减

1.1 李文海等用芍药甘草汤加味治疗不安腿综合征 10例 基本方：白芍、丹参各 30g，赤芍 20g，川芎 12g，甘草、红花、当归、牛膝、制大黄各 10g。双下肢浮肿加薏苡 30g；气血虚加黄芪 30g，鸡血藤 20g；血色素低加服归脾丸或驴胶冲剂。服药 2~10 剂。结果：全部治愈^[1]。

1.2 何刚用三仁汤加减治疗不安腿综合征 12例 药用杏仁、厚朴、通草、木瓜各 10g，白蔻仁 12g，滑石、川牛膝各 15g，薏苡仁、丹参各 30g。湿热重合二妙散；小腿拘紧加伸筋草。日 1 剂水煎服。结果：经治 15~17 日均治愈^[2]。

1.3 乔连厚等用柴胡桑鸡汤治疗不安腿综合征 30例 本方含桑枝、鸡血藤、王不留行各 30g，柴胡、怀牛膝各 15g，党参、清半夏、黄芩各 12g，甘草 7g，生姜 3 片，大枣 5 枚。下肢恶寒去黄芩，加桂枝；刺痛加红花；睡眠困难加炒枣仁、夜交藤。日 1 剂水煎服，10 日为 1 疗程。用 1~2 疗程，结果：痊愈 15 例，显效 6 例，有效 7 例，无效 2 例，总有效率 93.3%^[3]。

1.4 郝素云等用补阳还五汤治疗不安腿综合征 33例 本方含黄芪 30g，当归、赤芍各 15g，川芎、桃仁各

10g, 红花、地龙各 6g。疼甚加牛膝; 转筋加木瓜、白芍; 麻木不适加桂枝。日 1 剂水煎服, 10 日为 1 疗程, 疗程间隔 5 日。停用它药。结果: 痊愈 22 例, 好转 9 例, 无效 2 例^[4]。

2 固定方治疗

2.1 李广振等用四妙丸加味治疗不安腿综合征 13 例

药用苍术 10g, 黄柏、川牛膝、汉防己各 15g, 薏苡仁、忍冬藤各 30g, 车前子 12g。日 1 剂水煎服。结果: 治愈 9 例、显效 3 例, 有效 1 例^[5]。

2.2 杜豁然以芍药甘草汤治疗不安腿综合征 54 例

药用白芍 15g, 炙甘草 15g。以水 3 茶杯, 煮取 1 茶杯, 分 2 次温服, 于日暮时服 1 次, 2 小时后再服 1 次。结果: 治愈 48 例, 显效 6 例。服药最多 9 剂, 最少 2 剂^[6]。

2.3 林宗广自拟方治疗不安腿综合征 2 例 药用生地、淮山药、制黄精、川石斛、当归、赤芍、白芍、柴胡、白术、茵陈、山栀各 10g, 甘草 3g。日 1 剂, 水煎服。服 20 余剂, 均痊愈^[7]。

3 验案报道

3.1 苗毅韧用十全大补汤加味治愈不安腿综合征 1 例 药用黄芪、熟地黄、木瓜、淮山药各 30g, 肉桂、党参、白术、茯苓、甘草、酸枣仁、川芎各 10g, 白芍、当归各 15g, 怀牛膝 20g。日 1 剂水煎服。服药 18 剂, 病愈^[8]。

3.2 江传伸用血府逐瘀汤合桂枝茯苓丸加减治愈不安腿综合征 1 例 药用生地 12g, 桃仁 10g, 甘草 4g, 枳壳 8g, 红花 6g, 赤芍 10g, 柴胡 6g, 川芎 8g, 牛膝 10g, 桂枝 8g, 茯苓 8g, 丹皮 8g, 日 1 剂, 水煎服。宗上方加

减，共服 15 剂，病愈^[9]。

4 中西医结合

4.1 谢明德中西医结合治疗不安腿综合征 18 例 治疗方法：（1）中药内服：白芍 30g，甘草 10g，木瓜 18g，怀牛膝 18g。日 1 剂，水煎分 2 次口服。（2）手法推拿：休息前患者自己用手掌上下擦患肢 3~5 分钟，以有舒适感为止。（3）西药穴封：维生素 B₁50mg、B₁₂50μg 混合，轮流注射委中穴、承山穴，或沿腓神经干体表部位，每日患肢 1 穴（处）1 次。5 天为 1 疗程，休息 3 天（只停穴封），重者 2 个疗程。结果：1 个疗程痊愈 10 例，2 个疗程痊愈 8 例。随访 1 年，复发 1 例^[10]。

4.2 黄光玉以芍药甘草汤配合西药地巴唑治愈不安腿综合征 2 例 药用白芍 20g，甘草 20g。水煎服，日 1 剂。同时配合西药地巴唑 10mg，1 日 3 次，口服。结果：2 例分别于 7 天、10 天治愈^[11]。

5 针刺及其他疗法

5.1 朱超英采用针刺治愈不安腿综合征 1 例 取穴：足三里、阳陵泉、三阴交、绝骨、下巨虚等穴位。针法：提插补法，每次留针 1 小时，2 周后治愈^[12]。

5.2 扬元德用针刺与耳针治疗不安腿综合征 108 例 针刺组 56 例，取双侧血海、地机、三阴交、足三里、上巨虚、太溪。用齐刺法，得气后留针 30 分钟，用呼吸补泻的补法。日 1 次。耳针组 52 例，取耳穴神门、内分泌、皮质下、心、脾、肾、肝穴。用 5 分毫针针刺，留针 20 分钟。起针后用王不留行籽贴于穴上，每日早晚各按压 1 分钟，隔 3 日换贴 1 次。均 12 日为 1 疗程。结果：两组分别痊愈 19、9 例，显效 21、14 例，进步 12、15 例，

无效 4、14 例，总有效率 92.86%、73.08%。两组疗效比较具有显著性差异， $P < 0.01^{[13]}$ 。

5.3 熊周清采用按摩导引疗法治疗不安腿综合征 28 例 本组均先按摩，后导引。1. 按摩手法：(1) 揉摩放松法：患者取俯卧位，医者先后用手掌、大鱼际、掌根在小腿轻度抚摩揉捻数次。(2) 循经点穴法：运丹田之气于拇指，点按双侧昆仑、承山、承筋、合阳、委中、肾俞等穴，以穴位产生较强的酸、麻、胀、重感为宜，或行一轻一重的抖动点按。(3) 分拨掌推法：双拇指循小腿纤维方向作垂直分拨，再用掌根自臀部沿膀胱经反复推揉。(4) 腓肠肌直擦法：用擦法在腓肠肌腹处施术 2~3 分钟。(5) 屈曲击穴法：屈曲患者膝关节，使足跟击打秩边穴数次。(6) 抖晃活络法：双手紧握患者双踝关节，连续抖晃拔伸，频率稍慢。(7) 擦搓舒散法：用合掌法在下肢分别行擦法、搓法数次，至局部透热止。2. 导引法：患者仰卧，排除杂念，意守双下肢，行缓慢深吸气，运气下沉至涌泉穴，再缓缓将气沿膀胱经上行至肾俞穴，如此反复数次。继嘱患者擦热双掌，反复搓揉双小腿肌肉 1~3 分钟。日 1 次，10 日为 1 疗程。结果：痊愈 19 例，显效 5 例，好转 2 例^[14]。

参 考 文 献

- 1 李文海，等．湖南中医杂志，1992；8（3）：12
- 2 何 刚．中医药信息，1993；10（2）：37
- 3 乔连厚，等．中国农村医学，1995；23（12）：49
- 4 郝素云，等．新中医，1996；28（11）：43

- 5 李广振, 等. 江苏中医 .1992; 13 (9): 24
- 6 杜豁然. 河北中医 .1984; (3): 29
- 7 林宗广. 中医杂志 .1984; 25 (2): 58
- 8 苗毅韧. 新中医 .1985; (5): 38
- 9 江传仲. 江西中医药 .1984; (5): 35
- 10 谢明德. 中西医结合杂志 .1985; (5): 268
- 11 黄光玉. 江西中医药 .1985; (3): 封3
- 12 朱超英. 河南中医 .1989; (2): 12
- 13 杨元德. 中国针灸 .1993; 13 (3): 13
- 14 熊周清. 按摩与导引 .1994; (1): 22

(江秀卿)

颅内血肿

颅内血肿是急性颅脑损伤的常见病之一。本病多由暴力损伤，头颅血管破裂；或因高血压、病脉硬化，血管脆性增加，血管破裂而致脑出血。当血液直接进入脑组织，在颅腔内某部位积聚，成为局限性占位病变，积为颅内血肿。该病属于中医的瘀血症，其共同特点为血液不循常道，溢于脉外，积血成瘀。

1 一方为主 随症加减

1.1 蒋平采用活血化瘀法治疗外伤性颅内血肿 18 例

基本方：当归、桃仁各 15g，丹参、川芎、红花、赤芍、茜草、延胡索、郁金、三七粉各 10g，鸡血藤 20g。气虚加黄芪、人参、白术、茯苓；血虚加枸杞子、熟地、阿胶、桑椹子；气滞加香附、木香、青皮、枳壳；湿热加薏苡仁、半夏、黄芩、山栀子。结果：临床治愈 9 例，好转 8 例，有效 1 例^[1]。

1.2 杨香锦用完带汤加减治疗颅内血肿 13 例 本组均因外伤致硬脑膜外血肿，均有明显的中间清醒期，剧烈头痛，频繁呕吐和偏瘫，其中 5 例经手术后仍有此症。药用红参、苍术、柴胡各 10g，白术 12g，车前子 30g，荆芥炭、丹参、炒山楂、石菖蒲各 15g，甘草 5g。高烧加知母、生石膏；便秘加枳实、大黄；小便闭塞加白茅根；呕吐有痰涎加法夏、羌活；烦躁易怒加炒山栀。结果：临床治愈 9 例，好转（留有后遗症）3 例，无效（死亡）1 例^[2]。

1.3 宓志达自拟方治疗外伤性颅内血肿 10 例 本组均在伤后 1~4 日内用 CT 确诊，血肿大小为 2cm × 1.5~

6cm×5cm；脑内血肿6例，硬膜下血肿4例。在严密观察下，用益气化瘀药：生黄芪60~120g，当归、生薏苡、郁金各15g，石决明、丹参各30g，天麻、制大黄各10g。头痛甚加川芎、藁本；眩晕甚加钩藤、菊花；呕吐剧加代赭石；神疲乏力、纳差者，合四君子汤加减。1剂日2服。结果：全部患者服药2~3天后自觉症状减轻，1周后视乳头水肿消退，神经系统阳性体征消失。治疗20~25天后复查CT，血肿均全郁吸收^[3]。

1.4 柯梦笔等用活血消肿汤治疗外伤性急性脑内血肿12例 本方含当归、赤芍、川芎、桃仁、泽兰各12g，丹参、川牛膝、车前子（包）各15g，红花、苏木、泽泻各10g，生甘草5g。呕吐加姜半夏10g，代赭石20g（先煎）；头痛剧加延胡索12g，蔓荆子10g；痰盛加服鲜竹沥，1支/日2次；大便干结加生大黄6g；颅伤骨折伴发热加银花15g，连翘10g，蒲公英30g，黄芩12g。日1剂水煎服。停用西药。结果均获临床治愈，服药10剂治愈8例，15剂愈4例^[4]。

2 固定方治疗

2.1 许笃聪等用补阳还五汤治疗慢性硬膜下血肿18例 本方含黄芪30g，当归、川芎、赤芍、地龙各10g，桃仁、红花各6g。日1剂水煎服，20日为1个疗程。治疗9~20日，结果：治愈15例，基本治愈2例，无效1例^[5]。

2.2 秦元等用血府逐瘀汤治疗外伤性颅内血肿55例 本组患者中硬脑膜下血肿31例（慢性30例、亚急性1例），硬脑膜外血肿17例（亚急性15例，慢性2例），脑内血肿7例（均亚急性），用本方（当归、赤芍、生地、

桃仁、红花、川芎、牛膝、桔梗、柴胡、枳壳、甘草) 日 1 剂水煎服。经服药 20 ~ 140 剂后, 全部有效, 其中治愈 53 例, 治愈率为 96.3%。对 10 例患者曾多次以头颅 CT 追踪检查, 于动态下观察到血肿吸收的全过程, 发现 CT 值均由高向低转化至完全吸收, 未发现新鲜出血现象, 表明本方有增强血肿壁血管韧性, 免于再出血, 增强血肿周围组织的血液循环, 使血肿之囊壁及血性囊液机化吸收。认为这可能是中药治愈外伤性颅内血肿的药理机制^[6]。

3 中西医结合

刘成顺用益气活血汤治疗颅内血肿术后综合症 66 例

本组用本方: 太子参、地龙、桃仁、郁金、菖蒲、陈皮各 10g, 生黄芪 30g, 当归 15g。赤芍、川芎、丹参各 12g, 蜈蚣 1 条, 升麻 9g。病久加水蛭; 痰多、恶心加半夏; 肢体活动欠佳加鸡血藤、丝瓜络。日 1 剂水煎服或鼻饲。对照组 25 例, 用三磷酸腺苷 40mg, 辅酶 A100u, 细胞色素 C30mg, 维生素 C3g, 维生素 B₆0.1g, 加 10% 葡萄糖液 500ml, 静滴, 日 1 次。谷维素 40mg, 脑复康 0.8g, 日 3 次口服。均于术后 3 ~ 5 日予止血、抗炎等常规处理; 均 10 日为 1 疗程。用 1 ~ 2 个疗程, 结果: 两组分别痊愈 48、0 例 ($P < 0.01$), 显效 12、17 例 ($P < 0.01$), 有效 5、6 例, 无效 1、2 例, 总有效率为 98.48%、92% ($P > 0.05$)^[7]。

参 考 文 献

- 1 蒋 平. 新中医. 1993. 1993: 25 (1): 28

脑震荡

脑震荡是指头部受外界直接或间接的暴力作用后而引起的一过性脑功能障碍，但无器质性病变。主要表现为短暂的意识丧失，意识恢复后见逆行性遗忘，伴头痛、头晕、恶心、呕吐等。本病属祖国医学“昏迷”范畴。神志清楚后主见头痛等，属祖国医学“头痛”范畴。

1 一方为主 分期论治

朴永日等以通窍活血汤为主，分期治疗脑震荡 32 例

药用丹参 20~25g，石决明 25~30g，赤芍、桃仁各 15~20g，川芎、红花、菊花、牛膝各 10~25g，麝香（冲）0.25g（或白芷 10~15g 代），葱 3 根，姜 3 片，大枣 3 枚。晕厥期加服至宝丹；中期头痛眩晕加天麻、石菖蒲，胸闷呕恶加法半夏、竹茹，烦躁发热、惊厥抽搐加紫雪丹，并加丹皮、黄芩、山栀子，恢复期见头目眩晕、神呆加石菖蒲、远志、红参、酸枣仁、茯神，纳呆加香砂六君子汤等。结果：痊愈 12 例，显效 10 例，好转 8 例，无效 2 例^[1]。

2 一方为主 随症加减

2.1 郭景周用颅伤愈震汤治疗脑外伤后遗症 36 例

本方含当归尾、天麻、白芷、廬虫、地龙、制半夏各 9g，细辛、广木香各 6g，茯苓 15g，桃仁 12g。头痛甚加藁本、蔓荆子、川芎；头晕甚加钩藤、石决明、菊花；耳聋耳鸣加灵磁石、石菖蒲；抽搐加白蒺藜、钩藤；恶心呕吐加竹茹、代赭石；心烦失眠加合欢皮、夜交藤、远志；心悸加生龙骨、生牡蛎；便秘加大黄、火麻仁。日 1 剂水煎服。18 日为 1 疗程，疗程间隔 3~4 日。治疗 2 个疗程，结果：

痊愈 44 例，好转 6 例^[5]。

2.5 郭锡权用川芎钩藤汤治疗脑震荡 13 例 本组中有颅骨骨折 3 例，头皮挫裂伤 4 例，单纯头部外伤 6 例。基本方：川芎、当归、赤芍、石菖蒲各 12g，朱茯苓、丹参各 15g，钩藤、白芷各 10g，薄荷 6g，怀牛膝、生龙骨、生牡蛎各 20g。损伤初期，头痛较甚如锥刺样，可加三七粉 6g 冲服；胸闷呕恶，烦躁易怒加菊花、白蒺藜、姜半夏；烦躁不安，夜间头痛加重，夜间不眠加山栀子、合欢皮、珍珠母；瘀血日久，头痛仍甚加蜈蚣或全虫。水煎日 1 剂。经 10~40 日治疗，治愈（症状消失，无后遗症）8 例，好转（症状明显减轻，偶有头痛）4 例，无效 1 例^[6]。

2.6 周林宽等用丹参龙琥汤治疗脑震荡 100 例 本方含丹参、茯神各 30g，龙齿、川牛膝各 15g，琥珀粉、三七粉各 3g（均冲服），川芎 10g，菊花、桑叶各 9g，木通 6g。头顶痛加藁本、荆芥穗；太阳穴痛加白芷；后枕部痛加羌活、细辛；心烦胸闷加淡豆豉、郁金；恶心呕吐加砂仁、赭石；失眠加远志、枣仁、夜交藤；纳呆加神曲、炒谷芽、炒麦芽。日 1 剂水煎服，10 日为 1 疗程。用 2 个疗程，结果：痊愈 61 例，显效 20 例，有效 14 例，无效 5 例，总有效率 95%^[7]。

2.7 周端求用龟芍牡蛎菖蒲汤治疗脑震荡后遗症 102 例 药用龟板、乳香、没药、石菖蒲、蔓荆子各 10g，白芍、枸杞各 15g，熟地、生地、石决明各 20g，牡蛎、赭石、磁石各 50g。头痛甚加水蛭、川芎；神疲乏力、纳呆，牡蛎、赭石、磁石用量减半，加黄芪、人参、白术、荷叶；项强加葛根；大便燥结加黑芝麻、胡桃肉、蜂蜜。

日1剂，水煎服。结果：治愈24例，显效59例，好转11例，无效8例，总有效率为92.16%^[8]。

2.8 贺哲等报道贺清义治疗脑震荡后遗症42例 基础方：丹参、川芎各18g，蔓荆子、白芷、地龙、路路通各10g，桃仁、羌活、防风、薄荷各6g，血竭、甘草各3g。心烦失眠加合欢皮、夜交藤各15g；兼痰湿者加菖蒲、半夏各10g。待症状消失后，改服补肾滋脑汤：牛膝、桑枝、山萸各12g，紫河车6g，当归、郁金、熟地各10g，党参、黄芪各18g。结果：痊愈36例，好转5例，无效1例，总有效率为98%^[9]。

3 固定方治疗

3.1 梁鹿章等用祛伤醒脑汤治疗脑震荡 本组84例，经脑电图检查41例；有异常者18例。用本方（含木香、青皮、丹参、川芎、赤芍、乳香、归尾、防风、藁本、赤茯苓、甘草），日2次每次1剂，水煎服。6日为1疗程，可连服2~3疗程。对照组69例，脑电图查30例，异常者12例。用西药谷维素、三溴合剂、谷氨酸、维生素B₁、维生素B₆、安定片等。一般在症状消失后停药，症状不缓解者服药4周停药。本组与对照组疗效分别为优（症状消失，能正常工作，随访4~12月症状无复发）49、26例，良（症状大部消失，生活能自理，4~12月随访症状未加重）31、28例，差（症状缓解不明显，生活需人照顾，随访症状消失缓慢）4、15例，优良率95.2%、78.3%。脑电图复常18、12例。两组疗效比较有非常显著差异 $P < 0.01$ ^[10]。

3.2 陈甲模用通窍祛瘀定志汤治疗脑震荡后遗症29例 本组均有头部外伤史，伤后曾有一时的意识丧失及呕

参 考 文 献

- 1 朴永日, 等. 新中医 .1987; 19 (5): 10
- 2 郭景周. 新中医 .1995; 27 (11): 23
- 3 王贻芳. 吉林中医药 .1994; (4): 41
- 4 刘向东, 等. 实用中西医结合杂志 .1993; 6 (1): 24
- 5 盛子敬. 山东中医杂志 .1994; 13 (2): 66
- 6 郭锡权. 湖北中医杂志 .1988; (6): 15
- 7 周林宽, 等. 浙江中医学院学报 .1997; 21 (2): 30
- 8 周端求. 陕西中医 .1991; 12 (6): 247
- 9 贺 哲, 等. 四川中医 .1990; 8 (5): 26
- 10 梁鹿章, 等. 广东医学 .1991; 12 (5): 35
- 11 陈甲模. 湖南中医杂志 .1988; 4 (6): 40
- 12 田殿兴, 等. 山东中医杂志 .1995; 14 (2): 66
- 13 李达清, 等. 云南中医杂志 .1991; 12 (3): 37

(王学瑞)

脑萎缩

脑萎缩是指脑组织体积缩小，是老年病中的常见难治病。临床主要表现为记忆力减退，判断、识别能力下降，以及个性改变、失语失用、瘫痪等症状。本病相当于中医学的“痴呆”症。

1 辨证论治

1.1 黄政叶等辨证治疗脑萎缩 40 例 肝肾阴虚用熟地 20g，龟板、石决明、珍珠母各 30g（先煎），山萸肉、巴戟天、黄精、菟丝子、枸杞子、白芍各 15g，淮山药、麦冬、玉竹、刺蒺藜、丹参、丹皮各 10g，鹿角胶（烔）12g。脾肾阳虚用熟附子、人参各 30g（先煎）、炒白术、薏苡仁、茯苓、泽泻各 20g，车前子、半夏、瓜蒌、苍术、炙甘草、白芥子各 10g，肉桂（后下）6g。瘀血内停用桃仁、红花、赤芍、生地、柴胡、当归各 15g，炙甘草、大黄各 10g，麝香（冲）0.5g。痰浊阻滞用半夏、陈皮、茯苓、苍术各 15g，石菖蒲、郁金、制南星、僵蚕、炙甘草、天麻、全蝎、钩藤、地龙各 10g，薏苡仁 30g。痰热上扰用半夏、茯苓、陈皮、竹茹、炙甘草、枳实、黄连、山栀子、石菖蒲、郁金、菊花、大黄各 10g，牡蛎、龙齿、石决明各 30g（先煎）均随症加减。日 1 剂水煎服，10 剂为 1 疗程，疗程间隔 5 日。结果：治愈 15 例，好转 19 例，无效 6 例，总有效率为 85%^[1]。

1.2 雷慧敏等辨证治疗脑萎缩 32 例 痰瘀痹阻型用黄芪 30g，党参、天麻、生地各 15g，远志、当归、五味子、石菖蒲、赤芍、白芍、胆南星、白术、陈皮、穿山甲各 10g；茯苓 20g，琥珀 3g，地龙 12g。肾虚瘀阻型用熟

地、龟板、山萸、丹参、首乌、枸杞子、楮实子各 15g，桃仁、红花、川芎、菖蒲、郁金、赤芍各 10g，黄精 20g。均日 1 剂水煎服。治疗 25 ~ 120 日后，痊愈 4 例，显效 13 例，有效 11 例，无效 4 例，总有效率 87.5%^[2]。

1.3 刘祖贻等从肝、肾、血瘀辨证治疗脑萎缩 16 例

风阳阻络证：生白芍 12g，天麻、钩藤、益母草、地龙、山楂各 10g，珍珠母、石决明各 30g，丹参、生蒲黄各 15g，全蝎 5g。瘀阻脑络证：生黄芪 30g，丹参、生蒲黄各 15g，川芎、益母草、钩藤、山楂各 10g，全蝎 5g。阳虚血瘀证：生黄芪 30g，淫羊藿、鹿角霜、丹参、生蒲黄各 15g，巴戟天、川芎、山楂各 10g。阴虚血瘀证：生地 12g，枸杞子、当归、山楂各 10g，女贞子、丹参、蒲黄各 15g。随症加减。结果：显效 5 例，有效 6 例，无效 5 例^[3]。

1.4 洪亨炤等报道脑萎缩的中医康复治疗 本组 42 例。肝肾亏虚髓海不足者用山茱萸、熟地、山药、丹参、远志、五味子、首乌、麦冬、龟板胶、当归、白芍、茯苓。阴虚火旺者用黄芩、黄连、生地、玄参、丹参、枣仁、生铁落、磁石、龙骨、牡蛎、菖蒲。气血不足者用人参、白术、茯苓、当归、白芍、酸枣仁、木香、龙眼肉、远志、山药。痰浊瘀血闭阻清窍者用竹茹、枳壳、陈皮、半夏、胆南星、黄芪、当归、赤芍、菖蒲、郁金、僵蚕。疗程为 2 个月，结果：显效 10 例，有效 23 例，无效 9 例^[4]。

2 一方为主 随症加减

2.1 贺仲华用定眩汤治疗脑萎缩 38 例 本方含龟板、黄精、生牡蛎各 30g，首乌、牛膝各 20g，山萸肉、

12g, 熟地 20g, 炙甘草 6g。痰热加竹茹、清半夏、胆南星; 失眠加酸枣仁、生龙齿; 肢体活动障碍加全蝎、瓜蒌; 头痛重加细辛、僵蚕。结果: 临床治愈 20 例, 好转 4 例, 无效 1 例, 总有效率 96%。服药 24~57 剂^[8]。

2.5 喇万英用脑萎煎治疗脑萎缩 8 例 本方含黄芪 60g, 当归、川芎、地龙、麦冬、五味子、石菖蒲、穿山甲、天麻、白芷各 10g, 熟地、茯苓各 30g, 何首乌、天竺黄各 15g。随症加减, 日 1 剂水煎服, 1 月为 1 疗程。结果: 痊愈 1 例, 有效 6 例, 无效 1 例^[9]。

2.6 卢桂梅用芎芪醒脑方治疗脑萎缩 22 例 本方含黄芪、丹参、党参各 30g, 熟地、女贞子各 20g, 川芎 10g, 赤芍、地龙各 15g, 僵蚕 12g, 田三七、全蝎各 6g, 蜈蚣 2 条。头晕头痛加天麻、钩藤、刺蒺藜; 肢瘫加怀牛膝、威灵仙、鸡血藤; 失语或语言不清加胆南星、菖蒲、郁金; 失眠烦躁去黄芪、蜈蚣, 加黄芩、熟枣仁、龙骨(先煎); 小便失禁加益智仁、桑螵蛸。日 1 剂水煎服, 1 个月为 1 疗程。用 2 个疗程, 结果: 基本治愈 2 例, 显效 12 例, 有效 5 例, 无效 3 例^[10]。

2.7 刘松林等采用滋肾荣脑法治疗小脑萎缩 6 例 基本方: 熟地 30g, 怀牛膝、石菖蒲、天麻各 10g, 龟胶、丹参各 15g, 黄花 30g, 珍珠母(另包) 50g, 甘草 5g。言语不清, 头重麻木加泽泻、白菊; 头昏心烦加知母、枣仁; 肾阳虚加仙茅、巴戟。日 1 剂, 水煎 3 次分 3 次温服。配合功能锻炼。2 例病情较重加用胞二磷胆碱 0.5g/日静滴, 连用 20 日。肌张力明显减弱配用针灸 2 日 1 次。结果: 临床治愈 5 例。随访 6~12 个月未复发^[11]。

2.8 王贵林等采用补肾健脑化痰法治疗脑萎缩 35 例

基本方：首乌、山药、龟板、巴戟天各 20g，山萸肉、枸杞子、菟丝子、赤芍、桃仁、红花、远志、郁金、瓜蒌、泽泻、淫羊藿、楮实子、川芎各 15g，石菖蒲 25g。肥胖、流涎或痰多加半夏、陈皮、茯苓；气虚加黄芪、党参或太子参；睡眠不佳加枣仁、柏子仁、夜交藤；头晕肢麻加天麻、钩藤；口渴加天花粉、石斛或元参；心慌气短胸闷加丹参、川芎。日 1 剂水煎服，2 个月为 1 疗程。或配蜜丸 1 丸（2 钱）/日 3 次口服。结果：显效 16 例，有效 14 例，无效 5 例，总有效率 85.7%^[12]。

2.9 武宇平采用补肾化痰法治疗脑萎缩 48 例 本方含生地、熟地各 20g，山萸肉、巴戟天、胡桃肉、菟丝子、淮山药各 15g，泽泻、丹皮、白芍、云苓、当归、丹参、赤芍、红花各 10g。阳虚加附子、肉桂；阴虚加元参、天冬、枸杞子。日 1 剂，水煎服。结果：痊愈 12 例，有效 30 例，无效 6 例^[13]。

3 固定方治疗

戴维葆等用生精益髓治疗脑萎缩 120 例 本方含灵芝、龟板、郁金各 15g，山茱萸、莲须、土鳖虫、水蛭各 6g，补骨脂、首乌、韭子各 12g，菖蒲、南星、白蒺藜、巴戟天各 10g。日 1 剂，水煎，取浓缩液，分 3 次口服；或用 1/3 量，制成散剂口服。3 个月为 1 疗程。结果：显效（症状、体征消失）81 例，有效 29 例，无效 10 例，总有效率 91.6%^[14]。

4 验案报道

傅儒雄报道脑萎缩治验 1 例男患经 CT 检查诊断为“轻度弥漫性脑萎缩”，辨证为肾阴亏损，肝风内动，肝血不足，筋脉失养。治以滋阴补肾、养血熄风，药用枸杞、

生地、阿胶（烔冲）、黄精各 15g，白芍 20g，当归 12g，天麻、僵虫各 10g，钩藤 18g（后煎），甘草 6g 等加减，共服用 40 余剂治愈^[15]。

5 中西医结合

秦茂林中西医结合治疗大脑半球皮质下萎缩 1 例 中药用熟地、枸杞子、五味子、鸡血藤、当归各 12g，山萸肉、龟板、潼蒺藜、郁金、胆星、半夏、天竺黄、鲜菖蒲、淮牛膝、桂枝、虎骨各 9g，丹参 18g 等加减。合用穴位（两侧肩髃、曲池、外关、环跳、足三里及昆仑）交替注射维生素 B₁、B₁₂、加兰他敏各 1 支。配合肌注三磷酸腺甙，静注 10% 葡萄糖酸钙，口服强的松、安坦。经治 6 周而愈^[16]。

参 考 文 献

- 1 黄政叶，等．辽宁中医杂志．1995；22（1）：15
- 2 雷慧敏，等．中医杂志．1992；33（12）：34
- 3 刘祖贻，等．江西中医药．1993；24（2）：12
- 4 洪亨焰，等．福建中医药．1994；25（1）：13
- 5 贺仲华．吉林中医药．1992；（6）：11
- 6 田立，等．山西中医．1992；8（1）：18
- 7 董俊峰．实用中医药杂志．1993；9（2）：15
- 8 李滋栋．陕西中医．1992；13（9）：397
- 9 喇万英．北京中医．1990；（4）：29
- 10 卢桂梅．新中医．1996；28（5）：41
- 11 刘松林，等．湖南中医杂志．1991；7（6）：43
- 12 王贵林，等．中医药信息．1996；（1）：36
- 13 武宇平．天津中医．1997；14（4）：150

- 14 戴维葆, 等. 辽宁中医杂志 .1997; 24 (10): 451
- 15 傅儒雄. 湖南医药杂志 .1984; (6): 34
- 16 秦茂林. 江苏中医 .1994; (1): 60

(岳宗海)

脑动脉硬化症

脑动脉硬化症系指脑动脉粥样硬化，小动脉硬化、玻璃样等动脉管壁变性所引起的慢性、弥漫性脑组织改变与脑功能障碍。脑动脉硬化症往往合并脏器的动脉硬化，发病多在 50 岁以后，病程长，缓慢进展，男性多于女性。本病属于祖国的“神志病”、“头痛”、“眩晕”、“中风”、“健忘”、“癫痫”等病的范畴。

1 辨证论治

梁艳芳辨证治疗脑动脉硬化症 56 例 瘀阻脑络型用丹参、全蝎、黄芪各 15g，蒲黄、益母草、钩藤各 10g，川芎 8g，山楂、牛膝、当归尾各 12g。风阳络阻型用天麻、钩藤、石决明、山楂各 15g，地龙、白芍、丹参、蒲黄、益母草各 10g，全蝎 5g。阳虚血瘀型用鹿角霜、黄芪、丹参、蒲黄、川芎各 15g，淫羊藿、巴戟天、山楂各 12g。阴虚血瘀型用生地、山楂各 15g，枸杞子、女贞子、麦冬各 12g，丹参、蒲黄、当归各 10g。中度并发血管性痴呆加石菖蒲、郁金、胆南星；血管性头痛加露蜂房。日 1 剂水煎服。1 个月为 1 疗程。结果：显效（症状、体征消失，血脂正常，眼底、脑电图检查明显改善）22 例，有效 25 例，无效 9 例，总有效率 83.9%^[1]。

2 一方为主 随症加减

2.1 张翠英等用通脉舒脑汤治疗脑动脉硬化症 50 例

本方含当归、红花、五灵脂各 10g，川芎、生麦芽各 12g，丹参、生山楂、菖蒲（先煎）、女贞子、枸杞子、制首乌、寄生各 15g，毛冬青 30g。胸闷痛加郁金、生蒲黄、三七粉；高血压加夏枯草、钩藤、珍珠母；脑梗塞或肢体

麻木加姜黄、络石藤、水蛭、地龙；便秘加大黄；便溏加茯苓；苔白腻加佩兰。日1剂水煎服，15日为1疗程。停用其它药，节制饮食，禁食肥甘厚味。用1~2个疗程，结果：显效（症状、眼底检查、脑血流图、血脂、血液流变学等指标均明显改善）23例，有效25例，无效2例，总有效率96%^[2]。

2.2 高正今等用补肾活血汤治疗脑动脉硬化症 158例 本组用本方：制首乌、女贞子、淫羊藿、骨碎补、丹参各30g，川芎、泽泻、山楂、玉竹各15g，枸杞子、桃仁、红花、牛膝各10g。气虚加黄芪、党参；痰浊加胆南星、半夏；运动障碍加地龙、僵蚕；肝阳上亢加天麻、钩藤。日1剂水煎服。对照组69例用地巴唑20mg，脑益嗪50mg，均日3次口服；低分子右旋糖酐500ml静滴，日1次。两组均2~4周为1疗程，连用2~3个疗程。结果：两组分别基本治愈96、25例，好转51、29例，无效11、15例，总有效率93.1%、78.2%，两组疗效比较有显著性差异， $P < 0.01$ ^[3]。

2.3 赵玉华用两地汤治疗脑动脉硬化症 12例 药用生地、玄参、白芍各15g，麦冬、阿胶（烊化）、地骨皮各10g。头晕甚加天麻、钩藤、蔓荆子；头痛甚加川芎、葛根；心悸加枣仁、远志；心前区憋闷或疼痛加瓜蒌皮、丹参；夜卧不安加夜交藤；四肢麻木或疼痛加鸡血藤、桑寄生；胆固醇或甘油三酯高加山楂、草决明；血压偏高加夏枯草。日1剂水煎服。服药10~65日，临床治愈5例，好转1例，无效6例^[4]。

2.4 周华珍用温胆汤合天麻钩藤汤加减治疗老年性脑动脉硬化症 30例 用黄芪、菟丝子各30g，钩藤（后

下)、菊花、枸杞子、茯苓各 15g, 淮山药 20g, 天麻、半夏各 10g, 枳壳、竹茹各 6g, 甘草 5g。阴虚加太子参或党参; 胸闷痰浊加瓜蒌、薤白; 心烦失眠加柏子仁、酸枣仁; 头痛加白芷或蔓荆子。日 1 剂水煎服。结果: 显效 21 例, 有效 9 例^[5]。

2.5 刘荣民用益脑汤治疗脑动脉硬化症 32 例 本方含熟地 30g, 山萸肉、制首乌、枸杞子各 15g, 怀山药、茯苓各 20g, 龟板胶、菖蒲各 10g, 炙远志 6g。随症加减, 日 1 剂水煎服。结果: 显效 (症状消失或明显减轻, 记忆力增加) 12 例, 有效 16 例, 无效 4 例, 总有效率 87.5%^[6]。

2.6 张兆臣用加味益气聪明汤治疗脑动脉硬化症 20 例 药用黄芪、丹参各 20g, 党参、葛根各 15g, 升麻 5g, 蔓荆子、川芎各 12g, 白芍、甘草各 10g, 黄柏 8g。随症加减。结果: 总有效率为 90%, 各种症状均有不同程度改善, 甲皱微循环、脑血流图改善满意^[7]。

2.7 林曲用升清养髓汤治疗脑动脉粥样硬化 82 例 本方含葛根、鸡血藤、枸杞子各 30g, 女贞子、当归各 20g, 丹参、川芎各 15g, 石菖蒲、菊花、炙甘草各 10g, 随症加减。结果: 痊愈 (临床症状消失, 脑血流图复查正常) 35 例, 显效 (临床症状消失, 脑血流图复查明显改善) 38 例, 有效 9 例^[8]。

2.8 胡学军用三七女贞饮治疗脑动脉硬化症 54 例 本组用本方: 三七粉 3g (分冲), 女贞子 30g, 制首乌、白术、昆布、白菊花、僵蚕各 10g, 山茱萸 12g, 炒蒲黄、山楂各 20g, 酒大黄 4g, 泽泻 25g, 天麻 9g (另蒸兑服), 夜交藤 15g。痴呆去大黄加石菖蒲、郁金; 吞咽困难加姜

半夏、厚朴；振掉加白芍、钩藤。日1剂水煎服。对照组54例，用烟酸肌醇酯0.4g，维生素E200mg，维生素B₆20mg，均日3次口服。均40日为1疗程。治疗1个疗程，结果：两组分别显效（症状消失，体征改善，积分减少>10分，血脂下降>40%，其它各项检查部分恢复或明显改善）35、18例，有效15、24例，无效4、12例，总有效率92.6%、77.8%（ $P<0.01$ ）。两组脑血流电阻图7项指标治疗前后自身比较均有显著性差异 $P<0.01$ ；除波幅差外，其余6项指标治疗后本组均优于对照组（ $P<0.01\sim0.001$ ）；两组降血清胆固醇、甘油三酯总有效率分别为95.4%、74.5%，92.7%、79.6%（ P 均 <0.01 ）^[9]。

2.9 王金荣等采用益气养阴活血法治疗脑动脉硬化症120例 用软脉饮：生黄芪20g，麦冬、半夏、茯苓、川芎、天麻、钩藤、海藻各10g，首乌、丹参各15g，五味子6g，水蛭3g。目涩黑蒙加枸杞子、菊花；高血压加防己、葛根；高血脂加决明子、泽泻、生山楂；记忆减退加菖蒲、远志。日1剂水煎分3次服。停用其它药，戒烟酒。结果：显效（症状消失，实验室指标复常）52例，有效59例，无效9例，总有效率92.5%。脑血管血流速度（大脑前动脉、大脑中动脉、椎动脉）、血脂（甘油三酯、胆固醇、高密度脂蛋白）、血液流变学（全血粘度、血浆比粘度）及甲皱微循环（形态、流态及综合积分）治疗前后比较均有显著性差异， $P<0.01、0.05$ ^[10]。

2.10 郑爱国采用补中益气活血法治疗脑动脉硬化性眩晕54例 基本方：黄芪、西党参各30g，白术、陈皮、柴胡、天麻、川芎、桃仁、红花、地龙各10g，当归、丹参各15g，各麻、甘草各6g。纳差欲呕加砂仁、生姜；视

物模糊加枸杞子、菊花。日 1 剂水煎服。结果：显效（症状消失，脑血流图示脑供血明显改善，血脂恢复正常）45 例，好转 8 例，无效 1 例，总有效率为 98%^[11]。

3 固定方治疗

3.1 宋明会用益肾活血汤治疗老年脑动脉硬化症 20 例 本方含熟地、鸡血藤、丹参、生山楂各 30g，山药、山萸肉各 20g，怀牛膝、制首乌各 15g，枸杞子、川芎各 10g。日 1 剂水煎服。结果：显效（临床症状基本消失，血压、血脂、血粘度降为正常）6 例，有效 13 例，无效 1 例^[12]。

3.2 唐晨光等用左归饮合补阳还五汤治疗脑动脉硬化症 31 例 用熟地 15~30g，山茱萸、枸杞子、当归、桃仁、地龙、益智仁各 10g，山药、山楂、草决明各 15g，黄芪 30~50g，红花、密远志各 6g。日 1 剂水煎服，1 个月为 1 疗程。用 2 个疗程，结果：显效（症状、体征减轻，脑电图、脑阻抗血流图明显改善）6 例，有效 21 例，无效 4 例，总有效率 87.1%。血液流变学指标治疗前后比较均有显著性差异， $P < 0.05$ ^[13]。

3.3 支惠萍等用脑脉唐脑囊治疗脑动脉硬化症 50 例 本组用本品（含人参、三七、丹参、何首乌、葛根、川芎、红花、淫羊藿、桑寄生、石菖蒲、人参叶、山楂、水牛角、冰片等）2~4 粒/日 3 次口服，30 日为 1 疗程。观察 1~2 疗程。结果：自觉、精神症状的改善分别为 88%、87.8%；甘油三脂、 β -脂蛋白非常显著下降及 HDL-ch 非常显著升高（ $P < 0.01$ ），胆固醇显著下降（ $P < 0.05$ ）；全血粘度、血浆粘度、纤维蛋白原显著降低（ $P < 0.01$ 和 0.05）。服药期间个别患者有胃肠道不适、面色潮红^[14]。

3.4 林水森等用固本通脉复方治疗脑动脉硬化症 40例 用本吕（含首乌、苍术、白术等，制成合剂）30ml/日2次；对照组16例，用非诺贝特0.1g/日3次；均口服，用3个月。结果：两组血清甘油三酯（TG）、总胆固醇（T-ch）显效率分别为43%、68.7%，47.5%、31.3%；TG、T-ch、载脂蛋白B₁₀₀、高密度脂蛋白-胆固醇/T-ch、载脂蛋白AI/载脂蛋白B₁₀₀及血液流变学指标（RBV、RPV），两组治疗前后自身比较有显著性差异， $P < 0.01$ 或0.05；血液还原粘度、记忆商，仅本组治疗前后比较有显著性差异， P 均 < 0.05 ^[15]。

4 中西医结合治疗

4.1 杨卫生等中西医结合治疗脑动脉硬化症 62例 中药用地龙归芎散（地龙、当归、川芎各30g，人参20g，研末）6g/日2次冲服。西药用胞二磷胆碱1000mg加500ml液体静滴，第2周改用胞二磷胆碱500mg稀释至60ml静注，均日1次，2周为1疗程，疗程间隔3~5日。治疗2个疗程。结果：显效43例，有效15例，无效4例，有效率为93.5%^[16]。

4.2 彭世桥等中西医结合治疗脑动脉硬化性麻木症 50例 用补阳还五汤加味：黄芪20g，当归、地龙各12g，赤芍、桃仁、红花、全蝎各10g，川芎15g，水蛭、甘草各6g。气虚明显重用黄芪，加党参；偏阳虚加桂枝、制附片；阴虚加生地、枸杞子、女贞子；血虚重用当归，加鸡血藤；肝阳偏亢加夏枯草、珍珠母、钩藤；兼风邪加荆芥、防风。日1剂水煎服。西药用低分子右旋糖酐500ml加丹参注射液5~10支静滴，日1次。15日为1疗程。治疗1~3疗程。结果：完全控制21例，基本控制16例，

好转 10 例，无效 3 例，总有效率 94%^[17]。

5 针刺、艾灸、输液疗法

孙远征等治疗脑动脉硬化症 45 例 随机分为 3 组。针刺组选百会、风池、风府、外关、曲池、足三里等穴，用平补平泻手法，留针 30 分钟，日 1 次。艾灸组选曲池、外关、足三里穴，用无瘢痕直接灸，以局部皮肤充血红晕为度，每次 15 分钟，日 1 次，输液组用 5% 葡萄糖注射液 500ml 加丹参注射液 3 支、维生素 C5g 静滴。治疗 14 日后，显效 38 例，进步 5 例，无效 2 例，总有效率为 95.5%。结果表明 3 组对甲皱微循环的异型管样、样顶瘀血及血流速度均有一定影响和调节作用，针刺组及艾灸组作用优于静脉输液组，其中对后 2 项指标影响更为显著^[18]。

6 药氧针刺疗法

秦敏采用药氧针刺治疗治疗脑动脉硬化症 30 例 头皮针取穴：额区取太阳（水平向前进针，深 0.5 ~ 0.8cm）及头维穴（对准百会，30°角进针约 1cm）、顶区（前后正中中线中点及旁开各 1.5cm 处，交叉进针，对向额部、与前后正中中线呈 45°角、30°角进针，深约 1cm）、颞区（耳尖后 1cm 向上引 5cm 垂直线，分成 3 等份，水平向前，呈 15°角进针）、枕区（枕骨粗隆左右各旁开 3cm，垂直向下，呈 20°角进针，深 0.8cm）、颈区（第 3 颈椎左右旁开 3cm，斜向内下，呈 60°角进针，深 0.8cm）。5 个区域各选 1 ~ 3 穴，快速旋转 > 200 次/分，约 1 分钟，得气后留针 30 分钟。并吸药氧：用麝香、丹参、桃仁、红花、川芎等十余味，加 75% 酒精与蒸馏水浸泡，取浓缩液。每次用 20ml，加入氧气湿化瓶内，流量为 2L/分钟，每次 1 小进。隔日

- 9 胡学军. 山东中医杂志. 1995; 14 (11): 496
- 10 王金荣, 等. 浙江中医杂志. 1997; 32 (4): 154
- 11 郑爱国. 湖南中医杂志. 1994; 10 (5): 36
- 12 宋明会. 贵阳中医学院学报. 1991; (1): 23
- 13 唐晨光, 等. 湖南中医药导报. 1997; 3 (2、3): 25
- 14 支惠萍, 等. 上海中医药杂志. 1993; (2): 26
- 15 林水森, 等. 上海中医药杂志. 1995; (1): 10
- 16 杨卫生, 等. 实用中西医结合杂志. 1992; 5 (10): 602
- 17 彭世桥, 等. 江苏中医. 1992; 13 (5): 16
- 18 孙远征, 等. 针灸学报. 1991; 7 (3): 18
- 19 秦 敏. 针灸临床杂志. 1996; 12 (7、8): 61
- 20 王竹行. 针灸临床杂志. 1995; 11 (11、12): 23

(赵丽珠)

椎—基底动脉供血不足

椎—基底动脉供血不足最常见的症状为眩晕，伴发视野缺损、复视。但很少同时有耳鸣。可以发生言语不清、一肢供济失调、双眼视物模糊、声嘶、呃逆、呕吐，偶尔可有意识障碍。一侧颅神经麻痺，伴双侧肢体瘫痪或感觉障碍。本病隶属于祖国医学的“中风先兆”、“眩晕”、“厥证”等病的范畴。

1 辨证论治

王雄开等辨证治疗椎—基底动脉供血不足 93 例

(1) 心气不足型：方用补中益气汤加減：黄芪、党参、当归、陈皮、升麻、柴胡、远志、枣仁、五味子等。方中参、芪用量宜大。(2) 经络阻滞型：方用蠲痹汤加減：羌活、姜黄、当归、赤芍、鸡血藤、桂枝、川芎、天麻等。(3) 气虚不运型：方用补中益气汤与蠲痹汤合方加減：黄芪、党参、当归、升麻、柴胡、姜黄、羌活、鸡血藤、桂枝、炙甘草等。结果：显效 60 例，占 64.5%；好转 25 例，占 26.8%；无效 8 例，占 8.6%^[1]。

2 一方为主 随证加減

2.1 黄政叶等用黄芪赤风汤加味治疗椎—基底动脉供血不足 50 例 本组用本方加味：黄芪 50g，防风 25g，赤芍 20g，茯苓、泽泻各 30g。气血不足加党参、升麻、当归、白芍、川芎、鸡血藤；痰湿瘀阻加半夏、陈皮、天麻、葛根；心阳不振加桂枝、白术、丹参、生地、麦冬；肝肾不足加杜仲、牛膝、黄柏；阴虚加熟地、丹皮；阳虚加淫羊藿、熟附子；脉络瘀阻加威灵仙、木瓜。日 1 剂水煎服。配合按摩，从双侧风池穴开始，沿颈项的头半棘

肌、头夹肌、肩胛提肌，按冯天有的分经、理经、镇定方法，手法强度以患者不疼痛、不疲劳为准。每次30分钟，日1次。均10日为1疗程，疗程间隔4日。对照组34例，用扩张血管药物为主治疗。结果：两组分别治愈29、8例，好转17、12例，无效4、14例，总有效率为92%、58.8%。两组疗效比较有显著性差异 $P < 0.01^{[2]}$ 。

2.2 陈根芳采用祛邪扶正法治疗椎—基底动脉供血不足性眩晕53例 本组药用天麻、姜半夏、白术、川芎、白芍、地龙各10g，葛根、淫羊藿、熟地各30g，细辛5g。肝阳上亢加石决明30g，钩藤10g（后下）；肝肾阴虚加山萸肉15g，女贞子10g；气滞血瘀加三七参5g，鸡血藤30g；肾阳亏虚加锁阳15g，鹿角胶5g。日1剂水煎服。结果：治愈32例，好转19例，无效2例，总有效率96.4%。平均治疗21日^[3]。

2.3 郭天彝以益气活血为主治疗椎—基底动脉供血不足26例 本组年龄60~79岁。有高血压病史17例，糖尿病4例，颈椎病5例，高脂血症9例。基本方：黄芪30~40g，首乌、益母草、川芎、当归、茯苓、龙骨、牡蛎各20g，地龙、赤芍各15g，葛根、牛膝各30g，半夏10g。阴虚加生地、熟地、丹皮各20g；偏阳虚加淫羊藿10g；肝阳上亢或血压高加钩藤20~30g；痰热加黄芩、竹茹各10g；颈椎增生加威灵仙15g，木瓜、白芍各20g。日1剂，水煎200ml分2次服。服7~34剂。5例予丹参注射液20ml加5%葡萄糖500ml静滴，日1次。结果：显效（用药<1周眩晕及伴随症状完全消失）18例，有效（用药<1周眩晕及症状明显好转）6例，无效2例，有效率92%。治疗前后行血液流变学有关指标测定16例，结果全血粘

度和纤维蛋白原下降、红细胞压积减小，均有显著差异， P 均 $< 0.01^{[4]}$ 。

3 一方为主 随症加减

3.1 马佩琼等自拟葛灵汤治疗椎一基底动脉供血不足 56 例 本方含葛根、威灵仙、狗脊、川芎、白术、泽泻、龙齿、云苓、地龙、鸡血藤、龟板、白芍、生甘草、三七。用 10 剂效差加生水蛭；肢冷、麻木加桂枝；单纯肢麻加桑枝；肝郁加片姜黄或郁金；夹痰加陈胆南星、石菖蒲、远志。结果：显效 41 例，有效 13 例，无效 2 例，总有效率 96.5%^[5]。

3.2 阎丰书等用茯苓泽泻汤加味治疗椎一基底动脉供血不足性眩晕 55 例 本方含茯苓、泽泻、石决明各 30g，白术 18g，天麻 15g，半夏、丹参、桂枝各 9g，生姜炙甘草各 6g。舌蹇加菖蒲、郁金；肢麻喎僻加钩藤、全蝎。日 1 剂水煎服。结果：服药 1~3 周主要症状均消失。眩晕症状控制之后，需分别治疗原发病^[6]。

3.3 蒋森等用通络止眩汤治疗椎一基底动脉缺血性眩晕 58 例 本组用本方：丹参、葛根、鹿含草各 30g，川芎、赤芍、自然铜、穿山龙各 15g，红花、全蝎、制南星各 6~12g，蜈蚣 1~2 条。随症加减，日 1 剂水煎服。对照组 21 例，用桂益嗉、阿斯匹林、潘生丁各 50mg，尼卡地平 40mg，均日 3 次口服。治疗 45 日，结果：两组分别治愈 21、5 例，显效 25、6 例，有效 7、6 例，无效 5、4 例，总有效率 91.4%、80.9% ($P < 0.01$)^[7]。

3.4 滑顺刚等采用活血化瘀法治疗椎一基底动脉供血不足性眩晕 63 例 基本方：丹参 30~45g，川芎 6~9g，赤芍、当归、地龙各 9~15g，桃仁 9~12g，鸡血藤、葛根

各 15~30g。面赤口苦、烦躁易怒、血压升高者加石决明、珍珠母、夏枯草；耳鸣、聾、五心烦热、舌瘦面红者加生地、玄参、钩藤、磁石；面色晄白、气短懒言、纳呆者加党参、黄芪、陈皮；精神萎靡、四肢不温者加附片、肉桂；胸闷、苔腻加瓜蒌、薤白、枳壳；恶心呕吐加姜半夏、竹茹、橘皮；血脂高加山楂。日 1 剂水煎服。症状较重者配合复方丹参注射液 16~20ml 加葡萄糖水静滴，日 1 次，头痛明显者改川芎嗪注射液。结果：临床痊愈 37 例，显效 15 例，有效 8 例，无效 3 例。疗程 14 日~3 月^[8]。

4 外用药物治疗

韩兆祺等用速暖镇痛敷料治疗椎一基底动脉供血不足 23 例 本品分药物面和产热面 2 个部份。药物面由桂枝、肉桂、三七、白芷、冰片等组成；产热面由铁粉、木粉、食盐、活性炭、水及其他组成。使用时打开塑料袋后抖动 3 分钟，然后贴敷于大椎穴，使药面贴近皮肤，产热面与空气接触，如感太热可垫上一层纱布，每日换 1 次，5~10 次为 1 疗程。治疗 1 疗程后，显效（症状及体征基本消失）18 例，有效（头晕减轻，两手发麻消失）2 例，无效 3 例^[9]。

5 中药针剂治疗

黄立武等用黄芪注射速合复方丹参注射液治疗椎一基底动脉供血不足性眩晕 50 例 用黄芪注射液（广西中医学院提供）100ml（含生药 50g）；复方丹参注射液（江苏东台市制药厂生产）12~16ml，加 5% 葡萄糖液 250ml；均静滴，日 1 次。结果：治愈 35 例，好转 14 例，未愈 1 例，总有效率 98%^[10]。

6 针刺疗法

赵惠馨等以针刺治疗椎—基底动脉供血不足 102 例

取穴：风池（直刺 1~1.5 寸，针感放散到枕、颞部）、百会（30°角飞针刺入，方向指向前顶穴，针体刺入帽状腱膜下 0.5 寸）、络却（15°角飞针刺入，进针 0.5~0.8 寸，方向指向天柱穴，均小幅度捻转 1 分钟）颈椎夹脊穴（选 C₃~C₅ 棘突下旁开 0.5 寸处，双侧共 6 穴，均直刺 1~1.2 寸，针下有麻胀感后小幅度捻转 1 分钟，提至 0.5 寸处留针）。均 5 分钟行针 1 次，留针 20 分钟。日 1 次，10 次为 1 疗程。用 3 个疗程，结果：痊愈 49 例，好转 41 例，无效 12 例，总有效率 88.2%。椎及基底动脉的收缩峰值、舒张末及平均流速均显著上升（ $P<0.01$ ）^[11]。

参 考 文 献

- 1 王维开，等．四川中医．1992；10（6）：32
- 2 黄政叶，等．辽宁中医杂志．1994；21（3）：121
- 3 陈根芳．国医论坛．1993；8（3）：28
- 4 郭天彝．山东中医杂志．1990；9（2）：13
- 5 马佩琼，等．中医学报．1994；（4）：36
- 6 阎丰书，等．河南中医．1993；13（1）：22
- 7 蒋 森，等．中国中西医结合杂志．1995；15（6）：374
- 8 滑顺刚，等．河南中医．1992；12（6）：271
- 9 韩兆祺，等．浙江中医学院学报．1990；14（4）：22
- 10 黄立武，等．广西中医药．1997；20（2）：20
- 11 赵惠馨，等．中国针灸．1997；17（4）：211

（宿秀英）

重症肌无力

重症肌无力是由于神经肌肉间传递功能障碍而影响肌肉收缩，以横纹肌无力及易疲劳为特征的慢性疾病。本病属祖国医学“痿症”范畴。

1 辨证论治

1.1 李庚和等治疗重症肌无力 50 例 脾气虚型：药用黄芪、党参、升麻、柴胡、白术、甘草、当归、葛根等；选用自制强力 I 号冲剂。脾肾气阴两虚型：药用生地、熟地、山萸肉、龟板、枸杞、制首乌、白芍、脐带、五味子、党参等；选用自制强力 II 号冲剂。脾肾阳虚型：药用黄芪、党参、制附子、鹿角胶、熟地、巴戟肉、锁阳、怀山药、脐带、甘草等；选用自制力士散。治疗前服抗 Ache 剂者逐步递减药量。对照组 50 例用强的松 30 ~ 60mg/日。结果：本组与对照组分别痊愈 11、8 例，显效 18、19 例，有效各 20 例，无效 1、3 例。两组疗效比较无显著差异， $P > 0.05$ 。但本组无副作用，在递减激素剂量方面治疗前后比较有显著差异， $P < 0.001^{[1]}$ 。

1.2 陈贯一等治疗重症肌无力 371 例 本组患者病程 4 天 ~ 18 年。眼肌型 243 例，躯干型 93 例，全身型 34 例，延髓肌型 1 例。1. 肝肾阴虚予六味地黄汤加减：生地 15g，山药、茯苓、党参、麦冬、菟丝子、白芍、当归各 10g，山萸肉、泽泻、丹皮、枸杞子各 6g。2. 脾胃气虚予六君子汤加减：党参、白术、茯苓、山药、当归各 10g，炙黄芪 12g，陈皮 6g，炙甘草 3g，红枣 5 枚。3. 气血两亏予八珍汤。用药半年统计疗效，结果：痊愈 211 例，基本痊愈 34 例，好转（肌无力症状和全身症状消退

过半) 20 例, 无效 106 例^[2]。

1.3 李忠林治疗重症肌无力 42 例 脾胃气弱型用黄芪、白术、陈皮、升麻、柴胡、党参、当归、大枣、巴戟天、补骨脂、黄精、紫河车、鹿角胶。脾肾阳虚型用西洋参、黄芪、白术、附子、肉桂、熟地、山药、枸杞子、山萸肉、锁阳、巴戟天、紫河车、补骨脂、淫羊藿、鹿角胶。脾肾气阴两虚型用左归丸为主: 党参、黄芪、生地、熟地、山药、枸杞子、山萸肉、龟板、白术、首乌、天冬、阿胶。随症加减, 日 1 剂水煎服。结果: 痊愈 24 例, 有效 10 例, 无效 8 例, 总有效率 80.9%^[3]。

1.4 苏天聪采用补益脾胃法治疗眼肌型重症肌无力 8 例 脾弱气虚型用加味补中益气汤 1 号 (黄芪、党参各 20g, 白术、当归、倒提壶、黄精各 15g, 陈皮、升麻各 12g, 柴胡 10g, 炙甘草 7g); 气阴两虚型用 2 号 (1 号方去黄精, 改党参为太子参, 加生地、萸肉各 15g, 丹皮 12g)。两型中舌质夹青或有瘀点者每日加服生三七粉 5g, 酌情加大倒提壶剂量。均 3 日服 2 剂。治疗 8 例, 服药 6~30 剂后, 痊愈 7 例, 有效 1 例^[4]。

2 一方为主 随症加减

2.1 王球华用健脾益气强肌汤治疗重症肌无力症 21 例 本方含北芪 50g, 千斤拔、党参、牛大力各 30g, 白术、淫羊藿各 10g, 升麻 3g, 柴胡、炙甘草各 5g, 制马钱子 0.5g (冲)。儿童量酌减。复视、眩晕、耳鸣者选加桑椹子、梔子、山萸肉、熟地等; 头痛、眼胀、舌质紫暗或有瘀点者选加地龙、赤芍、红花等; 痰多、胸闷不舒、呼吸不畅者选加苏梗、法夏、橘红或海蛤丸等。日 1~2 剂水煎服。30 日为 1 疗程。重症患者吞咽困难不能饮食短

12例，显效19例，好转10例，无效1例，总有效率97%。T₄、β-EP和CD₈、CD₄/CD₈、AchRab治疗前后检测结果比较有显著性差异，P<0.01或0.05^[12]。

3.3 崔红等针刺治疗眼肌型重症肌无力47例 取穴：阳白、鱼腰、攒竹、丝竹空、足三里、申脉、脾俞、肾俞、三阴交。常规消毒，用30号1.5~2寸毫针针刺阳白，分别透刺攒竹、鱼腰、丝竹空1~1.5寸，捻转得气后，留针30分钟，10分钟行捻转补法3分钟。用1寸毫针针刺申脉，用平补平泻法；3寸毫针针刺足三里，用提插补法；得气后均留针30分钟。针毕，余穴均用小艾炷灸3壮。日1次，10次为1疗程。用3个疗程，结果：治愈32例，好转11例，未愈例，总有效率91.5%^[13]。

参 考 文 献

- 1 李庚和，等，上海中医药杂志 .1991；(11)：1
- 2 陈贯一，等，浙江中医杂志 .1988；23(2)：64
- 3 李忠林，天津中医 .1996；13(4)：21
- 4 苏天聪，云南中医杂志 .1991；12(1)：27
- 5 王球华，实用中西医结合杂志 .1992；5(7)：400
- 6 傅玉如，等，山东中医杂志 .1996；15(1)：18
- 7 徐杰，等，湖北中医杂志 .1988；(4)：19
- 8 张华英，等，辽宁中医杂志 .1987；11(5)：22
- 9 邓中光，等，中国医药学报 .1993；8(2)：41
- 10 李燕娜，山东中医杂志 .1996；15(6)：251
- 11 壬项，等，针灸学报 .1991；7(4)：41
- 12 廖运新，等，中国中医药科技 .1995；2(3)：20
- 13 崔红，等，针灸临床杂志 .1997；13(2)：9

(王学瑞)

发作性睡病

发作性睡病是一种病因未明的非生理性睡眠障碍性疾病。其特征是不论昼夜，时时欲睡，呼之能醒，醒后复睡。祖国医学称本病为“多寐”、“嗜卧”。

1 辨证论治

路志正将多寐分 5 型辨治 (1) 湿困脾阳，方用藿朴夏苓汤、胃苓汤等。如湿邪久郁，亦可酿成湿热，宜酌加黄芩、芦根、山栀。如胖人痰湿素盛者，酌加半夏、南星。(2) 脾气困顿，方用六君子汤加砂仁等。如妇女脾虚气陷，带脉不束，不能化水谷精微以生血，反聚而为湿，带下淋漓，腰膝乏力，少腹坠胀，神困欲寐，方用完带汤加减。(3) 胆热好眠，方用蒿芩清胆汤或生枣仁散等。若痰热壅盛者，则应酌加黛蛤散、天竺黄、川贝母、胆南星。(4) 气血虚弱，方用人参养荣汤、归脾汤等。(5) 髓海不足，如肾阴虚，方用左归饮、六味地黄丸；肾阳虚，方用金匱肾气丸、右归饮等，并酌加龟鹿二仙胶、紫河车、鹿角粉等血肉有情之品一二味。附验案 4 则^[1]。

2 一方为主 随证加减

2.1 刘传太等用醒脾化湿汤治疗嗜睡症 38 例 本方含白术、茯苓各 30~60g，白蔻、川朴、菖蒲、车前子各 10g。脾气虚弱加党参；痰湿内困加半夏；湿郁化热或肝胆湿热加栀子、黄芩；脾肾阳虚加附子；心阳虚加桂枝或肉桂；心气不足加党参、生枣仁。日 1 剂水煎服；困倦消除后，隔日 1 剂，用 3~5 剂。服 3~21 剂，结果：治愈 31 例，好转 5 例，无效 2 例^[2]。

2.2 郭慧敏等用消醒汤治疗发作性睡病 本组患者

共 12 例，其中因惊吓、长期服安眠药、脑炎后遗症、及动脉硬化所致各 1 例，脑外伤所致 2 例，原因不明 6 例。本方含陈皮、半夏、茯苓、石菖蒲、郁金各 15g，甘草 10g。日 1 剂水煎服。食欲不振加焦三仙、鸡内金；血压偏低加太子参、麦冬、五味子；舌苔黄腻加苍术；外伤加桃仁、红花。结果全部治愈。服药 1~3 剂病情好转。6~12 剂痊愈^[3]。

2.3 王卫平用泽泻汤加味治疗发作性睡病 18 例 用泽泻、远志、茯苓、川芎、枳实各 12g，白术、菖蒲各 15g，桂枝、升麻各 9g。气短懒言乏力加党参、黄芪；食欲不振加焦三仙；舌苔厚腻合二陈汤；有脑外伤史或病久兼瘀血加地龙、桃仁、全蝎。日 1 剂水煎服。结果：治愈 12 例，好转 4 例，无效 2 例^[4]。

3 验案报道

3.1 程运文用清气化痰丸加味治愈发作性睡病 1 例
男，25 岁。1 个月前因饮酒过多而致嗜睡，昼夜不分，一坐即睡，每日睡眠长达 18 小时之多，叫之能醒，醒后又睡。并见头昏胀痛，胸胁痞闷，脘腹胀满，口苦粘腻，常吐粘稠性痰涎，大便不畅，小便色黄，舌红苔黄腻，脉滑数。经脑电图检查发现嗜睡波，诊为发作性睡病。服苯丙胺、咖啡因等治疗 20 天无效。采用清化热痰法，方用清气化痰丸加味：陈皮、枳实、黄芩、瓜蒌仁、光杏仁、茯苓、胆星、姜半夏、石菖蒲、天竺黄、郁金各 10g，炒山栀、黄连各 5g。服 10 剂后，睡眠时间减少，诸症缓解。上方去枳实、黄连、炒山栀，加白术、党参、枳壳各 10g，服 15 剂后，病愈。以参苓白术丸调治善后，近月余。随访 1 年，未见复发^[5]。

湿中阻，蒙蔽清阳，清窍失荣所致。治以醒脾和胃、除湿化痰、芳香开窍，药用：菖蒲 12g，郁金 10g，鲜藿香、鲜佩兰（后下）、法半夏各 12g，茯苓 30g，生姜 12g，焦术、白蔻、葛花各 10g，生苡仁 30g，生藕节 15g，广陈皮 15g，太子参 15g，淡木通 6g。上药共进 20 剂，诸症悉除，已如常人^[8]。

3.5 谭俊臣用涤痰加味治愈月经期发作性嗜睡 1 例

女，17 岁。经行多寐已 4 年。每次行经期间昼夜思睡，呼之能醒，醒后复睡，持续 3~5 天，经净嗜睡消失。患者形体肥胖，懒言寡语。4 年来常感胸胁痞塞，头昏身重，神疲便溏，食欲不振，涕唾稠粘，面晦不华，舌质淡红，苔白厚腻，脉沉濡缓。证属湿痰内困，脾阳不振，治宜健脾燥湿，开窍化痰，方用涤痰汤加减：半夏（姜制）20g，胆星、橘红、枳实、茯苓、菖蒲各 10g，党参 25g，益智仁、甘草、麻黄各 5g，生姜 3 片，红枣 3 枚。日 1 剂，水煎服。服药 3 剂后，适值经水来潮，经行之际，患者自感有沉困欲睡之状，但能控制不睡。当顺其势，改用醒脾利湿，理气化痰之法，使湿化痰消，气顺滞散，取原方去党参、麻黄，加藿香、香附各 10g，薏苡仁 15g，橘络、砂仁各 5g。服 4 剂后嗜睡未作，唯胸闷纳呆，身重口粘尚存，苔白厚，脉沉滑。考虑湿痰凝滞中州未尽，选用二陈汤加苍术、白术，服 10 剂以善其后，随访 2 年未复发^[9]。

3.6 吴美娜用人参养荣汤加减治愈嗜睡 1 例

女，30 岁。患发作性嗜睡症 8 年。白昼严重嗜睡，如强制不睡则头额昏痛难忍，睡 2~3 小时醒来则精神如常人，但过 2 小时左右复又嗜睡。形体较胖，面色不华，疲倦乏

力，腹胀纳滞，夜梦纷纭，发作性头及嘴唇颤动，舌淡，苔微黄，脉沉细缓。神经检查（-），脑电图轻度异常。拟滋化源、调营卫、温阳气为法，方用人参养荣汤加减：太子参（5剂后改用北沙参）20g，炙黄芪、丹参、生地各15g，仙灵脾12g，白术、白芍、茯苓各10g，当归身6g，石菖蒲9g，桂枝、陈皮各5g，全蝎3g。服药10剂后，嗜睡减轻，30剂后能控制嗜睡。续服30剂以巩固疗效，复查脑电图正常，半年随访，未见复发^[10]。

3.7 殷明贵用补中益气汤加减治愈嗜睡1例 男，64岁。患神疲嗜睡半月余，每日睡眠15小时，食后尤甚，每餐后睡卧2小时左右，乏力，喜静，腹胀纳差，舌淡苔白，脉象沉弱。证属中气不足，阳气不振。治宜补中益气、健脾消食。药用：党参、黄芪、山楂、谷麦芽各30g，白术、茯苓、木香、法夏、陈皮各15g，生姜20g，大枣5枚，甘草3g。日1剂，水煎服。服3剂后，嗜睡减，服9剂嗜睡消失，以香砂六君子丸善后^[11]。

3.8 陈景河等采用活血化瘀法治愈4例发作性睡病
本组病程4年、10年、11年、26年各1例，因气滞引起发病者1例，因外伤引起发病者2例，原因不明发病者1例。舌色多青紫或暗红，脉多沉涩。均治以活血化瘀法。药用当归、红花、乳香、没药、川芎、丹参等，并酌情佐以行气药如青皮、枳壳、柴胡等，或清里热药如黄芩、竹茹、生地等。结果：分别服药6、9、12、30剂，病愈^[12]。

4 针刺疗法

4.1 冯建文针刺治疗发作性睡病15例 取心俞、交信、跗阳穴。用28号毫针于背部第5胸椎下旁开2横指

处进针，针尖斜向脊突根，进针 5~8 分后刮针得气，再行右旋弧旋捻针至针感传导胸前。交信用泻法，跗阳用补法。留针 15~30 分钟。1~2 日 1 次，6 次为 1 疗程，疗程间隔 2~3 日。结果：治愈 10 例，好转 3 例，无效 2 例^[13]。

4.2 孔令举针刺治疗多寐症 26 例 治法：先刺心俞穴（双），针尖斜向脊突根进针 1 寸，捻转提插至针感传到前胸为宜；足三里、三阴交（均双）深刺，捻转提插，使针感行至足部；百会穴沿皮向前斜刺得气为度。均行平补平泻法，留针 15~20 分钟，中间行针 1~2 次，10 次为 1 疗程。结果：治愈 20 例，有效 5 例，无效 1 例^[14]。

4.3 徐笨人等针刺治愈发作性睡病 2 例 均为服中、西药治疗无效者。皆取内关（双）、神门（双）。手法：针刺取得针感后，捻转提插 1~2 分钟后出针，不留针，每日针 1 次。结果：分别针 24 次，16 次后治愈。分别随访半年、2 个月，均未复发^[15]。

4.4 张化南以温针治疗嗜睡 30 例 选穴：通里、大钟、心俞、脾俞，均双侧。将普通艾条剪成约 20 毫米长的艾段，进针得气后行补法。把剪好的中有小孔的圆型纸片套在针身上并覆盖皮肤，再将艾段套在针柄上，艾段距皮肤约 20 毫米，从艾段下端点燃，待其燃尽后如法再灸，每穴 2~3 壮。每日 1 次，7 次为 1 疗程。共治 30 例，显效 22 例，有效 8 例^[16]。

参 考 文 献

- 1 路志正. 中医杂志. 1980; 21 (3): 16

- 2 刘传太,等.河南中医.1996;16(4):232
- 3 郭慧敏,等.辽宁中医杂志.1990;14(11):30
- 4 王卫平.国医论坛.1997;12(1):15
- 5 程运文.辽宁中医杂志.1987;(10):46
- 6 王心东.黑龙江中医药.1986;(3):36
- 7 郭梅英.福建中医药.1987;(2):21
- 8 金宇安.辽宁中医杂志.1987;(10):46
- 9 谭俊臣.北京中医.1987;(5):52
- 10 吴美娜.浙江中医杂志.1986;(7):309
- 11 殷明贵.浙江中医杂志.1986;(7):309
- 12 陈景河,等.中医杂志.1980;21(8):31
- 13 冯建文.新疆中医药.1994;(1):21
- 14 孔令举,等.新中医.1986;(11):33
- 15 徐笨人,等.北京中医.1985;(4):45
- 16 张化南.吉林中医药.1990;(1):27

(宿秀英)

不寐

不寐亦称失眠或“不得眠”、“不得卧”、“目不瞑”。是指经常不能获得正常睡眠为特征的一种病证。不寐的证情轻重不一，轻者入寐困难，或寐而不甜，时寐时醒，醒后不能再寐，严重者可整夜不能入寐。现代医学的神经官能症、更年期综合征及某些精神病早期见失眠诸证时，可按不寐辨证施治。

1 一方为主 辨证（随症）加减

1.1 张中英自拟安神汤为主治疗失眠症 36 例 本方含枣仁、柏子仁、朱茯苓各 15g，夜交藤、合欢皮各 20g，琥珀 1g。心肝火旺加生地、黄连、山栀子、龙胆草；痰热内扰重用枣仁，加远志、陈皮、法半夏、枳实；心脾两虚加党参、白术、龙齿；心胆气虚加远志、党参、菖蒲、浮小麦；心肾不交加黄连、肉桂、法半夏、夏枯草。日 1 剂水煎服，30 日为 1 疗程。并酌用言语疏导心理疗法。结果：痊愈 25 例，好转 10 例，无效 1 例，总有效率 97.23%^[1]。

1.2 赵福顺用血府逐瘀汤治疗血瘀性失眠 40 例 基本方：当归 15g，生地、赤芍各 12g，川芎 10g，桃仁 6~10g，枳壳、柴胡、桔梗各 6g，川牛膝 30g，西红花（另煎）2g。日 1 剂水煎服。症状改善后，气虚加西洋参或太子参；阴虚加阿胶、龟板、知母、鹿角胶；脾虚加白术、茯苓、山药；适当选用重镇安神药如磁石、朱砂、琥珀、生龙牡等。结果：治愈 20 例，显效 16 例，有效 4 例^[2]。

1.3 舒盛良用活血眠通汤治疗顽固性失眠 112 例 本方含三棱、莪术、柴胡、炙甘草各 10g，白芍、白术、

芽、酸枣仁、夜交藤各 20g，合欢皮 25g，冰糖 1 两。阴虚火旺型去党参、苍术，加沙参、黄芪、山栀子。日 1 剂，水煎服，连服 5 剂。结果：有效 24 例，好转 2 例，无效 1 例^[6]。

1.7 董长华用柴胡疏肝散加味治疗顽固性失眠 30 例

用柴胡、香附各 15g，白芍 20g，川芎、枳壳各 12g，甘草 6g。血瘀加赤芍、丹参；肝火盛加菊花、栀子；痰湿加胆南星、石菖蒲；心神不安加炒枣仁、夜交藤、茯神。日 1 剂水煎服，10 日为 1 疗程。结果：临床治愈 26 例，好转 3 例，无效 1 例，总有效率 96.7%^[7]。

2 固定方治疗

2.1 王敬俭治疗顽固性失眠 84 例 本组均予焦枣仁、磁石（另包先煎）、生龙骨、生牡蛎各 30g，淡豆豉、山栀、远志、陈皮、白术各 10g，天竺黄、知母、琥珀（另包冲服）各 6g，石斛、柏子仁、仙灵脾各 12g，合欢皮、夜交藤、枸杞子各 15g，生百合 20g，朱砂 1.5g（分冲），水煎，每日下午 3 点和 10 点各服 1 次，一般于短期内睡眠即转佳，为巩固疗效可服成药善后，偏心肾不交者服天王补心丹，心脾两虚者服归脾丸，情志郁结者服磁朱丸或逍遥丸。结果：痊愈 61 例，好转 18 例，无效 5 例^[8]。

2.2 李德益用复方独活胶囊治疗失眠症 210 例 取独活 30g，朱砂、琥珀各 6g，共研为末，混匀后装入 2 号空心胶囊内，每晚睡前 2 小时服胶囊 6 粒，连服 10 日。结果：治愈 175 例，有效 30 例，无效 5 例，总有效率为 97.6%^[9]。

3 外用药物治疗

吴月娥等报道手心敷药辨治失眠 54 例 基本方：生龙骨 20g（研细），珍珠粉 4.5g，琥珀末 5g，3 药合调拌匀，装瓶备用。每日取 3~4g，加鲜竹沥少许调湿，分为 2 份，用 2 层纱布包妥，于午睡和晚睡前分置于两手心，（劳宫穴周围），外用胶布固定，并用手指轮流缓慢按压药包 30~50 分钟，每分钟 40~60 次。夜间可留药至次晨取下。邪热内扰热偏盛基本方加黄连末 5g；痰偏盛加生半夏 10g；阴虚火旺加黄连末 6g，肉桂末 1g。气虚加朱砂 5g。气血两虚在本法基础上加服归脾丸。结果：显效 23 例，有效 27 例，无效 4 例。治疗时间 7~30 日^[10]。

4 中西医结合

周建章用丹参加脑活素治疗老年功能性失眠 本组 35 例，用丹参注射液（上海第一制药厂生产，批号 901028）、脑活素（奥地利依比威药厂生产）各 20ml，分别加 5% 葡萄糖 250ml，静滴，日 1 次。对照组 27 例，用谷维素、维生素 B₁、B₆ 各 20mg，日 3 次口服。急性上呼吸道感染者予对症治疗。均治疗 14 日。结果：两组分别治疗 23、6 例，显效 6、5 例，有效 4、2 例，无效 2、14 例，有效率 94.3%、48.1%（ $P < 0.01$ ）。治疗前后两组入睡难、时常觉醒、多梦、晨醒早主症除对照组晨醒早无变化外，余均有显著改善（ $P < 0.001$ 或 0.01）。本组测定血脂 30 例，治疗后均降至正常^[11]。

5 针刺疗法

5.1 吴学章以针刺治疗失眠症 120 例 心脾两虚取心、肝、脾、肺、肾、胃、胆俞（均双），留针 30 分钟。脑髓失调取印堂、百会、安眠（双），留针 30 分钟。心血

不足取脾俞、足三里、隐白（小艾炷灸3~5壮）、神门（均双），留针30分钟。心肾不交取三阴交、太溪、心俞、肾俞、神门（均双），留针15~20分钟。胃气失和取足三里、丰隆、胃俞（均双）、四神聪，不留针或留针10~15分钟。肝胆郁热取风池、丘墟、行间、期门、神门（均双），不留针或留针10分钟。均日1次。结果：治愈81例，有效30例，无效9例，总有效率92.5%^[12]。

5.2 王冲汉以针刺治疗失眠70例 本组取穴：甲组取神庭、太阳、安眠穴、合谷、三阴交；乙组取印堂、颞髃、安眠穴、神门、足三里。两组交替使用，手法运针120~250次/分，捻转90~360度，提插5~10mm，然后接电针仪，密波，中等强度，留针15~20分钟。肌注组30例，肌内注射安定10~20mg/日。均每周3次，30日为1疗程。结果：两组分别痊愈21、6例，显效18、7例，有效27、12例，无效4、5例，有效率为94.3%和83.3%。两组治疗后睡眠率均明显提高^[13]。

5.3 张滨农针刺四神聪治疗失眠110例 患者取坐位，穴位常规消毒，用28~30号不锈钢针，针尖向百会沿皮刺入，进针寸许。稍加捻转至针下有紧涩感，留针40~60分钟，期间可捻转数次，10日为1疗程，疗程间隔2日。结果：治疗68例，显效35例，无效7例，总有效率为94%^[14]。

5.4 赵素章等报道针刺加经络导引快速安眠20例 本组为每晚需服安定类药物方能入睡或不能入睡10日以上者。患者平卧，先用指针点穴导引手足12经及督脉大椎、百会、上星、印堂等穴，然后用32号毫针刺入双侧足三里、三阴交，轻补手法，留针20分钟，留针期间，

教患者以呼吸导引冲任二脉。结果：最佳 12 例，显效 7 例，有效 1 例^[15]。

6 针药并用

周黎等用归脾汤配合针刺治疗顽固性失眠 40 例 本方含人参、黄芪各 15 ~ 30g，白术、茯苓各 10 ~ 20g，枣仁、远志、当归各 15 ~ 25g，甘草、木香各 10g。肝郁气滞加龙胆草、柴胡、栀子；痰热内扰加半夏、陈皮；阴虚火旺加玄参、知母、麦冬。日 1 剂水煎服。并取神门、三阴交、足三里。心脾两虚加心俞、脾俞、厥阴俞；肝火旺加肝俞、间使。均用平补法。结果：临床治愈 18 例 (45%)，显效 10 例，好转 7 例，无效 5 例，总有效率 87.5%^[16]。

7 耳穴贴压疗法

7.1 高扬采用耳穴贴压治疗失眠 128 例 本组主穴取神门、心、脑点。心脾两虚配脾；肝火上扰配肝、胆；胃腑不和配胃、脾；阴虚火旺配肾。王不留行籽贴压，每日按捏 2 ~ 3 次，每次 3 ~ 5 分钟，隔 1 ~ 2 日换药 1 次，10 次为 1 疗程，治疗 1 ~ 12 次。针刺组 65 例，心脾两虚取脾俞、心俞、神门、三阴交等，补法，针灸并用；阴虚火旺取大陵、太溪、神门、太冲等，补泻兼施；胃腑不和取任脉、足阳明、足太阴经穴，针宜泻法；肝火上扰取足少阳、足厥阴、手少阴经穴，泻法。留针 20 ~ 30 分钟，日 1 次，10 次为 1 疗程。西药组 65 例，用舒乐安定 2 ~ 4mg/日。结果：3 组分别治愈 83、38、11 例，有效 42、18、21 例，无效 3、9、33 例，总有效率为 98%、86%、48%。本组疗效优于两对照组 ($P < 0.01$)^[17]。

7.2 焦新民等采用耳穴贴酸枣仁治疗失眠症 经治

从患者印堂穴依次分抹至双太阳穴。(2)揉眉弓：双拇指腹点压印堂穴并沿眉弓向两侧对揉至太阳穴。(3)抹眼球：双拇指指腹点压睛明穴，然后分别分抹上下眼睑。以上均反复操作2~3分钟。(4)压三经：先用双拇指腹从印堂穴压至百会穴，然后从眉中穴向头顶压至百会穴水平，3条直线依次按压。(5)点十四孔：用双拇指腹从印堂穴依次点压睛明、迎香、人中、地仓、承浆、大迎、颊车、下关、耳门、听宫、听会、翳风、太阳穴。以上各点压3遍。(6)扫散法：病人头部侧放于术者之一手上，另一手拇指偏峰推角孙穴，自耳前向耳后直推30次，两侧交替进行。(7)指疏法：双手五指指峰从头正中线快速上下分疏至两侧颞部，反复操作20次后，点压风池穴，拿颈后大筋、肩井约2分钟。最后重复前5种手法3分钟。对病程>1年者，除上述手法外，并按摩神门和三阴交穴；重症加捏脊疗法。经6~20次治疗后，痊愈38例，显效15例，有效3例，无效1例^[20]。

8.2 卢同乐等以推拿治疗失眠42例 (1)患者取坐位，医者用双手拇指指腹由印堂至上星交替上推，再向两侧抹按阳白穴，各20~30次。(2)用双手拇指按掐睛明、鼻穿、迎香、人中、承浆，转向太阳至风池，并用双手中指指尖按双侧安眠穴5次。(3)用拇指桡侧少商穴循足太阳、足少阳经在头部走行自前额至风池刮3~5次，并点按风池穴。(4)医者立在患者身后左侧，左手扶患者前额，右手五指自然分开，中指对督脉，指腹紧贴头皮，指端由前发际向后头部搔抓3~5遍，并按揉风池。(5)按揉后项部3~5分钟。(6)医者用10指指腹甩打头部2分钟。治疗15次后，当晚正常睡眠19例，睡眠好转17

例，无效6例，总有效率为85.24%。经3个月随访症状消失者32例，无效10例^[21]。

8.3 聂桂兰等以推拿治疗严重失眠 65 例 (1) 患者伏卧位，取心俞、膈俞、肝俞、脾俞、胃俞、肾俞，用推、揉、按手法。(2) 患者仰卧位，先推、按、摩膻中、中脘、气海，疏胸及两侧胁部，按足三里；再按、抹太阳、印堂、上星、头维、百会。(3) 患者坐位，拿风池、肩井、合谷；搓两肩至两胁。日1次，10次为1疗程，疗程间隔3~5日。结果：痊愈（症状消失，可睡6小时以上）23例，显效（可睡5小时左右）25例，进步（症状减轻，可睡4小时左右）16例，无效1例^[22]。

8.4 余庭源等采用头面部推拿合以足底按摩治疗失眠 两组各20例，均仰卧闭目。术者先用右手拇指轻揉百会200次，再用双手拇指由印堂→上星→百会交替推5~6次，共4分钟；双拇指自印堂起向内外依次点揉睛明、鱼腰、丝竹空、太阳、四白等穴，共3分钟；患者坐位，术者右手5指均匀张开，中指吸定印堂穴，其余4指对称吸定鱼腰及头维穴，通过腕关节及前臂的摆动，均匀地向后摆推，至风池止，并点按风池，反复4~5遍，共5~6分钟；年龄大、病程长，点按三阴交、足三里、太冲，约3分钟。本组加用足底按摩，着重点按肾、膀胱、垂体、头部、甲状腺、肝、胃肠、腹腔神经等反射区，约15分钟。均日1次，10日为1疗程，疗程间隔5日。治疗4个疗程，结果：两组分别痊愈12、8例，好转8、7例，无效0、5例，有效率100%、75% ($P < 0.05$)^[23]。

8.5 杨桂林等采用若石健摩法治疗顽固性失眠 40 例
本法又称足部健康法。嘱患者仰卧，全身放松5分钟。

夜游症

“夜游症”，又叫“梦行症”，是发生在睡梦中的自动性的行为，即从睡眠状态进入到另一种意识障碍状态的表现。其方式多种多样，五花八门，有的平淡无奇，有的离奇古怪，有的甚至带有暴力性质。发作时，患者在睡眠中突然起床、穿衣着鞋，或只着睡时之内衣，朦朦胧胧地进行一些刻板的活动。如在室内走动，搬挪器具物品；或启门外出，做一些较复杂的活动，如浇花、扫院子、锄地、拔草、挑水等等。一般持续几分钟或一二小时后自返上床入睡，亦有的睡卧于野外。翌晨醒来，患者对昨宵的所作所为毫无记忆，茫然无知。其发作频率有数月、数十日一次，有三五日一次，特别严重者每夜必发，甚至一夜数次。

1 内服药物治疗

1.1 熊继柏用朱砂安神丸合磁朱丸治愈夜游症 1 例

男，14岁。辨证属火热扰于心肝而梦行。治以清心泻火安神，镇肝定魂。药用：生地 60g，黄连 18g，当归 30g，甘草 15g，煅磁石 30g，建曲 18g。上药碾细末和蜜为丸，外以朱砂 9g 水飞为丸衣，丸如黄豆大。每次吞服 30 丸，早晚各 1 次。服完 2 料丸剂，痊愈^[1]。

1.2 金克畅用血府逐瘀汤治愈夜游症 1 例 女，42 岁。1974 年 11 月 9 日初诊。患“神经官能症”已十余年。平素性情抑郁，多疑善愁，今年以来常寐寤外出，挑水，扫地后复寐，翌晨却不知己为，近半月来，每夜或间夜如此。昨夜复出，昏倒在沟渠之中。诊时神志如常，形体消瘦，面容憔悴，目眶暗黑，肌肤甲错，头晕神倦，舌质紫

苔薄，脉沉涩，参合脉症，从瘀血论治。血府逐瘀汤加煅龙齿、石菖蒲、生铁落，药进七剂后，夜游发作次数明显减少，增服十剂，夜游未再发作，但睡至夜半，烦躁易惊。原方加黄连、肉桂，又服五剂，夜能安睡，继用归脾汤调理，以善其后，随访两年未复发^[2]。

1.3 王天位采用豁痰泄热法治愈 1 例梦游症 女，30 岁。半月前发颐，近五日出现梦游。辨证属热病伤津，灼津聚痰，痰热扰心，心无所主则神气浮动，形神不得相符，形骸荡然而作梦游。治以豁痰醒神、益阴清热，药用法夏 12g，枳实 6g，灸远志 6g，葛根 30g，菖蒲 6g，知母 60g，沙参 40g，姜竹茹 1 团，滚痰丸 6g。日一剂水煎服、分 2 次送丸药服下。以上方加减共服药 6 剂梦游不再出现，继用温胆汤调理善后^[3]。

1.4 周琦应用赵益人老中医经验治愈夜游症 1 例 女，48 岁。发病已 6 年，夜间呓语，随即起床，四处走动，翌日不知夜间所为。多处诊治，效果罔然。现夜游每夜必发。主诉：多梦、头晕、心悸。查舌质稍红，苔薄白，脉细。治以宁心安神，祛痰开窍，淮小麦 30g，甘草 6g，夜交藤 30g、陈皮 9g，制半夏 9g，云苓 15g，姜竹茹 9g、枳壳 12g、石菖蒲 9g、陈胆星 9g、生龙、牡各 30g。服药 7 帖后，夜游已控制，仍诉多梦、头晕、心悸，呓语仍发。治守原意原方加川芎 12g，白芷 9g。连服 20 帖，夜游未发，睡眠见安。随访一年未见复发^[4]。

2 针刺疗法

2.1 黄之光用针刺治愈夜游症 2 例 一中年男性，自幼即患有轻度夜游症，近 10 年加剧，治以针魂门、魄户为主，辅以神门、太冲，均用补法，隔日针 1 次，先后

针治 48 次，痊愈。又一男青年，兼患阳痿病，治以补魂门、魄户、太渊、太冲、太陵、太溪，并补心俞、肾俞，针治 11 次后，两病均愈^[5]。

2.2 林治万用针刺四缝穴放液法治疗夜游症、哭夜病 80 例 取消毒三棱针刺入四缝穴 2~4mm，左右捻转 2 次即出针，然后用拇指挤压针眼，当即溢出胶胨样液体或血液，擦净并压迫止血，3~7 日 1 次。经 1~3 次治疗均获愈^[6]。

2.3 马定祥运用头穴电针治梦游症 3 例 取百会、前顶、上星、脑户、脑空（双）、四神聪等穴进针深达筋膜，将针柄 G6805 治疗仪联接，用疏密波进行电针治疗。每日 1 次，每次 20 分钟，10 次为 1 疗程。结果：3 例均治 2 疗程梦游停止。一般治疗 1~2 疗程，为巩固疗效可加针 1~2 疗程^[7]。

3 针药并用

3.1 李嘉荣采取针药并用治疗梦游症 10 例 本组患者年龄 5~50 岁，病程 1~7 年。均予针药并用，以 15 日为 1 疗程，疗程间隔 3~5 日。针刺取穴：（1）内关、太陵；（2）神门、太溪。每日针 1 次，每次留针 30 分钟；每组穴位针 2 次后换用另 1 组。内服汤剂用生铁落 100g（先煎），小麦 30g，炙甘草 9g，大枣、白芍各 15g，第 1 疗程每日 1 剂，第 2 疗程每周 2~3 剂。结果：治愈 8 例，好转 1 例，无效 1 例。对治愈病例追访 10 年未见复发^[8]。

4 按摩疗法

4.1 邱承雄采用按摩治疗小儿夜游、夜惊、夜哭 1 例 女，6 岁，1981 年 7 月 5 日就诊。父代诉：患儿睡后每于半夜起来在住屋周围行走数圈，家人发现后，叫之不

醒，至天明后自醒，问其何因？患儿不知。2~3夜一发，已有一月，饮食及大小便正常，日间生活如常，惟舌赤唇红。拟诊心经有热，是为夜游。用按摩疗法，手法与穴位，分阴阳、运八卦、清心经、摇斗肘、拿总经，每日按摩1次，3次告愈。3年半未见再发^[9]。

参 考 文 献

- 1 熊继柏，中医杂志 .1981； 22（11）： 62
- 2 金克杨，四川中医杂志 .1986；（9）： 12
- 3 王天位，北京中医。1985；（1）： 1
- 4 周 琦，辽宁中医杂志 .1985；（5）： 3
- 5 黄之光，中医杂志 .1982； 23（3）： 33
- 6 林治万，等，中国针灸。1990； 10（1）： 16
- 7 马定祥，陕西中医。1987； 8（12）： 553
- 8 李嘉荣，中医杂志。1988； 29（1）： 25
- 9 邱承雄，新中医。1985；（6）： 33

（李桂英）

神经官能症

神经官能症，又称神经症。是指一组精神障碍，为各种躯体的或精神的不适感。强烈的内心冲突或不愉快的情感体验所苦恼。其病理体征经常持续存在或反复出现，但缺乏任何可查明的器质性基础，患者力图摆脱，却无能为力。由强烈的情感体验或某种心理机理引起的运动或感觉功能障碍或意识状态改变，即谓所“转损性”或“分离性”精神障碍也包括在内。神经衰弱是神经官能症中最常见的一种。

神经衰弱是指精神容易兴奋和脑力容易疲乏，并常伴有情绪烦恼和一些心理生理症状的精神障碍。这些疾病不能归于已存在的躯体疾病、脑器质性病变或某种特定的精神疾病，但病前可存在持久的情绪紧张或精神压力。在中医学“失眠”、“虚劳”、“郁症”中可找到类似的描述。

1 辨证论治

1.1 龙功宏辨证治疗神经衰弱症 107 例分 心脾亏损型用党参 30g，茯神、黄芪、淮山药各 20g，远志、白术、枣仁各 10g，龙眼肉、夜交藤各 15g，甘草 6g。阴虚火旺型用生地、山茱萸、茯苓各 20g，泽泻、知母、淮山药各 15g，丹皮、枣仁、参须各 10g，黄柏 8g，麦冬 12g，远志 6g。脾胃不和型用法半夏、枳实、川厚朴、枣仁、太子参各 10g，陈皮 6g，茯苓 12g，竹茹 5g，煎水送服保和丸或五积散。结果：临床治愈 82 例，有效 17 例，无效 8 例，总有效率为 92.52%^[1]。

1.2 关学庆自拟一百三白汤为主结合辨证治疗神经衰弱 500 例 本方含百合 30g，白芍、白薇、白芷各 12g。

日1剂水煎服，7日为1疗程。心脾两虚与归脾汤合用；肾阴亏虚与六味地黄汤合用；阴虚火旺与知柏地黄汤合用；心肾不交与交泰丸合用；脾肾阳虚与四神丸合用。结果：痊愈378例占75.5%，基本痊愈79例占15.8%，好转26例占5.2%，无效17例占3.4%，总有效率为96.6%^[2]。

2 固定方治疗

2.1 华伦荣报道用刘仕昌教授健脑丸治疗神经衰弱症健群153例 本方含红参须9g，蜜炙黄芪、淡水龟甲（打碎先煎）、麦冬、益智仁、石菖蒲（后下）、知母各12g，北五味子、甘松各10g，远志6g，当归8g。日1剂水煎服，1个月为1疗程，用2个疗程。结果：临床治愈23例，显效78例，有效44例，无效8例，总有效率95.12%^[3]。

2.2 王常勇等用归脾道健丸治疗神经衰弱200例 本组用本品（含柴胡、黄芪、党参、当归、白芍、生地、茵陈、炒白术、茯苓、广木香、炒枣仁、炙远志、五味子、石菖蒲、麝香、薄荷、甘草等，蜜制为丸，每丸15g，哈尔滨自来水公司职工医院药厂提供）1丸/日3次口服。对照组100例，用谷维素20mg，维生素B₁10mg，舒乐安定2mg，日3次口服。失眠严重加用舒乐安定4mg或水合氯醛10~20ml，每晚口服。均20日为1疗程。部分体虚甚者选用5%或10%葡萄糖液，或生理盐水静滴。结果：两组分别治愈128（64%）、46例，显效48（24%）、17例，好转19（9.5%）、26例，无效5（2.5%）、11例，总有效率97.5%、89%（ $P < 0.01$ ）；1年后随访121、40例，复发11（9.09%）、9（22.5%）例（ P

<0.05)^[4]。

2.3 骆学新等自拟益气补脑汤治疗神经衰弱症 86 例

本方含高丽参（切薄片每晨空腹含嚼 3~4 片，约 1g，服 15g 后，用生晒参 10g，入煎剂）、大熟地、益智仁各 15g，炙黄芪、茯苓各 30g，炙龟板、炙鳖甲（先煎）、麦冬、五味子、全当归各 10g，炙远志、陈皮各 6g。日 1 剂水煎服。结果：治愈 24 例，好转 55 例，无效 7 例，总有效率 91.9%^[5]。

2.4 彭亿海等用益智饮治疗神经衰弱症 110 例 本组患者病程 6 月~32 年，均以失眠为主诉，睡眠时间 <5 小时/日。本品为党参、茯神、远志、菖蒲、蜂王浆、蜂蜜各等份制成的膏剂，口服 50ml/日 2 次，20 日为 1 疗程。结果：显效 30 例，有效 72 例，无效 8 例，有效率为 92.73%。对照组 50 例服用安定常规剂量，结果：显效 4 例，有效 29 例，无效 17 例，有效率为 66%。本组疗效显著优于西药对照组 ($P < 0.001$)。在临床应用本品过程中仅 2 例出现荨麻疹，部分患者有恶心、上腹胀、便溏等，停药后自行消失，与镇静安眠剂比较，副作用少，且能调节人体机能，改善全身症状，适用于年老、久病、体衰患者^[6]。

2.5 李兴民等报道安神口服液治疗神经衰弱 94 例及药理研究 药用枳实、山楂各 200g，松石蕊 150g，香菇、白芍、陈皮各 50g，西洋参、酸枣仁、枸杞子各 100g。经醇提水沉，低温浓缩，制成每支 10ml（含生药 10g）之口服液。10ml/日·2 次口服，连服 30 日。结果：痊愈 15 例，显效 31 例，有效 35 例，无效 13 例，总有效率为 87.2%。本品对各证型均有显著疗效。药理实验结果表明，本品具

有显著的免疫调节作用，可显著抑制小鼠自主活动，无毒副作用^[7]。

2.6 谢道珍等用安神胶囊治疗神经衰弱 294 例 本品取枣仁 40.5g，五味子 97.2g，粉碎过 80 目筛；取知母 111.8g，川芎、茯神、麦冬各 97.2g，首乌 32.4g，丹麦 129.6g，水煎 3 小时过滤，加水再煎 2 小时再过滤，合并两次滤液浓缩成膏，80℃烘干并粉碎，过 80 目筛，与上述药粉混合装入胶囊，每粒 0.25g，口服 4 粒/日 3 次，4 周为 1 疗程。治疗期间不用任何镇静、镇痛药物。结果：痊愈 7 例，显效 80 例，好转 158 例，无效 49 例，总有效率 83.3%^[8]。

2.7 容碧嫔用蚂蚁制剂治疗神经衰弱 248 例 蚂蚁制剂剂型有片剂、冲剂和酒剂。均服 2g（含蚂蚁量）/日 3 次，疗程 4~8 周。结果：痊愈 10 例占 4%，显效 148 例占 59.7%，有效 78 例占 31.5%，无效 12 例占 4.8%，总有效率 95.2%，各种剂型疗效差异不大^[9]。

3 中西医结合

3.1 蒋松定中西医结合治疗神经衰弱 108 例 本组肝肾阴虚、肝阳上亢用钩藤、菊花、白芍、五味子、女贞子、珍珠母、石决明、龙骨、牡蛎；气血不足用炙黄芪、党参、当归、白芍、辰茯苓、枸杞子、丹参、生地；失眠甚加天麻、枣仁、合欢皮、夜交藤。与对照组（97 例）均用舒乐安定 1mg，谷维素 400mg，谷氨酸 1.5g，脑复康胶囊 0.8g，均日 3 次口服。结果：两组分别治愈 41、16 例，显效 58、39 例，无效 9、42 例。本组疗效优于对照组（ $P < 0.05$ ）^[10]。

3.2 宋学贤中西医结合治疗神经官能症 152 例 本

组患者病程 30 天 ~ 10 年。1. 肝肾阴虚型：予杞菊地黄汤加菟丝子、炒枣仁；2. 肝气郁结型：予逍遥散加香附、枳实、陈皮；3. 心脾亏虚型：予归脾汤。均随症加味。4. 肾阳不足型：予右归丸去山药、枸杞、鹿角胶、杜仲，加巴戟天、淫羊藿、炙甘草。各型病人均同时服用西药：以衰弱症状为主者服谷氨酸 3g/日 3 次，早午各服五味子糖浆 20ml；以兴奋症状为主者服谷维素 30mg 和安定 2.5mg，均日服 3 次，兴奋症状好转后停服安定；凡睡眠不佳者予睡前服安定 2.5 ~ 5mg，睡眠改善后停药。服药 6 ~ 42 剂（平均 11 剂）后，痊愈 91 例，好转 55 例，无效 6 例，总有效率为 96.1%^[11]。

3.3 简文安用中药加安定治疗神经衰弱 84 例 本组共 117 例。卧龙丸组 84 例，取苦参 10g，山药 12g，远志 9g，夜交藤 30g，大枣 5 枚，加水（1:6 ~ 8）煎煮 2 次，浓缩成稠膏；再将酸枣仁、白术、枸杞、木香各 12g，龙眼肉 15g，天麻 9g。烘干，粉碎成细末，并以成药每 12g 中含安定 2.5mg 之比例计算出总量后，加入安定粉过筛，用炼蜜制丸。12g/日，早晚各 1 次服。安定组 33 例，每晚服安定 5mg。结果：卧龙组治愈 66 例，好转 15 例，无效 3 例，有效率 96%；安定组好转 12 例，停药后均复发，无效 21 例。两组疗效比较有非常显著的差异， $P < 0.001$ ^[12]。

3.4 张永祥等用脑力宝丸治疗神经衰弱及神经衰弱症状群 323 例 本组均用本品（含石菖蒲、远志、五味子、菟丝子、维生素 E 等 10 味药）4 丸/日 3 次口服，10 岁以下儿童酌减，连服 2 个月。结果：显效 162 例占 50.15%，有效 142 例占 43.96%，无效 19 例占 5.89%，总

有效率 94.11%^[13]。

4 穴位封闭疗法

4.1 王淑琴等采用穴位封闭法治疗神经官能性头痛 168 例 偏头痛取太阳穴后上方凹陷处；头顶、前额及后头痛取天柱穴；全头痛患者取上述两穴位。对照组用银针刺入，得气后留针 30 分钟。治疗组穴位注射 0.5% 奴佛卡因 0.5 ~ 1ml，隔日 1 次，3 次为 1 疗程。结果：治疗组 168 例，治愈 109 例，好转 52 例，无效 7 例，有效率为 96%；对照组 107 例中，治愈 48 例，好转 43 例，无效 16 例，有效率为 84.8%^[14]。

4.2 文仰能采用穴位封闭法治疗神经衰弱 296 例 取穴：主穴为太阳、上星、合谷、百会。配穴为风池、印堂、头维。用药：维生素 B₁₂ 注射液 500 μ g，维生素 B₁ 注射液 100mg，维生素 B₆ 注射液 500mg，将 3 种药混合。封闭：一般选用双侧太阳，双侧合谷，加上星、百会，不得注入血管内，如前头痛再加印堂，后头痛加风池，偏头痛加头维。对烦躁不安、失眠、患者处于恐惧状态者，用安定 10mg，双侧太阳或合谷注射即入睡。按摩：封闭后随即穴位按摩，持续 15 分钟。每天 1 次，7 次为 1 疗程，如须继续治疗者，暂停 5 天后按上法治疗。结果：痊愈 270 例，显效 24 例，好转 2 例。总有效率为 100%^[15]。

5 气功疗法

5.1 马有忠采用铜钟气功治疗重症神经衰弱 351 例 本组 351 例。功法：（1）姿式：体质虚弱，失眠严重，伴头晕心悸者，取虾卧或蛰龙式；症状较轻、体质尚好者，取坐式或站式铜钟式。在铜钟式基础上练铜钟自发动功。症状加重者可改练卧功。（2）呼吸：以自然呼吸为

6.3 李彦友等采用穴位按压与敷贴治疗神经衰弱 150

例 本组均为脑不当所致本病的学生。取穴：印堂、太阳、百会、玉枕、风府、阿是穴。根据头痛部位选相应穴位，将聪敏膏（含白芷、细辛、川芎、白芥子、冰片）贴穴位上，以手心压之，用药 10 分钟后即可减轻疼痛。每隔 1~2 分钟活动大拇指，以促经气运行。同时以智力康复器按压太冲穴，使患者有酸、麻、胀、痛和灼热感，每次 20 分钟，日 1 次，6 次为 1 疗程。结果：痊愈 145 例占 96.6%，显效 3 例占 2%，有效 2 例占 1.4%^[20]。

参 考 文 献

- 1 龙功宏. 湖南中医杂志. 1994; 10 (5): 38
- 2 关学庆. 河北中医. 1989; 11 (4): 15
- 3 华伦荣. 新中医. 1994; 26 (1): 28
- 4 王常勇, 等. 中医药信息. 1995; 12 (5): 38
- 5 骆学新, 等. 安徽中医临床杂志. 1996; 8 (3): 117
- 6 彭亿海, 等. 湖南中医杂志. 1986; 2 (6): 10
- 7 李兴民, 等. 陕西中医. 1992; 13 (4): 145
- 8 谢道珍, 等. 陕西中医. 1988; 9 (7): 298
- 9 容碧嫻. 中草药. 1989; 20 (6): 41
- 10 蒋松定. 浙江中医杂志. 1996; 31 (9): 412
- 11 宋学贤. 中级医刊. 1987; 22 (12): 48
- 12 简文安. 湖北中医杂志. 1989; (2): 18
- 13 张永祥, 等. 新中医. 1989; 21 (5): 51
- 14 王淑琴, 等. 吉林中医药. 1987; (4): 9
- 15 文仰能. 陕西中医. 1989; 10 (8): 367
- 16 马有忠. 气功. 1989; 10 (2): 57

- 17 李景义 . 气功 .1990; 11 (9): 387
- 18 李景义, 等 . 上海针灸杂志 .1991; 10 (2): 26
- 19 刘汉城 . 湖南中医杂志 .1989; 5 (6): 41
- 20 李彦友, 等 . 陕西中医函授 .1994; (1): 28

(杨淑莲)

果：痊愈 39 例，近期治愈 18 例，好转 4 例^[2]。

1.3 高永汉等用熄风定痫丸治疗癫痫 120 例 阳痫常以情绪波动为先兆，用 1 号方：胆南星、天麻、法半夏、地龙、青木香、藿香、陈皮、天竺黄、沉香、川贝母、生大黄、青礞石、白矾、二丑、全蝎、钩藤、石菖蒲、茯神、丹参、海浮石、冰片、琥珀粉、姜汁。阴痫用 2 号方：1 号方去冰片、大黄、二丑，加黄芪、当归、紫河车、鹿茸、黄精、降香、檀香、乌梢蛇、川乌头。瘀痫有脑外伤或产伤史，用 3 号方：1 号方减去白矾、冰片，加川芎、红花、鸡血藤、牛膝。制成蜜丸，6~18g/日 2 次，小儿酌减。癫痫持续状态予抗癫痫及镇静、止痉西药，待症状缓解后再服本品。忌烟、酒、辛辣刺激食物；避免精神刺激；忌房事。经治 56~183 日后，显效（停止发作 > 2 年）76 例，有效（停止发作 < 2 年或发作频率减少 75%）41 例，无效 3 例，总有效率为 97.5%^[3]。

1.4 苟生茂自拟阴阳抗痫丸治疗癫痫 60 例 (1) 阳痫，指病程较短，体质较强，癫痫发作多在昼夜，大便干，小便赤，口唇干燥，舌质红绛，舌苔黄腻，脉弦滑而数。药用郁金、白矾、钩藤、僵蚕、栀子、胆南星各 50g，生赭石、地龙、磁石、天竺黄各 100g，守宫 200g，硼砂 800g，半夏 10g，朱砂、皂角、广角各 20g，白花蛇 2 条，蜈蚣 10 条，共为细末，化蜜为丸，每丸重 7.5g，1 丸/日 2~3 次，年老体弱者量酌减，1 个月为 1 疗程。(2) 阴痫，病程较长，体质较弱，多在夜间发作，大便多溏，小便清长，口唇湿润，舌质淡红，舌苔白腻，脉沉细微。用上方加炙马前子 50g，用法同上。结果：治愈（停药后 > 1 年未发作）48 例，好转（发作次数减少、时间缩短，

或大发作停止) 10 例, 无效 2 例, 总有效率 96.6%, 其中治愈率 80%^[4]。

1.5 徐明用抗痫胶囊治疗癫痫 767 例 肝火痰热型用抗痫 1 号: 羚羊丝、珍珠各 100g, 朱砂、胆草各 300g, 牛黄 50g, 天竺黄、知母、礞石各 200g, 胆南星、半夏各 150g, 赭石、栀子、白芍、生龙骨各 500g, 蜈蚣 50 条, 川芎 250g。脾虚痰湿型用 II 号: 黄芪、丹参、生龙骨、生牡蛎、白芍各 500g, 党参、白术、青礞石各 250g, 枣仁、柏仁、陈皮各 200g, 朱砂 300g, 南星、半夏各 150g, 羚羊丝、珍珠各 100g, 牛黄 50g。上药加工后装胶囊, 每粒重 0.5g, 10 粒/日 3 次口服, 儿童酌减。对照组 313 例用扑痫酮、癫痫安、卡马西平等。结果: 两组分别治愈 507、69 例, 好转 180、78 例, 无效 80、166 例, 有效率为 89.6%、46.9%, 两组比较有显著性差异^[5]。

2 一方为主 辨证治疗

2.1 杨晓等用止痫汤辨证治疗癫痫 73 例 本方含天麻、丹皮、旋覆花各 15g, 钩藤、赤芍、生龙骨、生牡蛎、磁石、珍珠母、生地、赭石各 30g, 郁金、菖蒲各 20g, 全蝎、白矾各 10g, 蜈蚣 2 条。风痰闭阻加半夏、僵蚕、蝉蜕; 痰热内盛加天竺黄、栀子、龙胆草、大黄; 心肾亏虚加黄芪、太子参、益智仁, 加用六味地黄丸。日 1 剂水煎服, 30 日为 1 疗程。结果: 治愈 52 例, 显效 15 例, 好转 6 例, 总显效率 91.7%^[6]。

2.2 王兆荣用礞龙菖星汤治疗癫痫 54 例 本方含礞石、菖蒲各 30g, 龙骨 20g, 胆南星 10g, 赤芍 15g, 全蝎 5g。瘀血阻窍型加丹参、川牛膝、黄芪、地龙; 风痰闭阻型加天竺黄、远志、僵蚕; 热邪上扰型加黄芩、生地、钩

藤、地龙；肝郁气滞型加郁金、栀子、竹黄、牡蛎；肝肾阴虚型加牛膝、山药、枸杞子、紫河车。2日1剂水煎分4次服，原服西药在3个月内逐渐减量至停药。1个月为1疗程。治疗12~18个疗程，结果：痊愈36例，显效10例，好转5例，无效3例，总有效率为94.4%^[7]。

2.3 保健用定痫散治疗癫痫 60例 用本品（全蝎、水飞朱砂、水蛭各30g，蜈蚣15条，灵磁石60g，明矾20g，莪术、土鳖虫、胆南星、郁金、川芎各15g，共研细末，分成90包），＜3、4~9＞10岁及成人分别1/3、1/2、1包；脾胃虚弱用六君子汤；心气血虚用归脾汤；肝肾虚损用六味地黄丸加益智仁、白芍等；外伤型及头痛型用通窍活血汤；腹痛型用芍药甘草汤；水煎，日3次送服；无明显虚象用温开水。结果：治愈6例，显效27例，有效16例，效差5例，无效6例，总有效率90%^[8]。

2.4 张建夫等用宁痫散治疗癫痫 103例 本方含郁金、白矾、香附、菖蒲各30g，木香、朱砂各18g。共为细面，3g/日。并辨证选用中药汤剂，7日复诊1次，3个月为1疗程。结果：显效54例，有效、效差各19例，无效11例^[9]。

2.5 孙立德以止痫散为主分型治疗癫痫 98例 制法：玳瑁、琥珀、石菖蒲、天竺黄、胆南星、远志各20g，蜈蚣、全蝎、白矾各10g，粉碎过120目筛，置乳钵内研入麝香2g，牛黄、羚羊角粉各5g，混匀，装入0号胶囊（每粒含药0.3g），4粒/日3次口服，小儿酌减，一般连服半年。脾虚痰盛型加服陈皮、清半夏、党参、竹茹、旋覆花各12g，茯苓25g，白术15g，甘草6g，薏苡9g；肝火痰热型加服龙胆草、清半夏、竹茹各9g，黄芩、

梔子、木通、橘红、枳实各 6g；均日 1 剂水煎服，连服 3 月；肝肾阴虚型加服熟地 18g，山药、山萸肉、杜仲、龟板胶各 9g，生牡蛎 30g，枸杞子、肉苁蓉各 12g，当归 15g。日 1 剂水煎服，连服 4 月。结果：痊愈 53 例，有效 40 例，无效 5 例，有效率 4.9%^[10]。

2.6 傅竟成等用鲜滩中药方 1~4 号治疗癫痫 68 例

本方为四川省眉山县中医癫痫专科医院曾俊辉创制。各型均用 1 号药丸（天麻、僵蚕、半夏、川贝、神曲等）每次 7g。风痰闭阻型加 2 号散剂（生南星、菖蒲、龙骨、牡蛎等）每次 4g；肝火痰热型加 4 号散剂（柴胡、羚羊角、龙胆、生大黄等）每次 4g，脑脉瘀滞型加 3 号散剂（桃仁、三七、桂枝、黄芪等）每次 3.5g。儿童用量：<3 岁用 1/3 成人量，4~7 岁用 1/2 量，8~12 岁用 2/3 量。各型患者均于早晨 7~8 时饭后用姜汤冲服。结果：显效 35 例，有效 30 例，无效 3 例，总有效率为 95.6%^[11]。

3 一方为主 随症加减

3.1 史学义用定痫止抽丸治疗癫痫 87 例 本品含黑丑、白丑各 120g，蜈蚣、全蝎、钩藤、地龙各 50g，沉香、胆南星、甘遂、青礞石、海浮石各 40g，远志、菖蒲、皂角刺各 35g，当归尾、丹参、赤芍、川芎、甘草各 30g，珍珠母 20g，羚羊角 10g。痰多加白矾、天竺黄各 30g；抽搐严重加蜈蚣、全蝎（等量为末 1.5g/日 2 次冲服）；便干加郁李仁、火麻仁各 35g；热重加黄连、黄芩各 25g；失眠加珍珠母、炒枣仁各 45g；情绪焦躁加甘草、小麦、合欢花各 15g，大枣 15 枚。共研细末，炼蜜为丸，每丸 9g。1 丸/日 2 次口服，3 个月为 1 疗程。结果：显效（发作控制在 6 个月以上）47 例，有效 31 例，无效 9 例，

日1剂水煎服，6小时1次。治愈后继用15日，避免精神刺激，禁烟酒辛辣等。结果：治愈15例，有效3例，显效、无效各1例，总有效率95%^[15]。

3.5 刘开苏治疗继发性癫痫32例 基本方：胆南星、石菖蒲、白僵蚕各10g，磁石、代赭石（均先煎）各30g，全蝎3g，蜈蚣1条，地龙、白芍各12g，苍耳草20g，羌活6g。每日1剂，控制发作后，在3~6个月内，每月再服5剂以巩固。加减：体壮多痰、便秘、苔黄厚腻者加礞石滚痰丸、大黄各10g；苔白厚腻者加白金丸10g；健忘加松子仁15g，柏子仁12g；气虚加党参、黄芪各12g；肾虚加紫河车、鹿角、龟板各10g，制首乌15g；阳虚加肉桂6g，制附片10g；阴虚加麦冬、生地各10g；失眠多梦、心悸加天王补心丹10g或茯神、枣仁各12g，朱砂（分冲）3g。如频发或服药不明显者可配合针刺长强穴，2~7日1次。结果：控制癫痫发作，脑电图基本恢复正常，维持半年以上者27例，无效5例^[16]。

4 固定方治疗

4.1 尹铁汉等用愈痫胶丸治疗癫痫387例 用本品（羚羊角粉、麝香、玳瑁、龙齿、龟板、全蝎、蜈蚣、僵蚕、蜥蜴、地龙、天麻、天竺黄、南星、半夏、郁金、明矾、苦参、黄连、菖蒲、月石、皂荚、甘松、汉防己、金礞石、曼陀罗、白术、人参、神曲、陈皮、山萸肉、淫羊藿、当归、丹参、琥珀等，共研细过筛，装胶囊，每粒0.3g）10粒/日2次口服，儿童酌减。忌食腥膻辛辣生冷，孕妇禁服。6个月为1疗程，3个疗程为1阶段。结果：近期治愈168例，好转211例，未愈8例，总有效率98%^[17]。

4.2 刘道清用礞石愈痫丸治疗癫痫 196 例 本组用本品（菖蒲、天南星、天竺黄、路路通、半夏、远志、橘皮、茯苓、厚朴、苏子、槟榔、大黄、琥珀、郁金、生蒲黄、竹茹，研极细末。用青礞石、赭石水煎液与猪胆汁调药粉，制成绿豆大水丸）6g（＜18岁及年老体弱者酌减）；对照组 168 例，用鲁米那 30mg（12～16岁 25mg）；均日 3 次口服，3 个月为 1 疗程。用 3 个疗程，结果：两组分别近愈 38、32 例，显效 66、50 例，好转 72、61 例，无效 20、25 例，总有效率 89.8%、85.1%。两组近愈者随访 1 年，复发 1、22 例（ $P < 0.01$ ）。本品未见副反应^[18]。

4.3 张宏国用交济除痫丸治疗癫痫 476 例 取干紫河车 1 具，生晒参、水牛角浓缩粉、玳瑁各 45g，菖蒲、僵蚕、全蝎、水蛭、地龙、胆星各 30g，檀香、益智仁、硼砂各 15g，蜈蚣 15 条，共研细粉。以丹参 120g，远志、桑椹、神曲各 60g，鲜猪苦胆（或牛胆）2 个，水煎浓缩收膏，合药粉制成黄豆大丸，用朱砂、琥珀、人工牛黄各等份研粉挂丸衣，阴干。6g/8 小时 1 次，以生姜大枣汤送服。儿童量酌减。女性患者月经前 1 周药量增至 9g/次；单纯夜间发作者，白天少用或不用药，下午 4～5 点和睡前各服 9g；症状控制半年后，根据临床表现和脑电图改善情况减少药量，直至停药。治疗 0.5～2 年。结果：近期痊愈 304 例，好转 167 例，无效 5 例，总有效率为 98.9%。多数患者服本丸 2 周左右，发作频率反较前明显，症状加重；但服至 3 周后，发作次数和持续时间明显减少^[19]。

4.4 张洪海用雄黄停痫丸治疗癫痫 87 例 取双钩

藤、制乳香各 25g，琥珀、天竺黄、天麻、全蝎、胆南星、郁金、黄连、木香各 19g，荆芥穗、明矾、甘草各 13g，珍珠、冰片各 2g，绿豆 200 粒，各药共为细末，制成水丸如绿豆大，以雄黄 25g，朱砂 5g 研细末为衣。成人每次 4~6g，1 岁儿童 1~1.5g，随年龄体质增减药量，每日 2 次，用温开水冲服或选 1~2 味中药煎汤送服；儿童以 1 月、成人以 3 月为 1 疗程。结果：临床控制（服药 1 疗程、随访 1 年以上无发作）34 例，有效（服药期间及停药后尚有发作、但症状较轻间隔时间延长）20 例，无效 33 例，总有效率为 62%。认为停止发作后，须连续服药 100 天~1 年以上，以免复发^[20]。

4.5 王宗起用癫痫丸治疗癫痫 324 例 本品含巴豆霜 5g，杏仁 20g，赤石脂、代赭石各 50g。巴豆去壳并挤压去油，取渣制成巴豆霜，再加入杏仁、赤石脂、代赭石，共为细末，制成蜜丸如小豆粒大小。成人于饭后服 3 粒/日 3 次，如无不良反应可逐渐增至每次 5 粒；儿童酌减。发作频繁、间歇时间短者以 1 月为 1 疗程；发作次数少、间歇时间长者以 2 月为 1 疗程。孕妇忌服。结果：治愈（症状完全消失，1 年以上无癫痫发作者）247 例，好转 59 例，无效 18 例，总有效率为 94.4%^[21]。

4.6 池松泉自拟医痫神丸治疗癫痫 1000 例 用本品（防葵、箭羽、山萸肉、茯苓各 20g，李根、凌霄花、盐黄柏各 15g，菟丝子 25g，木通 10g，研细末，过 100 目筛，蜜丸，每丸 10g）1 丸/日 3 次口服。禁食辛辣。用 100 日左右，结果：治愈 500 例，好转 450 例，无效 50 例，总有效率 95%^[22]。

4.7 田正美用羊胎合豁痰丸治疗癫痫 10 例 本组病

<0.005)^[25]。

4.10 杜明等用宁痫丹治疗癫痫 607 例 本品含全蝎、地龙、僵蚕、菖蒲、郁金、南星、磁石、紫贝齿等 20 余味，蜜丸，每丸 3g。1 岁以下用 0.5~1 丸/日，1~2 岁 2~3 丸/日，3~6 岁 3~4 丸/日，7~10 岁 4~6 丸/日，10~14 岁 6~9 丸/日，成人 9~12 丸/日，口服。本组总有效率 93.4%，服药 3~6 个月疗效最佳。动物实验表明：本品具有明显镇静、催眠及抗最小电休克作用，无毒性反应^[26]。

4.11 汤正才用新加保和丸治疗难治性癫痫 41 例 本组用本丸：神曲、山楂、葛根各 60g，茯苓、党参、黄芪各 35g，莱菔子、甘草各 12g，山药、地龙、僵蚕、生南星各 20g，陈皮、法半夏各 10g，蜈蚣 15 条，全蝎 14g，紫河车 45g，诸药焙干研末，蜜丸，每丸 1g。4~8g/日 3 次口服。对照组 35 例用苯妥英钠 0.1g、安定 5mg/日 3 次口服。均 6 个月为 1 疗程，治疗 2 个疗程。结果：两组分别显效 21、4 例，有效 16、20 例，无效 4、11 例。两组疗效比较有非常显著性差异 $P<0.01$ 。两组治疗前后脑电图比较有显著差异 $P<0.05$ ^[27]。

4.12 黄吉文用癫痫散治疗癫痫 300 例 本方含丹参、当归、白花蛇、蜈蚣、竹茹、半夏、枳实、茯苓、陈皮、橘红、全蝎、紫河车、人参、何首乌、天冬、麦冬、青黛、远志、冰片、地龙、僵蚕、皂角、礞石、菖蒲、沉香、天麻、白矾、胆南星、郁金、黄芩、桂枝、柴胡、白芍、钩藤、蝉蜕、栀子、天竺黄、白术、神曲、琥珀、熟地、山茱萸、大黄、朱砂。以上药去杂质熬膏烘干研细末，装胶囊，每粒重 0.5g。8~10 粒/日 2 次口服，小儿酌

减，3个月为1疗程。结果：显效（未发作，脑电图正常，1年未复发）140例占46.66%，好转98例占32.66%，有效42例占14%，无效20例占6.66%，总有效率93.32%^[28]。

4.13 高国举自拟癫痫散治疗癫痫 38例 方用陈皮、法半夏各15g，茯苓、胆南星、郁金、全蝎各12g，枳实、石菖蒲、生远志各10g，沉香、朱砂各6g，蜈蚣3条，海浮石、青礞石各30g。研末，装瓶备用。成人6~10g/日3次口服，发作频繁者10g/6小时1次或改汤剂。小儿酌减。2个月为1疗程。结果：痊愈34例，好转3例，无效1例。治疗6~18个月^[29]。

4.14 张林用抗痫散治疗痫证 本品含牛黄1g，天竺黄、僵蚕、钩藤各20g，蜈蚣8条，珍珠0.5g，朱砂10g，天麻15g，共为细末，分成8包，1包/日2次口服。共治20多例均获愈。附病案1则，服药4剂而愈，随访10余年未复发^[30]。

4.15 杨继新用金礞散治疗癫痫 38例 用本品（郁金、礞石、白芍、当归、丹参、天麻、白矾、香附、党参、白术、菖蒲、胆南星各30g，合欢花12g，赭石60g，朱砂18g，共研细末），≤7、≥8、≥15岁分别2~3、3~4、4~6g，日3次口服，30日为1疗程。服药期间避免劳累和精神刺激，忌食生冷厚味及发物。本组<15岁、成人分别为17、21例，用1~4个疗程，结果：治疗35例，有效2例，无效1例^[31]。

4.16 苟桢桃用琥珀四重散治疗癫痫 本品制法：先将灵磁石100g在猛火中煅透，趁热入食醋后捣碎，再将琥珀40g，石决明、生牡蛎各100g，代赭石75g，冰片5g，

共研细末过筛，混匀装瓶备用。20g（小儿酌减）/日3次口服，效果满意。附验案1则，患本病10余年，7~15日发作1次，经服本药1剂后发作时间间隔延长，3剂后发作停止，连服6月，随访3年未复发^[32]。

4.17 任方雄用猴枣散治疗癫痫 41例 用本品（含猴枣12g，羚羊角、沉香、礞石、硼砂各3g，天竺黄、石菖蒲各9g，川贝6g，麝香1.3g，全蝎1g，琥珀2g。研末，广州奇星药厂生产）0.36g，<1岁、1~3岁、4~14岁分别日1、2、3次；0.72g，15~25岁、26~42岁分别日2、3次，均口服。结果：痊愈12例，显效8例，有效15例，无效6例，总有效率84%^[33]。

4.18 张继德用牵牛子散治疗癫痫 586例 本组用本品（牵牛子、石菖蒲各250g，枯矾120g，龙骨、地龙适量，研末，装胶囊）3g/日3次，吞服，10日为1疗程。对照组466例，用苯妥英钠0.1g，癫痫安1片，均日3次；儿童10~30mg/kg体重/日，分2~3次口服。均治6~12个月后，两组分别治愈354例占60.4%、152例占32.0%，有效211例占36.0%、156例占33.4%，无效21例占3.6%、158例占34.6%。两组疗效比较有非常显著差异 $P<0.005$ ^[24]。

4.19 张永洛等用半夏白术天麻汤治疗癫痫 本组41例，用本方：法半夏、天麻、陈皮、苍术、泽泻、黄柏各10g，白术、黄芪、党参、茯苓、炒神曲各15g，麦芽30g，干姜6g。日1剂水煎，6~9岁服1/2量，9~12岁服2/3量，>12岁服1剂。就诊前服西药在1个月内者停药西药，>1个月者在1月内逐渐减服西药至停药，4个月为1疗程。结果：显效19例，有效13例，效差3例，无效6

星、玳瑁、羊鼻虫（焙）、琥珀各 15g，蜈蚣 10 条，天竺黄 10g，赤金 30 张，共为细末，装胶囊，每粒重 0.55g。1~2 岁 1 粒，2~4 岁 1~2 粒，4~6 岁 2~3 粒，6~9 岁 3~4 粒，9~14 岁 4~5 粒，14~18 岁 5~6 粒，成人 6 粒，均日 2 次口服。结果：基本控制 127 例占 84.67%，无效 23 例占 15.33%^[38]。

4.23 张文才用镇痫酒治疗顽固性癫痫 23 例 用本品（川牛膝、地龙各 20g，丹参各 30g，穿山甲、防风、荆芥、大茴香各 12g。加水 1500ml，文火煎 30 分钟后加白酒，待凉后装瓷罐密封大半月，过滤去药渣，取液装瓶备用）15~20ml/日 3 次口服，2 周为 1 疗程，疗程间隔 3~5 日。治疗 1~3 个疗程，痊愈 19 例，好转 3 例，无效 1 例，总有效率为 95.7%^[39]。

4.24 张尚谦用愈痫胶囊治疗癫痫大发作 100 例 本品含生赭石 100g，僵蚕、全蝎、黄芪、桃仁、丹参各 30g，红花、郁金、川芎各 15g，天仙子 50g，胆南星 20g，紫河车 40g。共为细末，过 100 目筛，装胶囊，每粒含生药 0.4g。5 粒/日 2 次，饭后服，小儿酌减。1 个月为 1 疗程，服半月后，减服西药，一般 2 个月内停用西药。结果：总有效率 95%^[40]。

4.25 肖裕光等用伏痫散冲剂治疗癫痫 148 例 取杜仲、巴戟天、钩藤、甘草各 150g，白芍、远志、麦冬、天冬、黄芩、丹参各 180g，长春花、田三七各 120g，柴胡、竹茹、石菖蒲、郁金各 160g，藏红花 50g，全蝎、蜈蚣各 20g，珠贝 300g，水煎去渣文火浓缩至 500g，加人中白 50g，经发酵后再加朱砂、琥珀末各 60g 混匀，适当烘干分装 30 包，每包 20g。本组予本品 1 包/日分 3 次口服。

果：总有效率、病程 10 年以上有效率、控制率分别为 97.3%、96% 和 66.2%，优于口服苯妥英钠对照组；脑电图复常率亦高于对照组，均有显著性差异， P 均 < 0.001 。对比检测甲皱微循环 36 例，治疗后微循环障碍发生率由原 74% 降至 40% ($P < 0.05$)。本品对心、肝、肾及骨髓无毒副作用^[41]。

4.26 刘松青等用夏星磁颗粒剂治疗原发性癫痫大发作（风痰型） 两组各 20 例，本组用本品（含姜半夏、胆南星、竹茹、干地龙、灵磁石、云茯苓等 13 味，两组药均由湖南中医学院提供）4g/日 3 次口服；对照组用苯妥英钠 10mg/kg/日分 3 次口服；均 4 周为 1 疗程，疗程间隔 1 周。治疗 3 个疗程，结果：两组分别治愈各 1 例，显效 3、2 例，有效 14、15 例，无效各 2 例；脑电图改善率分别为 15%、10%；两种药对血尿素氮、血肌酐均无明显影响，两组治疗前后自身及组间比较均无显著性差异， P 均 > 0.05 ^[42]。

4.27 朱中健等用复方青黛片治疗癫痫 375 例 本品含青黛 1 份，硼砂 3 份，山药 6 份，共为细末，以硬酯酸镁作赋型剂压片，每片含 0.5g。成人服 5g/日 3 次，用药半年不发作者改为 5g/日 2 次，1 年不发作者改为 5g/日 1 次，饭后服。小儿以成人剂量按年龄折算。结果：痊愈（症状消失，随访 5 年未复发）3 例，显效（症状减轻，发作间隔时间延长、持续时间缩短）99 例，有效（症状减轻，或发作间隔时间延长，或发作持续时间缩短）226 例，无效 47 例，总有效率 87.4%。药理试验示本品有明显的抗戊四氮惊厥作用，有增强硫贲妥钠的麻醉和巴比妥钠的催眠作用，还有一定的镇痛作用。本品副作用小，一

般用药 3 月内即有明显效果^[43]。

4.28 晏九银等用全蝎韭糖汁治疗癫痫 110 例 本组用全蝎 1 个（不去头尾），置洗净的瓦片上，文火焙干研成细粉，新鲜韭菜 250g，洗净晾干，将全蝎粉与韭菜混合一起揉汁，用新纱布滤汁，汁中放红糖 50g，拌匀后蒸熟，空腹 1 次服。大发作型：每月发作 5 次以下者每周服药 3 次；发作 6~10 次者每日服药 1~2 次；发作 10 次以上者每日服药 2~3 次；癫痫持续状态者每日服药 3~4 次。局限性癫痫、头痛型、精神运动性及腹痛癫痫发作，根据每月发作次数，服药次数控制在每周 1~3 次。发作控制后，服药由每周 1 次逐渐减少到 1 月 2 次或 1 月 1 次，维持 0.5~1 年。对照组 60 例服苯妥英钠，部分患者用硝基安定及鲁米那。结果：本组与对照组分别显效 78、31 例，有效 17、12 例，效差 9、6 例，无效 6、11 例，总有效率 95%、82%。两组疗效比较有显著差异， $P < 0.05$ ^[44]。

5 内外并治

5.1 王天才用镇痫灵治疗癫痫病 239 例 将桃花蕊、黄花败酱、缬草、丹参、水牛角浓缩粉、珍珠层粉、羚羊角粉、地龙、紫河车、冰片提取物浓缩烘干，加粘合剂压片，每片 0.45g。1~3 片/日 2 次口服，儿童酌减。将桃花蕊、黄芩花、胆南星、白僵蚕、丹参、天仙子、青阳参等放入香油中文火煎枯，过滤去渣，再熬油至滴水成珠，下黄丹搅匀，待冷却摊于牛皮纸上，用时将膏药贴敷神阙穴，3 日换 1 次，以上均用 6 月以上。结果：显效 157 例，有效 71 例，效差 4 例，无效 7 例，总有效率为 95.4%^[45]。

5.2 周宇红以中药敷贴穴位配合内服药治疗原发性

癫痫 42 例 取穴：大椎、腰俞。局部消毒后用消毒瓷片划破穴位皮肤，轻微出血后拔火罐，约 1~2 小时。去火罐后，依次用活斑蝥（捣碎）、白矾、麝香（均另研）自下而上敷出血处，再用自制风湿膏固定，保留 3 日，每周 1 次。并用朱砂 0.3~1g，鸡蛋 1 只，混合清炒后童便兑服，日 1 次。4 周为 1 疗程，2 个疗程间隔 2 周。结果：治愈 6 例，显效 9 例，近期控制 6 例，好转 9 例，无效 12 例，总有效率 71.4%^[46]。

6 中西医结合

6.1 汤小京等中西医结合治疗癫痫 114 例 痰火内盛：药用龙胆草、石决明各 15g，黄芩、全虫各 6g，栀子、泽泻、生地、半夏、胆星、菖蒲、天麻、僵蚕各 10g；心肾亏虚：药用熟地、枸杞子各 60g，山萸肉、龟板胶、柏子仁各 40g；桂元肉、贝母、胆星、菖蒲、竹茹各 30g，朱砂、琥珀各 10g，研末制成蜜丸；心脾两虚：用当归、党参、黄芪、远志、菖蒲、茯神、柏子仁各 15g，白术、桂元肉、竹沥、橘红、竹黄各 10g。原服西药的患者继服维持量并逐渐减量；癫痫大发作及呈持续状态者，静脉注射安定 10mg，或用水合氯醛 2g 稀释至 40~60ml 灌肠，待持续状态控制后仍以中药治疗为主。经 3 月~>24 月治疗，显效（2~5 年未发作）38 例，控制（1~2 年未发作）34 例，好转（6~12 月未发作）28 例，无效 14 例。总有效率为 87.7%^[47]。

6.2 况琼琰等中西医结合治疗癫痫 50 例 本组用绿矾（煅红）、鱼胶（切断，麸炒）、铅粉（炒黄）各 25g，朱砂 4.5g（研细水飞）。均研细末。4~10、11~16、>17 岁分别用 0.5~1.5、1.5~3、3~4g/日晨空腹顿服。与对

照组 50 例均用苯巴比妥 2 ~ 5mg/kg/日，苯妥英钠 3 ~ 8mg/kg/日，均分 2 次口服。20 日为 1 疗程，疗程间隔 7 日。用 3 个疗程，经果：两组分别痊愈 20、1 例，显效 25、6 例，有效 5、28 例，无效 0、15 例，总有效率 100%、70%^[48]。

6.3 刘玉玺等用狼毒大戟碱性提取液治疗癫痫 72 例

均用西药（卡马西平、苯妥英钠和丙戊酸类药）1 年以上，未能完全控制发作。不变更西药，加用本品（主要成分为狼毒生物碱，用狼毒大戟 1000g 水煎液，经阴离子交换树脂柱吸附，用 0.3% 氨水洗脱，浓缩至 1000ml，每 ml 相当生药 1g，山西医学院药学系提供）10ml（儿童 5ml）/日 2 次口服。3 个月为 1 疗程，治疗 3 ~ 12 个月。其中顽固性癫痫 22 例，单盲交叉用对照剂（生理盐水加止咳糖浆 1ml）及本品各 1 个月为 1 疗程，剂量同上。结果：显效（发作次数减少 75% 以上）30 例，有效 26 例，效差及无效 16 例，总有效率 78%。治疗前后自身比较发作次数明显减少（ $P < 0.05$ ）；用对照剂无明显改变（ $P > 0.05$ ）^[49]。

6.4 杨卫生以补肾汤为主治疗顽固性癫痫 14 例

本组患者均在用西药抗癫痫药的基础上加用中药熟地、紫河车、石菖蒲、枸杞、菟丝子各 30g，杜仲、山萸肉、郁金各 20g，牛膝、党参各 18g，寸冬、神曲、甘草各 15g，巴戟、肉桂、远志各 12g。另以琥珀 2g，朱砂 3g 冲服。湿热重加天竺黄、山栀、龙胆草；阴虚热加生地、龟板、丹皮；痰湿偏重加茯苓、苍术、白术、陈皮；肝阳上亢加生龙骨、生牡蛎、生赭石；血瘀加当归、丹参、川芎、红花、三棱、莪术。结果：显效（发作次数较治前减少

75%以上或基本控制) 4 例, 有效 (发作次数减少 50 ~ 75%) 3 例, 缓解 (发作次数减少不到 50%) 4 例, 无效 3 例。均治疗 3 ~ 6 月, 最快 1 ~ 2 周见效。12 例脑电图异常者中 7 例改善^[50]。

6.5 张宏泉标本兼治难治性癫痫 42 例 本组用抗癫痫散 (治本): 黄芪、焦六曲各 15g, 鸡血藤 30g, 炙守宫 2 条, 天麻、钩藤、制南星各 10g, 全蝎、炮山甲各 5g, 白僵蚕、九节菖蒲各 12g, 炒薏苡仁 20g。血瘀加王不留行、血竭或琥珀末; 痰湿壅阻加半夏或竹茹、礞石; 肝火偏旺加白蒺藜、夏枯草; 肝风内动加石决明。日 1 剂水煎服。对照组 38 例, 用苯巴比妥成人 30 ~ 60mg/日 2 ~ 3 次, 小儿 1mg/kg/日, 均口服。两组均用硝基安定成人 5 ~ 10mg/日 2 ~ 3 次, 小儿 0.5mg/kg/日分 1 ~ 2 次, 均口服。观察 2 年, 药量可酌情调至最低有效控制量。结果: 两组分别痊愈 12 (21.03%)、7 (16.27%) 例, 完全控制 24 (45.38%)、15 (30.09%) 例, 减少发作 4、8 例, 无效 2、8 例, 总有效率 95.23%、73.83%。两组治愈 (包括完全控制) 率、总有效率比较均有显著性差异 $P < 0.01$ 、 $0.05^{[51]}$ 。

7 针灸疗法

7.1 彭润生等针刺治疗癫痫 54 例 取穴: 鸠尾、筋缩、腰奇、间使、丰隆。痰热较盛加太渊; 肝热加太冲; 体弱加足三里。快速捻转进针, 得气后留针 15 分钟。一般用平补平泻法, 邪实者用泻法, 体弱用补法。每次选 4 ~ 6 穴, 间日 1 次, 10 次为 1 疗程。禁食辛辣、羊肉、酒酪, 避免惊、恐、怒等精神刺激。结果: 痊愈 34 例, 显效 10 例, 好转 4 例, 无效 6 例^[52]。

头针治疗 240 例：取癫痫穴（风池向内 1 寸再向上 1 寸，在斜方肌尽头处），用 1~1.5 寸毫针直刺进针，针尖略向上刺深约 5~8 分，连接 G680—5 治疗机，密波，以针感达前额为好，留针 30~120 分钟；配合顶中线、颞后斜线（双）、额中线，手法捻转，5 分钟行针 1 次。（2）羊肠线穴位埋藏 57 例：7 例在局麻下于前顶、百会、后顶各切开 0.5~1cm，用蚊式钳向切口周围刺激达骨膜使有沉重感，放在约 3~5 毫升，埋入长 4cm 之羊肠线，缝合切口，15 日 1 次，3 次为 1 疗程；50 例用套管针作羊肠线穴位埋藏，主穴取大椎、陶道、身柱、筋缩、腰奇、长强等，配穴取肝俞、心俞、肾俞、内关、丰隆、足三里，7 日 1 次，每次取 2~3 穴，7 次为 1 疗程，疗程间隔 7 日。（3）内服癫痫丸 20 例：本品含煅青礞石、姜半夏、天南星、海浮石、僵虫、沉香、生地、熟地、焦三仙、大黄等药，1 丸/日 2 次。（4）综合治疗组 68 例。治疗 15 日~>1 年后，痊愈 56 例，显效 98 例，有效 211 例，无效 20 例，总有效率 94.8%^[55]。

7.5 冯文华以针灸奇经俞穴为主治癫痫 35 例 主穴：身柱、神道及两穴之间（胸椎 4、5 之间），直刺 1~1.2 寸，灸 3~5 壮；鸠尾斜刺 0.5~1 寸。配穴：昼发加申脉，夜发加行间、丰隆，肝肾阴虚加太溪，脾胃虚弱加太白、百会。常规针刺并灸 3~5 壮，隔日 1 次，12 次为 1 疗程，疗程间隔 7 日，一般 1~4 疗程。治疗中发作时急针人中、太冲、长强。结果：痊愈（5 年内未发作）12 例，显效（半年以上未发作或发作症状被控制 3/4 以上）11 例，有效（发作症状被控制 1/4 以上或 3/4 以下）8 例，无效 4 例^[56]。

7.6 翟生等采用醒脑开窍针法治疗癫痫 60 例 患者仰卧，先取百会穴，得气后捻转 1 钟；再取人中穴，用雀啄手法，至眼球湿润度；取双侧劳宫穴，进针后提插捻转，便指有放电感；取双侧涌泉穴快速进针，快速捻至脚心发热、脚掌发胀；最后取双侧内关穴得气后捻转 1 分钟，留针 1 小时，每 20 分钟行 1 次。结果：治愈 9 例，显效 18 例，好转 30 例，无效 3 例^[57]。

8 针药并用

8.1 黄宗勳针药并治癫痫 54 例 主穴：大椎、腰奇、间使、丰隆。日间发作加申脉；夜间发作加照海；发作时加人中、颊车。针刺大椎用 2 寸毫针，向上约 30°斜刺 1~1.5 寸，得气后留针，若有触电样针感时，立即出针，不得提插。腰奇在第二骶椎棘突下，向上斜刺 2~2.5 寸。未发作时用平补平泻法，留针 30 分钟；发作时用泻法，不留针。每日或隔日 1 次，12 次为 1 疗程，疗程间隔 5 日。同时药用白矾、郁金各 60g，胆星 30g，天竺黄 12g，朱砂、琥珀、薄荷各 9g，研末装胶囊，成人每服 3g，小儿每服 1.5~2g，日 3 次。结果：基本治愈 21 例，显效 25 例，有效 7 例，无效 1 例，总有效率 98.2%^[58]。

8.2 程玩梅等以针刺配合癫痫丸治疗癫痫 64 例 主穴：百会、大椎、神庭、癫痫、腰奇、太冲。配穴：太阳、风池、安眠、神门、内关、丰隆、陶道、筋缩、长强。每次各选 3~4 穴，强实者用泻法，虚弱者用平补平泻法，得气后留针 20~30 分钟。小儿用快速轻度提插。发作时加刺人中穴，强刺激；白天发作加申脉；夜间发作加照海。2~5 日 1 次。用癫痫丸（天麻、胆南星、半夏各 15g，煅磁石、赭石、龙齿各 10g，郁金 12g，蜈蚣 4

条，共为细末，炼蜜为丸，朱砂 4g 包衣）10 丸/日 1~3 次口服，小儿酌减。症状控制后改服愈痫丸（上方去磁石，加石菖蒲 12g）。结果：痊愈 31 例，显效 16 例，有效 12 例，无效 5 例^[59]。

8.3 李英才自拟大黄丹参汤配合针刺治疗癫痫 103 例 本方含大黄 20g，丹参 26g，红花、赤芍、石菖蒲、党参、青皮、香附各 9g，竹茹 8g，丝瓜络、白术各 10g。惊痰痫型加珍珠母、龙骨；抽搐甚加天麻、钩藤；肝火痰热型加龙胆草、黄连、栀子；气郁痰痛型加柴胡；病程长体虚加紫河车；痰多加天竺黄、瓜蒌、半夏。日 1 剂水煎服，6 个月为 1 疗程。取穴：百会透前顶 1.5 寸，风府透双风池 1.2 寸，命门进针 1 寸，手法均由轻至重，从上至下依次行针快频率捻转，每穴每次 2 分钟；双神门 0.4 寸，重刺激。心悸痰盛加内关、双丰隆、中脘（直刺 1.5 寸，轻刺激捻转，留针 10 分钟）；发作频繁加长强，斜刺 0.8 寸，轻捻 30 秒~1 分钟；失眠加双间使。日 1 次，第 2 周隔日 1 次，1 个月为 1 疗程，疗程间隔 6 日。结果：显效（不发作或频率减少 75% 以上）65 例，有效 32 例，无效 6 例，总有效率 94.2%^[60]。

8.4 孙曙霞以针刺配合药物贴脐治疗癫痫 48 例 取穴：发作期取水沟（用 0.38mm×25mm 毫针向鼻中隔方向刺入 0.5~0.6 寸，强刺激）、腰奇（用 50~60mm 毫针刺入 2 寸）、后溪（刺入 1~1.5 寸左右，留针至患者抽搐停止，神志清醒。每隔 5 分钟强刺激泻法 1 次）。间歇期取大椎、间使、丰隆、百会；常规刺法，日 1 次，10 次为 1 疗程。疗程间隔 3~4 日，用 8~10 个疗程。用吴茱萸末 1.5g，填肚脐，胶布固定。用 5 日，停 1 日。连续用 5~6

第3次间隔2月，余类推。术前长期服抗癫痫药者须在医生指导下逐渐减量，2~3年后酌情停药。埋线数的多少视病情及疗效而定。结果：基本治愈（患者癫痫控制3年无发作或停药3年无发作，无人格变态和智能障碍，或脑电图正常）677例占88.04%，显效51例占6.63%，进步37例占4.81%，无效4例占0.52%^[63]。

9.3 王瑞恒等以穴位植线治疗原发性癫痫80例 取穴：身柱、神道、灵台、筋缩。白天发作加申脉，晚上发作加照海，痰盛加丰隆，体虚加足三里。常规消毒后，用利多卡因局麻。将00号羊肠线剪为1.5cm长小段，浸入生理盐水中煮沸，用特制植线专用针将羊肠线植入穴位中，消毒后盖以敷料或创可贴。1周后可在原穴位上下部位再次植线。小儿可改用毫针速刺法，隔日1次，6次为1疗程，疗程间隔2周。结果：痊愈28例，显效20例，进步12例，无效20例，总有效率75%^[64]。

9.4 虎发彩采用穴位埋线配合中药内服治疗痫证223例 取穴：长强、腰奇、大椎、癫痫（第12胸椎棘突与第1腰椎棘突之间）、筋缩、丰隆，白天发作加申脉，夜间加照海。穴位埋线，1个月1次。并用赭石（研细水飞）、神曲、郁金、清半夏各120g，朱砂（研细水飞）、白矾各60g，共研细末。3个月~1岁、2~5岁、6~10岁、11~15岁、>16岁分别2~5、5~10、10~15、15~20、20~25g，均日3次饭后服。1个月为1疗程。忌腥荤油腻。用1~3个疗程，结果：均治愈^[65]。

9.5 刘峥采用穴位埋线合并针刺督脉穴治疗癫痫50例 治法：取消毒羊肠线1~2厘米，用穿刺针沿督脉循行方向由下向上地埋入腰奇穴皮下，每半月换1次。针入

中斜向上鼻中隔方向进针 0.5 寸，施雀啄法，以鼻子发酸、眼睛湿润为度”百会穴平刺 1 寸，左右捻转，平补平泻；针风府时头微前倾，向下颌方向缓慢刺入 0.8~1.2 寸，行提插补泻法；大椎穴斜刺，施补法以有热感为度。留针 20 分钟，日 1~2 次。结果：显效（发作基本控制，偶尔因诱因发作 1 次，疗效保持 2 年以上）29 例，有效（发作次数明显减少，症状减轻）18 例，无效 3 例^[66]。

9.6 李建山采用新法穴位埋线术配合经络导向法治疗癫痫病 518 例 取穴：百会、长强、腰奇、肾俞、膻中、内关、足三里、丰隆、神门、定癫痫穴（自定穴）。辨证取穴，常规消毒局麻后，用异体长效免疫蛋白药线（白求恩国际和平医院研制）埋入穴位，针眼用 75% 酒精纱条覆盖 3 日。并辨证分型施经络导向法。2~3 个月 1 次，3 次为 1 疗程。结果：治愈 328 例，显效 138 例，有效 43 例，无效 9 例，总有效率 98.3%^[67]。

9.7 赵富春等采用穴位埋线配合辨证用药治疗痫证 28 例 （1）穴位埋线：①大椎、陶道、身柱、长强；②新一（第 5、6 颈椎处）、陶道、筋缩、腰奇，两组穴位交替使用。患者俯卧，两腿分开，背部暴露，在局麻下，以带有羊肠线的弯三角针在穴位旁开 1.5cm 处进针，穿过皮下组织至穴位另一侧 1.5cm 处出针。出针后将羊肠线来回抽动几下，至病人感到局部酸、沉、胀、麻感后，在贴近皮肤处剪断肠线，盖以敷料并固定 7 日。每月埋线 1 次，3 次为 1 疗程。严重心脏病、糖尿病、活动性肺结核、高烧、孕妇禁用。（2）内服中药：磁石 20g，陈皮、半夏、天麻、全虫、胆南星各 9g，钩藤、天竺黄各 12g，生熟曲各 15g，琥珀、朱砂各 3g（另包混合分两次冲服）。肝肾

阴虚配六味地黄丸；脾胃虚弱配参苓白术散；肝火痰热便秘加大黄、芒硝、礞石等。结果：痊愈 20 例，患者脑电图有改善，3 年无复发；有效 7 例；无效 1 例^[68]。

9.8 王学林采用穴位封闭加服地龙汤治疗癫痫病 本组患者 2370 例，其中大发作型 1238 例，小发作型 348 例，精神发作型 129 例，混合发作型 290 例，局限性发作型 365 例；病程 3 ~ > 10 年者为 91.9%。(1) 取鲜地龙 50 条，洗净包煎 40 分钟，加入半夏 12g，郁金 30g，生大黄 10g，全蝎和蜈蚣各 1g，同煮 15 分钟，于早晨空腹顿服。每日 1 剂，15 日为 1 疗程，疗程间隔 10 日。(2) 于鸠尾（针深 4 ~ 6 分）、癫痫和大椎（均针深 5 分）、腰奇（针深 2 分）等穴各注入 5% γ -氨基酪酸 2ml，注射局部用无菌纱布轻揉数分钟，卧床休息 30 分钟。每周 1 次，5 次为 1 疗程。经治 4 ~ 5 疗程后，4 年以上无发作者 746 例占 31.48%，2 年以上无发作者 984 例占 41.52%，2 年内数月发作 1 次或发作次数明显减少者 468 例占 19.74%，无效 172 例占 7.26%。各型患者 2 ~ 4 年以上控制和基本控制率其大小依次为大发作型、局限性型、小发作和混合发作型、精神性型^[69]。

9.9 李沛清等用兔脑垂体穴位注射治疗原发性癫痫 200 例 选健康重 1.5kg 以上活家兔 1 只，处死后开颅，无菌操作下取出脑垂体，置生理盐水中制成细胞悬液。主穴：大椎、心俞、脾俞。一般取主穴，发作频繁者配平痫（第 4 胸椎下凹陷处）；抽搐严重配肝俞；身体虚弱或有头晕耳鸣配肾俞。用 0.5% ~ 1% 奴夫卡因在穴位处行皮内及皮下浸润麻醉后，将注射针刺入穴位并稍作提插，待局部胀感后注入药液，每穴 1 ~ 1.5ml。3 次为 1 疗程，第 1

次后间隔 1 个月, 第 2 次后间隔 2 个月。结果: 显效 54 例, 有效 115 例, 无效 31 例, 总有效率为 84.5%^[70]。

参 考 文 献

- 1 吴 铁, 等. 吉林中医药 .1992; (4): 26
- 2 蒋改苏, 等. 辽宁中医杂志 .1995; 22 (1): 18
- 3 高永汉, 等. 北京中医学院学报 .1991; 14 (4): 17
- 4 苟生茂. 内蒙古中医药 .1989; 8 (1): 5
- 5 徐 明. 黑龙江中医药 .1992; (3): 11
- 6 杨 晓, 等. 国医论坛 .1996; 11 (3): 36
- 7 王兆荣. 四川中医 .1995; 13 (7): 16
- 8 保 健. 云南中医中药杂志 .1997; 18 (2): 13
- 8 张建夫, 等. 陕西中医学院学报 .1986; 9 (4): 12
- 10 孙立德. 河北中医 .1992; 14 (1): 1
- 11 傅竟成, 等. 四川中医 .1989; 7 (12): 25
- 12 史学义. 山西中医 .1994; 10 (2): 10
- 13 吴京成. 江苏中医 .1993; 14 (2): 15
- 14 史淑芹. 黑龙江中医药 .1990; (3): 12
- 15 杨树成, 等. 实用中医药杂志 .1996; 12 (3): 12
- 16 刘开苏. 安徽中医学院学报 .1988; 7 (3): 33
- 17 尹铁汉, 等. 光明中医 .1996; 11 (3): 38
- 18 刘道清. 中国中西医结合杂志 .1996; 16 (12): 750
- 19 张宏国. 山东中医杂志 .1992; 11 (6): 14
- 20 张洪海, 等. 上海中医药杂志 .1987; (10): 27
- 21 王宗起. 吉林中医药: 1988; (1): 10
- 22 池松泉. 辽宁中医杂志 .1996; 23 (2): 70
- 23 田正美. 新疆中医药 .1993; (1): 18
- 24 郭用露. 山西中医 .1994; 10 (4): 28

- 25 张继德, 等. 湖南中医杂志 .1995; 11 (4): 17
- 26 杜 明, 等. 天津中医 .1991; (4): 5
- 27 汤正才, 等. 四川中医 .1992; 10 (12): 26
- 28 黄吉文. 甘肃中医学院学报 .1994; 11 (1): 23
- 29 高国举. 浙江中医杂志 .1992; 27 (10): 444
- 30 张 林. 吉林中医药 .1988; (6): 20
- 31 杨继新. 湖北中医杂志 .1996; 18 (5): 36
- 32 苟桢桃. 云南中医杂志 .1989; 10 (6): 45
- 33 任方雄. 实用中医药杂志 .1995; 11 (5): 14
- 34 张继德. 湖南中医杂志 .1993; 9 (1): 14
- 35 张永洛, 等. 中国医药学报 .1995; 10 (3): 22
- 36 曾文长. 辽宁中医杂志 .1990; 14 (6): 23
- 37 张家庆. 山西中医 .1988; 4 (6): 14
- 38 朱秀罗. 河南中医 .1995; 15 (4): 241
- 39 张文才. 四川中医 .1993; 11 (11): 30
- 40 张尚谦. 陕西中医 .1994; 15 (9): 400
- 41 肖裕光, 等. 新中医 .1992; 24 (10): 42
- 42 刘松青, 等. 湖南中医学院学报 .1994; 14 (4): 33
- 43 朱中健, 等. 黑龙江中医药 .1990; (4): 15
- 44 晏九银, 等. 四川中医 .1991; 9 (11): 12
- 45 王天才. 中医杂志 .1992; 33 (4): 32
- 46 周宇红, 等. 新中医 .1996; 28 (10): 34
- 47 汤小京, 等. 河南中医 .1989; (1): 23
- 48 况琼琰, 等. 辽宁中医杂志 .1996; 23 (11): 516
- 49 刘玉玺, 等. 中国中西医结合杂志 .1994; 14 (5): 282
- 50 杨卫生. 辽宁中医杂志 .1989; 13 (7): 18
- 51 张宏泉. 辽宁中医杂志 .1994; 21 (7): 316
- 52 彭润生, 等. 国医论坛 .1990; (1): 32
- 53 李 智. 江苏中医 .1989; 10 (9): 21
- 54 许永迅. 上海针灸杂志 .1991; 10 (3): 16

- 55 申秀兰, 等. 贵阳中医学院学报 .1989; (3): 48
 - 56 冯文华. 陕西中医 .1989; 10 (3): 131
 - 57 翟 生, 等. 浙江中医杂志 .1992; 27 (10): 445
 - 58 黄宗勳. 福建中医学院学报 .1993; 3 (1): 7
 - 58 程玩梅, 等. 新中医 .1994; 26 (1): 38
 - 60 李英才. 浙江中医杂志 .1994; 29 (12): 533
 - 61 孙曙霞. 上海针灸杂志 .1997; 16 (1) 13
 - 62 陈锦枝. 四川中医 .1988; 6 (3): 14
 - 63 陆 英. 中级医刊 .1988; 23 (4): 50
 - 64 王瑞恒, 等. 山西中医 .1994; 10 (6): 36
 - 65 虎发彩. 光明中医 .1996; 11 (2): 51
 - 66 刘 峥. 中级医刊 .1990; 25 (11): 58
 - 67 李建山. 针灸临床杂志 .1996; 12 (9): 31
 - 68 赵富春, 等. 河南中医 .1988; 8 (2): 18
 - 69 王学林. 中级医刊 .1991; 26 (1): 61
 - 70 李沛清, 等. 甘肃中医学院学报 .1992; 9 (4): 21
- (常青)

躁狂抑郁症

躁狂抑郁症（简称躁郁症）是一种以情感障碍为主的功能性精神病。临床上可单独表现为周期发作的躁狂症或周期发作的抑郁症，也可表现为躁狂状态与抑郁状态的循环发作或交替出现。躁狂症相当于中医学的“狂证”，抑郁症相当于中医学的“癫证”。

1 辨证论治

1.1 缪增玲辨证治疗癫狂 280 例 本组病程 1 月 ~ 10 年。(1) 狂症：痰型治以开窍化痰，以菖蒲、胆星、天竺黄、麝香、牛黄为主药；火型治以清热泻火，以石膏、知母、黄芩、黄连、栀子、大黄、芒硝、芦荟、竹叶、连翘、生地、丹皮、元参为主药。(2) 癫症：气结血瘀型治以调气破血法，以苏子、莱菔子、白芥子、陈皮、沉香、川朴、香附、桃仁、红花、丹皮、赤芍、大黄、当归、虻虫、水蛭、三棱为主药；脾肾阳虚型治以补虚养正为法，以党参、黄精、茯神、酸枣仁、远志、龙骨、龟板、生地、熟地、五味子、巴戟天、淫羊藿、附子、干姜、仙茅为主药。结果：治愈（症状消失，能胜任正常工作，停用一切药物，随访 3 年以上未复发）229 例，基本治愈（症状及精神基本痊愈，能参加工作，近期因某种因素而诱发，重复治疗 1 ~ 2 疗程，并经随访 1 ~ 2 年不再复发）15 例，显效（症状与精神状态明显好转，能承担轻微工作，3 月内复发，经多次治疗，病情比原来有明显好转）14 例，无效与中断治疗 22 例；总有效率为 92.15%^[1]。

1.2 许兰芬辨证治疗癫狂证 癫证：痰气郁结型用顺气导痰汤加味（法半夏、陈皮、胆南星、茯苓、香附、

木香、菖蒲、远志)；心脾两虚型用养心汤（人参、黄芪、当归、川芎、茯苓、远志、柏子仁、五味子、肉桂、甘草）。狂证：痰火上扰型用生铁落饮（生铁落、胆南星、贝母、橘红、菖蒲、远志、茯神、天冬、麦冬、玄参、连翘）为主方，痰火壅盛用礞石滚痰丸或安宫牛黄丸；火盛伤阴型用二阴煎（生地、麦冬、玄参、黄连、木通、竹叶、灯芯草、茯神、酸枣仁、甘草）。兼瘀血内阻者用血府逐瘀汤或癫狂梦醒汤加减。附验案3则^[2]。

1.3 张质斌辨证治疗癫狂证 18 例 基本方含胆南星、枳实、川贝母、郁金、瓜蒌、川黄连、远志、石菖蒲、丹参、陈皮、甘草。每日煎服1剂。癫证期（10例）以精神抑郁为主要表现，予清癫散：羚羊角粉3g，胆南星、川黄连、朱砂各1g。共研细粉，以基本方药液分2次冲服。狂证期（3例），用大戟、芫花、甘遂各30%，明矾10%。共研细粉，每次取3~5g，以基本方加大黄15g煎汤冲服。癫狂后期（5例），心脾两虚者以基本方加白术、党参、茯苓、柏子仁、炒枣仁；阴虚火旺者则基本方加熟地、元参、麦冬、珍珠母、知母、五味子等。结果：近期治愈（症状消失，随访半年以上未复发）14例；好转3例；无效1例；附癫狂证病案1则，病程2年，服药18剂后单用清癫散调理月余而愈，随访3年未复发^[3]。

1.4 高广见辨证治疗癫狂证 560 例 （1）癫证：气郁痰瘀型用柴胡、枳实、茯苓、郁金各18g，大黄、半夏、胆南星、菖蒲、桃仁、赤芍、瓜蒌仁、桑白皮各15g，甘草10g；胆虚痰扰型用温胆汤加龙骨、牡蛎、远志、菖蒲、胆南星。（2）狂证：气火上亢型用生铁落200g，生石膏、寒水石各70g，生大黄、知母、赤芍各

24g, 芒硝 60g, 芦荟 6g, 川连、栀子各 15g, 龙胆草、生甘草各 10g; 痰火上扰型用生大黄、瓜蒌仁、浙贝、知母、黄芩、天竺黄各 18g, 芒硝 50g, 生石膏 70g, 竹沥 20ml, 竹茹、栀子、桑白皮各 15g, 甘草 10g。兼服礞石滚痰丸。(3) 癫狂证: 药用柴胡、枳壳、赤芍、香附、丹皮、丹参、桃仁各 18g, 青皮、桑皮各 15g, 甘草 10g。均随症加减。结果: 治愈 447 例, 好转 101 例, 无效 11 例, 死亡 1 例, 总有效率为 97.8%。平均治疗 48 日^[4]。

1.5 马明磊辨证治疗癫、狂、郁证 427 例 (1) 癫症 19 例, 治以疏肝解郁、涤痰宣窍, 药用龙齿 30g, 生石膏 15g, 胆星、菖蒲、枳壳、茯苓、陈皮、党参、半夏、甘草各 10g, 竹茹 6g, 蜈蚣 2 条, 生姜 3 片, 大枣 7 枚; (2) 狂症 56 例, 治以泻火逐痰、镇心安神, 药用巴豆霜、胆南星、明雄、朱砂各 0.5g, 珍珠 0.1g, 共为细末, 1 次口服, 泻 3~5 次, 泻后食稀粥; 次晨服二黄二丑丸 1 丸, 晚服磁朱丸 2 丸 (丸重各 9g)。(3) 郁症 352 例, 治以健脾养心、安神定志, 药用淮小麦 60g, 焦枣仁、甘草、女贞子各 30g, 牡蛎 15g, 玉竹 10g, 大枣 10 枚。服 10~60 剂后, 临床痊愈 323 例, 好转 87 例, 无效 17 例, 总有效率 95.9%^[5]。

2 一方为主 随证加减

2.1 李发明等用小柴胡汤治疗抑郁症 90 例 用柴胡 15g, 酒黄芩 12g, 党参 20g, 姜半夏、甘草各 10g, 生姜 6 片, 大枣 6 枚。阴虚内热加生地、元参、麦冬; 肝郁气滞加香附、郁金、枳壳; 痰湿困脾加厚朴、白术、茯苓。日 1 剂水煎服, 10 日为 1 疗程。结果: 痊愈 64 例, 好转 7 例, 无效 19 例, 总有效率为 78.8%^[6]。

2.2 林天青用甘戟滚痰汤治疗狂症 10 例 方用大戟、甘草、大黄（后下）、风化硝、枳壳、礞石、黄芩、沉香各 10g，莲子芯 3g。肝火夹痰、上扰心神，加代赭石（先煎）15g，生铁落（先煎）30g，瓜蒌皮 10g；痰浊壅盛加明矾、常山各 0.4g，牙皂 3g。日 1 剂，水煎服，服药 2 ~ 10 剂后，治愈 6 例，好转、无效各 2 例^[7]。

3 一方为主 随症加减

3.1 胡思荣用平心忘忧汤治疗抑郁症 470 例 本方含磁石、礞石各 30g（另包先煎），枳实、黄柏、半夏、厚朴、朱茯苓、神曲各 12g，肉桂、苏叶、菖蒲各 6g，生姜 9g。湿盛痰多，恶心欲呕加藿香、川羌活；失眠多梦加枣仁、远志；血压高、便干去黄芪，加大黄。日 1 剂水煎分 3 次服。并进行心理治疗。治疗 30 ~ 180 日，结果：痊愈 330 例占 70.2%，好转 95 例占 20.2%，无效 45 例占 9.6%，总有效率 90.4%^[8]。

3.2 华元贞用龙胆泻肝汤加减治疗癡狂 13 例 本方含龙胆草、生栀子、黄芩各 12g，赤茯苓、柴胡、车前子各 10g，泽泻 11g，生甘草 6g。躁狂甚加磁石、菖蒲；沉默寡言加浮小麦、远志、合欢花；便秘加生大黄、柏子仁；盗汗加枣仁、生龙骨、生牡蛎。日 1 剂水煎服。治疗 2 个月，结果：治愈 2 例，显效 9 例，有效、无效各 1 例^[9]。

3.3 包培蓉用柴胡加龙骨牡蛎汤化裁治疗狂症 21 例 用柴胡 24g，茯苓、生龙骨、生牡蛎各 30g，桂枝 6g，黄芩 9g，半夏 12g，党参 15g，大枣 6 枚，大黄 6 ~ 15g，铅丹 4.5g，铁锈 30 ~ 60g。不寐加朱砂、琥珀；烦闷加菖蒲、郁金；痰热加胆南星、天竺黄、礞石；痰阻胸膈配用

显效 59 例，有效 93 例，无效 2 例。经对 135 例痊愈和显效病例进行随访，复发 14 例，占 10.36%。复发后仍以本法治疗，效果亦佳^[13]。

4.3 杨金洪用特愈癫狂散治疗癫狂 560 例 本组包括狂燥型患者 400 例，妄想型、青春型、周期型患者共 160 例。(1) 丸剂：牛黄 1.2g，巴豆霜 1.5g，大黄 15g，朱砂 0.5g，制成玉米粒大之蜜丸，每粒含量 0.04g，孕妇忌服。(2) 散剂：狗脑 21g，天竹黄、柏子仁、石菖蒲、远志、黄连、栀子、桃仁各 9g，礞石 15g，酸枣仁 12g，天南星、三棱、莪术各 6g，共研细末。每日晨起空腹服丸剂 1 粒，连服 2~3 日（不可久服，年老体弱者酌减用量）；然后改服散剂 4g/早晚各 1 次。以生铁落 30g 为引，心火旺者用竹叶、茅根各 5~10g 为引。若不用丸剂，须于服散剂的同时加牛黄 0.25g、朱砂 0.15g 冲服。如仍不能控制病情，应加服西药镇静剂。结果：痊愈 453 例，显效 55 例，进步 33 例，无效 19 例，总有效率 96.6%。服药 3~15 日。随访 1~2 年未见复发^[14]。

4.4 王学平用重剂量大黄治疗狂症 50 例 生大黄 30~150g，生地、菖蒲、生龙骨、生牡蛎各 30g，黄连 5g，橘红 20g，天竺黄 10g。日 1 剂水煎服，重症病例日服 2 剂。结果均获愈^[15]。

5 中西医结合

5.1 吴文荣等中西医结合治疗抑郁症 45 例 本组肝郁脾虚型用柴胡、陈皮、当归、炒白芍、白术、炒建曲、薄荷各 12g，制香附、枳壳各 10g，焦栀子 9g，党参、茯苓、川芎、佛手各 15g，甘草 6g。肝血瘀滞型用柴胡、川芎、三棱、莪术、山楂各 12g，郁金、赤芍、当归各 15g，

丹参 20g, 枳壳、红花、炒五灵脂、鸡内金各 10g。心脾两虚型用党参、黄芪、茯神、炒枣仁、远志各 15g, 白术 12g, 合欢花、麦冬各 20g, 柏子仁、龙眼肉、当归、陈皮各 10g, 砂仁、甘草各 6g, 龙齿 30g, 大枣 5 枚。脾肾阳虚型用制附子、白术、熟地、巴戟天、山萸肉、肉苁蓉、当归、杜仲各 12g, 肉桂 9g, 党参、山药、川断各 15g, 鹿角胶、鸡内金各 10g。日 1 剂水煎服。与对照组 32 例, 均用氯丙咪嗪或阿密替林或多虑平, 分别日平均 $<100\text{mg}$ 、 225mg 。结果: 两组分别痊愈 17、7 例, 显效 21、13 例, 进步各 7 例, 无效 0、5 例, 总有效率 100%、84.4% ($P < 0.05$)^[16]。

5.2 彭法忠用解郁汤协同小剂量三环抗抑郁药治疗抑郁状态 40 例 本方含柴胡、制香附、炙甘草各 6g, 白芍、炒枣仁、郁金各 12g, 当归、朱茯神各 15g, 青龙齿 20g, 石菖蒲 10g, 大枣 7 枚, 陈小麦 60g。悲伤欲死加佛手、生牡蛎; 神志恍惚、口苦、小便黄加百合、知母; 烦躁不安加生山栀、淡豆豉; 便秘加生大黄、瓜蒌仁或礞石滚痰丸; 昼夜不眠加合欢花、夜交藤; 口干舌燥加石斛、天花粉; 痰多而稠加胆南星、天竺黄。水煎服日 1 剂。用阿米替林或多虑平 $25\text{mg}/\text{日}$ 2 次口服。对服上方后睡眠仍差者, 加用硝基安定 5mg 或舒乐安定 1mg , 睡前服。对精神分裂症后抑郁, 或分裂情感性障碍、分裂—抑郁障碍者还需加服冬眠灵、奋乃静、舒必利等药。经治疗抑郁状态消失后, 停中药, 西药逐渐减量, 直至停药。结果: 痊愈 25 例, 显效 13 例, 好转 1 例, 无效 1 例。其中有轻生欲念和自杀行为者 32 例, 治疗 3~5 天以后, 有 31 例消除了轻生欲念和自杀行为^[17]。

28号1寸针1枚、1.5寸针4枚。取人中、虎边（双）、三阴交（双）。5人各针刺1穴，同时进针，同步操作，捻转补泻，人中、虎边用泻法，三阴交用补法。得气后，同时捻转1~2分钟，留针1分钟，再捻针，如此反复3次，待患者逐渐进入睡眠状态后出针。狂证用重度刺激；癫证用中度刺激，留针时间延长至5~10分钟。初病或病程短者每周针1次，久病隔日1次，病情控制后每周1次。本组10例，治疗3~5次后，显效7例，好转3例^[21]。

7 针（灸）药结合

7.1 马景盛针药结合治疗癫狂症 73例 （1）狂躁型：①急则治标：三棱针刺人中、十宣。毫针刺心俞、肝俞，泻法；针后拔火罐10~20分钟，以出血为宜。再用泻法针刺合谷、内关、神门、涌泉。②缓则治本：用代赭石100g，青礞石、龙骨、牡蛎各50g（上均碎后先煎30分钟），郁金、桃仁、大黄（后下）各20g，菖蒲、黄连各15g，胆星、沉香各10g，大枣5枚。日1剂水煎服。病久势衰，症见倦怠乏力，诸药减量，酌加养阴之品，必要时加党参、黄芪，视病情去大黄、礞石。用清心镇静散（牛黄5g，麝香、冰片各1.5g，珍珠3g，琥珀、朱砂各30g，黄连15g，龙齿50g。共为细末）5g/日3次口服，7日为1疗程。（2）抑郁型：①针刺合谷、内关、神门、肝俞、心俞、风池、风府等，以平补平泻为主，留针15~30分钟；心俞、肝俞穴针后拔火罐以出血为宜，7日为1疗程。药用柴胡、当归、云苓、赤芍、木香、桃仁、川连各15g，郁金、青皮、枳壳各20g，菖蒲、青礞石各30g，胆南星、半夏、甘草各10g。日久心阴不足，上方去半夏、礞石、木香，加党参、黄芪、枣仁、柏仁、五味子、麦冬。并用

- 17 彭法忠 . 安徽中医学院学报 .1988; 7 (4): 25
- 18 王守玺 . 陕西中医 .1989; 10 (5): 197
- 19 马明磊 . 陕西中医 .1993; 14 (3): 111
- 20 赵密芬, 等 . 中医药学报 .1987; (2): 36
- 21 马玉莹 . 辽宁中医杂志 .1993; 20 (7): 40
- 22 马景盛 . 北京中医 .1990; (4): 35
- 23 色 . 哈斯巴根, 等 . 中国民族医药杂志 .1996; 2 (3): 22
(王继亮)

精神分裂症

精神分裂症是一种常见的病因未明的精神病，多发于青壮年，具有思维、情感、感知和行为等多方面的障碍，常导致精神活动不协调。相当于中医学的“癫狂”证。

1 辨证论治

1.1 丁德正辨证治疗精神分裂证偏执型 218 例 分 8 型：1. 痰气郁结：用柴胡、香附、郁金、黄芩、胆星、海石、礞石、白芍、枳实、半夏、远志、菖蒲、甘松、薄荷、狼眼、甘草、琥珀。2. 痰火上扰型：用黄连、天竺黄、栀子、黄芩、郁金、大黄、胆星、海石、礞石、寒水石、石膏、远志、菖蒲、竹茹、甘草、朱砂。3. 气虚痰结型：用党参、黄芪、炙草、枣仁、白术、茯苓、郁金、远志、菖蒲、枳实、胆星、海石、礞石、龙齿、磁石、朱砂、琥珀。4. 肝气虚型：用熟地、当归、枣仁、阿胶、云苓、柏子仁、远志、龙骨、牡蛎、磁石、甘草、甘松、朱砂、琥珀。5. 瘀血型：用当归、赤芍、川芎、桃仁、红花、枣仁、大黄、丹参、郁金、龙齿、甘草、琥珀。6. 痰瘀内结型：用胆星、枳实、红花、桃仁、远志、菖蒲、水蛭、虻虫、枣仁、大黄、海石、礞石、丹参、郁金、甘草、琥珀。7. 血虚风稽型：用当归、熟地、党参、枣仁、五味子、柏子仁、茯神、远志、秦艽、羌活、防风、薄荷、白芷、甘草、龙骨、朱砂。8. 湿毒内扰型：用黄芪、炙草、党参、白术、桂枝、枣仁、苦参、云苓、泽泻、远志、菖蒲、木通、朱砂。均配针灸，留针 2~3 小时。结果：痊愈 212 例占 97.2%，无效 6 例占 2.8%。痊愈 212 例 10 年随访，除 11 例死亡外，良好 97 例占 48.3%，显

著进步 65 例占 32.3%，好转 27 例占 13.4%，无效 12 例占 6%^[1]。

1.2 冯秀杰辨证治疗精神分裂症 122 例 痰火内结，上扰脑神用生石膏 120g，陈皮、竹茹、黄芩各 15g，礞石 60g，栀子、枳实、酒制大黄、佩兰各 10g，炒枣仁 80g 等。肝火内炽，灼及脑神用生石决明、生龙齿各 60g，龙胆草、黄芩、枳壳各 15g，栀子、车前子、酒制大黄各 10g 等。肝郁痰结，上及脑神用佛手、远志各 10g，香附 12g，郁金、白芍各 20g，柴胡 6g。肝郁脾虚，上不荣脑用柴胡 6g，郁金、山萸肉各 20g，香附、炒白术各 12g，白芍、百合、炒麦芽各 30g，茯苓 60g，党参 15g，炒枣仁 80g。肝肾两虚，上不益脑用当归、枸杞子各 15g，白芍、女贞子、菟丝子各 40g，杜仲、首乌、炒麦芽各 30g，炒枣仁 60g。脾肾两虚，上不益脑用党参、枸杞子各 15g，茯苓、菟丝子各 60g，炒白术 10g，女贞子 40g。心脾两虚，上不荣脑用党参、生黄芪、山萸肉、大枣各 15g，茯苓、当归各 20g，白术、远志各 10g，甘草、木香各 6g，炒枣仁 60g。气虚血瘀，脑神失调用生黄芪、茯苓、百合各 60g，党参、红花、当归各 15g，山药、赤芍、怀牛膝、麦冬各 30g，枸杞子 20g。均日 1 剂水煎服，30~60 剂为 1 疗程。结果：痊愈 66 例占 54.10%，好转 55 例占 45.08%，无效 1 例占 0.82%^[2]。

1.3 王彦恒辨证治疗脾虚性慢性精神分裂症 48 例 肝郁脾虚用柴胡 6g，郁金、山萸肉各 20g，香附、炒白术各 12g，白芍、百合、炒麦芽各 30g，茯苓 60g，党参 15g，炒枣仁 80g。脾肾两虚用党参、枸杞子各 15g，茯苓 60g，炒白术 10g，女贞子 40g，菟丝子 50g 等。心脾两虚用党

参、炙黄芪、山萸肉、大枣各 15g，茯苓、当归各 20g，白术、远志各 10g，甘草、木香各 6g，炒枣仁 60g。脾虚血瘀用炙黄芪 50g，茯苓、百合各 60g，党参、红花、当归各 15g，山药、赤芍、怀牛膝、麦冬各 30g，枸杞子 20g 等。日 1 剂水煎服，30～60 剂为 1 疗程。结果：痊愈 25 例，好转 22 例，无效 1 例^[3]。

1.4 刘鑫辨证治疗精神分裂症 112 例 本组男性 39 例，女性 73 例。病程 3 日～22 年。癫症：多属虚证，或为虚中夹实。治以理气解郁，化痰开窍，活血通络，养心安神，用菖蒲、枣仁各 12g，远志、当归、川芎、赤芍、川牛膝、桔梗、柴胡、大黄、白术各 9g，红花、桃仁、胆南星各 6g，甘草 3g。水煎服。热盛加犀角 3g，黄连 6g；心惊妄见加琥珀 3g，茯神 9g；痰多加半夏、陈皮各 9g。每日 1 剂连服 10～20 剂。狂证：多属实证，治以调气活血，清热泻火，祛痰开窍，宣散表邪，用珍珠母 12g，郁金、半夏、当归、杭芍、川芎、桔梗、荆芥、防风、黄芩、白术、芒硝各 9g，红花、桃仁、黄连各 6g，大黄 15g，水煎服。方中大黄、芒硝可随患者体质加减，狂躁不安时，大黄可加至 30～50g，芒硝可用至 20g。结果：治愈 63 例占 56.25%，显效 28 例占 25%，好转 12 例占 10.71%，无效 9 例占 8.04%^[4]。

2 一方为主 随症加减

2.1 塔其一等用静神汤治疗精神分裂症 30 例 本方含黄连、龙胆草、香附、郁金、茯神各 15g，胆南星 10g，丹参、枣仁、夜交藤各 20g，菖蒲 30g，朱砂（冲服）2g。易怒加栀子、芦荟；痰涎壅盛加青礞石、清半夏、远志；胸闷气滞重用郁金、青皮；口干渴、舌苔燥或焦黑加玄

参、生石膏；夜寐不安加琥珀、生龙骨、生牡蛎；精神抑郁加合欢皮；气短乏力加人参、黄芪、炙甘草；面色不华、唇舌色淡加当归、白芍、阿胶。日1剂水煎服。服药期间忌烟酒、辣椒等。按1963年全国神经精神科会议标准，治疗8周后，显效20例，好转8例，无效2例，总有效率93.2%，服药起效时间12~30日^[5]。

2.2 李禄斌等治疗精神分裂症50例 本组病例入院后均先治以清热泻火涤痰，辅以疏肝安神，药用生石膏180g，柴胡、青皮各25g，生大黄（后下）、青礞石各50g，生铁落、夜交藤各60g，芒硝（冲服）40g，栀子15g。热盛加黄连10g，败酱草30g；痰湿盛去芒硝、栀子，加天竺黄10g，石菖蒲6g，法半夏15g。待症状基本消失后，改予滋阴潜阳扶正，药用生石膏60g，川芎、炒栀子各15g，僵蚕18g，菊花（后下）12g，生地50g，黄柏、炒枣仁各24g，黄连6g，钩藤、代赭石各30g。均日1剂，水煎3次，混合煎液3次分服。结果：治疗6周后获显效（症状消失，自知力恢复，生活自理，环境适应良好，能坚持全日工作）45例，好转4例，无效1例。随访5年复发14例^[6]。

2.3 王俊国以温胆汤加味治疗精神分裂症30例 本组病人病程3天~10年，但多在半年以内。均予温胆汤加味：法夏、陈皮、枳实、竹茹、菖蒲、黄芩、胆星各9g，茯苓、瓜蒌各12g，黄连6g，生铁落30g（先煎），生姜4片，甘草4.5g，随症加减，每日煎服1剂。少数病例配合冬眠灵100ml/日3次。结果：痊愈（精神症状基本消失，神清语利，记忆力恢复，生活自理）16例，好转（精神症状明显减轻，精神安静，有时清醒，反应及判断

力差，生活尚不能自理）12例，无效2例。服药8~45日^[7]。

2.4 刘吉祥用柴胡加龙骨牡蛎汤治疗精神分裂症 15例 使用本方治疗本病以口苦、心烦、胸胁苦满、脉弦为辨证要点。药用柴胡9~12g，黄芩6~9g，桂枝5~8g，云苓、党参、生姜各10g，龙骨、牡蛎、半夏各12g，大黄、菖蒲、远志各6g，大枣6枚。视症加减，日1剂水煎服；禁辛辣刺激食物。结果：服药28~97剂后，痊愈（临床症状消失，半年以内无复发者）8例，显效（仅有精神呆滞、睡眠差等症状，或半年内复发者）5例，无效2例。服中药期间均未服用其它药物^[8]。

2.5 汪斌采用活血化瘀法治疗精神分裂症 中药组20例，药用桃仁、赤芍、郁金各10~15g，丹参、莪术各15~20g，香附10g，生大黄30~50g，甘草6g。随症加减。日1剂水煎服，30剂为1疗程。西药组20例用氯丙嗪平均日量650mg。结果：中药组痊愈2例，显著进步8例，进步6例，无效4例；西药组分别为3、8、6及3例^[9]。

3 固定方治疗

3.1 张永祥用藤蛇乌花汤治疗精神分裂症 本组中初次发病者68例，发作2~25次者132例；病程15天~50年。药用钩藤30g，制川乌、红花各5g，曼陀罗花2g，甘草10g，加入适量冰糖，水煎日1剂分3~4次服。剂量由小逐渐加大，30日为1疗程。经治1~2疗程后，痊愈52例，显效87例，有效26例，无效35例，总有效率82.5%；初次发病者全部有效。服药期间注意检查肝功能和白细胞；如出现心跳加快、静坐不能，暂停服药多可自行缓解^[10]。

3.2 李祿斌用中药浓缩剂治疗精神分裂症 两组各40例。本组用生石膏 180g, 礞石 60g, 大黄、龙胆草各 30g, 龙骨 50g, 红花、胆南星、黄柏、石菖蒲各 15g, 水浸 1 小时后, 煎煮 2 次, 混合煎液, 再煎成粉剂, 晒干后加琥珀粉 5g, 混匀, 装 0 号胶囊 24 粒 (每粒 0.8g, 含生药 16.75g)。8 粒/日 3 次口服, 服药期间忌酒、烟、辣椒等。西药组用冬眠灵、奋乃静、氟哌啶醇、舒必利等, 用量折算成冬眠灵, 平均为 575mg/日。均疗程 6 周。结果: 两组分别痊愈 21、13 例, 显著进步 12、19 例, 进步 5、7 例, 无效 2、1 例, 有效率 95%、97.5% ($P > 0.05$)。BPRS 因子分析, 两组治疗前后自身比较均有显著性差异 P 均 < 0.01 ; CGI 疗效指数、副作用及复发率两组比较均有显著性差异, P 均 < 0.01 ^[11]。

3.3 张永祥等用青牛角粉治疗精神分裂症 200 例 本组患者病程 15 天 ~ 15 年。取适龄健康之黑牛或黑白花牛之青色牛角, 锉为粗粉, 捣碎, 过 7 号筛, 加入适量白砂糖备用。开始服 2 ~ 3g/日 3 次, 以后逐渐加量至每日 60g。30 日为 1 疗程。治疗 3 疗程后, 结果: 痊愈 (患者精神症状全部消失, 接触良好, 能参加社会活动, 有理解及思维能力, 自知力完全恢复) 143 例占 71.5%, 显著进步 (精神症状大部分消失, 能适应环境并参加部分社会活动, 自知力大部分恢复) 34 例占 17%, 好转 14 例占 7%, 无效 9 例占 4.5%, 总有效率为 95.5%。观察到本品用量增至 60g/日时, 脉搏及心率增速至 100 ~ 130 次/分; 对思维及感知分析综合能力障碍的疗效较满意; 对精神运动性兴奋也有一定抑制作用, 但对原发性情感障碍者效果较差; 发病时间短者疗效较高^[12]。

3.4 杨开满等用地龙治疗精神分裂症 220 例 1、3 组各 60 例，均用地龙 30g，白糖 10g，日 1 剂水煎服，每周 6 剂。2 组 100 例，用地龙注射液（每支 2ml，含生药 2g，长沙中药二厂生产）4ml/日 2 次肌注，每周用 6 日。1、2 组均每日用氯丙嗪 $\leq 300\text{mg}$ ，奋乃静 $\leq 24\text{mg}$ ，口服。均 60 日为 1 疗程。用 1 疗程，结果：三组分别近期治愈 36、22、4 例，显效 8、28、14 例，好转 8、24、16 例，无效 8、26、26 例^[13]。

4 中西医结合

4.1 张存喜中西医结合治疗精神分裂症 276 例 本组患者病程 7 日 ~ 22 年。基本方用黄连、胆南星、柴胡、当归各 10g，栀子、郁金各 15g，硫酸镁（冲服）6g，明矾 2g，生石膏、生大黄（后下）、礞石各 50g。1. 肝火型加龙胆草、花粉各 10g。治疗之初数日，可配合氯丙嗪片 50 ~ 200mg 口服，或每晚肌注氯丙嗪 50 ~ 100mg。2. 气郁型去大黄，加远志、石菖蒲各 20g，朱砂、琥珀各 0.5g（冲服）。配合利他林 10 ~ 20mg，早、午各 1 次口服；若有本僵症状，治疗开始即每晨肌注苯甲酸钠咖啡因 0.5g，连用 5 日。3. 痰盛型加法半夏、陈皮、天竺黄各 10g，炒枣仁 20g。若伴心动过速可用心得安 10 ~ 30mg，泰尔登 25 ~ 75mg，均日 3 次口服。4. 血瘀型加丹参 10g，川芎 15g，红花 6g。配阿米替林 25 ~ 50mg，日 3 次口服。结果：痊愈 208 例，好转 64 例，无效 4 例，总有效率为 98.6%。服药期间出现腹泻为正常现象，一般勿需用止泻药。可多饮水，待症状消失后以归脾汤善后^[14]。

4.2 刘京凤等中西医结合治疗精神分裂症 80 例 本组用百合宁神汤：炙百合 60g，炒枣仁、合欢皮、夜交

剂水煎服，30日为1疗程。本组及对照组76例，均用三氟拉嗪或氟奋乃静或氟氮平，剂量折算成氟丙嗪，均300mg/日。结果：两组分别治愈40、24例，好转34、27例，无效6、25例，有效率92%、51% ($P < 0.01$)^[17]。

4.5 彭玉萍中西医结合治疗精神分裂症28例 本组用肾气丸加减：熟地20g，山茱萸、淮山药各15g，泽泻、茯苓、丹皮各12g，桂枝、附子、益智仁、枣仁、菖蒲、甘草各10g。日1剂水煎服。与对照组26例，均用氟氮平350mg，谷维素90mg，维生素B₂600mg，肌苷1.2g，日1次口服，30日为1疗程。用3个疗程，结果：两组分别痊愈4、2例，显著进步9、5例，进步13、9例，无效2、10例，总有效率92.85%、61.54% ($P < 0.05$)^[18]。

4.6 张保汉等中西医结合治疗精神分裂症124例

1. 中药治疗。狂症泻法为主，药用芒硝20g，川大黄60g，枳壳、槟榔、连翘、黄柏、郁金、贝母各10g，滑石6g，黄连15g，熟地、橘红、菖蒲各12g，瓜蒌25g。效不显或狂躁至极用吐法，用白矾1.5g（冲服），藜芦45g，瓜蒂15g，黄芩6g，石膏25g，白矾30g。近愈或形羸用补法，用党参30g，当归、白术、茯苓、柏子仁、远志、菖蒲、麦冬、钩藤、栀子、炙黄芪各10g，炒枣仁18g，木香、竹茹各6g，琥珀（冲服）、朱砂（冲服）各3g。日1剂水煎服。癫症用熄风补心汤：人参、白术、桂元肉、远志、半夏、麦冬各10g，当归、黄芪、赭石各15g，菖蒲、枳实各12g，木香、竹茹各6g，朱砂3g（冲服），水煎服。

2. 西药。狂症轻者用奋乃近，重者用氟丙嗪，体虚者静脉推注葡萄糖、维生素；癫症不用西药镇静剂。

3. 针灸。多用于狂症。主穴取大椎、陶道、身柱、百会。配穴取安

眠 1、安眠 2。结果：治愈 102 例占 82%，好转 17 例占 14%，无效 5 例占 4%。对愈者随访 12 个月，治愈、好转率分别为 77%、23%^[19]。

4.7 刘立芬等中西医结合治疗精神分裂症 100 例：附西药对照组 100 例 本组用宁神解郁汤：五味子 15g，炒枣仁 30g，夜交藤、菖蒲、当归各 20g，郁金、柴胡各 15g，甘草 10g。痰火内扰加胆南星、栀子、生石膏；痰湿内阻加竹茹、半夏、胆南星；气滞血瘀加桃仁、红花、鸡血藤；阴虚火旺加麦冬、沙参。日 1~2 剂水煎顿服。两组每日分别用氯丙嗪 100~200mg、400~800mg，氯氮平 100~200mg、300~600mg，奋乃静 4~8mg、20~40mg，氟哌啶醇 6~10mg、30~60mg。结果：两组分别治愈 69、53 例，显效 24、29 例，进步 7、12 例，无效 0、6 例，显效率 93%、82%。随访 1 年，复发 3、11 例^[20]。

4.8 胡佰文中西医结合治疗精神分裂症 6 例 对本组患者逐例进行自身交叉药物对照，以丹参与氯氮平同用为观察组，予丹参注射液 10ml/日 1 次静滴，以后渐增至 14~20ml/日 1 次；按常规用氯氮平。单用氯氮平治疗为对照组。治疗分 4 期：1. 停用抗精神病药物 1 周以上，以主要精神症状复现，病情明显为度。2. 按随机原则单用氯氮平或加丹参治疗 4 周以上。3. 同第 1 期。4. 交换两种治疗方法 4 周以上。根据国内沿用的 4 级疗效标准，两组痊愈各 1 例，显效 4、1 例，有效 1、4 例；显效以上分别占 83.3%、33.5%，两组比较有显著差异 $P < 0.01$ 。两组各有 5 例出现流涎、嗜睡、乏力、便秘及中度脑电图异常等副作用；对照组有 3 例出现心电图 T 波、S—T 段改变而观察组则无，提示丹参注射液有改善氯氮平引起心电

图异常的作用。认为本法对久治不愈及伴有心脑疾患者值得一试^[21]。

4.9 杨春林等以金蒲片为主治疗精神分裂症 本品含郁金、石菖蒲、丹参各 40g，香附 20g，共制成 50 片，每片含生药 2.8g。本组 204 例，均用本品 15 ~ 25g/日 2 次。同时选用 1 种西药：氯丙嗪（ $< 300\text{mg/日}$ ）、或三氟拉嗪（ $< 20\text{mg/日}$ ）、或舒必利（ $< 500\text{mg/日}$ ）、或氟奋乃静（ $< 20\text{mg/日}$ ）。西药组 100 例，单用西药品种同上，选 1 种，用药剂量折算成氯丙嗪，平均为 585mg/日。均 6 周为 1 疗程，1 疗程后评定疗效。结果：本组与西药组分别治愈 64 例、44 例，显著进步 70 例、24 例，进步 49 例、25 例，无效 21 例、7 例，显效率分别为 65.7%、68%，比较无显著差异 $P > 0.05$ 。但本组副作用较西药组显著减轻^[22]。

4.10 张继志等以血府逐瘀汤加减为主治疗精神分裂症血瘀证 本组 35 例，药用柴胡、川芎、降香各 15g，红花 10g，赤芍、丹参各 30g。理气加香附；清热加酒军；健脾加茯苓、白术；益气加党参、黄芪。日 1 剂水煎服。对照组 31 例。两组均酌情选用一种小剂量抗精神病药，选用氯丙嗪、奋乃静、三氟拉嗪、氟哌啶醇、舒必利、氯氮平。均 8 周为 1 疗程。结果：两组分别痊愈 9、4 例，显著好转 16、12 例，好转 10、12 例，无效 0、3 例，两组疗效无显著差异 $P > 0.05$ 。本组治疗能使精神症状消减，可使血液流变学的异常指标趋向正常^[23]。

4.11 朱运斋等以水蛭大黄合剂为主治疗精神分裂症血瘀证 均为女性患者。本组 32 例，用本品（每 500ml 含生药：水蛭、虻虫、藏红花、菖蒲各 10g，大黄 120g），

首次 50ml/日 2 次口服；无不良反应增至 50 ~ 100ml/日；血瘀证明显最大量用 560ml/日。并用氯丙嗪平均 $250 \pm 42.8\text{mg/日}$ 。对照组 35 例，用氯丙嗪平均 $350 \pm 45.8\text{mg/日}$ 。用 30 日，结果：两组分别痊愈 9、10 例，显著进步 13、14 例，进步 10、11 例。血瘀证消减率分别为 60%、11% ($P < 0.01$)。两组部分患者均见副反应，但本组较轻。血液流变学血栓长度、血栓湿重、血栓干重、全血粘度比的低切值两组治疗前后自身及红细胞压积、血浆粘度比、全血粘度的高切值本组治疗前后及血栓干重、全血粘度比的高低切值治疗后两组比较均有显著性差异， $P < 0.01$ 、 $0.05^{[24]}$ 。

4.12 杨春林等以大黄片为主治疗精神分裂症 对精神分裂症患者辨证属实者 186 例（病程 3 月 ~ 12 年）予本法治疗。取桃仁 20g，大黄、赤芍各 40g，制成浸膏糖衣片 50 片。初用每次 10 ~ 15 片，若无腹泻，病情又未见好转，可逐渐加量至每次 25 ~ 30 片，于上午 9 时和下午 3 时各服 1 次。同时加用小剂量西药如氯丙嗪、氟哌啶醇、氯氮平等，以 6 周为 1 疗程。结果：痊愈 73 例占 39.2%，显著进步 55 例占 29.5%，进步 42 例占 22.6%，无效 16 例占 8.6%。与单用大剂量西药组的疗效无显著差异 ($P > 0.05$)，但与文献报道单用小剂量西药治疗的效果比较则有显著提高。以本法治疗的副反应轻，减轻了西药引起的锥体外系等副作用，用总体印象量表评定，由于本组的副反应分低，使疗效指数分显著高于西药组。观察到本法对便秘、不寐、喜怒无常、妄见妄闻、狂躁、行为怪异等狂证症状疗效较好，对呆滞、妄言妄语则疗效较差^[25]。

灵折算, 分别用 225.5、439.5mg/日。结果: 两组分别痊愈 35、26 例, 显效各 9 例, 无效 6、15 例, 有效率 88%、70%; 本组疗效及平均显效时间均优于对照组 ($P < 0.05$)^[27]。

6.2 吕雅芝采用穴位埋线治疗精神分裂症 100 例

取华佗夹脊穴胸₁₋₇、腰₄₋₅、骶₁, 配天泉、大肠俞、委中、承山穴, 并按精神症状随症取穴。局部常规消毒, 于两横突间平棘突旁开 5~8 分处注入 2% 盐酸利多卡因适量 (避免直刺或深刺), 再次 00~1 号铬制肠线穿入三角全层缝合针, 从一侧穴刺向对侧穴出针, 剪断肠线, 盖以敷料, 胶布固定。15~20 日 1 次, 3 次为 1 疗程。埋线 2~4 次后, 痊愈 59 例, 显效 24 例, 进步 6 例, 复发 7 例, 无效 4 例, 总有效率 96%。心脏病、出血性疾病、糖尿病、高热、妊娠期、过敏体质、肥胖、牛皮癣、传染病、脑瘤等患者忌用^[28]。

参 考 文 献

- 1 丁德正. 北京中医. 1988; (6): 28
- 2 冯秀杰, 等. 中医杂志. 1996; 37 (1): 34
- 3 王彦恒. 北京中医. 1997; (1): 11
- 4 刘 鑫. 山西中医. 1988; 4 (4): 13
- 5 塔其一, 等. 吉林中医药. 1991; (6): 9
- 6 李禄斌, 等. 中医杂志. 1990; 31 (5): 23
- 7 王俊国. 陕西中医. 1987; 8 (3): 139
- 8 刘吉祥. 陕西中医函授. 1991; (5): 30
- 9 汪 斌. 中西医结合杂志. 1986; 6 (12): 736
- 10 张永祥, 等. 湖南中医学院学报. 1997; 7 (4): 17

- 11 李禄斌, 等. 新中医. 1994; 26 (8): 30
- 12 张永祥, 等. 铁道医学. 1987; 15 (5): 264
- 13 杨开满, 等. 辽宁中医杂志. 1996; 23 (12): 567
- 14 张存喜. 浙江中医杂志. 1991; 26 (6): 249
- 15 刘京凤, 等. 山东中医杂志. 1995; 14 (7): 314
- 16 范火淮, 等. 新中医. 1996; 28 (5): 31
- 17 胡海浪, 等. 陕西中医学院学报. 1994; 17 (3): 22
- 18 彭玉萍, 等. 湖南中医杂志. 1997; 13 (2): 8
- 19 张宝汉, 等. 山西中医. 1991; 7 (5): 22
- 20 刘立芳, 等. 辽宁中医杂志. 1996; 23 (5): 225
- 21 胡佰文. 山东中医杂志. 1991; 10 (1): 24
- 22 杨春林, 等. 中西医结合杂志. 1987; 7 (9): 529
- 23 张继志, 等. 中国中西医结合杂志. 1993; 13 (7): 39
- 24 朱运斋, 等. 中国中西医结合杂志. 1996; 16 (11): 646
- 25 杨春林, 等. 中医杂志. 1986; 27 (9): 31
- 26 舒德海, 等. 中国针灸. 1996; 16 (7): 13
- 27 孙化海, 等. 上海中医药杂志. 1995; (12): 28
- 28 吕雅芝. 中国针灸. 1988; 8 (5): 12

(邢桂琴)

